

BBT opmaak WVGA 2026 – technische vragen

Inhoud

Technische vragen BBT WVGA – CD&V	4
Overkoepelend	4
Beleidsondersteuning	5
Armoedebeleid	6
Welzijnswerk	7
Sociale akkoorden	8
Preventie	8
Eerste lijn	10
Gespecialiseerde Zorg.....	10
Woonzorg	13
Opgroeien	19
Jeugdhulp	19
Geïntegreerd gezinsbeleid.....	21
Groeipakket	22
Personen met een handicap	23
Sociale Bescherming	26
Zorginfrastructuur	28
Apparaatskredieten.....	28
Technische vragen BBT WVGA – Groen	29
Algemeen.....	29
Omtrent het uitbreidingsbeleid:	30
Het deel ARMOEDE	31
De Meerjarenraming 2025 - 2030.....	32
Technische vragen BBT WVGA – N-VA	33
IV Overkoepelende strategische doelstellingen	33
VI Beleidsveld Zorg.....	37

ISE Beleidsondersteuning	37
ISE Armoedebeleid	40
ISE Welzijnswerk	42
ISE Sociale akkoorden	45
ISE Preventie	45
ISE Eerste lijn	50
ISE Gespecialiseerde Zorg.....	52
ISE Woonzorg.....	58
ISE Algemeen Gezondheidsbeleid	63
VII Beleidsveld Opgroeien	64
ISE Jeugdhulp.....	64
ISE Geïntegreerd gezinsbeleid	70
ISE Groeipakket.....	77
VIII Beleidsveld personen met een handicap	78
ISE Personen met een handicap	78
IX Beleidsveld Sociale bescherming	82
ISE Zorgbudgetten	82
ISE Algemeen beleid sociale bescherming	84
X Beleidsveld Zorginfrastructuur	84
ISE Zorginfrastructuur	84
XI Apparaatskredieten en begrotingsprogramma's zonder beleidsveld	85
Technische vragen BBT WVGA – Open VLD	86
Overkoepelende strategische doelstellingen.....	86
Beleidsondersteuning	86
Welzijnswerk	87
Sociale Akkoorden	89
Preventie	90
Eerste lijn	92
Gespecialiseerde zorg.....	94
Woonzorg.....	97
Opgroeien – Jeugdhulp	101
Geïntegreerd gezinsbeleid	106

Groeipakket.....	111
Personen met een handicap	112
VSB.....	122
VIPA.....	123
Technische vragen BBT WVGA - PVDA	126
Algemeen.....	126
Jeugdhulp.....	127
Ouderenzorg.....	130
Personen met een handicap	132
Schoolmaaltijden	135
Activering reserves	135
Sociale akkoorden	135
Technische vragen BBT WVGA – Vlaams Belang	137
Overkoepelende strategische doelstellingen.....	137
Beleidsveld Zorg:	138
Beleidsondersteuning	138
Armoedebestrijding	142
ISE Welzijnswerk.....	143
ISE sociale akkoorden	145
ISE preventie	145
ISE eerstelijns	151
ISE gespecialiseerde zorg	152
ISE Woonzorg	154
ISE Jeugdhulp	155
ISE geïntegreerd gezinsbeleid	161
ISE Groeipakket	163
ISE Personen met een handicap	164
ISE zorgbudgetten	169
ISE Zorginfrastructuur	170

Technische vragen BBT WVGA – CD&V

Overkoepelend

1. Onder verschillende ISE wordt een besparing doorgevoerd onder de noemer ‘activering van opgebouwde reserves’. Aangezien er heel uiteenlopende types voorzieningen en organisaties onder eenzelfde ISE kunnen vallen is het onduidelijk waar de besparing precies wordt doorgevoerd.
 - a. Bestaat er een gedetailleerder overzicht van hoeveel reserves per sector op deze manier worden aangesproken?
 - b. Beschikt de Vlaamse overheid over een overzicht van de opgebouwde reserves die met subsidies vanuit het beleidsdomein WVGA werden opgebouwd?

Deze vraag hangt samen met een hele cluster van vragen die gesteld wordt omtrent de reserves en winst op zorg. Ik beantwoord ze samen. Voor een goed begrip: subsidies zijn investeringen in betaalbare, kwaliteitsvolle zorg. Zij hebben niet tot doel als winst te worden uitgekeerd, noch om ongebruikt op een balans te blijven staan.

Het spreekt evenwel voor zich dat voorzieningen financieel gezond moeten kunnen worden gerund. Zij mogen een redelijke winst boeken en reserves opbouwen op een manier die past bij een gezonde, redelijke bedrijfsvoering, zoals de aanleg van een sociaal passief of van bestemde fondsen of reserves die nodig zijn om bouwen of investeringen mogelijk te maken.

Omtrent winst op zorg wordt een kader uitgewerkt waarbij we naar de toekomst kijken. Daarvoor werd geen bedrag in de begroting ingeschreven. Omtrent reserves wordt een gelijkaardig kader uitgewerkt dat naar reserves opgebouwd in het verleden kijkt en die in rekening brengt bij de uitbetaling van nieuwe subsidies.

Er werd in de begroting een bedrag van €12 mio geraamd voor het hele beleidsdomein. Er werd nog geen verdeling over sectoren heen vastgelegd.

Conceptueel zijn we nog bezig met een evenwichtige en juridisch robuuste invulling van beide maatregelen. De gegevens waarover we beschikken zijn immers niet volledig en moeten verder geanalyseerd worden. We kijken ook naar het overleg met de experts uit de sector.

2. De algemene toelichting bij de begroting vermeldt het volgende (p.50):
“Overeenkomstig de op 2 september 2025 door het Planbureau gepubliceerde maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex vindt de volgende overschrijdingen van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex normalerwijze plaats in januari 2026. Met de federale hervorming van 2025 worden de sociale uitkeringen en lonen vanaf 1 juli 2025 pas 3 maanden na

overschrijding van de spilindex met 2% aangepast in plaats van 1 maand (sociale uitkeringen) of 2 maanden (lonen) na overschrijding van de spilindex voor 1 juli 2025.”

- a. Op basis van eerder gestelde vragen aan minister Gennez kan worden geconcludeerd dat het huidige indexeringstempo van de lonen van personeel in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren zal behouden blijven, en dus niet zal uitgesteld worden naar drie maanden na overschrijding van de spilindex.

Bij BA2025 werd beslist om het Vlaams beleid te aligneren op de federale maatregel.

- b. Welke indexprovisie wordt hiervoor toegekend aan het beleidsdomein WVG?

In de algemene toelichting bij de BO2026 kan op pagina 133 en meer bepaald in tabel VIII-12 de indicatieve verdeling van de indexprovisie per beleidsdomein worden teruggevonden. In het geval van WVG betreft het een bedrag van 166,475 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 162,647 miljoen euro aan vereffeningskredieten.

- c. Is deze indexprovisie gebaseerd op het huidige indexeringstempo voor de lonen in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren? Met andere woorden, wordt er vermeden dat de zorg- en welzijnsvoorzieningen zelf een maand loonindexering moeten overbruggen?

Zie antwoord a.

- d. Waar precies in de begroting kunnen de voorziene middelen hiervoor worden teruggevonden?

Zie antwoord a.

Beleidsondersteuning

GB0-1GCF2BA-WT - BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING

3. P24: er wordt verwezen naar de ‘duurzame inbedding van de subsidies voor het verschaffen van evidence-based gezondheidsinformatie aan burgers’. Over welke subsidies gaat het precies, voor welke organisaties en voor welke bedragen?

De duurzame inbedding van de subsidies voor het verschaffen van evidence-based gezondheidsinformatie aan burgers betreft een jaarlijkse subsidie die door de secretaris-generaal van het Departement Zorg wordt toegekend aan één organisatie. Deze subsidie is gebaseerd op een meerjarenplan van vijf jaar en heeft tot doel burgers op een bevattelijke en actuele manier te informeren over gezondheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 300.000 euro per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks bepaald worden aan de hand van hun ingediend jaarplan,

met bijhorende begroting en binnen de beschikbare middelen van het uitgavendecreet. De toekenning gebeurt op basis van een oproep waarbij organisaties een meerjarenplan indienen. De oproep zal op korte termijn verspreid worden.

4. P34: er wordt verwezen naar de subsidies van innoverende projecten in het kader van Flanders' Care. Over welke innoverende projecten en bijhorende subsidies gaat het?

Het traject ToekomstZorg voorziet innovatieruimte waarbinnen organisaties op innovatieve wijze aan de slag kunnen om intersectorale samenwerking in praktijk te brengen. Voor het traject ToekomstZorg zijn de budgetten reeds aangerekend op de begroting 2024 (5.900.000 euro).

Armoedebelaid

GB0-1GCF2CA-WT - ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

5. P45: er wordt verwezen naar de opstart van het nieuwe opleidingsprofiel 'ervaringsdeskundige'. Hoeveel middelen worden hiervoor voorzien, en worden hiervoor ook middelen ingezet vanuit het beleidsdomein Onderwijs?

De opleiding kost 180.000 euro per opleidingslocatie per jaar. De opstart van de eerste locatie is voorzien in januari 2027. We bekijken nog hoeveel de voorbereiding van deze opstart zal kosten in 2026.

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) die de opleiding "ervaringsdeskundige" inrichten, dragen bij aan deze opleiding in dezelfde mate als voor andere opleidingen.

6. Hoeveel vrije beleidsruimte is er beschikbaar voor armoedebelaid uit elders niet ingezette middelen?

Er is momenteel nog geen zicht op de niet ingezette middelen in 2026.

GB0-1GCF2CB-WT - COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID

7. P46: hoeveel middelen worden er voorzien voor de projecten preventieve gezinsondersteuning?

Voor de projecten wordt 620.000 euro uitgetrokken voor een periode van 3 jaren. Het betreft 5 projecten.

8. P48: een deel van het voorziene uitbreidingsbudget voor 'gezonde voeding op school' wordt uitgesteld naar 2027. Het bedrag van €46.667k wordt verminderd met €33.500k, zodat dit neerkomt op €13.167k uitbreiding in 2026. Met de reeds

voorziene €23.3 miljoen voor 2025 komt het totale budget voor gezonde schoolmaaltijden in 2026 op €36.5 miljoen of de helft van het oorspronkelijk voorziene bedrag.

- a. Wanneer kunnen bijkomende lokale besturen instappen in het project?

Voor het schooljaar 2026-2027 zal er het instapmoment op 1 september 2026 liggen.

- b. Wordt bekeken op welke andere manieren de overige middelen voor gezonde schoolmaaltijden kunnen worden ingezet, ivf de strijd tegen armoede?

De toewijzing loopt nog. We zullen de oproep evalueren en waar nodig bijsturen.

Welzijnswerk

GB0-1GCF2EA-WT - WELZIJNSWERK

9. P59: er wordt €925k overgeheveld van structuurelement lokaal sociaal beleid naar structuurelement welzijnswerk voor de structurele inbedding van de projecten Housing First. Betreft dit het volledige bedrag binnen welzijn ihkv Housing First? Gaan deze middelen enkel naar de CAW of zijn hier nog andere organisaties bij betrokken?

De CAW zijn momenteel buiten programmatie reeds voor 6,41 VTE erkend in het kader van Housing First. In 2026 wil ik hier 11 VTE aan toevoegen voor structurele inbedding van de lopende projecten. Daarnaast zetten de CAW ook reguliere middelen vanuit hun enveloppe in het kader van Housing First in, dat een werkvorm is binnen hun breed aanbod woonbegeleiding.

Deze middelen worden toegekend aan de CAW, die voor Housing First diverse samenwerking aangaan met actoren uit onder meer de verslavingszorg, GGZ, VAPH, lokale besturen, woonmaatschappijen, ...

GB0-1GCF2ED-WT - LOKAAL SOCIAAL BELEID

10. P60: er wordt €2 miljoen gecompenseerd vanuit 'thuis- en ouderenzorgbeleid' naar lokaal sociaal beleid voor de versterking van het lokaal sociaal beleid voor ouderen. Op welke manier worden deze middelen momenteel ingezet binnen het thuis- en ouderenzorgbeleid? Gaat het om €2 miljoen extra voor het lokaal sociaal beleid voor ouderen, of gaat het om €2 miljoen die momenteel ook al met die doelstellingen worden ingezet, zij het vanuit een ander begrotingselement?

Deze middelen worden momenteel niet ingezet. Het betreft extra middelen die zullen worden ingezet voor het lokaal sociaal beleid voor ouderen.

GB0-1GCF2EE-WT - WERK-ZORG

11. P61: er wordt €282k teruggevorderd door het Dpt. WEWIS owv niet volledig aangewende middelen voor casemanagers zorg en middelen voor arbeidsmatige activiteiten. Hoe komt het dat deze middelen niet volledig ingezet raakten?

Deelname aan AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid gebeurt op vrijwillige basis en met als voornaamste focus participatie aan de samenleving. De stijging verloopt trager dan initieel verwacht maar het aantal AMA-trajecten blijft nog steeds stijgen.

Sociale akkoorden

GB0-1GCF2FB-WT - UITVOERING SOCIALE AKKOORDEN

12. P64: de budgetten voor IFIC worden geïntegreerd binnen de basistegemoetkoming voor zorg. Doordat op die manier de zorg niet meer per individuele medewerker maar volgens de zorgzwaarte van bewoners zal worden gefinancierd, kan dit afhankelijk van de profielen die een woonzorgcentrum in dienst heeft, leiden tot een extra inkomst dan wel een verlies. Zijn er maatregelen voorzien om verliezende voorzieningen te compenseren?

De integratie van de financiering voor de IFIC meerkost in de basisfinanciering is een budgetneutrale oefening. Er zijn geen maatregelen voorzien om verliezen bij de organisaties op te vangen. De IFIC-meerkost financiering is een individuele meerkost-financiering, daar waar de BTZ een forfaitaire financiering is die rekening houdt met zorgzwaarte. Het is onmogelijk om één op één de IFIC-integratie op te vangen.

Preventie

GB0-1GCF2JA-WT - PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

13. P77: er wordt €750.000 bespaard op de 'activering van reserves'. Welke organisaties of instanties die vanuit dit begrotingsartikel gefinancierd worden, komen hiervoor in aanmerking?

Zie het antwoord op vraag 1.

GB0-1GCF4JA-WT - PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

14. P79: wat betreft de geraamde uitgaven ihkv PFAS: waaraan worden deze middelen precies besteed?

Deze middelen zijn voorzien voor uitvoer van de conceptnota visie Zeer Zorgwekkende Stoffen. In samenwerking met het Departement Omgeving, de VMM en OVAM wordt die conceptnota visie in 2026 omgezet in een beleidsplan met aanhorig actieplan. In afwachting hiervan wordt verder gewerkt met de actieplannen PFAS en Zorgwekkende

Stoffen. Voor PFAS specifiek worden deze middelen ingezet voor het engagement m.b.t. de gezondheidsaspecten genomen in de overeenkomst met het saneringsverbond te Zwijndrecht.

15. P79: kan verhelderd worden op welke manier het vastleggingskrediet voor de uitgaven ihkv PFAS vermindert met €16.650 miljoen, terwijl de uitgaven uit dit begrotingsfonds verder lopen? Klopt het dat de middelen uit het PFAS-begrotingsfonds gespreid over meerdere jaren worden uitgegeven en dus wel degelijk nog steeds beschikbaar zijn? Hoeveel middelen resten er in het PFAS-begrotingsfonds?

De PFAS-middelen in het begrotingsfonds Preventief Gezondheidsbeleid volgen de principes 'Vervuiler betaalt' en 'In = Uit'. Het fonds laat toe saldo op te bouwen en deze middelen in te zetten over een langere periode waarbij er zorgvuldig met deze budgetten dient te worden omgegaan en waarbij er afhankelijkheden zijn ten aanzien van voorgaand onderzoek en vervolgonderzoeken. De geraamde uitgaven in het kader van PFAS worden bijgesteld met -16.650 keuro in 2026 ten gevolge van de terugdraai van een eenmalige verhoging van de geraamde uitgaven in het kader van PFAS in 2025. Het betreft een vermindering van 24,3 mio VAK in 2025 naar 7,65 mio VAK in 2026. Het is de raming van de verwachte uitgaven die wordt bijgesteld. Het budget blijft echter beschikbaar in het begrotingsfonds waar het omgezet wordt in saldo en gespreid wordt uitgegeven over meerdere jaren. De vooropgesteld uitvoerperiode voor PFAS is een periode van 10 jaar cf. de overeenkomst met het saneringsverbond. Actueel is er nog 24.126.833 euro nog niet vastgelegd, doch wel al bestemd. Cf. Mijn antwoord op de vorige vraag.

P79: wat betreft de verminderde uitgaven voor het preventief gezondheidsbeleid dat niet aan PFAS is gelinkt: waarin zitten de minderuitgaven precies?

- Door toepassing van artikel 20 uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen (het Legionellabesluit) wordt een dossierkost aangerekend ter evaluatie van projecten voor alternatieve beheersmaatregelen voor legionella in een watersysteem. De inkomsten en uitgaven zijn een inschatting, de laatste jaren was dit bedrag steeds lager dan initieel ingeschat. Daarom verminderen we de raming VAK en VEK dit jaar.
- Hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met Umicore in een engagement voor duurzaamheid van het bedrijf rekening houdend met de milieu-impact van zijn activiteiten op de volksgezondheid. De huidige samenwerkingsovereenkomst liep van 1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2025. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorziet in de tewerkstelling van een preventiemedewerker als ondersteuning van de Medisch Milieukundigen (MMK) van de gezondheidsmakers dat in 2026 wordt vastgelegd, maar over 3 jaar wordt vereffend.

Eerste lijn

GB0-1GCF2KA-WT - BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG

16. P86: er wordt €1 miljoen bespaard op de 'activering van reserves'. Welke organisaties op niveau van de eerstelijnszorg die vanuit dit begrotingselement gefinancierd worden, komen hiervoor aanmerking?

Zie het antwoord op vraag 1.

17. P86: er wordt €2.612 miljoen VEK in mindering gebracht, als 'terugdraai van eenmalige VEK-bijstelling van de vorige begrotingsronde'. Kan worden verduidelijkt waarover dit precies gaat?

Bij BO 2025 werd er 2.612 keuro extra VEK voorzien om te kunnen voldoen een jaar overschrijdende subsidiëring vanuit eind 2024. In 2026 is deze subsidie opgenomen in de reguliere werking waardoor deze bijkomende VEK niet langer nodig is.

Gespecialiseerde Zorg

GB0-1GCF2LA-WT - BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

18. Pp 93-94: een prestatie-indicator voor dit beleidselement is de capaciteit voor begeleiding van volwassenen met langdurige psychische zorgnoden. Specifiek wordt ernaar gestreefd om de opnamecapaciteit dichterbij de theoretische programmatie te brengen. Voor de IBW zijn hiervoor 353 plaatsen tekort. Voor de PVT gaat het om 2.216 plaatsen. Voor de PVT werd de doelstelling bijgesteld naar een 'meer realistische' uitbreiding van 5% tov de huidige capaciteit.
- Welk tijdsschema wordt er voor deze uitbreidingen (IBW en PVT) vooropgesteld?

De mogelijkheden tot uitbreiding van de capaciteit IBW en PVT en het daarbij horende tijdsschema worden momenteel besproken met de administratie.

- Hoeveel extra middelen zijn er nodig voor de creatie van de nodige bijkomende IBW- en PVT-plaatsen?

De kostprijs voor één bijkomende plaats opnamecapaciteit PVT bedraagt €41.000.

De kostprijs voor één bijkomende plaats begeleidingscapaciteit IBW bedraagt €18.000.

- Welke extra middelen zijn er in 2026 voorzien voor de creatie van bijkomende IBW- en PVT-plaatsen?

Dit maakt onderdeel uit van de concrete invulling van het uitbreidingsbudget dat in 2026 1 miljoen euro uitbreidingsbeleid bedraagt. Zoals meegegeven in de toelichting verschuift het saldo van de voorziene opstap van 9 miljoen euro naar 2027.

19. P95: er wordt verwezen naar bijkomende middelen ifv diagnostiek bij jonge kinderen door de CAR. Over hoeveel middelen gaat het en hoeveel kinderen kunnen hiermee een diagnose krijgen?

Sinds 2024 wordt €1.000.000/jaar bijkomend geïnvesteerd in gespecialiseerde diagnostische capaciteit voor kinderen & jongeren.

Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) zetten hiermee capaciteit in (buiten hun reguliere financieringskader) in innovatieve 'samenwerkingsverbanden vroegdiagnostiek'. Deze pilootprojecten lopen tot september 2026.

20. P96: er wordt verwezen naar de methodiek van bemoeizorg voor zorgmijdende personen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Door welke organisaties wordt deze methodiek toegepast?

Deze methodiek wordt toegepast vanuit de gesubsidieerde pilootprojecten aanklappende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren. Deze subsidiëring verloopt via 6 initiatieven voor beschut wonen van waaruit aanklappende zorg kan georganiseerd worden voor het begeleiden en ondersteunen van zorgmijdende mensen met psychische problemen op de sociale huurmarkt. In de praktijk betreft het een samenwerking tussen de IBW, CAW, sociale diensten van de huisvestingsmaatschappijen en de federaal gefinancierde mobiele 2B-teams.

21. P97: er wordt verwezen naar investering in het hulpverleningsaanbod voor gedetineerden en geïnterneerden met geestelijke gezondheidsproblemen. Kan er een overzicht gegeven worden van welke middelen in het kader hiervan gegeven worden en aan welke organisaties? Graag daarbij een onderscheid tussen de middelen die toebedeeld worden ihkv deradicalisering, versus de overige middelen ifv geestelijke gezondheidszorg.

- Continuering van het specifieke hulpaanbod dat de CGG's realiseren voor de doelgroep van geradicaliseerde gedetineerden (**disengagement-trajecten**): 85.344 euro (niet geïndexeerd) voor de inzet van 1 VTE. Deze middelen worden toegekend aan CGG Integra, CGG Prisma en CGG Adentro.
- Continuering van de **TANDEM-werking**: er wordt een jaarlijks budget voorzien van 657.693,54 euro.
- Het **tweedelijns hulpaanbod vanuit de CGG** voor gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen, wordt gerealiseerd binnen hun enveloppefinanciering.

22. Pp 97-98: wat is de timing van de hervorming van het revalidatielandschap?

De uitwerking van de eerder bepaalde conceptuele fase van de hervorming van het zorgaanbod voor fysieke revalidatie is gestart. Om dit proces te structureren en te begeleiden, werd een Vlaamse stuurgroep opgericht. De stuurgroep zal prioritaire deelprojecten vastleggen en moet daarbij nog een plan van aanpak, inclusief timing, uitwerken.

Maximale afstemming met het federale beleid is noodzakelijk. Daarom werd een interfederale werkgroep samengesteld. De interfederale werkgroep is een eerste keer samengekomen op 8 oktober 2025. In deze werkgroep zijn alle Gemeenschappen en Gewesten, alsook de federale overheid vertegenwoordigd.

23. P101: er komt €366k vrij als gevolg van uitdovende PVT-bedden. Deze middelen worden opnieuw ingezet voor langdurige psychische zorg.

- a. Welke instantie zal deze middelen ontvangen voor de organisatie van langdurige psychische zorg?

Dit is nog niet beslist.

- b. Hoe garandeert men dat deze middelen bij dezelfde doelgroep terecht zullen komen?

In samenspraak met mijn administratie zal bekeken worden op welke manier deze middelen kunnen ingezet worden voor de doelgroep personen met ernstige en langdurige psychische zorgnoden.

- c. Waarom zijn er PVT-bedden uitdovend gezien het feit dat de theoretische opnamecapaciteit vandaag reeds niet gehaald wordt en men streeft naar een uitbreiding van de capaciteit met minstens 5%?

In 1990 werden de PVT opgericht, onder federale bevoegdheid. Er ontstonden definitieve en uitdovende PVT bedden. Uitdovende PVT bedden zijn gelinkt aan een concrete zorggebruiker. Wanneer deze zorggebruiker de voorziening verlaat of komt te overlijden, wordt ook de erkenning die verbonden is aan deze plaats geschrapt.

24. P102: er wordt €1 miljoen uitbreiding geestelijke gezondheidszorg voorzien. Hoe worden deze middelen ingezet?

Dit wordt nog bekeken.

GB0-1GCF2LX-IS - VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)

25. P103: er komt €4 miljoen bij voor de revalidatieconventies. Gaat dit over de nodige middelen op basis van de verwachte bezettingsgraad van de revalidatieziekenhuizen?

Neen, de begroting voor de revalidatieconventies mag niet worden verward met de begroting voor de Vlaamse revalidatieziekenhuizen. De begroting voor de revalidatieziekenhuizen gebeurt op basis van de berekening van het BRZ (Budget Revalidatieziekenhuizen), dat de werkingskosten van de (acht) revalidatieziekenhuizen betaalt.

Woonzorg

26. P109: technologie en innovatie in de woonzorgsector wordt gestimuleerd. Hoe ziet men dit precies en welke budgetten staan daar tegenover?

Technologie en innovatie vormen een belangrijk onderdeel van de modernisering van de ouderenzorg. Hun inzet wordt gestimuleerd wanneer ze een duidelijke meerwaarde bieden voor de verbetering van de zorgkwaliteit, het verlichten van de werkdruk en het verhogen van de tevredenheid en levenskwaliteit van bewoners. Maar technologie blijft een middel, geen doel op zich en dient de menselijkheid van de zorg te versterken, niet te vervangen. Woonzorgcentra zijn vrij om binnen hun bestaande middelen te investeren in technologische toepassingen die zij relevant achten.

Binnen thuiszorg, en meer specifiek de diensten voor gezinszorg, zal hierop worden ingezet met het project collectieve gezinszorg en het verduurzamen van de methodiek van hybride gezinszorg.

Voor collectieve gezinszorg kan koepelorganisatie Zorggezind gedurende de periode 1 december 2023 tot en met 31 december 2026 beroep doen op een subsidie van 450.000,00 euro.

Er werden in de voorbije jaren twee opeenvolgende gefinancierde projecten (van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2023 en van 1 september 2023 tot 31 december 2024) doorlopen rond hybride gezinszorg. Op basis van de ervaringen uit de projecten, wordt verduurzaming onderzocht. Tegenover deze verduurzaming staan geen extra budgetten.

27. P109: wat is de timing van het nieuwe financieringsmodel voor de gezinszorg?

Het hervormingstraject om te komen tot een nieuw financieringsmodel is lopende. Het nieuwe financieringsmodel moet implementeerbaar zijn in 2028.

28. P109: wat betreft transparantie over de factuur voor bewoners van woonzorgcentra: op welke manier wordt gegarandeerd dat de factuur voor bewoners zal worden opgedeeld in zorg-, woon-, leef- en beheerskosten? En vanaf wanneer moeten woonzorgcentra desgevallend de woonzorgfactuur voor bewoners op deze manier opstellen?

Het is niet de doelstelling om de individuele gebruikersfactuur op te splitsen in zorg-, woon-, leef- en organisatiekosten. De gebruikersfactuur moet transparant en leesbaar blijven.

We beogen wel om via de sectorspecifieke transparante boekhouding op termijn informatie te ontsluiten die per voorziening kan geconsulteerd worden en inzicht biedt in het aandeel dat de kosten voor zorg-, woon-, leef- en organisatiekosten in de dagprijs (de factuur) van de voorzieningen representeren.

29. P110: er staat volgende “Om te waarborgen dat de door de prijzendienst goedgekeurde dagprijzen en supplementen correct worden toegepast, herzien we de formulieren die deze voorzieningen moeten indienen in het eLoket van het Departement Zorg”. Graag verduidelijking wat er precies beoogd wordt, en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

De huidige e-loket formulieren voor het melden en registreren van de dagprijsgegevens werden ontwikkeld in het kader van de zesde staatshervorming. De formulieren kunnen zowel functioneel als datamatig verbeterd en gebruiksvriendelijker worden. We denken daarbij aan het linken van elk formulier. Dit laat toe om elke evolutie van dagprijzen in het eLoket (bvb. indexatie, melding van dagprijsverhoging) telkens onmiddellijk in het formulier te toetsen aan de maximaal goedgekeurde dagprijs. Tot slot moeten de gewijzigde formulieren ook toestaan dat de meting dagprijzen niet meer afzonderlijk jaarlijks moet worden uitgevoerd maar dat op elk moment de gewogen gemiddelde dagprijs uit de formulieren kan worden opgehaald.

30. P110: er staat volgende “We werken erkennings- en financieringsvoorwaarden uit voor de Centra voor Herstelverblijf”. Bedoelt men dat de huidige erkennings- en financieringsvoorwaarden zullen worden aangepast?

Vanaf 2025 laat de regelgeving toe dat de erkende centra voor herstelverblijf kunnen gefinancierd worden (een erkenning betekent niet automatisch subsidiëring). Bij de aanpassing van de regelgeving met het oog op de invoering van een financieringssysteem voor de centra voor herstelverblijf, zijn de bestaande erkenningsvoorwaarden momenteel ongewijzigd gebleven. Op termijn worden de erkenningsvoorwaarden best verfijnd.

31. P112: er wordt 7.033keuro naar dit begrotingsartikel gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel voor thuis- en gezinszorg 'ter versterking van de preventieve en coördinerende rol van de lokale dienstencentra'. Hoe worden deze middelen ingezet?

In het kader van de uitwerking van geïntegreerde zorg en ondersteuning, werken we momenteel aan een verduurzaming van de kernelementen uit de zorgzame buurten wat moet leiden tot een vernieuwd model van de huidige lokale dienstencentra. Voor de wijzigende opdrachten zullen bijkomende middelen voorzien worden.

32. P113: het voorziene uitbreidingsbeleid wordt gereduceerd van €12 miljoen naar €10 miljoen. De besparing wordt uitgevoerd door het 'milderen' van het groeipad en 'via regelluwte en efficiënter beheer'.

- a. Welk groeipad wordt er precies gemilderd (voor welke van de sectoren die onder dit begrotingsartikel vallen) en voor welk bedrag?

Het groeipad dat wordt gemilderd, betreft het voorziene uitbreidingsbeleid voor ouderen- en gezinszorg binnen het begrotingsartikel. Het gaat specifiek om de verschillende sectoren ouderenzorg en gezins- en thuiszorg. Dit betekent dat er €10 miljoen minder wordt uitgetrokken voor uitbreidingsbeleid in de verschillende sectoren.

Op welke manier zal regelluwte en efficiënter beheer leiden tot een besparing en hoeveel moet er precies op die manier bespaard worden?

We willen inzetten op regelluwte en efficiënter beheer door overbodige en nutteloze regels te schrappen die nu tijd, mensen en/of middelen vragen. We denken bijvoorbeeld aan erkenningsnormen die te maken hebben met infrastructuur. Daarnaast wensen we meer flexibiliteit tussen erkenningen mogelijk te maken, zodat zorgaanbieders hun beschikbare capaciteit kunnen verhogen door betere bezettingsgraden en dus efficiëntieverbetering. Deze heeft m.a.w. geen rechtstreekse impact op de huidige financiering van diensten of voorzieningen maar door te combineren met regelluwte en efficiënter beheer, kan er meer ruimte komen voor andere zaken.

GB0-1GCF2VC-WT - THUIS- EN GEZINSZORG

33. P114: voor het groeipad voor de gezinszorg met 1% werd €8.797k voorzien, maar dit wordt met hetzelfde bedrag gereduceerd. Bij de uitleg staat er 'toekenning groeipad 1% niet opnemen'.

- a. Betekent dat dat het voor geen enkele thuiszorgdienst mogelijk zal zijn om het aantal uren uit te breiden in 2026?

Ja dat klopt.

- b. Op welke manier zal erop ingezet worden dat daar waar een uitbreiding van het urencontingent mogelijk is, dat ook zoveel mogelijk gerealiseerd wordt? Hoeveel groeimarge is er nog voor 2026?

Er is geen groeimarge voor 2026.

- c. Kan de prestatie-indicator van extra uren gezinszorg gehaald worden zonder groeipad?

Als er geen groei gezinszorg is, zal de indicator ook niet groeien.

34. P114: er wordt €4 miljoen bespaard op gezinszorg door de 'stopzetting van de erkenning voor diensten die de minimale invulling van het urencontingent niet halen gedurende 2 jaar op rij'.

- a. Wat was de laatste gekende budgettaire invulling van het urencontingent gezinszorg?

De laatste budgettaire invulling van het urencontingent gezinszorg dateert van 2024 en bedroeg 97,48%.

- b. Wordt er daarbij ook rekening gehouden met de achterliggende reden waarom de minimale invulling niet gehaald wordt, zoals personeelstekort?

Het betreft enkel de diensten voor gezinszorg die niet minimaal de uren van 10 VTE verzorgend personeel presteren. Dat is ook de minimale erkenningsnorm van een dienst voor gezinszorg in functie van kwaliteitsvolle en efficiënte werking. Deze diensten zullen ook de mogelijkheid krijgen om te fusioneren met een andere dienst voor gezinszorg of om hun erkenning naar een andere dienst voor gezinszorg over te dragen.

- c. Is er een mogelijkheid voorzien om de diensten die dit wel kunnen, extra uren te laten opnemen uit elders niet-ingezet urencontingent?

De huidige regelgeving ([MB 4/02/2021](#)) laat momenteel toe om onbenutte uren van een regionale stad toe te voegen aan de extra te verdelen uren gezinszorg in diezelfde regionale stad. Voor 2026 zal er, in het kader van de budgettaire context (daling subsidiabel urencontingent), een afwijkende regelgeving worden opgesteld.

35. P114: er wordt €21 miljoen bespaard op de verhoging van de efficiëntie van het urencontingent. Gaat dit over de vermindering van gelijkgestelde uren, bijvoorbeeld in het kader van wijkwerking en VAP-uren voor werknemers ouder dan 45 jaar?

De norm van de gelijkgestelde uren zal verlaagd worden.

Daarnaast zal het urencontingent gezinszorg lineair gerationaliseerd worden.

- a. Is er een berekening gemaakt van de impact die dit kan hebben op diensten voor gezinszorg met veel oudere werknemers?

De betrokken diensten voor gezinszorg zullen zodra de norm wordt overschreden, moeten voorzien in vervangende tewerkstelling om hun subsidies te behouden. Naast de middelen van de sociale maribel kunnen hiervoor de middelen werkdrukvermindering gebruikt worden.

- b. Wordt er op een andere manier voor gezorgd dat diensten voor gezinszorg voldoende mankracht kunnen inzetten met het oog op geïntegreerde zorg en afstemming?

De gelijkgestelde uren kunnen hier nog steeds voor ingezet worden. Ook het inzetten van vervangende tewerkstelling kan extra ruimte bieden. Daarnaast zetten we sterk in op vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lasten, naast automatiseren, in het nieuw financieringsmodel gezinszorg. Dit zal betekenen dat er meer ruimte komt voor kwaliteit van zorg, vooral in kwetsbare en complexe zorgsituaties vanuit een geïntegreerde en interdisciplinaire benadering.

GB0-1GCF2VX-IS - VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)

36. P115: er wordt €8 miljoen bespaard door sterker in te zetten op financiële inspectie en andere controles waaronder kappa-controles.

- a. Zijn er aanwijzingen dat ouderenvoorzieningen indicatiestellingen van de zorgzwaarte verkeerd doorgeven met het oog op het bekomen van hogere subsidies?

Er is een occasionele anomalie bij de controles. Daarnaast komt het voor dat voorzieningen de zorgzwaarte van hun bewoners zelf wijzigen op het moment dat zij een brief ontvangen dat er een controle kan plaatsvinden, om kort nadat die periode afgelopen is die zorgzwaarte opnieuw te wijzigen.

- b. Waarop is het bedrag van €8 miljoen gebaseerd?

Dit is een assumptie op basis van de som van de effecten die een aangescherpte controle zal hebben op het aantal woonzorgcentra dat hun bewoners te hoog inschaalt en woonzorgcentra die hun bewoners te laag inschalen.

37. P115: er wordt €29.3 miljoen bespaard door de basistegemoetkoming voor zorg systematisch naar omlaag bij te stellen.

- a. Zijn er projecties gemaakt wat dat betekent op het vlak van personeelsinzet? Concreet: hoeveel verpleeg – en zorgkundigen kunnen er door deze maatregel minder worden ingezet?

Het ingeschreven bedrag bedraagt €29,3 mio. Het is een aanpassing via de basistegemoetkoming Zorg. Momenteel berekent de administratie de impact per zorgvoorziening op basis van de meest recente parameters en de methodiek.

Samen met de sector wordt bekeken hoe hiernaast een interessant pakket aan maatregelen kan komen te staan rond het wegwerken van overbodige of gedetailleerde regellast en meer flexibel inzetten van personeel.

- b. Zullen de minimum personeelsnormen ook naar omlaag worden bijgesteld zodat deze gelijke tred houden met de gesubsidieerde zorg?

Er is geen wijziging aan de normen voor het zorgpersoneel gekoppeld aan de aanpassingscoëfficiënt.

- 38. P115 + P117: er wordt €8 miljoen bespaard doordat er wordt uitgegaan van een lagere zorgzwaarte. Tegelijkertijd wordt er €9 miljoen extra voorzien ihkv zorgzwaarte. Betekent dit dat er in totaal €1 miljoen wordt voorzien om te anticiperen op de toegenomen zorgzwaarte van bewoners? Is dit gebaseerd op een prognose van de zorgzwaarte in 2026?

Om de begrotingsdoelstellingen te halen werd met deze maatregel bewust gekozen voor een bijstelling - niet voor een besparing - die de woonzorgcentra niet zullen voelen. Het is een begrotingstechnische ingreep die, op basis van de cijfers uit het verleden, als erg haalbaar wordt ingeschat. Het budget voor de actualisatie werd oorspronkelijk immers te hoog ingeschat en wordt daarom voorlopig bijgesteld naar beneden.

GM0-AGCF2VD-WT – Werking en Toelagen – Sociale Bescherming – Residentiële Ouderenzorg

- 39. P117: er zijn extra middelen voor de aangroei van WZC en CVK. Gaat dit over de verwachte gebruiksnaam van nieuwe plaatsen?

Dat klopt. Dit gaat over de vereiste aangroei van het budget naar aanleiding van de uit de erkenningskalender in 2026 in gebruik te nemen woongelegenheden WZC en CVK. Ook de impact voor een volledig jaar van de in 2025 in gebruik genomen woongelegenheden zit mee in dit budget.

- 40. P118/205: het infrastructuurforfait voor de ouderen zorg wordt verhoogd met 4.174 keuro, dit owv indexering en bijkomende geplande gebruiksnaam. Zijn er nog andere middelen voorzien voor het infrastructuurforfait met het oog op het stimuleren van bijkomende infrastructuur of voor een hogere tussenkomst in de dagprijs?

Wat de capaciteit betreft, werd reeds rekening gehouden met een normale uitbreiding en vervanging. Het forfait/dag groeit enkel op basis van de index.

Opgroeien

Jeugdhulp

41. P123: er staat dat de Huizen van het Kind ‘binnen een referentieregio op verschillende locaties ook een fysiek onthaal aanbieden’. Wordt er dan afgestapt van de doelstelling om op niveau van elke eerstelijnszone een HvhK te hebben?

De doelstelling is om ervoor te zorgen dat elk gezin via het Huis van het Kind gebruik kan maken van een basisaanbod en van daaruit, indien nodig, snel en efficiënt toegang kan krijgen tot aanvullende zorg.

42. P124: de herdefiniëring van de OCJ als enige gemandateerde voorziening zal gefaseerd gebeuren zodanig dat er ook rekening kan gehouden worden met de ‘personele voorwaarden’ en het onder controle houden van de caseload. Hoeveel bijkomende VTE-personeelsleden bij de OCJ worden er beoogd om deze overgang te laten slagen en wat is het tijdspad daarnaartoe?

We grijpen de evolutie naar het OCJ als enige gemandateerde voorziening aan om een ruimere transitie van de sociale diensten, de OCJ en de toegangspoort door te voeren. Met deze transitie willen we een aantal ambities uit het regeerakkoord - vroegtijdig ingrijpen, vereenvoudiging van processen, ... - waarmaken. De exacte impact op de personeelsomkadering van de OCJ zullen we pas weten wanneer die transitie concreter uitgewerkt is.

43. P126: mbt de zin “We streven ernaar dat elke jongere die de residentiële jeugdhulp verlaat via een jaarlijks contingent aan woonsttoewijzingen een dak boven het hoofd heeft.”

a. Over welk contingent gaat dit?

Dit contingent wordt nog uitgewerkt.

b. Kadert dit binnen het sociale woonbeleid waar een deel wordt voorbehouden voor jeugdhulp-verlaters?

Dit is een maatregel bovenop de bestaande instrumenten, waarbij vooral oplossingen voor een nieuw aanbod worden aangereikt.

c. Over hoeveel woningen gaat het op jaarbasis die hiervoor nodig zijn?

Uit het registratiesysteem BinC blijkt, over het werkjaar 2024, dat er tussen 250 en 300 jongeren die uit een residentie uitstroomden een indicatie voor zelfstandig wonen hadden.

44. P126: mbt de zin “We lanceren een oproep ter uitbreiding gezinshuizen binnen de beschikbare kredieten, voor diegenen die snel kunnen opstarten en operationeel zijn.”

- a. Welke kredieten zijn er momenteel beschikbaar voor de gezinshuizen, en welke kredieten zijn er beschikbaar voor uitbreiding van de gezinshuizen?

Momenteel investeren we 4.067.100 euro in gezinshuizen via het reguliere jeugdhulpbudget. Daarnaast investeren we 570.000 euro projectmatig met middelen uit het crisis- en investeringsplan voor de drie gezinshuizen in Brussel. Het zwaartepunt van de residentiële uitbreiding, ook van de gezinshuizen ligt later in de regeerperiode.

- b. Met hoeveel plaatsen kunnen de gezinshuizen in 2026 worden uitgebreid?

We willen met de oproep inspelen op de dynamiek die vandaag in het werkveld bestaat door initiatieven die op korte termijn realiseerbaar een snel opstartperspectief te geven. De oproep moet dan ook begrepen worden als een manier om zicht te krijgen op de mogelijkheden op korte termijn. Pas nadien kan een budgettaire planning voor 2026 en volgende jaren worden opgemaakt.

45. P127: mbt de zin “We implementeren een CrisisApp die een snelle en efficiënte matching faciliteert van kinderen in crisissituaties aan een pleeggezin.”

- a. Wat staat een snelle plaatsing vandaag in de weg?

In crisissituaties moet er een snelle match gebeuren tussen een kind en een kandidaat-pleeggezin. Het kost op dit moment veel tijd om de in aanmerking komende pleeggezinnen uit de pool van crisispleeggezinnen te contacteren en in bepaalde gevallen ook over de provincie heen te zoeken naar een geschikt en beschikbaar pleeggezin. Pleeggezinnen zijn ook vragende partij om zelf nog meer inspraak te hebben bij de matching.

- b. Wat zal een nieuwe app bijdragen aan de huidige werking?

Een crisisapp waar pleeggezinnen zelf meer regie krijgen in functie van de matching, waar ze zelf kunnen aangeven wanneer ze al dan niet beschikbaar zijn als pleeggezin, zal het proces van matching in crisissituaties versnellen. De pool aan geschikte crisispleeggezinnen zal transparanter zijn en ons helpen om in crisissituaties sneller een geschikt pleeggezin te vinden.

46. P127: mbt de zin “We versterken de leefgroep-werkingen met bijzondere aandacht voor leefgroep-grootte en voorkomen van exclusiecriteria.” Betekent dit dat er zal geïnvesteerd worden in kleinere leefgroepen? Zijn er streefcijfers voor de begeleider-kind/jongere ratio?

Een versterking van het residentieel aanbod kadert in de ambitie om huidige erkende capaciteit ten volle en kwalitatief in te zetten. Investerings moeten een positieve impact hebben op de leefgroep grootte, alsook op de begeleider-kind/jongere ratio. Concrete streefcijfers zijn nog niet voorhanden.

GB0-1GEF2MX-IS - OPGROEIEN REGIE

47. P133: er is €11.104k voorzien als ‘kostendrijver pleegzorg’. Waar bestaat deze meerkost precies uit?

De regelgeving bepaalt dat de financiering het effectieve aantal pleegzorgsituaties volgt. Deze meerkost betreft de begeleidingskost van de bijkomende pleegzorgsituaties en onkostenvergoedingen voor de pleeggezinnen.

Geïntegreerd gezinsbeleid

48. P139: er wordt verwezen naar een 'Kennis- en Innovatiecentrum' dat leermiddelen zal ontwikkelen voor kinderen waarvoor de thuistaal niet het Nederlands is.
- Wat is de timing voor de oprichting hiervan?
 - Hoeveel middelen worden hier vanuit beleidsdomein WVG aan besteed?
 - Welke andere beleidsdomeinen dragen hieraan bij?

We willen de regelgevende basis voor dit Kennis- en innovatiecentrum in het voorjaar van 2026 goedgekeurd hebben. De bestaande budgetten die hier nu al voor ingezet worden ten aanzien van verschillende ondersteuningspartners worden hiervoor geheroriënteerd. Door deze bestaande budgetten te bundelen bekomen we efficiëntiewinsten. Er wordt geen nieuw budget voorzien

49. P139: wat is de timing voor het nieuwe erkennings- en financieringskader voor de Overkop-huizen?

We voorzien een gefaseerde aanpak: we continueren de huidige investeringen, incl. tijdelijke en projectmatige middelen voor psycho-educatie, vanaf 1 januari 2026. Het nieuwe kader voor de erkenning en financiering zal in werking treden vanaf januari 2027.

50. P141: er wordt voorzien dat 600 T1-plaatsen kunnen overschakelen naar T2. Op welke manier gebeurt de selectie van deze 600 plaatsen en wat is de timing hiervoor?

De modaliteiten voor deze oproep moeten nog worden vastgelegd.

GB0-1GEF2UX-IS - OPGROEIEN REGIE

51. P147: er wordt €10 miljoen ingezet uit resterend VEK-uitbreidingsbeleid BO2024 mbt de verlaging van de ratio in de kinderopvang. Op welke manier wordt deze €10 miljoen ingezet?

Deze 10 mio euro is de te verwachten toename van de subsidies als voor alle plaatsen de verlaagde ratio per plaats behaald wordt.

GDF-BGEFAUA-OW - Ontvangsten werking en toelagen

52. P147: er wordt €11.1 miljoen extra inkomsten geraamd tov de BA2025 oww een verhoging van de ouderbijdragen in de kinderopvang. Het gaat om een aanpassing van het aantal prestatiedagen en de gemiddelde ouderbijdrage.

- a. Verwijst deze aanpassing van de ouderbijdrage naar de hervorming van de kindkorting ten belope van €10 miljoen?

Zowel bij BA2025 als bij BO2026 wordt er rekening gehouden met 10 mio euro extra aan ouderbijdragen door wijziging regelgeving mbt kindkorting. In 2025 realiseren we deze 10 mio euro echter niet, in 2026 wel. Maar dat betekent dat dus dat we zowel bij BA2025 als bij BO2026 hetzelfde bedrag inschrijven voor kindkorting.

De delta van 11 mio euro is dus niet het gevolg hiervan. De gestegen gemiddelde ouderbijdrage heeft te maken met indexering.

- b. Verwijst het aantal prestatiedagen naar een verwachte toename van het gebruik van kinderopvang?

Dat gaat vooral over bijkomende plaatsen met Trap 2-subsidie, waardoor het verwachte aantal prestatiedagen ook zal stijgen.

Groeipakket

- 53. P150: in 2026 wordt de toegang tot de sociale toeslag hervormd, met een meer geleidelijke uitfasering van de inkomensgrenzen. Dat nieuwe systeem zou al worden toegepast op nieuwe instroom vanaf 1 januari 2026. Hoe kan dit systeem al vanaf 1/1/2026 worden toegepast wanneer het technisch traject nog moet gelopen worden? Of wordt bedoeld 'met terugwerkende kracht', zodat gezinnen die vanaf ten vroegste 1/1/2026 een sociale toeslag ontvangen, later zullen overstappen naar het nieuwe systeem?

De nieuwe instroom of de personen die recht hebben op sociale toeslag op basis van inkomensgegevens van aanslagjaar 2026 heeft uitwerking vanaf september 2028. Aanslagbiljet inkomsten 2026 wordt in 2028 gebruikt om te bepalen wie recht heeft op een sociale toeslag vanaf september 2028 (= nieuw toekenningsjaar). Het systeem waarbij men werkt met inkomensgegevens van twee jaar eerder (T-2) wordt nu al toegepast omdat dit de meest recente door de FOD Financiën gevalideerde (en stabiele) gegevens zijn waarover we kunnen beschikken.

GB0-1GEF2QY-IS - VUTG

- 54. P155: er wordt €1.5 miljoen bespaard op de werkingsenveloppe van de private uitbetalingsactoren. Dit onder de noemer 'efficiënter inzetten van overheidsmiddelen'.

- a. Is er een gelijkaardige besparing onder een ander begrotingselement dat betrekking heeft op de publieke uitbetalingsactor?

Neen.

- b. Is er een analyse gemaakt van de huidige efficiëntie van de uitbetalingsactoren, bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal

groeipakketdossiers die door de verschillende uitbetalingsactoren (privaat en publiek) behandeld worden naargelang de ingezette middelen?

Neen, deze efficiëntiemaatregel is een punctuele maatregel beslist door de Vlaamse Regering.

Personen met een handicap

55. P166: er staat dat de acties ihkv de uitvoering van de conceptnota 'projectmatig' worden aangepakt. Kan er een overzicht gegeven worden van deze projecten en welke experts of stakeholders daarbij betrokken zijn?

Om uitvoering te geven aan de acties uit de conceptnota heeft het VAPH een programma Hervormingen met 15 onderliggende projecten gedefinieerd:

1. Bepalen zorgniveau en vraagverheldering
2. Handicapspecifieke zorg en ondersteuning
3. Zorgniveau 1
4. Instrumenten toeleiding minder- en meerderjarigen
5. Hervormen toeleiding minderjarigen (PAB, MFC, IMB)
6. Nieuw model voor zorg en ondersteuning minderjarigen met een handicap
7. Hervormen toeleiding meerderjarigen
8. Hervormen procedure herinschaling
9. Hervormen besteding i.h.k.v. geïntegreerde zorg
10. Erkennen en financieren i.h.k.v. geïntegreerde zorg
11. Programmatie, planning, bemiddeling en afstemming i.h.k.v. geïntegreerde zorg
12. Intermediaire organisaties in het nieuwe systeem
13. Zorgniveau 3
14. Budget en monitoring
15. Eén erkenning handicap

In elk van die 15 projecten worden experts ingeschakeld. Experts kunnen ervaringsdeskundigen, (vertegenwoordigers van) gebruikers, aanbieders en koepels, intermediaire organisaties, wetenschappers, collega's van andere entiteiten ... zijn. Naargelang de inhoud en het tijdsbestek van elk specifiek project wordt bepaald op welke manier de experts ingezet zullen worden. Dat kan via bilaterale gesprekken of groepsgesprekken, aan de hand van bevestigingen, focusgroepen, thematische besprekingen, deelname aan het projectteam.

56. P167: met betrekking tot de passage "We passen het huidige instrumentarium aan dat wordt gebruikt voor het bepalen van het persoonlijke assistentiebudget (PAB) in functie van een geactualiseerde en ruimere zorgzwaartebepaling. Dit instrument zullen we gebruiken om de zorg en ondersteuning voor minderjarigen

met een handicap op maat te kunnen vaststellen en realiseren, ongeacht de keuze voor PAB of Multifunctioneel centrum. We zorgen ervoor dat dit instrument afgestemd wordt met andere instrumenten die gebruikt worden voor kinderen en jongeren.”

- a. In welke zin zal de zorgzwaartebepaling verruimd worden?
- b. Zal een ruimere zorgzwaartebepaling leiden tot een hoger PAB-budgetniveau?
- c. Is het de bedoeling dat de zorgzwaartebepaling voor elk kind dat toegang wil hebben tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (PAB/MFC) op dezelfde manier zal gebeuren?
- d. Met welke ‘andere instrumenten die gebruikt worden voor kinderen en jongeren’ zal dit instrument worden afgestemd?

Er is overleg met o.a. Opgroeien en er wordt gewerkt met een technische werkgroep die de diverse instrumenten in kaart brengt. Een ruimere zorgzwaartebepaling betekent dat er een breder zicht komt op de ondersteuningsnoden ten opzichte van het PAB-instrument zou kunnen meten, om zo een meer accuraat beeld te geven. Of dit zal leiden tot een hoger of lager budgetniveau kunnen we nog niet stellen. Het is onze betrachting om deze methodiek te gebruiken zowel in kader van toegang tot een MFC als tot een PAV.

57. P191: wat betreft de vermelding “Het VAPH erkent en subsidieert voorzieningen om ondersteuning te bieden aan personen die door het VAPH erkend zijn als een persoon met een handicap, of aan personen met een vermoeden van handicap, die in de gevangenis verblijven als gedetineerde of als geïnterneerde.”

- a. Welke zijn de organisaties die ondersteuning bieden aan personen met een (vermoeden van) handicap die in de gevangenis verblijven?
- b. In welke gevangenissen wordt er door deze voorzieningen ondersteuning geboden?
- c. Zijn er ook gevangenissen waar er momenteel nog geen ondersteuningsaanbod is voor mensen met een (vermoeden van) een handicap?
- d. Hoeveel middelen gaan er naar deze organisaties voor de ondersteuning in de gevangenis?

VZA	Project	Gevangenis	Personeelspunten
Klavier	ABAGG	Merksplas, Turnhout, Wortel Hoogstraten	752 punten
OLO-Rotonde	Otwee	Arresthuis Antwerpen	179 punten
Voluit	Ontgrendeld	Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Beveren	716 punten
Sint-Ferdinand	De Schakel	Gevangenis Hasselt	154 punten
Sint-Idesbald	Itinera	Penitentiair Complex Brugge,	250 punten

		Gevangenis Ieper, Penitentiair landbouwcentrum Ruiselede, Detentiehuis Kortrijk	
Staf	Radar 3000	Leuven Hulp, Leuven Centraal	250 punten
Hubbie	Morpho	Gevangenis Sint-Gillis, Gevangenis Haren, Detentiehuis Vorst	232 punten

Als we kijken naar de gevangnissen in Vlaanderen en Brussel, is er geen ondersteuningsaanbod in de gevangnissen Mechelen, Olen en Tongeren en in de hulpgevangenis van Dendermonde.

In totaal zijn er voor alle erkende projecten 2.533 personeelspunten voorzien. Er wordt daarnaast een werkingstoelage van 89 euro per personeelspunt voorzien. In totaal komt dit op 225.437 euro. Een raming van het totale aantal middelen voorzien voor deze projecten komt op 3.172.000 euro.

58. P191: wat betreft de zorg aan geïnterneerden die niet in de gevangenis verblijven: bestaat er een overzicht van de voorzieningen voor personen met een handicap waar geïnterneerden verblijven? Hoeveel personen met een profiel geïnterneerde worden opgevangen in voorzieningen voor personen met een handicap?

Binnen de VAPH-sector hebben we een specifiek aanbod voor geïnterneerden in 3 erkende forensische VAPH-units. Daarnaast is er een aanbod lage beveiliging bij de reguliere VAPH-voorzieningen via de directe financiering geïnterneerden. Op 30 juni 2025 waren 74 voorzieningen in Vlaanderen hiervoor geregistreerd.

Op 30 juni 2025 waren er in totaal 84 geïnterneerden in begeleiding bij deze voorzieningen via de directe financiering geïnterneerden en 50 geïnterneerden hadden een begeleidingsovereenkomst in een forensische VAPH-unit.

Bijkomend zijn er nog geïnterneerde PVB-budgethouders die in onze voorzieningen begeleid en ondersteund worden, maar waar we geen cijfers kunnen van kunnen meegeven aangezien we het forensisch statuut van de PVB-budgethouders niet bijhouden.

GH0-AGGF2RD-WT FINANCIERING VAN NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

59. P193: er wordt €9.255 miljoen extra VAK voorzien op uitbreidingsbeleid PVB. Dit is een anticipatie op de voorziene onderbenutting van het uitbreidingsbeleid voor automatische toekenningen en prioriteitengroep 1. De extra middelen zullen ook voor deze doelgroepen worden ingezet. Echter, het voorziene uitbreidingsbeleid

van €46,5 miljoen was gebaseerd op prognoses omtrent het aantal AT + PG1.
Betekent dit dat deze prognoses een onderschatting waren?

In de prognoses werd reeds rekening gehouden met de te verwachten benutting. Het verhoogde VAK is nodig om de effectief benodigde middelen VEK correct te kunnen aanrekenen. Dit houdt niet enkel rekening met de onderbenutting, maar bevat tevens een 'technisch VAK' om toe te laten dat alle potentiële kosten die ingediend worden in MijnVAPH effectief correct kunnen aangerekend worden in Orafin (het financieel systeem van de Vlaamse overheid). Het gaat onder meer over potentiële bijkomende VIA-kost bij cash besteding verhoging van het budget bij teruggevorderde bedragen.

GH0-AGGF2RE-WT FINANCIERINGEN VAN ONDERSTEUNENDE EN INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

60. P197: hoeveel bedragen de kosten voor de uitgifte van de European Disability Card en hoe worden die middelen precies ingezet?

De financiële bijdrage voor de aanmaak en afgifte van de EDC-kaart bedroeg in 2024 93.739,78 euro voor Vlaanderen. Het VAPH betaalde deze factuur in 2025. De factuur voor 2025 kan pas opgesteld worden in 2026 zodra duidelijk is hoeveel kaarten in 2025 werden uitgereikt. De kosten voor de EDC worden volledig ingezet voor de productie van de kaarten zelf. De verdeling van deze kosten gebeurt op basis van een protocolakkoord waarin volgende verdeelsleutel werd vastgelegd: "iedere deelnemende instelling betaalt het aantal kaarten volgens de uitreiking (aantal erkenningen (bij automatische toekenning vanaf 01/01/2024) of het aantal aanvragen (bij niet-automatische toekenning)).

Sociale Bescherming

GB0-1GHF2TX-IS - VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)

61. P205: dit begrotingsartikel verwijst naar de toelage aan het agentschap VSB voor de VSB-pijlers zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, zorgbudget ouderen met een zorgnood, en zorgbudget personen met een handicap. Kan worden toegelicht waarom er op dit begrotingsartikel tal van compensaties staan die niets te maken hebben met de zorgbudgetten? Bijvoorbeeld een compensatie vanuit VAPH ikv overdracht aanpassingen op manuele rolstoelen, indexering infrastructuurforfait, herinzet vrijgekomen PVT-middelen, enz.

Tijdens de opmaak van de begroting voor 2026 werden alle compensaties en bijstellingen gecentraliseerd op één artikelcode. Deze keuze werd gemaakt omdat dit de meest praktische en efficiënte manier van werken was om het overzicht te bewaren tijdens het begrotingsproces. Nadat alle wijzigingen en compensaties waren verwerkt, zijn de kredieten in totaliteit verdeeld over de verschillende toelage-artikels (zie hieronder), zodat de middelen correct en transparant konden worden toegewezen.

- GB0-1GCF2VX-IS (mobiliteitshulpmiddelen, ouderenzorg en infrastructuurforfait ouderenzorg);
- GB0-1GCF2LX-IS (revalidatieziekenhuizen, revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen);
- GB0-1GCF2KX-IS (multidisciplinair overleg (MDO) en multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE));
- GB0-1GHF2WX-IS (Algemeen beleid VSB).

62. P206: omwille van een hogere zorgpremie daalt de toelage aan VSB met €135 miljoen. De zorgpremie was aanvankelijk bedoeld voor de financiering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. De verwachte uitgave voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden staat onder begrotingsartikel GM0-AGHF2TC-WT en bedraagt 460.083 keuro in VAK en VEK. In de algemene toelichting staat dat de eigen ontvangsten voor de zorgpremie stijging tot 432,5 miljoen euro.

- Is het correct om te concluderen dat het aandeel van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dat niet gefinancierd kan worden met de zorgpremie, en waarvoor algemene middelen worden gebruikt, €27.6 miljoen bedraagt?

Neen, want er is ook nog een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro aan inkomsten uit de administratieve geldboetes, inclusief achterstallige premies, dit na aftrek van de kosten voor inning. Dit betekent dus dat ongeveer 14 miljoen euro uit algemene middelen wordt gebruikt voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

63. P212: wat betreft de ontwikkeling van het zorgprognose-instrument:

- Waar verwijst begrotingsartikel GM0-AGHF2WA-WT naar?

GM0-AGHF2WA-WT = Werking en toelagen – Algemeen Beleid: algemene werkingskosten agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

- Hoeveel middelen zijn er voorzien voor de ontwikkeling van dit instrument?

Het zorgprognoseproject bevindt zich momenteel in een conceptuele fase waarin een wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar welke data relevant zijn voor de inschatting van de evolutie van de zorgnood. In 2026 is hiervoor een budget van 81.795 euro beschikbaar dat reeds werd voorzien in 2025.

- Het instrument zal pas klaar zijn in 2029. Welke tussenstappen zijn er voorzien, hoe ziet de timing eruit voor dit proces, en wat wordt er in 2026 gedaan ifv de ontwikkeling van dit instrument?

Het project verloopt in 2 grote fasen. In een eerste fase wordt in 2026 een technische startversie voor het zorgprognosemodel ontwikkeld. Vervolgens zal in een tweede fase, tegen 2029, het eigenlijke zorgprognosemodel ontwikkeld worden.

Zorginfrastructuur

ISE Zorginfrastructuur

64. P220: wat betreft de passage “Om voorzieningen met reële investeringsnoden in een context van beperkte overheidssubsidies toch te helpen om hun financieel plan voor een nieuwbouw- of renovatieproject of emissiebeperkende investering rond te krijgen, ontwikkelen we een Rollend Welzijnsfonds door het activeren en inzetten van de reserves binnen de Vlaamse Sociale Bescherming.”

a. Is dit Rollend Welzijnsfonds iets nieuw op te richten?

We evalueren de uitvoering van de bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 december 2018 betreffende de financiering van de welzijnssector uit Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VR 2018 2112 DOC.1640/1BIS).

b. Welke reserves zijn er binnen de VSB die kunnen geactiveerd worden?

Bij de oprichting van de IVA Vlaams Zorgfonds n.a.v. de oprichting van de Vlaamse zorgverzekering (de voorloper van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming) heeft de Vlaamse regering een reservefonds opgericht. Dit fonds werd tussen 1999 en 2008 gespijsd met jaarlijkse dotaties, extra dotaties en de kapitalisatie van beleggingsopbrengsten. Sinds 2009 heeft de Vlaamse regering geen (extra) dotaties meer gedaan aan het reservefonds en wordt de beleggingsopbrengst niet meer gekapitaliseerd maar gebruikt voor de financiering van de uitgaven. Meer over dit reservefonds en de huidige beleggingen vindt u in het jaarverslag van het agentschap onder ‘3.6 Vermogensbeheer’.

c. Waar zijn deze reserves van afkomstig en over welk bedrag gaat het?

Zie hierboven.

d. Welke voorzieningen zullen hiervan gebruik kunnen maken? Worden deze middelen uit reserves toegevoegd aan VIPA?

De middelen blijven deel uitmaken van het reservefonds van het Agentschap VSB. De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën voorziet dat het reservefonds ten belope van maximaal de helft van de middelen kan aanwenden voor specifieke noden van de Welzijnssector. Vandaag worden daarmee reeds rentedragende leningen gefinancierd i.k.v. infrastructuurprojecten van de welzijnssector (zie jaarverslag AVSB titel 3.6.4.5) en renteloze leningen i.k.v. energiemaatregelen (zie jaarverslag AVSB titel 3.6.4.6).

Apparaatskredieten

GD0-1GAF2ZZ-LO – LONEN

65. P237: er wordt €1.202 miljoen uitbreiding voorzien voor jeugdhulp, specifiek voor de structurele financiering van consultants binnen Opgroeien Regie. Over hoeveel consultants gaat dit en wat is hun taakstelling?

Deze 1,2 mio euro is nodig ter financiering van de 33 consultants waarvoor bij BO2024 het budget éénmalig en nog niet structureel werd toegekend. In 2025 werd de helft hiervan structureel gemaakt, nu ook de laatste helft van deze 33 consultants.

Technische vragen BBT WVGA – Groen

Algemeen

- Wordt er een opvolger voorzien voor de Green Deal duurzame zorg?

De Green Deal Duurzame Zorg loopt nog tot eind 2026. Momenteel is er dus nog geen beslissing genomen. Tijdens de looptijd wordt bekeken wat de impact van dit initiatief is, waar er nog nood aan is en welke andere initiatieven er lopen. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers en de sectorvertegenwoordigers.

- Welk specifiek budget is er voorzien voor het eenzaamheidsplan 2026-2029? Wanneer zal het plan af zijn en waarom is niet toegewerkt naar de datum van 1 januari 2026 om het plan te laten ingaan.

Er is geen specifiek budget voorzien voor het Vlaamse eenzaamheidsplan 2026 – 2029. Omwille het opnemen van de resultaten uit wetenschappelijke studies, de afstemming met andere plannen en om te vermijden dat dezelfde acties in meerdere beleidsdomeinoverschrijdende plannen zouden worden opgenomen, werd de timing aangepast. Op die manier realiseren we sterk onderbouwd plan met meer (meetbare) impact.

- In verschillende rubrieken duikt de bewuste zin 'Activering van de opgebouwde reserves. Kader uit te werken' op: op welke termijn wil u dit laten ingaan? Zijn hier decretale wijzigingen voor nodig? Bent u in overleg met de verschillende sectoren hierover? Is dit een eenmalige maatregel? Kan u per deelsector de vooropgestelde regeling schetsen?

Zie het antwoord op vraag 1.

- Bestaan er ramingen van de budgettaire impact van een volgend VIA-akkoord? Wat is het stappenplan en de timing om tot een VIA te komen?

Er zijn nog geen ramingen gemaakt voor een volgend VIA-akkoord. De besprekingen moeten nog starten. Er is wel sociaal overleg. De traditie schrijft voor dat het budget voor nieuwe sociale akkoorden voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de VIA-sectoren samen bepaald wordt en afhankelijk is van de budgettaire mogelijkheden.

- Begrotingsartikel GDF-AGEF2UA-LO en begrotingsartikel GDF-AGEF2UA-WT
 - Adoptiebeleid - p.144 ev
 - *De afgelopen jaren is ook onze blik op adoptie sterk gewijzigd. Zo pleit het rapport van de experten die door de Vlaamse Regering werden aangesteld onder meer voor een sterkere verbinding tussen pleegzorg en adoptie vanuit het perspectief van meerouderschap. Verder bouwend op het werk van een werkgroep en wetenschappelijk onderzoek, implementeren we het theoretische raamwerk voor een gezamenlijk voortraject ‘pleegzorg – adoptie’ in regelgeving en praktijk, zodat de eerste kandidaten vanaf 2027 kunnen worden voorbereid en gescreend. Daartoe voeren we de nodige aanpassingen door aan de sectorale regelgeving van zowel pleegzorg als adoptie. **In één enkele beweging zorgen we ervoor dat het regelgevend kader houdende de organisatie en bemiddeling bij interlandelijke adoptie wordt afgestemd op de meest recente inzichten en ontwikkelingen.***

Het ‘nieuwe’ decreet over de organisatie en bemiddeling bij interlandelijke adoptie dat eind vorige legislatuur werd gestemd, moet sowieso gewijzigd worden om uitvoering te kunnen geven aan het gezamenlijk voortraject pleegzorg – adoptie. Geadopteerden, maar ook rapporten over wantoestanden in het verre en recente verleden, formuleren heel wat bezorgdheden. We zullen dit bijgevolg kritisch bekijken, inclusief een grondige evaluatie van het legistiek kader en bijhorende praktijk zoals voorzien in het Regeerakkoord.

Omtrent het uitbreidingsbeleid:

- Kan u mij een overzichtstabel bezorgen van het uitbreidingsbeleid per sector, kinderopvang, personen met een handicap, jeugdzorg, VIPA, ouderenzorg en gezinszorg en de reële uitgegeven en geplande bedragen in BA 2025 en BO 2026, alsook de projecties voor de komende jaren tot het einde van de legislatuur.

Ter inspiratie de eigen tabel van de Vlaamse regering uit het centenblaadje voor 2024.

3.2 WARM VLAANDEREN

	2025	2026	2027	2028	2029
Personen met een handicap	102	159	231	320	478
Kinderopvang	100	100	100	150	200
Ouderenzorg en gezinszorg	12	24	40	80	140
Jeugdhulp	10	20	50	70	120
Buitenschoolse kinderopvang en activiteiten	80	80	80	80	80
Geestelijke gezondheidszorg	0	10	20	25	25
Preventie	10	10	10	10	10
Jeugddelinquentie	5	15	20	20	20
Totaal	319	418	551	755	1.073

Maatregel	2025	Delta 2	2026	Delta 2	2027	Delta 2	2028	Delta 2	2029
Gezonde voeding	23.333	13.167	36.500	33.500	70.000	0	70.000	0	70.000
Handicap Wachtlijst PG1	52.400	46.500	98.900	62.000	160.900	50.000	210.900	67.200	278.100
Buitenschoolse opvang	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
Kinderopvang	100.000	0	100.000	0	100.000	50.000	150.000	50.000	200.000
Jeugdhulp	10.000	3.000	13.000	37.000	50.000	20.000	70.000	50.000	120.000
Ouderenzorg en gezinszorg	12.000	2.000	14.000	16.000	30.000	40.000	70.000	60.000	130.000
Hervormen personen met een handicap	50.000	0	50.000	20.000	70.000	30.000	100.000	100.000	200.000
Zorginfrastructuur Forfaits	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Zorginfrastructuur klassieke	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000
Geestelijke gezondheidszorg	0	1.000	1.000	19.000	20.000	5.000	25.000	0	25.000
Welzijn - preventie	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	337.733	65.667	403.400	187.500	590.900	205.000	795.900	397.200	1.193.100

In duizend euro. Uitbreidingsbeleid jeugddelinquentie wordt vanaf 2026 opgenomen bij het Agentschap Justitie en Handhaving.

Het deel ARMOEDE

De koppeling van subsidies aan de hoogte van reserves bij welzijnsorganisaties.
(Art. 162 - programmadecreet)

*Voor subsidies die binnen de begroting welzijn, volksgezondheid en gezin van de Vlaamse Gemeenschap worden verstrekt, kan de subsidieverstrekker de omvang van de subsidie bijstellen in functie van de reserves die de ontvanger van de subsidie in de tien jaren die vooraf gaan aan de subsidiebeslissing heeft opgebouwd met subsidies die zijn verstrekt ten laste van de begroting welzijn, volksgezondheid en gezin van de Vlaamse Gemeenschap. **De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en voorwaarden waaronder dat gebeurt.** In het eerste lid wordt verstaan onder begroting welzijn, volksgezondheid en gezin van de Vlaamse Gemeenschap:*

1° Voor begrotingen tot en met 2025: de programmacodes GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH en GI;

2° Voor begrotingen vanaf 2026: de programmacodes GA, GB, GC, GE, GG, GH en GI.

Dit werpt heel wat vragen en bezorgdheden op.

- Hoe moeten we dit artikel begrijpen?
- Hoe wordt er gekeken naar private giften in die reserves die het middenveld (probeert) aan te leggen?
- Hoe zal dit het middenveld mogelijk verder aan banden leggen?

Zie het antwoord op vraag 1.

De Meerjarenraming 2025 - 2030

- Ik refereer naar de meerjarenraming 2025 - 2030, deel 2.2.3. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, pp. 35-36 over het groeipakket. Het VAK en VEK voor GB0-1GEF2QX-IS en GB0-1GEF2QY-IS voor BO 2026 bedraagt samengeteld 4.961.797 keuro. Kan u duiden wat bedoeld wordt met "Deze rechten zorgen voor een cumulatieve stijging van de uitgaven binnen het Groeipakket van 45,1 miljoen euro VAK en VEK in 2030 ten opzichte van 2026." en "Tussen het moment waarop er recht op Groeipakket ontstaat en de toekenning ervan kan er door allerlei redenen een vertraging optreden, wat leidt tot een regularisatie (12,6 miljoen euro VAK en VEK in 2030)." Is de verwachte toename van de uitgaven van het groeipakket beperkt met 45,1 miljoen euro + 12,6 miljoen euro? Of interpreteer ik dit foutief?

De verwachte toename van de uitgaven Groeipakket is groter dan de 45,1 miljoen euro + 12,6 miljoen euro:

- De 45,1 miljoen euro verwijst naar de evolutie van de uitgaven voor gezinsbijslagen, maar de evolutie is uitgedrukt op prijsniveau 2019. Dit wil zeggen dat in deze evolutie de jaarlijkse indexeringskost niet is meegenomen. In 2030 wordt dus verwacht dat de gezinsbijslagen die in een bepaald jaar ontstaan en in datzelfde jaar nog worden toegekend 45,1 miljoen euro hoger zullen liggen dan in 2026 (uitgedrukt op prijsniveau 2019 en dus exclusief indexeringskost).
- De 12,6 miljoen euro heeft betrekking op retroactieve bijpassingen die nog gebeuren, de zogenaamde regularisaties. Er zijn ook gezinsbijslagen waarvan door omstandigheden de rechten retroactief worden toegekend. Deze rechten worden geraamd om in 2030 12,6 miljoen euro hoger te liggen dan in 2026.

Zoals aangegeven, is in bovenstaande evolutie het effect van de jaarlijkse indexering niet meegenomen. De jaarlijkse indexering bedraagt minimum 2% per jaar en zal ervoor zorgen dat in 2030 de uitgaven voor het hele Groeipakket bijna 0,5 miljard hoger zullen liggen dan in 2026.

Technische vragen BBT WVGA – N-VA

IV Overkoepelende strategische doelstellingen

- P13: “Mentale gezondheid krijgt hierin een prominente plaats.”
 - Welke middelen zijn daar aan verbonden? Wat is de aard van die middelen? Binnen welke periode worden ze voorzien besteed te worden?
 - Hoe zal de doeltreffendheid van beleid gemeten worden?

Momenteel zijn de oproepen voor de nieuwe beheersovereenkomsten in het kader van preventieve gezondheidszorg in volle voorbereiding en worden deze na goedkeuring IF volgende maand bekend gemaakt. Mijn ambitie is alvast om hierbij in te zetten op mentale gezondheid.

- P13: “We hebben daarnaast specifieke aandacht voor mensen met een handicap, kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Om daartoe te komen zullen er niet alleen investeringen, maar ook hervormingen nodig zijn.”
 - Hoe zal dit concreet vertaald worden in acties en middelen?

Meer middelen dienen te gaan naar de begeleiding van de grote groep van personen met dementie die thuis verblijft, alsook naar de ondersteuning van mantelzorgers en de efficiënte inzet van de partnerorganisaties. Dit kan meerdere vormen aannemen: investering in referentierol dementie binnen de thuiszorg, uitbouw van ergotherapeutische begeleiding en aandacht voor woonaanpassingen, versterking rol LDC's, sterkere intersectorale samenwerking en interfederale samenwerking in het kader van het programma kwetsbare personen.

- P14: “In nauw overleg met gebruikers, het werkveld en stakeholders werken we stapsgewijs de vooropgestelde beleidsaspecten uit om het nieuwe beleid en de reorganisatie gefaseerd te implementeren de komende jaren.”
 - Werd al voorzien welke deze fasen zouden zijn en is voorzien binnen welke timing de fasen aangevat en volbracht moeten worden?

We verwijzen hier naar de goedgekeurde conceptnota, het overleg in kader van geïntegreerde zorg en de opmaak van perspectiefplan 2040 om tot meer gedeelde verantwoordelijkheid te komen over beleidsdomeinen en sectoren heen.

- P14: “In 2026 zullen we de eerste regelgevingsinitiatieven voor administratieve vereenvoudiging doorvoeren.”
 - Hoe zal dit concreet gebeuren en welke middelen zijn eraan verbonden? Over welke initiatieven gaat het?

De aanpassingen ter vereenvoudiging van administratieve processen zijn inhoudelijk uitgewerkt. De juridische vertaling daarvan is momenteel bezig. In de eerste jaarhelft

van 2026 zou de besluitvorming daarrond binnen de Vlaamse Regering afgerond moeten zijn.

- P14: “Indien we een significant verschil willen maken op het vlak van de administratieve lasten moeten we de invulling van de rollen en vooral de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren – privaat initiatief, administratieve en politieke overheid – verscherpen. We nemen hiertoe de nodige initiatieven.”
 - Wat wordt hier concreet mee beoogd? Wat is de timing en werkwijze?

Het verlichten van administratieve lasten beoogt o.a. voorzieningen en personeel meer ruimte en autonomie te geven om doelgerichter te werken. Kwaliteit van zorg staat daarbij altijd voorop. Meer autonomie mag daarom niet leiden tot minder transparantie voor de zorggebruiker. Doelregelgeving is daarom geen doel op zich en gaat samen met duidelijke verantwoordelijkheden t.a.v. de te leveren zorg en voor de overheid een duidelijk kader voor het toezicht daarop. Binnen het traject Regelrecht komen de verschillende perspectieven samen (voorzieningen, personeel, zorggebruikers en overheid) en werken we aan een evenwicht.

- P15: “We experimenteren met 1 zorg- en welzijnserkenning binnen het beleidsdomein WVG en stimuleren samenwerking om zorg en ondersteuning op maat en zorgcontinuïteit in de buurt te verbeteren.”
 - Hoe zal dit concreet in de praktijk vertaald worden? Welke impact zal dit hebben op de huidige erkenningen? Aan welke parameters zal deze erkenning moeten voldoen?

In het traject ToekomstZorg zullen we innovatieve piloten toestaan voor intersectorale samenwerking. We voorzien een innovatieruimte waarbinnen in een regelluw kader kan worden gepiloteerd. Eén van de projectoproepen zal specifiek oproepen tot 1 erkenning.

- P15: “Er komt 1 uitbetalingsactor voor het Groeipakket”
 - Wat is hier het voorziene traject en de timing? Wat zijn hier nog de voornaamste drempels?

Alvorens te komen tot 1 uitbetalingsactor dient er eerst geëvalueerd te worden zoals bepaald in het decreet. Die evaluatie is gestart op 1 juli van dit jaar. In de komende weken wordt zij afgerond. Daarna kan aan de besluitvorming worden begonnen. Er zijn twee voornaamste uitdagingen/drempels:

- De burger mag geen effect voelen van deze transitie.
- Een zorgzame transitie realiseren voor de medewerkers van de uitbetalingsactoren, gericht op de validering van hun expertise en continuïteit van de betalingen.

P15: “Er komt een verscherpt toezicht op de naleving van financiële regelgeving en een meer doelmatige aanwending van publieke middelen.”

- Hoe zal dit concreet in zijn werk gaan? Via extra inspecties of een ander type inspecties?

De voorbije tijd werden bijkomende financiële inspecteurs aangeworven voor het betrokken inspectieteam. Daardoor worden er geleidelijk aan, en afhankelijk van de mate waarin deze nieuwe inspecteurs ingewerkt zijn, meer inspecties uitgevoerd.

- Wat is de periodiciteit van nazicht?

Momenteel is er geen vaste periodiciteit. WVG is een breed beleidsdomein, met meer dan 4.000 inrichtende machten. Het toezicht gebeurt enerzijds op basis van:

- 1) financiële indicatoren die binnen Zorginspectie opgevolgd worden en
- 2) indicaties vanuit de bevoegde entiteiten.

Anderzijds vinden er financiële inspectierondes plaats waarbij een (deel van een) sector geïnspecteerd wordt.

- Welk budget voorziet de minister hiermee meer te mobiliseren?

Indien er mobilisatie van budget zou kunnen gerealiseerd worden, zal dit steeds fluctueren. Het is dan ook op dit moment niet mogelijk om hierover een gefundeerde uitspraak te doen.

- Hoe zal bepaald worden wat een “doelmatige aanwending van publieke middelen” is over alle sectoren van WVG heen?

Zie vraag 1.

- P15: “Daarnaast zal intensiever gerapporteerd worden over geaggregeerde vaststellingen, wat bijdraagt aan transparantie en beleidsgerichte inzichten.”
 - Hoe concreet moeten we ‘intensiever’ verstaan? Uitgebreidere rapportering of periodiciteit optrekken?

‘Intensiever’ verwijst in deze naar het gegeven dat een rapport over geaggregeerde vaststellingen sedert kort in principe voor elk type inspectie en iedere sector (technisch) mogelijk is. Dit zal ons toelaten meer van dergelijke rapporten te maken.

- P15: “In 2026 wordt dit uitgebreid naar inspecties binnen de sector van personen met een handicap, in lijn met het streven naar transparantie en publieke verantwoording.”
 - Wat is de timing van deze uitrol?
 - Is het doel om te komen tot zelfde rapportage dan bij kinderdagverblijven? Zo ja, dienen daarvoor verslagen aangepast te worden?

Een concrete timing is afhankelijk van het voorbereidend traject waarop we nu volop inzetten. Een deel van het voorbereidend traject bestaat o.a. uit het zoeken naar en bepalen van de meest geschikte vorm van publicatie die aan alle vereisten voldoet (in elk geval moet de huidige verslaggeving worden aangepast). Daarnaast zal ook de technische ontwikkeling een impact hebben op de timing. We blijven in dialoog met de sector en zullen helder communiceren zodra we een (afgestemde) concrete planning konden maken.

- P16: “We ronden de evaluatie van het actieplan voor (zij-)instroom in de gezondheidszorg en welzijnssector af en bevorderen instroom, zij-instroom en retentie.”
 - Welke timing heeft de minister voor ogen? Welke middelen zullen daaraan verbonden zijn? En hoe zal dit opgevolgd worden?

De evaluatie is gepland voor 2026. Op basis daarvan zal bepaald worden welke middelen hier eventueel tegenover zullen staan en op welke manier de opvolging concreet zal gebeuren.

- P16: “We werken aan een gezamenlijke IT-architectuur en beleid op basis van een gedeelde IT-beleidsvisie voor het hele beleidsdomein, ten voordele van zowel het zorgpersoneel als de burger.”
 - Welk tijdspad en hoeveel middelen worden hiervoor voorzien?

De beleidsraad WVG bepaalt de concrete projecten om deze architectuur verder te optimaliseren. Een concrete timing en budget wordt opgemaakt en zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden.

- P16: “Waar mogelijk werken we samen met Digitaal Vlaanderen.”
 - Zal er ook oog zijn voor de toegankelijkheid van de digitale toepassingen? Sommige zorgprofessionals kaarten immers aan dat toepassingen voor hen niet bruikbaar zijn.

Toegankelijkheid is één van de elementen waarmee wordt rekening gehouden. We vinden het belangrijk om hier een voorbeeldrol in op te nemen. Zorgverleners maken gebruik van eigen softwarepakketten. Om de kwaliteit en toegankelijkheid te vrijwaren, stemmen we hiervoor af met de softwareleveranciers. Waar nodig werken we met een webtoepassing zodat zorgverleners zonder eigen softwarepakket aan de slag kunnen.

- P17: “Hiervoor werken we samen met MAGDA en Vitalink in het ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal 3’-project (VRD3), speerpunt 3 ‘Datagedreven overheid’, om in 2026 de connectie tussen Magda en Vitalink op te zetten. De zwangerschapsattesten zullen de eerste testcase vormen bij de uitrol van dit project.”
 - Wat is de timing en welke middelen worden voorzien?

Voor dit VRD3-project is in 2026 een budget van 900K euro op VRD3 middelen beschikbaar. Tegen eind 2025 wordt een concreet projectplan met gedetailleerde budgetinschatting uitgewerkt.

- P17: “We bereiden ons voor op de implementatie van de Europese verordening over de European Health Data Space (EHDS). We investeren in een geïntegreerd datamanagementsysteem voor het beleidsdomein WVG.”
 - Welke middelen worden voorzien en hoe zullen die besteed worden?
 - Welke toepassingen zullen mogelijk zijn?
 - Hoe zal dit de reeds bestaande informatie kunnen ontsluiten? Is de vertaling van het ene systeem naar het andere te automatiseren of moet het manueel?
 - Binnen welk tijds kader zien we welke aanpassingen?
 - Welke impact zal dit hebben op de recentheid van data?

Om tegen maart 2029 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de eerste fase van de European Health Data Space (EHDS), wordt een gefaseerde aanpak gevolgd. Een degelijk data-managementsysteem, ondersteund door een betrouwbaar data-delingsplatform, zal de vindbaarheid en uitwisseling van data versnellen, wat de kwaliteit en recentheid van de gegevens ten goede komt, zowel voor primair als secundair gebruik. In het vierde kwartaal van 2025 start een pre-analyse voor een datamanagement programma met focus op de EHDS. In 2026 volgen diepgaande analyses van het datalandschap en de technische bouwblokken, de uitwerking van een governance- en juridisch kader, en de uitvoering van technische proof-of-concepts. Eind 2027 moeten de eerste meta-data-transfers mogelijk zijn binnen een testomgeving, en tegen eind 2028 moeten de bouwblokken operationeel zijn.

VI Beleidsveld Zorg

ISE Beleidsondersteuning

- P23: de prestatie-informatie over de administratieve vereenvoudiging heeft beperkte budgettaire impact binnen het ISE.
 - Welk budget is begroot binnen dit ISE voor administratieve vereenvoudiging?
 - Welk budget is voorzien voor administratieve vereenvoudiging binnen de hele begroting van het beleidsdomein?

Buiten ICT-matige investeringen en uitgaven (bv. eCalcura, VSB, platform zorgberoepen, meldingsplichtige infectieziekten enz.) en een deel personeelskosten binnen de administratie, zullen geen aparte budgetten worden ingezet.

- P25: “Verhogen van de participatiekansen van mensen met autisme”
 - Wat zijn de concrete acties binnen het plan die dit jaar vooropgesteld worden?

Dit wordt jaarlijks opnieuw bekeken. Momenteel is hierover nog geen beslissing genomen.

- P26: “We stroomlijnen daartoe de processen van de behandeling en handhaving van tweedelijnsklachten, rekening houdend met de specificiteit van bepaalde sectoren.”
 - Over welke sectoren gaat het concreet? Welke concrete acties worden er precies bedoelt met ‘stroomlijnen’?

Er is een grote variatie aan maatregelen en verschillen in toepassing tussen – soms gelijkaardige – WVG-sectoren. De doelstelling is dan ook om te komen tot een meer consistente en consequente aanpak tussen de sectoren, met een betere onderbouwing. Daarbij moet duidelijk zijn dat stroomlijning niet gelijk is aan uniformisering. Afwijkingen per sector moeten mogelijk zijn, op voorwaarde dat deze voldoende gemotiveerd kunnen worden. We zijn momenteel de prioritering en tijdslijn van deze acties aan het opmaken.

- P29: “We werken verder aan een regelgevend kader om het verkrijgen en verwerken van bepaalde geboorte- en sterftegegevens te verankeren.”
 - Worden hierbij ook de overlijdens omwille van suïcide meegenomen? Zal dit kader er ook voor zorgen dat er een vlottere doorstroom is van deze informatie?

In deze fase wordt de huidige federale wetgeving omtrent ‘verwerking en deling van de geboorte- en sterftegegevens’ vertaald naar een Vlaams decreet. Het administratief proces (of de snelheid van het proces) van aangifte wordt nu geregeld door het nieuwe eLys-decreet. Het nieuwe platform voor overlijdensadministratie, eLys, zal wel zorgen voor het sneller beschikbaar hebben, verwerken en analyseren van de data, ook die van de suïdecijfers. Daarenboven dient wel opgemerkt dat het Departement Zorg nooit sneller data zal kunnen aanleveren dan dat de parketten in Vlaanderen het Departement Zorg antwoorden verschaffen op de vragen bij niet natuurlijke doodsoorzaken (dus ook de suïcide cijfers).

- P31: “Om tijdens crisissituaties snel en gecoördineerd te kunnen optreden, voorzien we een oproepbare reserve-eenheid die op korte termijn inzetbaar is.”
 - Uit wie zal deze eenheid bestaan, op welke manier worden zij opgeleid voor crisissituaties en op welke manier zullen ze opgeroepen/ ingezet kunnen worden?

Binnen het Departement Zorg werd, met het oog op een verhoogde paraatheid bij noodsituaties, het concept van een Reserve-eenheid Paraatheid (REP) ontwikkeld. Deze

reserve-eenheid heeft tot doel om tijdens acute crisissituaties die binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap vallen, snel en gecoördineerd inzetbaar te zijn ter ondersteuning van het zorgsysteem en ter beperking van de impact op welzijn en gezondheid. De REP zal bestaan uit (para)medische profielen, waaronder artsen en verpleegkundigen die op vrijwillige basis beschikbaar zijn om bij acute noodsituaties tijdelijk ingezet te worden binnen de Vlaamse zorgcontext en dit in afwachting van een crisisorganisatie binnen de reguliere zorg

Voor de organisatie en operationele aansturing van de Reserve-eenheid Paraatheid werd gekozen voor een samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen, dat over de vereiste expertise, vrijwilligerswerking en operationele slagkracht beschikt om deze opdracht te vervullen.

De leden van de Reserve-eenheid Paraatheid volgen een gericht opleidingstraject dat wordt ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Campus Vesta.

- P31: “In 2026 worden reeds geplande initiatieven voor administratieve vereenvoudiging doorgevoerd.”
 - Graag de verschillende initiatieven.

De aanpassingen ter vereenvoudiging van administratieve processen zijn inhoudelijk uitgewerkt. De juridische vertaling daarvan is momenteel bezig. In de eerste jaarhelft van 2026 zou de besluitvorming daarrond binnen de Vlaamse Regering afgerond moeten zijn.

- P31: “We verfijnen en optimaliseren de evaluatie van subsidies binnen het beleidsdomein. Door eenvormige evaluatieprocessen te ontwikkelen, vereenvoudigen we de evaluatie van subsidies en faciliteren we een consistente en efficiënte aanpak.”
 - Welk tijdspad is voorzien?
 - Is dit op alle subsidies van toepassing? Ook op de lopende subsidies?
 - Verandert dit de subsidievoorwaarden, zodat de evaluatie vlotter kan verlopen?

Conform de VCO moet elke subsidie om de vijf jaar geëvalueerd worden. De evaluatie is verplicht voor alle subsidie(kader)s die worden voortgezet na een termijn van vijf jaar. Voor subsidie(kader)s die sinds 1 januari 2023 van kracht zijn, betekent dit dat zij ten laatste eind 2027 geëvalueerd moeten worden, op voorwaarde dat zij worden voortgezet in de volgende periode. Om dit proces te structureren, wordt jaarlijks een evaluatiekalender opgesteld waarin de geplande evaluatiemomenten worden opgenomen en de voortgang wordt opgevolgd.

De evaluatie kan aanleiding geven tot aanpassingen in de voorwaarden van de subsidie, bijvoorbeeld op vlak van rapportagevereisten, indicatoren of methodiek, zodat de subsidie doelmatig en doeltreffend kan verlopen. Deze aanpassingen gebeuren steeds in overleg met de betrokken actoren. De twaalf elementen zoals opgenomen in de VCO blijven uiteraard behouden in elk subsidiekader.

- P35: Bij de bijstelling op begrotingsartikel GB0-1GCF2BA-WT lezen we dat er 1,5 miljoen euro bespaard wordt door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen, meer bepaald de activering van opgebouwde reserves. Het kader is nog uit te werken.
 - Over welke reserves bij welke actoren binnen Beleidsontwikkeling – en ondersteuning gaat het concreet?
 - Wat is de stand van zaken van dit kader? Wat is hier de voorziene timing?

Zie het antwoord op vraag 1.

ISE Armoedebelaid

- P 44: “Een belangrijk instrument is het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)”
 - Wat is het totale budget voorzien voor de uitvoering van het VAPA? Graag een overzicht van alle begrotingsartikels met bijhorend budget binnen deze BBT en bijhorende actie.

Het VAPA is een bundeling van acties vanuit de verschillende beleidsdomeinen en verschillende begrotingsartikels. Voor het beleidsdomein welzijn worden deze elders in de BBT geduid, waar het over de specifieke actie uit het VAPA gaat.

- P45: “Concreet werden in 2025 twee armoedetoetsen opgestart door Opgroeien in het kader van het Groeipakket: 'afstemming inkomenstarief - Groeipakket' en 'uitfasering sociale toeslag'. De resultaten worden door Opgroeien meegenomen in een conceptnota in 2026.”
 - Wat waren de resultaten van deze armoedetoetsen? Indien de resultaten nog niet bekend zijn, wanneer worden deze verwacht?

De beide armoedetoetsen zijn opgestart voor de zomer, en er zijn ondertussen 2 stakeholderoverleggen doorgegaan. Voor de armoedetoets IKT-GP worden de resultaten eind dit jaar verwacht. De resultaten van de armoedetoets uitfasering sociale toeslag worden uiterlijk begin 2026 verwacht.

- Wat is de precieze timing van deze conceptnota?

De conceptnota zal in de loop van 2026 klaar zijn.

- P45: “De meerjarenplannen (van SAAMO) 2026-2030 vormen daarbij het kader voor de sector.”

- Wat zijn de belangrijkste elementen uit deze meerjarenplannen?

De acht SAAMO-organisaties kiezen in hun nieuwe meerjarenplannen voor drie overkoepelende strategische doelstellingen, die onderling sterk met elkaar verbonden zijn en betrekking hebben op:

- Grond- en mensenrechten
- Krachtige buurten, gemeenten en steden
- Collectief burgerschap

Samen vormen deze doelstellingen de kern van het opbouwwerk: ze zijn essentieel om het leven te verbeteren van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

- P46: project 'gezonde voeding op school':
 - Hoeveel projecten hebben nog ingetekend bij de tweede oproep in oktober 2025?

Hoeveel budget is er effectief toegekend aan de projecten?

19 lokale besturen hebben een aanvraag ingediend. Wat betreft het toegekende budget en de exacte cijfers over het aantal bereikte kinderen, kan ik op dit moment nog geen details geven. De gunningsprocedure is immers nog lopende. Zodra de procedure is afgerond en de definitieve beslissingen genomen zijn, zullen de concrete cijfers over het toegekende budget en het aantal bereikte kinderen gecommuniceerd worden.

- P46: "In 2026 verlengen we de projecten preventieve gezinsondersteuning die in 2023 zijn opgestart en positief zijn geëvalueerd."
 - Welke budget wordt hiervoor voorzien?

620.000 euro voor de 5 projecten voor drie jaar.

- P46: "We maken de Housing First-projecten bij de CAW's structureel."
 - Worden alle projecten structureel verankerd? Indien niet, over welke projecten gaat het dan concreet?

Ja, het is de bedoeling om alle 11 projecten Housing First structureel te verankeren.

- P46: "Tot slot zetten we de jaarlijkse gestandaardiseerde tellingen van dak- en thuislozen verder, maar trekken we het aantal regio's waarin jaarlijks geteld kan worden op van drie naar vijf. Daarnaast voorzien we in een begeleidingsaanbod voor telregio's die hier nood aan hebben bij het formuleren van effectieve maatregelen op basis van de resultaten van de lokale telling."
 - Welk budget is er voorzien voor deze telling? Hoeveel bedraagt het bijkomende budget om extra tellingen te voorzien?

173.000 euro inclusief BTW voor 5 regio's, te tellen in oktober 2026. Vorige twee jaren was 125.000 euro per jaar uitgetrokken voor 3 regio's.

- Hoeveel budget is er uitgerekend om het begeleidingsaanbod te voorzien?

Het geraamde bedrag zal tussen 300.000 euro en 340.000 euro bedragen voor een duurtijd van drie jaar.

ISE Welzijnswerk

- P53: “De middelen toegekend aan de hulplijnen (tele-onthaal, 1712, SIN!) zijn grotendeels opgenomen in de subsidieenveloppe van AWW.”
 - Over hoeveel budget gaat het concreet? Graag ook een opdeling per hulplijn.

Voor Tele-onthaal bedraagt voor 2026 het subsidiebedrag: 3.953.722,05 euro (onder voorbehoud).

Hulplijn 1712: Naast de financiering van 4,2VTE per 1712-team wordt CAW Oost-Brabant bijkomend erkend voor 3,5 VTE en dit voor de aansturing en coördinatie van 1712. CAW Oost-Brabant organiseert met deze middelen ook de chat-hulpverlening van 1712 voor heel Vlaanderen en Brussel.

Tot slot zijn er nog een aantal projectsubsidies die hulplijn 1712 ontvangt, hierbij is de ambitie om een aantal van deze projectsubsidies de komende legislatuur toe te kennen binnen de subsidie-enveloppes van de CAW.

- Avondpermanentie: 0,4 VTE per 1712-team ofwel een totaalbudget van 2 VTE;
- Versterking: 0,5 VTE per 1712-team ofwel een totaalbudget van 2,5 VTE;
- Communicatiebudget: 100.000 euro aan CAW Oost-Brabant;
- Versterking chat: 1,9 VTE aan CAW Oost-Brabant.

Stop it Now! wordt regulier gefinancierd vanaf 1 januari 2025. Er wordt 2.5 VTE toegekend aan de enveloppe van CAW Brussel.

- P55: “We evalueren het huidig regelgevend kader van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) met het oog op een heldere positionering, aansturing en opvolging van deze sector.”
 - Welke methode van evalueren zal gebruikt worden? Wie zal allemaal betrokken worden?
 - Welk tijdspad is hier voorzien?

De evaluatie gebeurt door middel van een traject dat bestaat uit verschillende stappen. Als eerste stap is de situatie zoals die vandaag bestaat in kaart gebracht. Hiervoor werd een analyse gemaakt van de jaarverslagen en beleidsplannen bij de CAW en waren er uiteraard ook contacten met de CAW. In een tweede fase wordt stilgestaan bij de bestaansredenen en opdracht van de CAW, hun positionering binnen het ruimere welzijnsveld, de manier waarop ze best georganiseerd kunnen worden en het aanbod. Eens dat duidelijk is, wordt ingezoomd op de monitoring en financiering. Het traject wordt vormgegeven in samenwerking tussen kabinet, administratie en CAW.

De evaluatie is gestart in september 2025 en zal vermoedelijk tot het einde van de legislatuur lopen als we zaken regelgevend verankerd willen hebben.

- P56: “We voorzien bijkomend aanbod in de nieuwe gevangenissen en detentiehuizen die in 2026 operationeel worden.”
 - Over welk aanbod gaat het concreet?
 - Welke middelen zijn hiervoor voorzien? Aan welke hulpverleningsactoren zullen deze worden toegekend?

Het aanbod is bepaald in het decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het bijkomende aanbod omwille van uitbreiding detentiecapaciteit zal verder worden uitgewerkt afhankelijk van de specifieke noden. Vlaanderen beschikt niet over financieringsmechanismen bij dergelijke capaciteitsuitbreiding. Het evenwicht tussen dit aanbod en de noodzakelijke hulp- en ondersteuning aan niet-gedeteneerden en niet-justitiabelen dient hierin bewaakt te worden.

- P56: “In samenwerking met de Vlaamse minister bevoegd voor Justitie en Handhaving versterken we de centra algemeen welzijnswerk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ondersteuningscentra jeugdhulp, sociale diensten jeugdrechtsbank en vertrouwenscentra kindermishandeling ter ondersteuning van de verdere uitbouw van de Veilige Huizen.”
 - Welk budget wordt hiervoor vrij gemaakt? Graag ook een opdeling per opgesomde actor.

Via de enveloppefinanciering worden hiervoor gefinancierd :

- 12,5 VTE voor CAW
- Hulplijn 1712: 1,5 VTE voor CAW en 1,5 VTE voor het vertrouwenscentrum Kindermishandeling
- 15 VTE zijn verdeeld over 8 CGG. Sinds 2025 is dit ingekanteld in de enveloppe, voorheen was er een afzonderlijk BVR van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. De CGG hebben van het Departement Zorg subsidies ontvangen voor het thema intrafamiliaal geweld: 0,5 VTE per CGG (deze middelen kunnen ruimer ingezet worden dan de casussen van de Veilige Huizen).

- P59: als uitleg bij begrotingsartikel GB0-9GCFAEA-OW lezen we “Deze ontvangsten zijn het gevolg van terugvorderingen van subsidies in het kader van welzijnswerk. Terugvorderingen doen zich voor als een subsidie niet of onvoldoende inhoudelijk of financieel wordt verantwoord.”
 - Over welke subsidies gaat het concreet? Van welke actoren werden deze teruggevorderd en voor welke acties?

Het gaat over zowel reguliere subsidies, werkingssubsidies als projectsubsidies. De actoren zijn dan ook alle begunstigen waarvan de subsidie onvoldoende verantwoord werd.

- P59: begrotingsartikel GB0-1GCF2EA-WT: graag een uitsplitsing van het budget per welzijnsactor, zowel voor de werkingsmiddelen als de projectsubsidies.

WELZIJN EN SAMENLEVING INCLUSIEF LOKAAL SOCIAAL BELEID	145	145
ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK	139.690	139.690
WELZIJNSBELEID	130	130
RONDPUNT	317	317
KONINGIN FABIOLA HOME VZW	527	527
FARA VZW	360	360
MODERATOR VZW	14	14
PAYOKE VZW	236	236
VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATIE HERSENVERLAMMING VZW	137	137
	141.556	141.556

- P60: “Bij de bijstelling op begrotingsartikel GB0-1GCF2EA-WT lezen we dat er 1,5 miljoen euro bespaard wordt door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen, meer bepaald de activering van opgebouwde reserves. Het kader is nog uit te werken.
 - Over welke reserves bij welke actoren binnen welzijnswerk gaat het concreet?
 - Wat is de stand van zaken van dit kader? Wat is hier de voorziene timing?

Zie het antwoord op vraag 1.

- P60: begrotingsartikel GB0-1GCF2ED-WT: graag een uitsplitsing van het budget voor de actoren lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed onthaal.

1GC024	TREFPUNT ZELFHULP	330.000
1GC034	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	138.000
1GC046	VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID	318.000
1GC070	LUS VZW	489.000
1GC141	PROJECTEN IN HET KADER VAN LOKAAL SOCIAAL BELEID	2.000.000
1GC144	PLAZZO	41.000
1GC147	WERKINGSMIDDELEN VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID	238.000

- P61: op begrotingsartikel GB0-1GCF2ED-WT wordt 2 miljoen euro voorzien voor de versterking van het sociaal lokaal beleid voor ouderen. Wat wordt hier concreet onder verstaan?

Met deze middelen willen we naar een verduurzaming gaan van de zorgzame buurten. Zorgzame buurten vormen een essentiële bouwsteen binnen geïntegreerde zorg en ondersteuning. Ze vormen eveneens een prioriteit op vlak van lokaal sociaal beleid. We bedden de kernelementen van een zorgzame buurtwerking in binnen de werking van de LDC's, zoals vermeld in het regeerakkoord.

- P61: GB0-1GCF2EE-WT Werk-Zorg: Graag een opdeling van de cijfers voor 2025 en de voorziene cijfers voor 2026 per provincie per organisatie die middelen ontvangt via dit begrotingsartikel.

Het betreffende begrotingsartikel behelst zowel budgetten die worden ingezet in het kader van de uitvoering van activeringstrajecten als in het kader van arbeidsmatige activiteiten. De toeleiding in het kader van activeringstrajecten gebeurt via VDAB. Departement Zorg betaalt op basis van gegevens die VDAB aanlevert de samenwerkingsverbanden Zorg uit voor het opnemen van de taken van de casemanagers Zorg. Elk samenwerkingsverband Zorg beslist intern op basis van de noden en het profiel van elke deelnemer en op basis van expertise en beschikbaarheid van casemanagers zorg welke organisatie binnen het samenwerkingsverband de casemanager zorg aanlevert.

We hebben geen cijfers per provincie per organisatie beschikbaar. De definitieve cijfers voor 2025 per organisatie zijn ook nog niet beschikbaar. Omwille van de eigenheid van AMA in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid is het niet mogelijk om een voorafname te doen van welke organisaties hoeveel AMA-overeenkomsten zullen afsluiten in 2026.

ISE Sociale akkoorden

- P62: “We starten de evaluatie van het VIA6 op.”: wat is hier de concrete timing voor en wanneer worden de resultaten verwacht?

De evaluatie van VIA 6 en de bepaling van de doelgroepen voor een volgende VIA-akkoord zal gebeuren in 2026.

ISE Preventie

- P10: “We bieden zorg zo geïntegreerd mogelijk aan. Dat betekent dat we de verschillende aanbieders zo veel mogelijk laten samenwerken in functie van de noden van de burger. We werken hiervoor samen met alle politieke niveaus. Concrete voorbeelden zijn de trajecten voor perinatale zorg, kwetsbare ouderen en kinderen en jongeren met obesitas.”
 - Concrete uitvoer? Hoe faciliteren en hoe opvolgen?
 - Staan daar middelen tegenover? Welke en hoe worden die ingezet?

Deze vraag betreft in hoofdzaak een adequate organisatie van de zorg. Het luik ‘preventie van overgewicht en obesitas’ (bij alle leeftijdscategorieën) wordt opgenomen binnen de nieuwe gezondheidsdoelstelling ‘Gezonde leefstijl’ die gelanceerd wordt op 15/12. Een Vlaams Actieplan obesitas bij kinderen en jongeren bouwt hier maximaal op verder.

- P66: De totale dekkingsgraad voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhals-, Borst- en Dikke darmkanker.
 - Dekkingsgraad voor de bevolkingsonderzoeken wordt opgetrokken naar 70%.
 - Hoe zal dit aangepakt worden? Welke rol kunnen/zullen apothekers spelen?

Er zal ingezet worden op het versterken van de maatschappelijke en individuele gedragenheid van de bevolkingsonderzoeken naar kanker door (sub)doelgroepen op maat betrouwbaar te informeren en te sensibiliseren tot deelname. Specifieke doelgroepen waar o.a. op ingezet worden zijn: nooit deelnemers en onregelmatige deelnemers, in- en uitstappers en kwetsbare doelgroepen. Ook zullen er initiatieven genomen worden om de toegankelijkheid tot de bevolkingsonderzoeken te bevorderen. Naast het bereiken van burgers wordt er ook ingezet op het verhogen van de gedragenheid van de bevolkingsonderzoeken bij zorgverstrekkers en andere intermediairs.

Met betrekking tot het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker zal er in 2026 in een pilootproject worden nagegaan of het haalbaar is dat de apotheek 50-55-jarigen (= doelgroep die het minst deelneemt aan het BVO) motiveren tot deelname.

- “Door de delay in volledigheid van de IMA-databank, beschikken we pas na 2 jaar na het desbetreffende jaar van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek over het correct cijfer. “
 - Wordt voorzien dat op te lossen? Zo ja, hoe? Is duidelijk waar de knelpunten zitten?

De Bevolkingsonderzoeken naar kanker worden continu gemonitord en resultaten voor de belangrijkste indicatoren worden jaarlijks weergegeven in de jaarfiches over het screeningsjaar x-1. Deze resultaten zijn gebaseerd op de meest recente en beschikbare data. Er wordt daarbij consequent aangegeven welke indicatoren nog niet volledig zijn. Alle indicatoren samen geven wel degelijk een goed inzicht in de jaarlijkse evolutie van het bereik van de screeningsprogramma's.

De bedoeling is om de vertraging structureel te verkleinen door verbeterde data-uitwisseling, meer geautomatiseerde koppelingen en snellere validatieprocessen. De gesprekken hierover lopen reeds met de betrokken databeheerders. De strikte vereisten op vlak van GDPR, en de noodzaak om registratie en koppeling van data decretaal te verankeren zorgt ook voor uitdagingen op vlak van voldoende en tijdige gegevens.

- P68: “Afhankelijk van de resultaten van het literatuur- en nodenonderzoek ontwikkelen we een methodiek voor postinterventie en ondersteuning na een suïcide gericht op de algemene bevolking en nabestaanden.”
 - Wat is het tijdspad voor de oplevering van het literatuur- en nodenonderzoek?
 - Wat wordt er concreet bedoelt met ‘afhankelijk van de resultaten’: aan welke vereisten moet er minimaal voldaan worden?

- Op welke termijn wordt daarna een aanpak of methodiek ontwikkelend?
Wanneer wordt verwacht dat die klaar is?

Het nodenonderzoek werd inmiddels gefinaliseerd door de partnerorganisatie voor suïcidepreventie VLESP. Op basis hiervan diende VLESP recent een projectaanvraag in voor de ontwikkeling van een toolbox waarmee organisaties aan de slag kunnen om aan onmiddellijke postinterventie te doen na een zelfdoding. Dit project kan onder voorbehoud van goedkeuring nog dit jaar van start gaan.

- P68: “Om aanbevelingen voor nog meer gerichte suïcidepreventie te kunnen formuleren starten we met een ‘Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren en risicogroepen voor suïcide in Vlaanderen’.”
 - Welke aanpak zal hier gehanteerd worden? Welk tijdsplan wordt voorzien?

Dit onderzoek is als strategie en actie opgenomen in VAS III. De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de UGent diende samen met VLESP een projectvoorstel in met als doel het verkrijgen van meer inzicht in de risicofactoren en risicogroepen voor suïcide in Vlaanderen, en het formuleren van concrete aanbevelingen zodat preventiemaatregelen doelgerichter kunnen worden toegepast. Dit project kan onder voorbehoud van goedkeuring dit jaar van start gaan, met een looptijd van 24 maanden.

- P68: “Om aanbevelingen voor nog meer gerichte suïcidepreventie te kunnen formuleren starten we met een ‘Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren en risicogroepen voor suïcide in Vlaanderen’. In 2026 evalueren we deze gezondheidsdoelstelling tussentijds.
 - Wie zal dit epidemiologisch onderzoek uitvoeren? Wat is de timing van opstart? Wanneer worden de resultaten verwacht?

Zie antwoord vorige vraag.

- Wat is de concrete timing voor de evaluatie van de gezondheidsdoelstelling? Wie zal deze uitvoeren? Wanneer worden de resultaten verwacht?

De concrete timing en aanpak van de tussentijdse evaluatie wordt dit najaar uitgewerkt in samenwerking met het Departement Zorg en de partnerorganisatie voor suïcidepreventie VLESP.

- P68: “We trekken verder de kaart van adequate monitoring en ontsluiten van data en volgen de meest recente wetenschappelijke evoluties actief op.”
 - Zal hier ook ingezet worden op recentere data? We werken immers al lang met data waarvan de huidige representativiteit niet meer duidelijk is.

De Bevolkingsonderzoeken naar kanker worden continu gemonitord en resultaten voor de belangrijkste indicatoren worden jaarlijks weergegeven in de jaarfiches over het screeningsjaar x-1. Deze resultaten zijn gebaseerd op de meest recente en beschikbare data. Er wordt daarbij consequent aangegeven welke indicatoren nog niet volledig zijn.

Alle indicatoren samen geven wel degelijk een goed inzicht in de jaarlijkse evolutie van het bereik van de screeningsprogramma's.

De bedoeling is om de vertraging structureel te verkleinen door verbeterde data-uitwisseling, meer geautomatiseerde koppelingen en snellere validatieprocessen. De gesprekken hierover lopen reeds met de betrokken databeheerders. De strikte vereisten op vlak van GDPR, en de noodzaak om registratie en koppeling van data decretaal te verankeren zorgt ook voor uitdagingen op vlak van voldoende en tijdige gegevens.

- P69: "Dit is en blijft belangrijk omdat de infectiedruk voor een aantal is verdwenen of enkel bij risicogroepen voorkomend geachte infecties toeneemt. Een voorbeeld hiervan is tuberculose."
 - Wat zal de minister concreet ondernemen om de vaccinatie tegen tuberculose op te drijven?

Tegen tuberculose wordt in België/Vlaanderen niet gevaccineerd. Het BCG-vaccin wordt alleen toegepast in landen waar het risico op zeer ernstige infectie bij jonge kinderen hoog is. Dit is niet zo in Vlaanderen. Daarom is een universeel vaccinatieprogramma niet aangewezen. De aanpak in Vlaanderen is gericht op vroegtijdige opsporing en vroege behandeling en opvolging van risicogroepen of na risico-contact.

- P72: "We werken daarom in 2026 aan een aanpak om sociaal-emotionele vaardigheden te versterken in de school, thuis of via andere contexten rond kinderen."
 - Wat is de concrete invulling hiervan? Welk tijdspad wordt voorzien?
 - Welke middelen staan hier tegenover?

Er wordt gewerkt aan een *verdieping en verankering* van een universeel, wetenschappelijk onderbouwd aanbod binnen de klascontext, gericht op alle kinderen en jongeren. Er wordt voortgebouwd op bestaande en succesvolle methodieken, zoals *Geluk in de klas* en *Expeditie Geluk*. Dit initiatief is m.a.w. een versterking van wat al werkt, met extra focus op intensieve vaardigheidstraining rond emotieregulatie, impulscontrole, sociale interactie en veerkracht bij stress en onzekerheid. Hiervoor is een budget toegekend van 249.000 euro .

- P73: "Voor voeding en beweging zetten we in op het creëren van een lokale omgeving die gezond gedrag ondersteunt. Zo krijgen lokale besturen handvaten om een gezonde voedings- en beweegomgeving te realiseren via o.a. een aangepast instrument die ook rekening houdt met het thema voeding."
 - Welke middelen aan verbonden?

In 2024 werd een facultatieve subsidie van 249.950 euro (2024-2027) toegekend aan Sciensano om dit instrument voor te bereiden.

- Welke concrete toepassing?

Er wordt: 1) geanalyseerd in hoeverre er op vandaag reeds ruimte is voor gezondheidsoverwegingen in de ruimtelijke planning van lokale besturen, en 2)

onderzocht in hoeverre een aangepast instrumentarium binnen het planningsbeleid mogelijk is, rekening houdend met onze federale staatsstructuur en gelet op het relevante Europese regelgevend kader, ter bevordering van een gezonde voedselomgeving.

- P73: “Er wordt een reflectie-instrument ontwikkeld voor de lokale besturen om hen te begeleiden bij het vaststellen van knelpunten op vlak van een gezonde omgeving (voeding en beweging) en gericht aanpassingen te doen.”
 - Welke middelen zijn hieraan verbonden, zowel qua opstart als qua onderhoud (in geval van een digitaal instrument)?

De tool wordt in 2025 ontwikkeld, getest in samenwerking met lokale besturen en Gezondheidsmakers, en op basis van hun feedback geoptimaliseerd tot een digitale versie die vanaf het najaar 2025 via gezondleven.be beschikbaar is. Het onderhoud bestaat uit technisch beheer, regelmatige inhoudelijke actualisaties en blijvende ondersteuning en disseminatie naar lokale besturen en partners. Onder de beheersovereenkomst VBSO wordt voor de ontwikkeling en onderhoud budget voorzien.

- P73: “Het beleid op vlak van seksuele gezondheid zet in op ondersteuning en promotie van hedendaagse en leeftijdsadequate relationele en seksuele vorming om op die manier zoveel mogelijk kinderen en jongeren te informeren, op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, informeren over gezinsplanning en seksueel welbevinden, gedragsmatige aspecten voor preventie van HIV en SOA en een specifieke werking naar categorieën in de bevolking die een verhoogd risico lopen (sekswerkers, kwetsbare migranten).”
 - Op welke manier zullen de niet-jongeren gesensibiliseerd worden op dit vlak? Een grote risicogroep voor HIV is immers een iets oudere bevolkingsgroep.

De term relationele en seksuele vorming (RSV) is inderdaad specifiek gericht op schoolgaande kinderen en jongeren en heeft als doel alle jongeren voldoende informatie te geven over allerlei aspecten van relationele en seksuele gezondheid, waaronder hoe zich te beschermen tegen hiv en andere soi. Voor volwassenen wordt er via andere kanalen gewerkt, o.a. online via allesoverseks.be, via doelgroepgericht communicatie- en sensibiliseringscampagnes, via specifieke terreinwerking naar risicogroepen, via methodieken die zorgprofessionals hanteren om een gesprek over seksuele gezondheid aan te gaan (Onder4Ogen).

- P76: op begrotingsartikel GB0-1GCF2JA-WT worden de middelen van de gezondheidsdoelstellingen begroot.
 - Welk budget is voorzien in het kader van suïcidepreventie? Hoeveel is er voorzien voor de uitwerking van het VAS III en hoeveel bedragen de werkingsmiddelen voor het VLESP en CPZ?
 - Hoeveel middelen zijn voorzien om na de evaluatie van de gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie de doelstelling bij te stellen?

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS III) wordt uitgevoerd via de beheersovereenkomst met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ, 933.250 euro en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP, 1.324.200 euro). Daarnaast is er de suïcidepreventiewerking van de CGG (16 VTE via enveloppe financiering van de CGG).

Ik zal meer investeren in de preventie van mentale gezondheid. Er wordt vanaf 2025 recurrent 500k euro extra voorzien voor Suïcidepreventie vanuit uitbreidingsbudget preventief gezondheidsbeleid. Het budget voor mentaal welbevinden verhoogt structureel met 700.000 euro waarvan 400.000 euro met uitbreidingsbudget.

- P77: Bij de bijstelling op begrotingsartikel GB0-1GCF2JA-WT lezen we dat er 750 keuro bespaard wordt door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen, meer bepaald de activering van opgebouwde reserves. Het kader is nog uit te werken.
 - Over welke reserves bij welke actoren binnen het preventief gezondheidsbeleid gaat het concreet?
 - Wat is de stand van zaken van dit kader? Wat is hier de voorziene timing?

Zie het antwoord op vraag 1.

ISE Eerste lijn

- P80: Wanneer zal de definitieve afbakening van de IFP-doelgroep en de uitwerking van het BVR vergoedbare zorgcoördinatie rond zijn? Worden nog andere doelgroepen bepaald zoals vermeld? Zo ja, Welke?

Het kader voor vergoedbare zorgcoördinatie dat wordt uitgewerkt is een generiek kader. Momenteel loopt hiervoor de voorbereidende werkgroep. Het regelgevend traject wordt in 2026 gelopen. Het IFP-programma kwetsbare personen krijgt verder vorm in 2026. In Vlaanderen zal dit zich in de eerste plaats richten op kwetsbare ouderen en personen met dementie, gekoppeld aan de visie en hervormingen binnen de brede ouderenzorg.

- P80: Tegen wanneer kan het ontwerp van samenwerkingsakkoord waarin de afspraken rond geïntegreerde zorg en ondersteuning tussen de federale overheid en de gemeenschappen worden vastgelegd verwacht worden?

De onderhandelingen hierover lopen volop en vormen een zeer intens traject. Het bereiken van een samenwerkingsakkoord in de loop van 2026 blijft de ambitie.

- P80: Tegen wanneer wordt het Vlaams actieplan inzake obesitas bij kinderen en jongeren voorgesteld?

De opdracht van Eetexpert vzw om een Vlaams actieplan voor te bereiden loopt tot en met januari 2026. Op basis van hun beleidsrapport met aanbevelingen zal een concreet voorstel worden uitgewerkt, met enerzijds acties die zullen worden opgenomen op

Vlaams niveau en anderzijds acties die zullen worden opgenomen in het kader van het interfederaal plan.

Het luik preventie van obesitas (bij alle leeftijdscategorieën) wordt opgenomen binnen de nieuwe gezondheidsdoelstelling 'Gezonde leefstijl' die gelanceerd wordt op 15/12. Een Vlaams Actieplan obesitas bij kinderen en jongeren bouwt hier maximaal op verder.

- P80: Welke maatregelen gaan er genomen worden in het kader van de uitvoering van het programma "Kwetsbare personen"?

Voor Vlaanderen wordt de scope van dit programma 'kwetsbare ouderen en personen met dementie' en zal nauw aansluiten bij de hervorming van de ouderenzorg en thuiszorg. Er zal gefaseerd gewerkt worden en bekeken worden welke maatregelen effectief opgenomen worden met de federale overheid in het kader van cofinanciering, gegevensdeling of gedeelde bevoegdheden.

- P80-81: Tegen wanneer kunnen de randvoorwaarden en het regelgevend kader rond de implementatie van vergoedbare zorgcoördinatie en casemanagement voor de individuele persoon in de thuissituatie verwacht worden?

Zie eerdere vraag.

- P81: Invoer Alivia in 2026. Wordt er een connectie gemaakt tussen Alivia en E-health (elektronisch medisch dossier)? Zo ja, hoe wordt gewaakt over de privacy?

De data van Alivia worden quasi integraal en volledig gepseudonimiseerd opgeslagen op de Vlaamse gezondheidskuis Vitalink. Vitalink maakt hierbij nu al gebruik van de beveiligings- en toegangsprotocollen van eHealth. Hierbij werken we volgens de principes van dataminimalisatie en wordt enkel de relevante medische gegevens gedeeld die noodzakelijk zijn voor een interprofessionele zorgplanning en waarvoor er een juridische basis is.

- P81: Nieuwe organisatie i.v.m. vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorgen. Wat zal gebeuren met de huidige organisaties in dit veld?

De drie bestaande erkenningsvormen (multidisciplinaire begeleidingsequippe, palliatieve netwerken en palliatieve samenwerkingsverbanden) zullen opgaan in de nieuwe erkenningsvorm Netwerken Palliatieve Zorg. Overleg met de sector is momenteel lopende. Deze hervorming vraagt het nodige maatwerk waar de volgende jaren tijd voor is voorzien.

- P81: Dementiereferentiearts, hoe zal die zich positioneren tov de huisartsen zelf en quid erkenning/financiering van de functie?

Het expertisecentrum dementie Vlaanderen ontvangt momenteel een projectsubsidie om het functieprofiel en de taken van de dementiereferentiearts verder te verfijnen, daarbij wordt de nadruk gelegd op de link met geïntegreerde zorg en ondersteuning en de plaats binnen de eerste lijn. Op basis hiervan zal de erkenning/financiering worden bekeken.

- P81: Op welke wijze gaan de relevante beroepsgroepen in de eerste lijn gestimuleerd worden om hun leden te begeleiden in de transitie richting doelgerichte en geïntegreerde zorg en ondersteuning?

De beroepsgroepen maken deel uit van het bestuursorgaan van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn en worden al jaren gestimuleerd om lokale kringen op te zetten en samen te werken met de zorgraad. Daarnaast ontwikkelen zij in samenwerking met VIVEL casussen om een opleiding rond doelgerichte samenwerking meer te richten op de praktijk van de individuele gezondheidszorgverlener.

- P81: Toegankelijke huisartsgeneeskunde moet dicht bij de patiënt zijn. Gegevens op niveau van ELZ is onvoldoende. Dat gebied is te groot. Komen er cijfers per gemeente?

In het beveiligd dashboard dat gebouwd wordt voor huisartsenkringen en zorggraden wordt ook data op gemeenteniveau opgenomen.

ISE Gespecialiseerde Zorg

- P10: “We maken extra middelen vrij om de toegankelijkheid en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en hebben hierbij aandacht voor vroegdetectie, diagnostiek en vroeginterventie.”
 - Hoeveel middelen? Op welke termijn worden ze ingezet? Hoe worden ze concreet ingezet?
 - Betreft het duurzame middelen, projectsubsidies of investeringen?

In samenwerking met mijn administratie werken we dit momenteel verder uit.

- P90: Verdere ontwikkeling rapportage VSB
 - Welk tijdspad wordt voorzien? En welke middelen zullen voorzien worden?

Momenteel zijn een aantal basisrapporten binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in ontwikkeling. De volgende fase houdt in dat de voorzieningen hun eigen data kunnen inkijken en valideren. In een latere fase zal de VSB-basisrapportering verder worden uitgebreid naarmate bijkomende sectoren, zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), in de VSB geïntegreerd worden. Voor het onderhoud van de VSB-basisrapporten wordt jaarlijks een budget van 35.000 euro voorzien. Voor de

ontwikkeling van nieuwe rapporten wordt vanaf 2027 een minimumbudget van 250.000 euro geraamd.

- P95: “We financieren de CAR’s verder om, buiten hun revalidatie-overeenkomst, specifiek bijkomend gespecialiseerd diagnostisch aanbod te kunnen realiseren voor de doelgroep tweede kleuterklas t.e.m. eerste leerjaar, in zes vernieuwende intersectorale samenwerkingsverbanden vroegdiagnostiek.”
 - Welke middelen? Dekken die ook de inhaalbeweging van de wachttijd van 2 jaar?

Vanaf 2024 werden hiervoor structureel uitbreidingsmiddelen geestelijke gezondheid voorzien, ten bedrage van bijna 1 miljoen euro op jaarbasis. Deze middelen worden toegekend aan de CAR voor het vergroten van de capaciteit gespecialiseerde diagnostiek en expertise-uitwisseling, specifiek voor de doelgroep tweede kleuterklas t.e.m. eerste leerjaar.

Tegelijkertijd worden deze middelen inhoudelijk gekoppeld aan de pilootprojecten vroegdiagnostiek en “zorg en ondersteuning op lokaal niveau”, die beiden vanuit Opgroeien worden geïnstalleerd.

- P96: “We willen de netwerken-geestelijke gezondheid volwassenen hierin ondersteunen door deze legislatuur de al voorziene decretale doelstelling van de aanspreekpunten te operationaliseren. We starten een traject op waarin een concreet projectkader voor de aanspreekpunten (duidelijke omschrijving van de opdrachten, kaders met minimale verwachtingen, financiering, te lopen traject) samen met de netwerkcoördinatoren en de betrokken sectoren wordt uitgewerkt.”
 - Welk tijdspad is hiervoor uitgetekend en welke middelen worden voorzien?

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en gezin (SWVG) voerde een onderzoek uit betreffende het bevorderen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg via (intersectorale) samenwerking in de geestelijke gezondheidsnetwerken voor volwassenen en ouderen. Op basis van deze onderzoeksbevindingen worden concrete strategische doelen geformuleerd. Een concreet tijdspad kan nog niet meegegeven worden.

- P96: “We sluiten een nieuwe overeenkomst af voor online hulpverlening gericht op geestelijke gezondheid.”
 - Welk tijdspad is voorzien voor de opstart van de overeenkomst?
 - Wie zal de doelgroep zijn?
 - Welke middelen worden hier voorzien?

De nieuwe overeenkomst wordt uitgewerkt. Het budget dat hiervoor vrijgemaakt wordt, is nog niet beslist.

- P97: “In het kader van de hervorming van het revalidatielandschap werken we een concreet en toekomstgericht plan uit in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders. Dit plan beoogt de noodzakelijke transformatie waarbij de bestaande conceptuele ideeën rond revalidatie worden vertaald naar werkbare en duurzame praktijken binnen het zorgsysteem.” Stand van zaken?

De uitwerking van de eerder bepaalde conceptuele fase van de hervorming van het zorgaanbod voor fysieke revalidatie is gestart. Om dit proces te structureren en te begeleiden, werd een Vlaamse stuurgroep opgericht. De stuurgroep zal prioritaire deelprojecten vastleggen en moet daarbij nog een plan van aanpak, inclusief timing, uitwerken.

Maximale afstemming met het federale beleid is noodzakelijk. Daarom werd een interfederale werkgroep samengesteld. De interfederale werkgroep is een eerste keer samengekomen op 8 oktober 2025. In deze werkgroep zijn alle Gemeenschappen en Gewesten, alsook de federale overheid vertegenwoordigd.

- P97: “We investeren tot slot verder in het hulpverleningsaanbod voor gedetineerden en geïnterneerden met geestelijke gezondheidsproblemen (zie ook ISE Welzijnswerk).”
 - Welke concrete middelen staan hier tegenover?
 - Hoe zullen die ingezet worden?

Het specifieke hulpaanbod dat de CGG's realiseren voor de doelgroep van geradicaliseerde gedetineerden (disengagement-trajecten) wordt verdergezet: 85.344 euro (niet geïndexeerd) voor de inzet van 1 VTE. Deze middelen worden verdeeld over 3 CGG.

De TANDEM-werking wordt gecontinueerd met een jaarlijks budget van 657.693,54 euro voor de realisatie van een kwaliteitsvolle en continue toeleiding van personen in detentie met een geestelijke gezondheidsproblematiek naar gepaste zorg- en hulpverlening na hun detentie.

Daarnaast verwijzen we naar het gespecialiseerd aanbod voor forensische zorg van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Dit maakt deel uit van de enveloppefinanciering van de CGG.

- P97: “In functie van de betere doorstroom van geïnterneerden naar de meest passende hulpverlening voorzien we extra capaciteit voor geïnterneerden binnen de sector beschut wonen.”
 - Welke maatregelen zullen hier concreet genomen worden? Welk tijdspad wordt uitgetekend?
 - Over hoeveel plaatsen gaat dit?
 - Welke middelen worden hier voorzien?

Vanaf 2026 wordt er een bijkomende erkende begeleidingscapaciteit voorzien voor initiatieven beschut wonen (IBW), specifiek bestemd voor geïnterneerde personen, om

zo de doorstromingsmogelijkheden voor de doelgroep binnen hun zorgtraject te bevorderen en daarbij de kans op een succesvolle re-integratie te vergroten. Er wordt financiering voorzien voor een bijkomende begeleidingscapaciteit van 20 plaatsen IBW. Het gaat over een budget van 366.422,06 euro.

- P97: “De overeenkomst met Psyche loopt af eind 2025. We bereiden een nieuwe overeenkomst met Psyche vzw voor.”
 - Wat is de stand van zaken? Wat gebeurt er met de financiering als de nieuwe overeenkomst er begin 2026 nog niet is?

Een voorstel voor een nieuwe overeenkomst wordt uitgewerkt. Indien de overeenkomst begin 2026 nog niet rond is, voorzien we een overgangsregeling.

- P98: “Om dit proces te structureren en te begeleiden, hebben we een Vlaamse stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep neemt de leiding in het uittekenen van het hervormingsplan en zal hiervoor beroep doen op experts uit diverse disciplines. Via gespecialiseerde werkgroepen zullen experts bijdragen aan de concretisering van het hervormingsplan. Voor elke werkgroep werken we een duidelijk afgebakende opdracht uit met afgebakende verwachtingen en doelstellingen.”
 - Wie maakt deel uit van de stuurgroep?
 - Wat is het tijdspad waarbinnen zij het hervormingsplan uittekenen?
 - Wat met het veld terwijl het uittekenen van het hervormingsplan loopt?
 - Welke middelen worden voorzien?

De uitwerking van de eerder bepaalde conceptuele fase van de hervorming van het zorgaanbod voor fysieke revalidatie is gestart. Om dit proces te structureren en te begeleiden, werd een Vlaamse stuurgroep opgericht. De stuurgroep zal prioritaire deelprojecten vastleggen en moet daarbij nog een plan van aanpak, inclusief timing, uitwerken. De Vlaamse stuurgroep bestaat uit twee revalidatieartsen, één vertegenwoordiger van de beroepsvereniging kinesitherapie, een vertegenwoordiger van de ziekenfondsen, een vertegenwoordiger van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, een vertegenwoordiger van de revalidatieziekenhuizen (één algemeen directeur), twee vertegenwoordigers van de administratie en een vertegenwoordiger van het kabinet van minister Gennez.

Maximale afstemming met het federale beleid is noodzakelijk. Daarom werd een interfederale werkgroep samengesteld. De interfederale werkgroep is een eerste keer samengekomen op 8 oktober 2025. In deze werkgroep zijn alle Gemeenschappen en Gewesten, alsook de federale overheid vertegenwoordigd.

De middelen zijn op vandaag beperkt tot de (vrijwillige) inzet van experts. Er is een zeer beperkte financiële bijdrage (van de federale overheid) voor het testen van een instrument voor het objectiveren van de revalidatienood in een tiental ziekenhuizen.

- P98: “Naast deze Vlaamse initiatieven is er ook nood aan een structurele afstemming met de federale overheid en de andere gemeenschappen en gewesten. Revalidatiezorg overstijgt immers de grenzen van bevoegdheden en vereist een gecoördineerde aanpak. Daarom is een interfederale werkgroep revalidatie opgericht onder het voorzitterschap van Vlaanderen. Binnen deze werkgroep zullen we met vertegenwoordigers vanuit de verschillende deelstaten samenwerken om beleidslijnen op elkaar af te stemmen, knelpunten te identificeren en gezamenlijke oplossingen uit te werken. Deze werkgroep zal een sleutelrol spelen in het realiseren van een coherent en geïntegreerd revalidatiebeleid.”

Timing? Wanneer komt deze interfederale werkgroep revalidatie samen?

Samenstelling? Wat met het werk dat al tijdens de vorige werkgroep werd verricht?

De vorige legislatuur was er de intentie om een interfederale werkgroep, met goedkeuring van de IMC Volksgezondheid, op te richten, maar dit is niet effectief gebeurd. In deze legislatuur is de opstart van deze werkgroep er wel gekomen. De interfederale werkgroep is daarbij een eerste keer samengekomen op 8 oktober 2025. In deze werkgroep zijn alle Gemeenschappen en Gewesten, alsook de federale overheid vertegenwoordigd. De interfederale werkgroep komt om de drie maanden samen.

- P100: Op begrotingsartikel GB0-1GCF2LA-WT worden alle middelen met betrekking het beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg begroot.
 - Graag een opdeling per ontvangende actor hoeveel budget zij ontvangen.

Onderstaand overzicht is een inschatting van de besteding van het budget.

Invulling BO 2026	Budget BO 2026
EVA PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	€ 11.583.000,00
EVA PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	€ 11.576.000,00
VIKZ	€ 690.143,22
Pilootproject CAR/CGG	€ 243.000,00
Project OBT	€ 159.000,00
IFIC OPZ	€ 855.680,00
Centra Menselijke Erfelijkheid	€ 2.696.000,00
CGG-enveloppe	€ 100.849.112,82
VIA6 IFIC-CGG (Saldo)	€ 2.533.452,63
CGG deradicalisering	€ 86.709,50
Familieplatform	€ 549.769,34
TDI-verwerking door Sciensano	€ 42.133,97
TANDEM (inclusief uitbreiding 2024)	€ 669.532,02
Psyche	€ 2.759.682,26
Onlinehulp	€ 1.000.629,38

Vlaams Patiëntenplatform	€ 258.781,98
VIA-5 samenwerking CAR-CGG	€ 400.000,00
UFC	€ 60.000,00
Intersectorale begeleidingsteams jongvolwassenen	€ 985.514,92
Perinet	€ 168.000,00
Herstelacademie	€ 760.500,00
Diagnostiek CAR	€ 964.000,00
Gents begeleidingspunt studenten	€ 193.200,00
Aanklampende zorg voor mensen met psychische problemen die sociaal huren	€ 1.345.588,37
CONNECT	€ 4.311.422,41
Aanbod personen met ernstige psychische zorgnoden	€ 1.205.989,22

- Bij het budget van de CGG graag ook een verdere uitsplitsing van het budget afhankelijk van de opdracht waarvoor zij deze middelen ontvangen.

De CGG ontvangen een enveloppefinanciering. Dit bedrag omvat de vergoeding voor alle activiteiten die zij uitvoeren (preventie opdracht, behandeling, diagnostiek,...) voor verschillende doelgroepen. Het is niet mogelijk dit budget op te splitsen.

- P101: Bij de bijstelling op begrotingsartikel GB0-1GCF2LA-WT lezen we dat er 1,5 miljoen euro bespaard wordt door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen, meer bepaald de activering van opgebouwde reserves. Het kader is nog uit te werken.
 - Over welke reserves bij welke actoren binnen het beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg gaat het concreet?
 - Wat is de stand van zaken van dit kader? Wat is hier de voorziene timing?

Zie het antwoord op vraag 1.

- P102: 9 miljoen euro van de voorziene 10 miljoen euro van het uitbreidingsbeleid wordt vertraagd tot 2027. Welk beleid wordt hierdoor mee vertraagd tot 2027?

De concrete invulling van het uitbreidingsbeleid is nog in voorbereiding.

- P103: Op begrotingsartikel GB0-1GCF2LX-IS worden de toelagen voor de VSB-pijlers Revalidatie Ziekenhuizen, Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Revalidatie Voorzieningen begroot. Graag een opdeling van het budget voor de 3 actoren.

Sector	Budget BO 2026
Revalidatieziekenhuizen	€ 120.370.285,00
Psychiatrische verzorgingstehuizen	€ 95.164.299,56

Revalidatievoorzieningen	€ 213.455.140,00
--------------------------	------------------

- P105: Op begrotingsartikel GM0-AGCF2LG-WT worden de werking en toelagen aan de Psychiatrische Verzorgingstehuizen begroot voor 151.486 keuro. Graag een opdeling van dit budget over de PVT en IBW.

Sector	Budget BO 2026
Initiatieven beschut wonen	€ 56.321.700,44
Psychiatrische verzorgingstehuizen	€ 95.164.299,56

ISE Woonzorg

- P15: “Om de uitdagingen van de vergrijzing en de toegenomen langdurige zorgnoden op te vangen, is een gecoördineerd interfederaal beleid vereist. Samen met de federale overheid maken we werk van een geïntegreerd zorgprogramma gericht op kwetsbare ouderen en personen met dementie, geënt op de bredere hervormingen in de ouderenzorg.”
Timing van dit geïntegreerd zorgprogramma?

Dit programma wordt in 2026 verder uitgewerkt. De effectieve uitrol hangt samen met de timing van het samenwerkingsakkoord. In het kader van de hervormingen in ouderenzorg kunnen er in tussentijd reeds acties door de Vlaamse overheid uitgewerkt worden die mee onderdeel zullen uitmaken van het programma.

- P62: “VIA6 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. We starten de evaluatie van het VIA6 op. De middelen en maatregelen die overeengekomen zijn in het kader van VIA, zijn inmiddels recurrent ingepast.
We integreren de IFIC-meerkostfinanciering in woonzorgcentra, desgevallend met bijbehorend centrum voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging in de basistegemoetkoming voor zorg (zie ook ISE Woonzorg).”
Timing? Welke stappen zijn reeds gezet?

Het doel is om de financiering voor de IFIC-meerkost te integreren in de BTZ vanaf 1 januari 2027. Het afgelopen jaar waren er besprekingen in een werkgroep met vertegenwoordigers van de sociale partners (koepelorganisaties en vakorganisaties). Een finaal voorstel wordt momenteel uitgewerkt.

- P69: “We ontwikkelen en behouden een kwaliteitsvol infectiepreventiebeleid in de gemeenschap en de residentiële zorgvoorzieningen - en specifiek in woonzorgcentra - in de strijd tegen zorginfecties.”
Timing?

Er wordt momenteel gewerkt aan een update van het werkinstrument infectiepreventiebeleid voor de woonzorgcentra. Vanaf eind 2025 zullen stapsgewijze updates beschikbaar zijn op de website. Tweejaarlijks wordt een handhygiënecampagne georganiseerd voor de woonzorgcentra. De volgende campagne vindt plaats in 2027. In 2026 komt er een nieuwe gevalideerde richtlijn over de preventie en diagnostiek van luchtweginfecties bij bewoners van Vlaamse woonzorgcentra, dit ter ondersteuning van een rationeel antibioticabeleid.

- P108: “We werken aan een zorgprognose-instrument waarmee we de toekomstige zorgnood op langere termijn in kaart trachten te brengen, zowel voor residentiële ouderenzorg als voor gezinszorg.”

Timing?

Het project verloopt in 2 grote fasen. In een eerste fase wordt in 2026 een technische startversie voor het zorgprognosemodel ontwikkeld. Vervolgens zal in een tweede fase, tegen 2029, het eigenlijke zorgprognosemodel ontwikkeld worden.

- P109: “We herbekijken de bestaande flexibiliseringsmaatregelen in woonzorgcentra, desgevallend met bijbehorend centrum voor kortverblijf en werken een nieuwe regeling uit.
We ontwikkelen eCalcura verder tot een gebruiksvriendelijke financieringstoepassing. We zetten daarbij stappen om na te gaan of het mogelijk is om gebruik te maken van RSZ-gegevens in de jaarlijkse aangifte.”

Tijdspad?

Een visie- en principenota werd afgerond en met de koepelorganisaties besproken. Een globale behoefte en impactanalyse wordt in 2026 afgerond. Na deze globale analyse kan een globaal tijdspad worden opgesteld. Na een gedetailleerde behoefteanalyse en functioneel ontwerp kan ook pas een meer gedetailleerde tijdslijn worden opgesteld.

- P108-109: “We stemmen beleidsplannen zoals het mantelzorgplan, het dementieplan, het ouderenbeleidsplan en het eenzaamheidsplan op elkaar af om constructieve synergieën te bereiken.

Tijdspad?

Het nieuw dementieplan 2026-2030 zal in maart 2026 voorgesteld worden aan de leden van de Vlaamse regering. De opmaak van het Vlaamse ouderenbeleidsplan is volop bezig en wordt voorgesteld eind 2025. Het nieuwe eenzaamheidsplan wordt gestart in het voorjaar 2026. Het mantelzorgplan loopt nog tot midden 2026, zal dan geëvalueerd worden en nieuwe acties ondernomen tweede helft 2026. Tussen de beleidsplannen wordt voldoende afgestemd en bepaald welke acties en speerpunten waar zullen worden opgenomen en hoe die onderling kunnen matchen zodat we winnen aan

efficiëntie, maximaal impact realiseren op het terrein en de plannen ook onderling een versterkend effect kunnen hebben voor deelaspecten.

We voeren het mantelzorgplan, dat afloopt op 30 juni 2026, verder uit en evalueren het in functie van het bepalen van het toekomstig te voeren mantelzorgbeleid.

Timing evaluatie?

Zie vorige vraag

We werken aan een nieuw dementieplan (2026-2030) met bijzondere aandacht voor meer en betere ondersteuning in de thuissituatie van personen met dementie en hun mantelzorgers. Indien nodig is er ook gespecialiseerde residentiële ondersteuning in woonzorgcentra.

Participatie van de personen met dementie in een inclusieve samenleving is ook een streefdoel. Speciale aandacht gaat naar preventie, beeldvorming en personen op jonge leeftijd met dementie.

Wanneer mogen we dat nieuwe dementieplan verwachten?

Zie vorige vraag.

We werken aan een zorgprognose-instrument waarmee we de toekomstige zorgnood op langere termijn in kaart trachten te brengen, zowel voor residentiële ouderenzorg als voor gezinszorg. Het zorgprognose instrument dient ook om knelpunten te identificeren, beleidsprioriteiten te bepalen, de nood aan infrastructuur in te schatten, populaties identificeren die bepaalde gezondheids- en welzijnsrisico's lopen, zicht op personele noden, het beleid post hoc te evalueren of te simuleren.

Quid zorgprognose-instrument?

Zie eerdere vraag.

We stimuleren technologie en innovatie in de woonzorgsector, die ondersteuning kunnen bieden aan organisaties, zorgverleners en gebruikers. Specifiek in de gezinszorg zetten we bijvoorbeeld in op alternatieven zoals mogelijkheden voor collectieve gezinszorg, hybride gezinszorg, ...

Hoe wil u dit doen? Kan dit geconcretiseerd worden?

Technologie en innovatie vormen een belangrijk onderdeel van de modernisering van de ouderenzorg. Hun inzet wordt gestimuleerd wanneer ze een duidelijke meerwaarde bieden voor de verbetering van de zorgkwaliteit, het verlichten van de werkdruk en het verhogen van de tevredenheid en levenskwaliteit van bewoners. Maar technologie blijft een middel, geen doel op zich en dient de menselijkheid van de zorg te versterken, niet

te vervangen. Woonzorgcentra zijn vrij om binnen hun bestaande middelen te investeren in technologische toepassingen die zij relevant achten.

Binnen thuiszorg, en meer specifiek de diensten voor gezinszorg, zal hierop worden ingezet met het project collectieve gezinszorg en het verduurzamen van de methodiek van hybride gezinszorg.

Voor collectieve gezinszorg gedurende de looptijd (periode 1 december 2023 tot en met 31 december 2026) kan koepelorganisatie Zorggezind beroep doen op een subsidie van 450.000,00 euro.

Er werden in de voorbije jaren twee opeenvolgende gefinancierde projecten (van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2023 en van 1 september 2023 tot 31 december 2024) doorlopen rond hybride gezinszorg. Op basis van de ervaringen uit de projecten, wordt verduurzaming onderzocht. Tegenover deze verduurzaming staan geen extra budgetten.

- P109-110: “Het project gaat een volgende fase in waarbij woonzorgcentra verplicht worden te rapporteren over boekjaar 2025. We zorgen dat aan alle voorzieningen opleidingstools en ondersteuning worden geboden en volgen op dat alle voorzieningen een rapportering indienen. We verwerken de ingediende rapporteringssjablonen en informeren individuele voorzieningen indien aanpassing vereist is.”

Woonzorgcentra zullen dus in 2026 moeten rapporteren over 2025 => de minister kan dus garanderen dat alle woonzorgcentra over de nodige opleidingstools zullen beschikken en op de nodige ondersteuning zullen kunnen rekenen?

De voorzieningen worden op diverse manieren ondersteund om het sjabloon dat wordt aangeboden door het Departement Zorg om de oefening transparante sectorspecifieke boekhouding te kunnen volbrengen, goed te kunnen invullen.

Sinds de eerste pilootfase in 2024 lopen er diverse initiatieven ter ondersteuning van de woonzorgcentra, het zogenaamde “opleidingstraject”. Uit deze initiatieven is al veel informatie voortgekomen die beschikbaar blijft voor de voorzieningen en waar nodig ook telkens geactualiseerd wordt. De informatie is beschikbaar in permanent consulteerbare documenten zoals voorbeelden, handleidingen, online kennisclips, e-learnings, faq, en ander ondersteuningsmateriaal.

Daarnaast organiseert het Departement Zorg ook vragensessies en helpdesk voor individuele ondersteuning. Een regelmatige nieuwsbrief houdt de sector op de hoogte van de evoluties in het project. Het projectteam kan ook steeds via generieke mailbox gecontacteerd worden. Ingediende rapporteringssjablonen zullen via een geautomatiseerd anomalieënrapport geanalyseerd worden waarbij vervolgens

specifieke analyses kunnen volgen en de nodige feedback aan de voorziening wordt bezorgd, hetzij door individueel advies, hetzij via een collectieve feedbacksessie.

- P110: “We implementeren het handelingskader handhaving naar gezinszorg.”
Tijdspad?

Momenteel loopt een periode van mogelijke remediëring voor de diensten Gezinszorg. Midden 2026 zal Zorginspectie van start gaan met inspectiebezoeken.

- P110: “We verduurzamen de implementatie van BelRAI in de woonzorgsector in functie van onderbouwde zorgplanningen aan de hand van een evaluatie van het gebruik van de instrumenten BelRAI LTCF, BelRAI Screener en Sociaal Supplement.”
Timing?

In 2025 worden er 2 evaluatieonderzoeken gevoerd:

- Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek lanceerde een bevraging richting de woonzorgcentra om het gebruik van BelRAI LTCF te evalueren en bijkomende ondersteuningsnoden in kaart te brengen.
- Lucas zal een beleidsevaluatie uitvoeren waarbij het zwaartepunt ligt bij het gebruik van BelRAI Screener en Sociaal Supplement.

De resultaten uit beide onderzoeken zullen in 2026 worden opgeleverd, vanwaar vervolgacties gedefinieerd zullen worden.

- P110: “In het najaar van 2025 is een pilootproject opgestart in het kader van Alivia. Bewoners van woonzorgcentra, hun mantelzorgers en hun zorgverleners testen binnen en buiten het woonzorgcentrum om doelgericht samen te werken aan een zorgplan. Alivia moet hen daarbij helpen. Het samenspel tussen Alivia, BelRAI en de verhouding tot een (woon)zorg(leef)plan wordt verder uitgediept in dit project en vertaald naar toekomstige ontwikkel- en implementatienoden.”
 - Timing?

Het pilootproject is gestart op 17 oktober 2025 en loopt tot en met 30 juni 2026. De Academie voor de Eerste Lijn zal onderzoek voeren naar succesfactoren voor de implementatie van doelgerichte zorg en parallel wordt technische input verzameld voor de samenwerking tussen Alivia, BelRAI en de verhouding tot het woonzorgleefplan.

- P111: “GB0-1GCF2VB-WT - THUIS- EN OUDERENZORGBELEID Voor de ouderenvoorzieningen betreft het volgende subsidies die vanop dit artikel worden uitbetaald, graag een verdere opsplitsing/uitklaring/detaillering van dit begrotingsartikel:

- de werkingssubsidies voor de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang;
- de tegemoetkoming voor de regularisatie van de projectgesco's in de ouderenzorg;
- de DAC-supplementen voor de woonzorgcentra;
- de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9 regionale expertisecentra;
- de subsidiëring van de BEVAK-serviceflats;
- projectsubsidies ouderenzorg.”

In keuro:

	VAK	VEK
werkingssubsidies centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang	15.433	15.493
ex-GESCO	3.833	3.833
ex-DAC	2.301	2.301
expertisecentra dementie	2.376	2.376
BEVAK serviceflats	0	1.074
Projectsubsidies	0	0

- P112: GB0-1GCF2VB-WT - THUIS- EN OUDERENZORGBELEID: Graag toelichting bij de 7.033 KEUR voor Warm Vlaanderen – gezinszorg: compensatie ter versterking van de preventieve en coördinerende rol van de lokale dienstencentra. Is dit budget voor meer lokale dienstencentra of wenst men de werking van de bestaande centra te versterken. Zo ja, hoe en binnen welke tijdslijn?

Een deel van het budget is voorzien voor de uitbreiding en versterking van de lokale dienstencentra.

- P112: GB0-1GCF2VB-WT - THUIS- EN OUDERENZORGBELEID: Graag toelichting bij de -2.000 KEUR verschuiving van budget richting lokaal sociaal beleid ter versterking van het lokaal sociaal beleid voor ouderen. Worden deze middelen weggenomen vanuit een andere werking of wordt dit gefinancierd met andere positieve compensaties?

Neen, deze middelen worden genomen van het uitbreidingsbeleid Warm Vlaanderen van 2026.

ISE Algemeen Gezondheidsbeleid

/

VII Beleidsveld Opgroeien

ISE Jeugdhulp

- P123: “We verduurzamen de middelen die we investeren in laagdrempelige projecten die werken rond de veerkracht van kwetsbare jongeren.”
 - Over welke laagdrempelige projecten gaat het concreet? Welk budget is hieraan gekoppeld?

Dit gaat over de projectmiddelen die aan Overkop toegekend worden voor psycho-educatie (budget is 1,68 miljoen euro) en over de projecten Young Fenix (50.000 euro), Homaar (200.000euro) en Tejo (100.000 euro). De middelen psycho-educatie worden verduurzaamd binnen de basisfinanciering Overkop.

- P123: “We blijven waken over de kwaliteitsvolle werking door met bestaande OverKop-huizen een stevig kwaliteitsbeleid uit te werken en een regelgevend akader vorm te geven.”

Welke timing is voorzien voor de uitwerking van het kwaliteitsbeleid en het regelgevend kader? Hoe zal het totstandkomingstraject eruit zien?

We voorzien de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevend kader (inclusief kwaliteit) tegen 1/1/27. Er is reeds een voorbereidend traject gelopen met de Stuurgroep Overkop, deze zal verder gebruikt worden als stakeholdersoverleg.

- Welke elementen zijn cruciaal in dit kwaliteitsbeleid?

Dit kwaliteitsbeleid moet in eerste instantie uitvoering geven aan het kwaliteitsdecreet. Cruciaal hierbij is dat het kwaliteitsbeleid dynamisch is en groei en verbetering faciliteert.

- P123: “We breiden de capaciteit van het diagnostisch aanbod uit, afhankelijk van evaluatie van de resultaten van de lopende proefprojecten.”
 - Welk budget staat hier tegenover? Op welke manier zal de capaciteitsuitbreiding verdeeld worden?

We voorzien een eerste investering van 2.000.000 euro waarmee we het aanbod van de centra voor ontwikkelingsstoornissen willen versterken.

- P124: “Aan de hand van een participatief traject met de vertrouwenscentra kindermishandeling wordt de impact op het OCJ en de vertrouwenscentra kindermishandeling bekeken, geven we de nieuwe positionering van de vertrouwenscentra kindermishandeling binnen het hulpverleningslandschap verder vorm en maken we goede samenwerkingsafspraken.”
 - Graag wat meer uitleg over het participatief traject: hoe, wie, wat, wanneer, waarom?

Het participatieproces wordt opgestart, in eerste instantie met vertegenwoordiging van de VK en de OCJ's. Zij komen maandelijks samen om onder meer samenwerkingsafspraken te maken met oog op de toekomstige samenwerking. Dit zowel wat betreft procesflows alsook expertise-uitwisseling op casusniveau én casusoverstijgend.

Op die manier wordt er ingezet op heldere flows die mee moeten bijdragen tot onder meer een vereenvoudiging en een gecoördineerde aanpak van verontrustende situaties.

- P124: “Daarbij voorzien we ook specifieke aandacht voor de ontwikkeling van een verscherpte definitie van vrijwillige, aanklappende en gedwongen hulpverlening”
 - Op welke manier zullen deze definities aangepast worden? Welke actoren zullen hierbij betrokken worden?

We grijpen de evolutie naar het OCJ als enige gemandateerde voorziening aan om een ruimere transitie van de sociale diensten, de OCJ en de toegangspoort door te voeren. Met deze transitie willen we een aantal ambities uit het regeerakkoord - vroegtijdig ingrijpen, vereenvoudiging van processen... - waarmaken. Dit omvat eveneens dat bepaalde begrippen terug onder de loop dienen genomen te worden ten einde maximale duidelijkheid te creëren in het continuüm van het begrip ‘verontrusting’. Er wordt een stakeholdertraject opgezet om relevante actoren te informeren en uit te wisselen. De opvolggroep in het plan jeugdhulp zal daar alvast een belangrijke positie in krijgen.

- P124: “Door een gefaseerde invulling van de personele randvoorwaarden om het OCJ als enige gemandateerde voorziening te laten functioneren houden we de caseload onder controle.”
 - Wat wil dit concreet zeggen? Welk budget staat hiertegenover?

OCJ zal fungeren als de enige gemandateerde voorziening. Er zal een inschatting worden gemaakt van de verwachte toename in caseload en van de benodigde personele middelen om deze kwalitatief te kunnen verwerken. In de komende maanden wordt de impact hiervan gericht in kaart gebracht en welk budget gaandeweg nodig is om deze dienstverlening, hetzij gefaseerd, maximaal te ondersteunen bij een mogelijke toename van instroom.

- P124: “We maken een samenwerkingsprotocol tussen actoren uit welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en justitie, gericht op een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak.”
 - Wat is de voorziene timing? Welk doel heeft dit samenwerkingsprotocol? Over welke type casussen moeten zij zich buigen?

We zetten in op een meer geïntegreerde aanpak van complexe scheidingen door structurele informatiedeling en multidisciplinair casusoverleg te versterken. We brengen de rollen, mandaten en expertise van alle betrokken actoren in kaart en faciliteren samenwerking tussen onder meer justitiële en welzijnssectoren.

- P125: “We werken een meldcode kindermishandeling uit.”
 - Wat is hier de timing van?

Tegen het najaar van 2026 ontwikkelen we een Vlaamse hulp- en meldcode kindermishandeling, waarna we deze tegen eind 2026 verankeren en zorgen voor een gepaste handhaving ervan. De effectieve uitrol en implementatie van de meldcode is voorzien in het jaar 2027.

- P126: “Daarom evalueren we het concept gezinshuizen inhoudelijk, organisatorisch, regelgevend en financieel zodat we ze verder kunnen versterken.”
 - Wat is de beoogde timing van deze evaluatie? Wanneer worden de resultaten verwacht? Wie zal deze evaluatie uitvoeren?

De eerste signalen zijn in kaart gebracht. Volgende stappen zijn bijkomend onderzoek en een juridische analyse over de gezinshuizen. Op basis hiervan volgt een meer doorgedreven evaluatie in 2026.

- P126: “We versterken de residentiële hulpverlening in gezinshuizen -en verblijven volgens nieuwe programmatie om tot regionale evenwichten te komen. We voorzien, na de analyse van drempels en zoektocht naar oplossingen, een meerjarentraject in functie van de beschikbare kredieten voor de verdere uitbreiding van de gezinshuizen.”
 - Hoeveel capaciteit wil de minister extra realiseren? Graag een opdeling tussen gezinshuizen en gezinsverblijf?
 - Hoeveel budget staat hier tegenover?
 - Wanneer zal dit meerjarentraject opgestart worden?

Het zwaartepunt van de residentiële uitbreiding, ook van de gezinshuizen en gezinsverblijf ligt later in de regeerperiode. We willen op basis van het capaciteitsbeheersysteem, in de loop van 2026 zicht krijgen op de effectieve residentiële noden en de spreiding. Pas dan zullen we een fijnmaziger overzicht kunnen geven van de uitbreidingsprioriteiten en de budgettaire koppeling hieraan. We gaan met een meerjarentraject van start in 2027.

- P127: “We implementeren een CrisisApp die een snelle en efficiënte matching faciliteert van kinderen in crisissituaties aan een pleeggezin.”
 - Wat is de timing? Hoeveel budget werd aangewend voor het maken en opstarten van de app? Wat zijn de lopende werkingskosten?

Begin 2026 wordt de app geïmplementeerd bij de groep van pleeggezinnen die op dit moment gescreend zijn als crisispleeggezin. Als de app helemaal technisch op punt staat, zal de app in een volgende fase (half 2026) geïmplementeerd worden.

Er werd 53.000 euro besteed voor het ontwikkelen en opstarten van de app. Dit bedrag wordt bekostigd door de diensten voor pleegzorg. De werkingskosten (jaarlijkse onderhoudskosten van de app) worden geschat op ongeveer 2.500 euro per jaar.

- Zal deze app provincie overschrijdend werken?

Ja, deze mogelijkheid is voorzien.

- P127: “We versterken de residentiële hulpverlening volgens nieuwe programmatie om tot regionale evenwichten te komen.”
 - Wat is de timing voor deze oproep? Hoeveel bijkomende capaciteit wordt er beoogd en in welk type opvang? Wat is het voorziene budget?

In een eerste fase, 2026, wordt een analyse gemaakt van de huidige programmatie en de regionale inbedding. De versterking van het residentiële aanbod situeren we vanaf 2027, en in 2028. Een versterking van het residentiële aanbod behelst niet enkel een uitbreidingsbeleid, maar in eerste instantie het mogelijk maken dat de huidige capaciteit ten volle, en kwalitatief, ingezet kan worden. Concrete versterkings- en uitbreidings-initiatieven zullen in de loop van 2026 verder vorm krijgen.

- P127: “We zorgen voor een bredere zorgstrategische oefening en een bijhorend aangepast kader voor zorgstrategische planning per regio om het divers jeugdhulppalet af te stemmen op de noden in die specifieke regio.”
 - Wie zal deze zorgstrategische oefening uitvoeren? Wat is hiervoor de timing en wanneer worden de resultaten verwacht? Welk budget staat hier tegenover?

In een eerste fase, 2026, zal Opgroeien een analyse maken van de huidige programmatie en de regionale inbedding. We komen op basis hiervan tot een heldere gebiedsafbakening, waarin we de diversiteit van het hulpaanbod kunnen situeren, en op basis van de spreiding mogelijke noden of hiaten beter in kaart hebben. We koppelen toekomstig uitbreidingsbeleid en regionale afstemming aan deze zorgstrategische oefening, en komen tot een heldere inbedding van het volledige jeugdhulpaanbod.

- P128: “Op basis van de praktijkervaringen met betrekking tot de hulpprogramma’s geblokkeerde ontwikkelingstrajecten installeren we een innovatieruimte met heldere rollen en mandaten”
 - Wat wordt er concreet bedoelt met ‘een innovatieruimte’? Welk budget staat hier tegenover?

Met ‘innovatieruimte’ wordt bedoeld dat we vanuit de overheid in samenspraak met het betrokken werkveld een context creëren waarin de partners maximaal gestimuleerd worden om tot innovatieve trajecten te komen voor de doelgroep, en waarbij we die

trajecten ook systematisch zullen monitoren. Daar staat geen extra budget tegenover. Dit valt binnen het bestaande financieringskader voor de hulpprogramma's.

- P129: “Deze noodoplossing kan enkel gefaciliteerd worden binnen de GI wanneer er parallel sprake is van de uitfasering van twee time-out leefgroepen.”
 - Over hoeveel plaatsen gaat het concreet bij het sluiten van de 2 time-out leefgroepen? Hoe zal dit binnen het reguliere aanbod worden opgevangen?

Het sluiten van twee Time-Out-leefgroepen in de Gemeenschapsinstellingen, staat in verhouding tot een capaciteit van 10 per unit/ een totaal van 20 plaatsen voor 2 units. Er is zowel time-out voorzien voor jongens als voor meisjes en heeft altijd een duur van 14 dagen. Het agentschap Opgroeien loopt momenteel een traject met de sector (zowel jeugdhulpvoorzieningen, VAPH-voorzieningen, als de kinder- en jeugdpsychiatrie) hoe we dit kunnen vervangen naar passende hulpverlening binnen de jeugdhulp. Over de concrete fasering moeten we nog verdere afspraken maken.

- P131: “Daarom sluiten we samen met mijn collega-minister van Justitie een samenwerkingsprotocol af dat deze gedeelde bevoegdheid vormgeeft.”
 - Wat is de voorziene timing van dit samenwerkingsprotocol?

Samen met de minister van justitie wordt een samenwerkingsprotocol uitgewerkt tegen het einde van dit jaar.

- P132: Op begrotingsartikel GB0-1GEF2MX-IS worden de werkingstoelagen voor jeugdhulp begroot.
 - Graag een opdeling van het budget voor preventieve jeugdhulp, basishulpverlening, crisishulp, residentiele hulpverlening, ambulante hulpverlening.

We gaan over het geheel van de regeerperiode voor een grofmazige spreiding als volgt:

- Preventief: 20%
 - Laagintensief: 20%
 - Reguliere jeugdhulp: 40%
 - Complexe jeugdhulp: 20%
- Naar welke concrete acties zal het 8.798 keuro uitbreidingsbeleid gaan?

Het uitbreidingsbeleid wordt in hoofdzaak aangewend om de tijdelijke projectsubsidies n.a.v. het crisis- en investeringsplan te continueren. Daarnaast hebben we gerichte ingrepen gedaan om de samenwerking tussen welzijn en onderwijs, in het bijzonder de internaten, te optimaliseren.

- Graag uitsplitsing van de –7.000 KEUR aan verdaagd uitbreidingsbeleid naar 2027. Welke bedrag ging waaraan worden uitgegeven in 2026 en in

welke periode van 2027 plant men dit nu vast te leggen?. Welk beleid zal hierdoor vertraagt worden tot 2027?

We maken expliciet de keuze om niet te besparen op kinderen en jongeren. Om de budgetafspraken binnen de Vlaamse Regering na te komen, is er wel voor gekozen om te temporiseren met het uitbreidingsbeleid. In 2026 starten we uitbreiding en structurele verankering van de Overkop-huizen, investeren we in vroegdiagnostiek en in aanbod voor het ongeboren kind. Door te schuiven met de opstartdata kunnen we deze noodzakelijke initiatieven in de loop van 2026 opstarten en structureel ondervangen met het uitbreidingsbeleid van 2027.

- P134: Bij de bijstelling op begrotingsartikel GB0-1GEF2MX-IS lezen we dat er 1,5 miljoen euro bespaard wordt door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen, meer bepaald de activering van opgebouwde reserves. Het kader is nog uit te werken.
 - Over welke reserves bij welke actoren binnen Jeugdhulp gaat het concreet?

Zie antwoord op vraag 1.

- Wat is de stand van zaken van dit kader? Wat is hier de voorziene timing?

Zie antwoord op vraag 1.

- P135: “Ten opzichte van BA2025 worden de ontvangsten uit de gezinsbijslagen van geplaatste kinderen constant gehouden, deze blijven behouden op 9.861 keuro.”
 - Hoe wordt dit gerijmd met het feit dat de gemeenschapsinstellingen onderdeel zullen uitmaken van Agentschap Justitie en Handhaving en zij zullen instaan voor de zorg van de geplaatste jongeren? Gaat een deel van deze middelen alsnog naar het andere agentschap?

Dit bedrag van 9.861 k euro wordt al enkele jaren constant gehouden in de begroting van Opgroeien regie, terwijl er hier wel groei op zit door bijkomende plaatsen en indexering. In 2024 werd er 10,1 mio euro gerealiseerd op dit begrotingsartikel. In 2025 zijn er de CKG's en nog enkele plaatsen mbt veilige trajecten bijgekomen waarvoor Opgroeien regie Groeipakketmiddelen inschrijft aan ontvangstenzijde.

Naar 2026 toe komt daar nog eens een indexering bij. Door deze toename van Groeipakketmiddelen gelinkt aan residentiële plaatsen in de jeugdhulp was het logisch om het bedrag van 9.861 k euro te behouden aan ontvangstenzijde, ondanks het feit dat de middelen voor de GI's, geraamd op 460 k euro, hieruit gaan.

Aan uitgavenzijde wordt geraamd dat er 460 k euro aan Groeipakketmiddelen via een interne stroom rechtstreeks naar AJH gaat voor de plaatsen in de

gemeenschapsinstellingen. Het gaat hier om een raming op basis van realisaties in 2024.

- Vraag over de begrotingsruiters binnen ISE Jeugdhulp: Welke bedragen aan vastleggingskredieten van 2025 worden overgeheveld naar 2026?

Bij BO2026 werd er geen ruiter voorzien om vastleggingskredieten over te hevelen van 2025 naar 2026.

ISE Geïntegreerd gezinsbeleid

- P139: Duiding bij en tijdlijn voor de uitvoering van het plan “Ieder Kind Taalheld”

De verdere operationalisering van het plan “Ieder Kind Taalheld” en de rol van de Huizen van het Kind daarbinnen is voorwerp van verdere uitwerking.

- P139: “We zetten in uitvoering van dit plan ook in op de professionalisering van de kinderbegeleiders in de kinderopvang en ondersteunen het op te richten Kennis- en Innovatiecentrum om hiervoor de nodige leermiddelen te ontwerpen.”
- Wat is de timing voor het oprichten van dit Kennis- en Innovatiecentrum? Welke actoren worden hierbij betrokken? Wat is hier het doel van? Wat is het voorziene budget?

We willen de regelgevende basis voor dit Kennis- en innovatiecentrum in het voorjaar van 2026 goedgekeurd hebben. De bestaande budgetten die hier nu al voor ingezet worden ten aanzien van verschillende ondersteuningspartners worden hiervoor geheroriënteerd. Door deze bestaande budgetten te bundelen bekomen we efficiëntiewinsten. Er wordt geen nieuw budget voorzien.

- P139: “We werken aan een nieuw erkennings- en financieringskader om de Overkop-huizen bij te sturen waar nodig en te verduurzamen.”
 - Welk tijdspad wordt hier voorzien?

We voorzien een gefaseerde aanpak: we continueren de huidige investeringen, incl. tijdelijke en projectmatige middelen voor psycho-educatie, vanaf 1 januari 2026. Het nieuwe kader voor de erkenning en financiering zal in werking treden vanaf januari 2027.

- Pg 140: “We werken in 2026 verder aan de uitvoering van ons plan Kinderopvang, volgens het ‘Plan Kinderopvang 2025-2029’ van 4 april 2025.”
 - Hoeveel van de extra plaatsen die de minister realiseerde in een eerste oproep worden gerealiseerd of werd op ingeschreven?

Er werd een eerste oproep gelanceerd op basis van een meerjarenprogrammatie voor 4500 trap 2-plaatsen. Aanvragen konden ingediend worden tot half september.

Opgroeien doorloopt nu het beslissingsproces. Half december 2025 gebeuren de toekenningen. Er waren iets meer dan 500 aanvragen, voor in totaliteit ruim 11.000 aangevraagde plaatsen.

- Wat zal er gebeuren met de plaatsen die open blijven staan?

Na toekenning van de plaatsen half december 2025 zal bekeken worden of en op welke manier zo snel als mogelijk een heroproep mogelijk is voor de resterende vrije middelen.

- Welke concrete stappen en timing voorziet de minister voor de verdere uitrol van het plan?

We voorzien eind dit jaar nog een oproep voor 600 plaatsen voor innovatief inkomensgerelateerd aanbod. Later deze legislatuur volgt nog een oproep voor 600 plaatsen voor gemeenten die op basis van cijfers van het lokaal loket kinderopvang grote nood hebben aangetoond.

- Hoeveel plaatsen werden toegekend in de oproep voor het omzetten van plaatsen naar trap 2? Welke timing voorziet de minister voor een nieuwe oproep gericht op gemeenten die nu niet werden opgenomen in de lijst maar waar wel interesse was?

De vorige oproep voor omschakeling naar trap 2 (vorige legislatuur) gebeurde niet op basis van een programmatie per gemeente. Aanvragen uit alle gemeenten waren mogelijk. De specifieke modaliteiten voor de oproep die we deze legislatuur zullen doen, moeten nog vastgelegd worden.

- Pg 140: “We blijven in dialoog gaan met de Toekomstgroep, met een focus op de visie en de strategie op de langere termijn om kinderopvang verder uit te bouwen als kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorziening voor elk gezin met jonge kinderen.”
 - Wanneer is het eerstvolgende overleg gepland met de Toekomstgroep? Welke thema's zullen op dit gesprek besproken worden?

De Toekomstgroep werkte in maart 2024 zijn eindrapport af. Het is niet de bedoeling dit werk nog eens over te doen. De dialoog met de Toekomstgroep zal heropgestart worden rond bepaalde specifieke toekomstgerichte aspecten die in dit eindrapport nog niet of onvoldoende werden uitgewerkt verder aan bod komen.

Een eerste agendapunt, momenteel in behandeling door de Toekomstgroep, betreft een globale vraag met meerdere deelvragen over het toekomstige (organisatorische) opvanglandschap van de Vlaamse Kinderopvang. De toekomstgroep heeft hierover tot nu twee keer van gedachten gewisseld. Een eerste inleidende keer op 19 juni 2026, en een tweede keer op 13 oktober 2026. De Toekomstgroep zal in januari-februari 2026 de werkzaamheden verderzetten.

- Pg 140: “Daarnaast kan het gaan om innovatie binnen de kinderopvang waarbij groeps- en gezinsopvang sterk geïntegreerd samenwerken. We volgen deze initiatieven op, met het oog op een beter geïntegreerde dienstverlening aan gezinnen met jonge kinderen.”
 - Hoeveel groeps- en gezinsopvangen werken momenteel op een sterk geïntegreerde manier samen?

Momenteel wordt dit niet geregistreerd, waardoor we hierover dus ook geen cijfers kunnen geven.

- Pg 140: “We implementeren een nieuw kader rond noodopvang...”
 - Wat is de timing?

Het bestaande kader rond tijdelijke vervangcapaciteit zal verlengd worden tot eind 2026, om dan in het voorjaar van 2026 een nieuwe regeling rond noodopvang uit te werken.

- Pg 140: “We werken aan een eenvoudige en transparante registratie van alle unieke vragen naar kinderopvang die over alle lokale loketten heen gebruikt kan worden.”
 - Wat is de timing?

We willen in 2026 hiervoor een digitale tool ontwikkelen.

- Hoe zullen de huidige data gebruikt worden voor de bijkomende oproep in 2027?

Dat hangt af van de verdere evolutie van het digitaliseringsproces.

- Pg 141: “Tot slot lanceren we een oproep waarmee 2400 bestaande plaatsen met de basissubsidie kunnen omschakelen naar de subsidie voor inkomenstarief.”
 - Wanneer zal deze oproep gelanceerd worden? Wat zal de duur van deze oproep zijn?

De modaliteiten voor deze oproep moeten nog worden vastgelegd, exacte timing is nog niet gekend.

- Pg 141: “We trekken, samen met de minister van Werk, lessen uit de evaluatie van de vijf proeftuinen voor kinderopvang in samenwerking met bedrijven”
 - Welke timing voorziet de minister voor de bekendmaking van deze evaluatie?

Deelnemers aan de proeftuinen krijgen tot 31 maart 2026 de tijd om hun inhoudelijke en financiële rapportage in te dienen bij WSE. Op basis van die rapportages zal dan een eindevaluatie opgemaakt worden in het tweede kwartaal van 2026.

- Op welke manier zal er aan de slag worden gegaan met zaken die naar voor komen?

Dat is afhankelijk van wat uit de eindevaluatie zal blijken.

- Pg 141: “We monitoren en evalueren hoe de sector de overgang maakt naar de lagere ratio die vanaf 2027 verplicht wordt.”
 - Hoe zal deze monitoring en evaluatie concreet gebeuren? Welke timing voorziet de minister voor de evaluatie?

Tijdens de overgangperiode wordt nauwgezet opgevolgd hoeveel initiatieven groepsopvang de extra subsidie voor medewerkersbeleid aanvragen als ze de nieuwe ratio al realiseren. Daarnaast volgen we ook nauwgezet de impact op de bezetting van het bestaande aanbod.

- Pg 142: “We volgen op in welke mate flexi-jobs in de kinderopvang worden ingezet en evalueren dit samen met de sociale partners.”
 - Wat is de timing? Hoe zal dit opgevolgd worden?

Flexi-jobs zijn een bevoegdheid van de federale overheid. We krijgen op regelmatige basis gegevens door van RSZ, om op te volgen in welke mate die worden ingezet in de Vlaamse kinderopvang.

- Pg 142: “Op vlak van de pedagogische kwaliteit onderzoeken we of en hoe het pedagogisch raamwerk en het zelfevaluatie- en monitoringinstrument voor de opvang van baby’s en peuters kunnen worden verruimd met het aspect groepssocialisatie.”
 - Wat is de timing?

De resultaten zullen bekend zijn tegen de zomer van 2026

- Zal dit kaderen in een brede evaluatie van het zelfmonitoringsinstrument en de MeMoQ?

Er gebeurde reeds een evaluatie van het monitoringsinstrument in 2023, de resultaten zijn beschikbaar op de website van Opgroeien: [Evaluatie MeMoQ Monitoring Instrument | Opgroeien](#). Deze actie komt er n.a.v. de aanbevelingen inzake de 1-meting van MemoQ, zie ook [MeMoQ éénmeting: pedagogische kwaliteit Vlaamse kinderopvang | Opgroeien](#)

- Pg 142: “We evalueren het starterstraject en sturen bij indien nodig.”
 - Wat is de timing? Door wie zal deze evaluatie gebeuren? Op welke manier wordt de sector betrokken?

Het evaluatierapport over het starterstraject zal worden afgerond in het eerste kwartaal van 2026. Op basis van deze evaluatie zullen eventuele beleidsvoorstellen voor de optimalisering van het starterstraject worden uitgewerkt en in overleg met de betrokken stakeholders besproken. Dit overleg is voorzien tegen het einde van het vierde kwartaal van 2026, zodat de implementatie van het geoptimaliseerde starterstraject begin 2027

kan worden afgerond. Voor de opmaak van de evaluatie wordt samengewerkt met Mentos, het ondersteuningsnetwerk kinderopvang, aangezien het starterstraject een gezamenlijke inspanning is van het agentschap en dit netwerk. Op deze manier wordt de sector structureel betrokken bij zowel de evaluatie als de verdere optimalisering van het traject.

- Welke aanpassingen werden reeds gedaan en hoe worden deze aanpassingen onthaalt door het werkveld?

Naar aanleiding van signalen uit de sector heeft het agentschap het vrijstellingsbeleid inmiddels aangepast. Waar dit beleid vroeger strikt werd toegepast – een vrijstelling werd enkel verleend wanneer de organisator op alle domeinen over voldoende beleidsvoerend vermogen beschikte – hanteren zij nu een meer pragmatische aanpak. Concreet werden volgende versoepelingen reeds toegepast:

- Wijziging van organisator zonder inhoudelijke wijziging van de werking
- Vrijstelling bij substantiële beleidsbekwaamheid
- Wijziging van groepsopvang naar gezinsopvang

Daarnaast werd door Mentos het begeleidingstraject van het starterstraject bijgestuurd met een onderscheid tussen:

1. een traject voor nieuwe organisatoren, en
2. een traject voor bestaande organisatoren die hun werking willen uitbreiden, met focus op groei en duurzame uitbouw.

- Heeft het werkveld ook andere werkpunten aangehaald die meegenomen zullen worden in de evaluatie?

Alle aandachtspunten en werkpunten die naar voren komen uit de bevraging bij kandidaat-organisatoren, evenals uit de besprekingen met het ondersteuningsnetwerk en de koepelorganisaties, zullen integraal worden meegenomen in de evaluatie van het starterstraject.

- Pg 143: “We ontwikkelen in overleg met de minister van Onderwijs voorstellen tot wijziging van de regelgeving om drempels in de samenwerking tussen opvang en kleuteronderwijs weg te werken.”
 - Wat is de timing hiervoor?
 - Welke actoren zullen nog betrokken worden bij het bepalen van deze wijzigingen?

We willen alvast begin 2026 de eerste voorstellen tot wijziging van de regelgeving hiervoor voorleggen. Deze voorstellen worden ook afgetoetst met het Raadgevend Comité van Opgroeien.

- P144: “We verankeren het evaluatiemodel zorgtoeslag 2.0 dat garanties biedt op kwaliteit, uniformiteit en snelheid van evalueren van de specifieke zorgnood bij Opgroeien.”
 - Wat houdt het evaluatiemodel zorgtoeslag 2.0 concreet in? Op welke vlakken biedt dit een verbetering van de kwaliteit, uniformiteit en snelheid?

In 2024 is het vierogenprincipe geïntroduceerd met medisch ondersteuners en interne/externe artsen. Er is echter verdere optimalisering mogelijk door de medische expertise van artsen voornamelijk daar in te zetten waar de inhoud van de aanvraag dit vereist. Daarom evolueert Opgroeien regie nu naar een evaluatieteam dat wordt samengesteld vanuit verschillende profielen, waaronder ook steeds één of meerdere artsen. Dit team behandelt de aanvragen voor zorgtoeslag als geheel, waarbij in functie van de inhoud van de aanvraag die profielen worden ingezet voor de voorbereiding én finale eindevaluatie die het meeste kennis en expertise daarin hebben.

- P144: “In 2026 bereiden we de overheidsopdracht voor waarmee artsen zullen worden aangeduid om de evaluatie van de zorgnood uit te voeren.”
 - Wat houdt dit concreet in? Gaat het om bijkomende artsen bij Opgroeien voor de zorgtoeslag of worden de huidige artsen vervangen?

Het huidige erkenningssysteem wordt opgeheven. Extern evaluerend artsen worden aangewezen door middel van een overheidsopdracht, waarbij evenwel niet de prijs maar wel de kwaliteit het bepalende criterium zal zijn.

- P144: “We zetten verder in op de versterking en professionalisering van het Afstammingscentrum zodat de verwachtingen vanuit de verschillende doelgroepen ingelost worden. We voorzien daarbij niet enkel bijkomende middelen maar sturen ook aan op een efficiëntere werking.”
 - Welke middelen zijn voorzien voor het Afstammingscentrum? Op welke manier zal ingezet worden op professionalisering?

Vanaf 2026 wordt er bijkomend 300.000 euro toegekend aan het Afstammingscentrum opdat nieuwe aanvragen tijdig behandeld kunnen worden en de bestaande wachtlijst weggewerkt kan worden. Naast een verhoging van de middelen, is het evenzeer noodzakelijk in te zetten op een meer efficiënte werking – daarbij staat het begrenzen van de gemiddelde begeleidingsduur (doorlooptijd) van de dossiers centraal.

- P145: “Verder bouwend op het werk van een werkgroep en wetenschappelijk onderzoek, implementeren we het theoretische raamwerk voor een gezamenlijk voortraject ‘pleegzorg – adoptie’ in regelgeving en praktijk, zodat de eerste kandidaten vanaf 2027 kunnen worden voorbereid en gescreend.”
 - Wat is het tijdspad dat hier werd uitgetekend? Wie zijn de betrokkenen hierbij?

Op dit moment is de inwerkingtreding voorzien voor begin 2027. In functie van een aantal nodige aanpassingen aan de sectorale regelgeving (zowel bij pleegzorg als adoptie), zal deze datum mogelijks nog iets naar achter verschuiven.

De praktische implementatie van het voortraject berust bij de diensten die momenteel al een rol spelen in het voortraject pleegzorg – adoptie, met name het Steunpunt Adoptie, de Dienst voor maatschappelijk onderzoek (MOA) vzw, de provinciale pleegzorgdiensten en Pleegzorg Vlaanderen.

- P145: op begrotingsartikel GB0-1GEF2UX-IS worden de middelen voor kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, adoptie, geïntegreerd gezinsbeleid en het Groeipakket begroot.
 - Graag een opdeling van het budget per sector, met een verdere uitsplitsing van kinderopvang (voorschoolse en BOA) en adoptie (binnenlandse, interlandelijke en het Afstammingscentrum).

De uitgaven voor kinderopvang worden begroot op 1.557,7 mio euro, voor PGJO op 36,2 mio euro en voor adoptie op 3,9 mio euro.

De beleidsuitgaven voor Groeipakket worden niet gefinancierd vanuit GB0-1GEF2UX-IS maar wel vanuit GB0-1GEF2QX-IS.

Binnen kinderopvang gaat er 1.290 mio euro rechtstreeks naar voorschoolse kinderopvang en 204,5 mio euro naar buitenschoolse kinderopvang. Voorts is er ook nog het budget voor zij-instroom van 30 mio euro en zijn er nog een aantal VIA-subsidies, uitgaven lokale loketten en nog enkele andere uitgavenrubrieken.

De beleidsuitgaven voor Groeipakket worden niet gefinancierd vanuit GB0-1GEF2UX-IS maar wel vanuit GB0-1GEF2QX-IS.

Binnen adoptie wordt budget voor Afstammingscentrum begroot op 874 duizend euro en het budget voor binnenlandse adoptiedienst op 669 duizend euro. Voorts zijn er nog de uitgaven voor nazorg, maatschappelijke onderzoeken, het steunpunt adoptie en de uitgaven die VCA zelf doet ikv interlandelijke adoptie.

- Graag ook apart het budget voor de Huizen van het kind, de OverKop-huizen en de consultatiebureaus.

De uitgaven voor de consultatiebureaus worden begroot op 18 mio euro, deze voor Overkop, exclusief uitbreidingsbeleid op 4,6 mio euro. Tenslotte worden de uitgaven voor de Huizen van het Kind inclusief Huis van het Kind Brussel geraamd op 3,6 mio euro. Voor de pilootprojecten van de Huizen van het Kind wordt er 1,35 mio euro begroot.

ISE Groeipakket

- P150: “Op basis van een conceptnota zal in 2026 het regelgevende traject worden opgestart en bekijken we daarbij welk technisch traject moet opgestart worden om te kunnen implementeren vanaf september 2028.”
 - Wat is de concrete timing voor de opstart? Wat zijn de voornaamste drempels in het dossier?

Een exacte datum is nog niet bepaald. Het in het regeerakkoord bepaalde overgangsmechanisme waarbij de huidige populatie van de sociale toeslag gevrijwaard wordt zal nog verder worden onderzocht en voor besluitvorming binnen de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

- P151: “Om de Centrale Groeipakketapplicatie performant en technologisch actueel te houden, zijn investeringen nodig.”
 - Wat is hier het nodige budget?

Er wordt een investeringsbudget voorzien van 2.500 duizend euro.

- P151: “We onderzoeken, in overleg met de federale overheid, de reeds bestaande aanpassingsmechanismen in bilaterale overeenkomsten voor de berekening van het Groeipakket en verschillende (belasting)voordelen toegekend aan personen van wie de kinderen permanent in een ander land buiten de Europese Economische Ruimte wonen. Met het oog op een meer algemeen aanpassingsmechanisme zullen we bilateraal akkoord per bilateraal akkoord onderzoeken.”
 - Wat is hier de stand van zaken in? Wat zijn de voornaamste drempels in dit dossier?

Het onderzoek is nog lopende. Uit dit onderzoek blijkt wel al dat voor aantal landen veel lagere bedragen worden uitbetaald. De voornaamste drempel bij een algemeen aanpassingsmechanisme is dan ook dat die eerder zou resulteren in hogere dan lagere uit te betalen bedragen. Vanuit die overweging valt te overwegen om dit project niet door te zetten.

- P155: begrotingsartikel GB0-1GEF2QY-IS
 - Er gaat 300 keuro naar de werking van het Afstammingscentrum. Welke acties kunnen hierdoor niet meer uitgevoerd worden binnen het Groeipakket? Wat is hier de verantwoording van?

De herschikking wordt gerealiseerd op het budget van de private uitbetalingsactoren. Uit de jaarrekening van de private uitbetalingsactoren blijkt dat de middelen niet geheel ten dienste van de burger staan, maar ook van de eigen werking (bv. marketingactiviteiten).

Er zijn dus op zich geen acties die hierdoor niet meer kunnen worden uitgevoerd en de burger zouden raken.

- Er wordt 1,5 miljoen euro bespaard op het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen bij de werkingsenveloppe van de private uitbetalingsactoren. Welke effect heeft dit op de private uitbetalingsactoren? Wat betekent dit concreet?

Cfr. vorige vraag.

- P155: “GDF-BGEFAQB-OW omvat de terugvorderingen i.k.v. groeipakket t.b.v. 34.836 keuro.”
 - Op basis waarvan wordt nu het teruggevorderde bedrag reeds ingeschreven in de begroting? Over welke terugvordering gaat het concreet?

Het bedrag van de geraamde terugvorderingen is gebaseerd op de uitvoeringscijfers van 2024. Het bedrag aan terugvorderingen uit boekjaar 2024 is gewoon overgenomen als raming voor begrotingsjaar 2026. Op het betrokken begrotingsartikel worden enkel de terugvorderingen ingeschreven die betrekking hebben op rechten van de vroegere rechtsjaren en die ontstaan zijn bij de private uitbetalingsactoren. De terugvorderingen die ontstaan bij de publieke uitbetalingsactor zijn terug te vinden in de begroting van het VUTG. Het grootste deel van deze terugvorderingen bestaat uit schooltoeslagen die worden teruggevorderd na de uitvoering van de pedagogische eindcontrole. Maar daarnaast worden er jaarlijks ook gezinsbijslagen teruggevorderd.

VIII Beleidsveld personen met een handicap

ISE Personen met een handicap

- P161: Op welke manier worden de actoren bepaald die meewerken aan het Perspectiefplan? Beperkt zich dit tot louter zorg en ondersteuning of ook over andere domeinen?

Perspectiefplan 2040 is een langetermijnplan waarbij we visie en doelstellingen ontwikkelen voor een meer inclusieve en toegankelijke samenleving over alle beleidsdomeinen heen. De actoren die hieraan meewerken gaan ruimer dan de sector zorg en ondersteuning en zijn beleidsdomeinoverschrijdend. Voor elk van de levensdomeinen (werk, wonen en leefomgeving, mobiliteit en openbare ruimte, vrije tijd, onderwijs, gezondheid en welzijn) worden actoren betrokken uit verschillende beleidsdomeinen waaronder zowel experts uit het werkveld, academici, beleidsmedewerkers uit verschillende overheidsdiensten en ervaringsdeskundigen.

- P162: Hoeveel middelen zullen er in 2026 naar het CuSeHa-project gaan? Welke globale samenwerkingsovereenkomsten heeft het VAPH momenteel lopen? Welke budgetten gaan hiernaar toe?

De raming voor 2026 bedraagt € 230.589,95. Het VAPH is de mogelijkheden aan het verkennen tot structurele samenwerking met andere partners en beleidsdomeinen in het kader van het expertisecentrum handicap. Op dit moment zijn er nog geen samenwerkings-overeenkomsten afgesloten.

- P163: Welk deel van hun middelen zullen erkende/vergunde en gesubsidieerde organisaties kunnen inzetten om niet-VAPH organisaties te ondersteunen bij het nemen van initiatieven en acties die de eigen hulp- en dienstverlening, beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk maken voor personen met een handicap? Hoe zal dit concreet worden vormgegeven?

We zien het ontsluiten, delen en gericht inzetten van de eigen ervaring en expertise van professionals binnen de VAPH-sector ifv het meer open en toegankelijk maken van de samenleving en de hulp- en dienstverlening in deze samenleving als één van de kernopdrachten van organisaties die door het VAPH erkend en gefinancierd worden. De middelen die organisaties krijgen van het VAPH dienen dan ook om ook deze opdracht mee waar te maken.

- P163: Tegen wanneer zullen de evaluaties zoals bv. rond het PVB na jeugdhulp rond zijn en gepubliceerd worden?

De lopende evaluaties worden meegenomen in de projecten rond de hervormingen.

- P164: Wanneer zullen de in het UNIC-project ontwikkelde internationale tools aangepast zijn aan de Vlaamse context en wanneer zullen deze uitgerold worden?

De aanpassing van de tools die ontwikkeld zijn in het UNIC-project aan de Vlaamse context wordt meegenomen in het RAAVI-Interreg project (Zelfbeschikking herdenken, Inclusief leven nastreven). Dit project is van start gegaan in oktober 2024 en loopt tot september 2028.

- P164: Wanneer zal de evaluatie van de overlap tussen verschillende vergoedingen gemaakt en gepubliceerd worden? Welke uitgaventoetsingen lopen binnen het VAPH nog?

Er zijn twee uitgaventoetsingen die betrekking hebben op de personen met een handicap:

- Uitgaventoetsing 5: Evaluatie van de bestedingsregels cashbudgetten bij persoonsvolgende financiering

- Uitgaventoetsing 6: Evaluatie van de verschillende vergoedingen voor personen met een handicap en de overlap tussen Vlaamse en federale financiering

De timing van publieke rapportering is opgenomen in het document VR 2025 1402 MED 0035.

- P165: Wanneer zal de evaluatie van de intersectorale plaatsen voor complexe problematieken, hun instroom en uitstroom, gemaakt en gepubliceerd worden?

De projecten lopen nog. Een eerste rapportering is voorzien binnen medio 2026.

- P165: Welke budgetten aangerekend op begrotingsartikel GH0-AGGF2RD-WT zullen toegewezen worden aan de 2 verknopingsunits?

De verknopingsunits zijn ondertussen opgestart. Deze vorm van intensieve ondersteuning is geregeld door het Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van units voor personen met een handicap met een bijkomende ernstige psychische problematiek van 19/07/2024. Er wordt een maximale subsidiëring van ca. 600.000 euro voorzien per verknopingsunit op jaarbasis.

- P166: Wanneer zal het onderzoek naar de potentiële inbedding van een centraal aanspreekpunt inzake handicap in de eerstelijns afgerond zijn?

Het is de bedoeling om tegen midden 2028 lokaal verankerde Aanspreekpunten Handicap te installeren. Voorafgaand aan deze installatie zal onder meer een vooronderzoek en situatieanalyse plaatsvinden. Dit vooronderzoek zal ten laatste eind 2026 worden afgerond, zodat de verdere uitrol en implementatie tijdig kunnen worden voorbereid.

- P168: Wanneer zullen de door de organisaties ervaren administratieve lasten in kaart gebracht zijn?

De administratieve lasten voor organisaties werden in kaart gebracht op basis van inzichten uit de voorbije jaren. Het VAPH bekijkt waar lasten kunnen worden verminderd of vereenvoudigd, in een continu proces.

- P168: Wanneer zullen de projectsubsidies, de doelstellingen die bereikt wensen te worden en de bijdrage van de subsidies aan deze doelstellingen in kaart gebracht worden?

De nieuwe richtlijn ivm. subsidiekaders zal ervoor zorgen dat er een duidelijkere en meetbare link is tussen de doelstellingen van de subsidie en de realisatie ervan. Elke nieuwe regelgeving zal hieraan voldoen, waarna er een betere meting van de doelmatigheid en doeltreffendheid van elke subsidie mogelijk wordt.

- P169: Wanneer zal het onderzoek naar hoe er wordt geëvolueerd naar een nieuw regelluw en impactgericht kwaliteitskader afgerond zijn?

Het wetenschappelijk onderzoek is gepland tot eind juni 2026.

- P170: Wanneer zullen alle nodige processen geïmplementeerd zijn zodat de handhavingscyclus volledig is afgestemd met de Zorginspectie?

De implementatie verloopt gefaseerd met de voornaamste wijzigingen in het toezicht bij aanpassing van het kwaliteitsbesluit begin 2026.

- P171: Wanneer zal het onderzoek naar de factoren die leiden tot een krapte op de arbeidsmarkt in de sector personen met een handicap afgerond zijn?

Het VAPH houdt vinger aan de pols m.b.t. de moeilijkheden die budgethouders ondervinden om persoonlijke assistenten te vinden en de moeilijkheden die de voorzieningen ondervinden bij het vinden van personeel. Dit wordt meegenomen in diverse projecten m.b.t. de realisatie van de conceptnota, o.a. het project rond bestedingsregels, het project zorgniveau 3,...

- P171: Tegen welke datum zou de betere gegevensdeling van diagnostische gegevens en indicatiestellingen tot stand komen?

Deze datum is nog niet bekend. Het VAPH werkt in 2025 en 2026 samen met de entiteiten van het beleidsdomein WVG en Digitaal Vlaanderen in het project 'VRD3-Vitalink'. Diagnostische of indicatiestelling gegevens voor het VAPH zullen pas 2026 in scope komen.

- P172: Welke persoonlijke zaken zullen personen met een handicap zelf kunnen beheren in het e-loket?

In 2026 kunnen personen met een handicap zelf hun rekeninginformatie beheren, contactpersonen toevoegen, het toegangsniveau tot hun dossier voor samenwerkende organisaties aanpassen. We verbeteren ook het beheer van hulpmiddelen, aanpassingen, vervoers- en verblijfkosten.

- P172: Wanneer zal de problematiek rond woon- en leefkosten op de interministeriële conferentie onder de aandacht gebracht worden?

Hiervoor is nog geen timing beschikbaar.

P174: Waaraan zal de 7.000 keuro uit de terugdraai van eenmalige compensatie uit de vorige ronde worden gealloceerd?

Er zal 6 miljoen naar PAB gaan en 1 miljoen naar organisaties (MFC)

IX Beleidsveld Sociale bescherming

ISE Zorgbudgetten

P 204: we evalueren het inkomensonderzoek, dit gaat o.a. over het feit dat mensen die hun woning verkopen geen recht meer hebben op een zorgbudget ouderen. Welke stappen zijn hiervoor reeds ondernomen?

De uitgaventoetsing van de zorgbudgetten leidde tot een aanbeveling dat een herdefiniëring van het inkomensbegrip binnen het zorgbudget ouderen kansen biedt om de automatische rechtentoekenning van het zorgbudget ouderen te versterken. Zo is het mogelijk om een inkomensonderzoek uit te werken waarbij de benodigde administratieve informatie digitaal raadpleegbaar is en geen tussenkomst van de gerechtigde vergt (bv. een inkomensstoets op basis van aanslagbiljet en kadastraal inkomen). Het agentschap gaat nu de inkomensbepalingen van andere entiteiten van het beleidsdomein samen met deze entiteiten evalueren op hun bruikbaarheid voor het zorgbudget ouderen.

P 205: welke noodzakelijke IT-investeringen zijn nog in planning voor de VSB?

Naast de noodzakelijke kost voor (onderhoud) van de infrastructuur en het onderhoud van de toepassingen per pijler moet er verder geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van reeds beslist beleid en i.k.v. de inkanteling van nieuwe pijlers zoals Diensten Gezinszorg, Zorgcoördinatie/casemanagement en het CAR/CGG pilootproject in de Vlaamse Sociale Bescherming.

P 205: hoe groot is de aangroei in capaciteit waarvan sprake bij het infrastructuurforfait?

De capaciteitsgroei in 2026 werd op moment van de begrotingsaanpassing geraamd op 2.122 eenheden. Voornoemde capaciteitsuitbreiding is slechts een foto genomen in juni, toen onder meer de resultaten van de meest recente oproep 10 nog niet waren verwerkt. Dit zal bijgevolg nog wijzigen in functie van gewijzigde timing en behoefte.

P 205: herinzet vrijgekomen middelen PVT. Hoe moeten we dit zien voor de toekomst van deze zorgvorm?

We bekijken hoe deze middelen kunnen aangewend worden voor het versterken van het geestelijke gezondheidsaanbod voor personen met ernstige en langdurige psychische zorgnoden.

P 206: daling toelage door meerontvangsten zorgpremie, gaat dit naar algemene middelen terug of gealloceerd op ander beleid binnen WVG?

De zorgpremie gaat naar de VSB. De ontvangsten daar zijn uiteraard niet dekkend voor het beleid WVG.

P 206: kan er duiding gegeven worden bij de 3,5% kostendrijver MOHM en de mildering hierop?

Bij de inkanteling van de mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse Sociale Bescherming is een kostendrijver aanvaard van 3,5% per jaar. In het regeerakkoord werd afgesproken op deze kostendrijver een mildering door te voeren van 1,8 miljoen euro per jaar.

P 206: klopt het dat de 135 mio extra door stijging zorgpremie er enkel komt door de verhoging van de zorgpremie zelf en de stijging in ontvangsten via constant beleid door demografische groei? Is die stijging van de zorgpremie toegepast op die demografische groei ook?

De 135 mio stijging is de extra ontvangst door de verhoging van de zorgpremie en die is berekend net zoals de eerdere raming ontvangsten zorgpremie op basis van de demografische groei.

P 207: ontvangsten uit beleggingen nemen af met 2,2 mio. Hoeveel bedragen de totale ontvangsten uit beleggingen binnen VSB?

De totale verwachte ontvangsten voor 2026 bedragen 25.774 keuro. De daling is onder andere te wijten aan obligaties die aflopen.

P 207: stijging BTZ zorgzwaarte gaat al enkele jaren mee met een bedrag van 9.000 keuro. Op basis waarvan is dit bedrag bepaald? Is het voldoende voor opvang zorgzwaarte?

Dit bedrag is forfaitair bepaald om bij begrotingsopmaak (BO) rekening te houden met het feit dat de BTZ stijgt als de zorgzwaarte stijgt. Bij de begrotingsopmaak, die in het jaar vooraf aan de begroting plaatsvindt, kennen we immers nog niet de effectieve BTZ per voorziening. Bij begrotingsaanpassing wordt rekening gehouden met de effectief berekende BTZ per voorziening voor het betreffende kalenderjaar.

P 207: op welke manier worden werkingssubsidies zorgkassen efficiënter ingezet?

Er wordt in 2026 1 miljoen euro in mindering gebracht op de werkingsmiddelen van de zorgkassen. Deze vermindering wordt evenredig verdeeld over de werkingssubsidie van de zorgkassen per pijler.

P212: “We bouwen aan een zorgprognose-instrument via het ZorgAtlas Data Platform, waarmee we de toekomstige zorgnood in kaart trachten te brengen en gebruiken dit in eerste instantie voor de meerjarenbegroting van enkele pijlers. Wat is de timing van dit instrument en wie werkt mee aan de uitwerking ervan?

Het project verloopt in 2 grote fasen. In een eerste fase wordt in 2026 een technische startversie voor het zorgprognosemodel ontwikkeld. Vervolgens zal in een tweede fase, tegen 2029, het eigenlijke zorgprognosemodel ontwikkeld worden. Het zorgprognose model bevindt zich momenteel in conceptuele fase waarin een wetenschappelijk

onderzoek door LUCAS (KU Leuven) wordt uitgevoerd naar welke data relevant zijn voor de inschatting van de evolutie van de zorgnood.

ISE Algemeen beleid sociale bescherming

P167: “We onderzoeken de mogelijkheid van efficiënte gegevensuitwisseling tussen administraties met een homogeen bevoegdheidsbeleid, zoals Wonen in Vlaanderen, VIPA en VSB. Het beleid rond het huren of hergebruiken van hulpmiddelen wordt voortgezet en mogelijke uitbreidingen worden onderzocht. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure, zodat mensen rechtstreeks bij het agentschap terecht kunnen voor diverse hulpmiddelen.” Wanneer mogen we de resultaten van dit onderzoek verwachten? Idem voor de aanvraagprocedure.

Er heeft afstemming plaats gevonden tussen VIPA en het VAPH, ook in overleg met de sector, over de financiering van bepaalde hulpmiddelen via de refertelijst van het VAPH dan wel het infrastructuurforsait van VIPA. Die afstemming vond plaats in kader van een herijkingsoefening van het infrastructuurforsait. De resultaten zullen tegen eind opgeleverd worden.

X Beleidsveld Zorginfrastructuur

ISE Zorginfrastructuur

- P220: “Om voorzieningen met reële investeringsnoden in een context van beperkte overheidssubsidies toch te helpen om hun financieel plan voor een nieuwbouw- of renovatieproject of emissiebeperkende investering rond te krijgen, ontwikkelen we een Rollend Welzijnsfonds door het activeren en inzetten van de reserves binnen de Vlaamse Sociale Bescherming.”
 - A) Over welke reserves gaat het concreet? Hoeveel budget wordt hiervoor voorzien?

Zie eerder antwoord op deze vraag.

- B) Wat is de timing voor oprichting en operationalisering van dit Rollend Welzijnsfonds?

We starten met de evaluatie van de uitvoering van de bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 december 2018 betreffende de financiering van de welzijnssector uit Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VR 2018 2112 DOC.1640/1BIS) om nog in 2026 met aangepast voorstel te komen.

XI Apparaatskredieten en begrotingsprogramma's zonder beleidsveld

/

Technische vragen BBT WVGA – Open VLD

Overkoepelende strategische doelstellingen

p. 15 Er is sprake van experimenteren met 1 zorg en welzijnserkenning. Kan dat worden toegelicht ? Welke stappen zijn daar al gezet ?

In het traject ToekomstZorg zullen we innovatieve piloten toestaan voor intersectorale samenwerking. We voorzien een innovatieruimte waarbinnen in een regelluw kader kan worden gepiloteerd. Eén van de projectoproepen zal specifiek oproepen tot 1 erkenning.

p. 15 Er komt één uitbetalingsactor in het Groeipakket. Wanneer komt die er ?

Zie het eerder antwoord op deze vraag.

Beleidsondersteuning

p. 33 GBO-1GCF2BA-WT beleidsontwikkelingen en -ondersteuning : graag een uitsplitsing tussen kost advies- en overlegorganen, IT-middelen, Vlaamse Ouderenraad, het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, SAM, Sociaal.Net, SOM en IMEC

Categorie	VAK (keure)	VEK (keure)
Advies- en overlegorganen	15	15
IT-middelen	9.913	11.140
Vlaamse Ouderenraad	1.026	1.026
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek	290	290
SAM	3.495	3.495
Sociaal.Net	386	386
SOM	161	161
IMEC	577	577

p. 26 Op vlak van de subquota voor geneeskunde en tandheelkunde, zal Vlaanderen aan de federale overheid haar vaststellingen mbt het aanbod van huisartsen en tandartsen per zorgregio bezorgen zodat het federale quotum voldoende hoog is ? Wordt bijvoorbeeld het gebrek aan arbeidsgeneesheren mee in rekening gebracht. Dat is zeker belangrijk nu men wil remediëren aan de aangroei van het aantal langdurig zieken.

De federale overheid voert bij het vastleggen van de federale quota overleg met de Vlaamse overheid en kan op verzoek van de Vlaamse Regering de federale quota verhogen. Dit kan gebeuren om bijvoorbeeld het historisch ondertal aan artsen in Vlaanderen weg te werken.

Arbeidsartsen vallen buiten de contingentering. De instroom in deze vervolgopleidingen wordt bijgevolg niet ingeperkt door het subquotabeleid. De Vlaamse overheid houdt verder wel rekening met de instroom in deze niet-gecontingenteerde vervolgopleidingen bij het bepalen van de startquota.

p. 26 De erkenning van buitenlandse zorgverleners verloopt vaak zeer traag. Wordt hier voorzien in verbetertrajecten ?

Zowel voor aanvragers zelf als voor de organisaties waarbinnen zij tewerkgesteld willen worden is een redelijke doorlooptijd van belang. Echter moeten we ons ook bewust zijn van de complexiteit van die aanvragen én van het belang van een afdoende controle om een kwaliteitsvolle instroom in de zorg te garanderen.

NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) beoordeelt de gelijkwaardigheid van diploma's en valt onder het beleidsdomein Onderwijs & Vorming waarvoor minister Demir bevoegd is. Voor verschillende diploma's moet daarna nog een erkenningsaanvraag ingediend worden bij het Departement Zorg. Het Departement Zorg en NARIC-Vlaanderen houden sinds juni 2025 ook periodiek overleg opdat Vlaanderen een eenduidige dienstverlening kan aanbieden aan kandidaat-zorgverleners met een buitenlands diploma. Daarnaast worden de werking van erkenningscommissies verbeterd en de communicatie naar de aanvrager transparanter gemaakt.

p.31 Om tijdens crisissituaties snel te kunnen optreden, voorziet men in een reserve-eenheid die op korte termijn inzetbaar is. Daarvoor worden afspraken gemaakt met een externe partner. Wie is die externe partner ? Welk type van opleidingen krijgen de leden van de reserve-eenheid en waarin want een volgende crisis is niet noodzakelijk van eenzelfde aard als de voorbije crisis ? Er is hiervoor 500.000 euro voorzien. Graag de detail van de besteding

Zie eerder antwoord op deze vraag.

Welzijnswerk

p.55 Men gaat voor een structurele verankering van Housing First-aanpak, dus met erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden. Men voorziet 925.000 euro extra. Betekent dit dan dat men het systeem verder uit te breiden en zo ja, welke capaciteitsuitbreiding voorziet men.

Zie eerder antwoord op deze vraag.

p.56 Men verkent hoe lotgenotenverenigingen en hulpverlening elkaar kunnen versterken. Hoe ziet u in dat kader voor de inbedding van het lotgenotencontact dat erg belangrijk is ?

Lotgenotencontact kan erg versterkend zijn voor slachtoffers in hun verwerkingsproces. Het is een waardevolle aanvulling op een hulpverleningstraject en dit zowel ervoor, tijdens maar ook erna. Een goede samenwerking tussen lotgenotenverenigingen en professionele hulpverlening is ook belangrijk voor een onderlinge doorverwijzing van slachtoffers en naasten en het bespreken van eventuele knelpunten en aanbevelingen. We hechten dan ook groot belang aan deze lotgenotenverenigingen. Een prioritaire doelgroep hierbinnen zijn lotgenoten van seksueel geweld. Dit onderstrepen we ook in het Vlaams actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

Wat betreft slachtoffers van seksueel geweld vroeg de commissie ad hoc vorige legislatuur dat er bij de dienst slachtofferhulp van een CAW een specifieke hulpverlener bereikbaar en beschikbaar zou zijn voor slachtoffers van seksueel geweld. Die hulpverlener zou daarvoor een specifieke opleiding moeten hebben gevolgd, op de hoogte zijn van de werking van het zorgcentrum na seksueel geweld en zou ook functioneren als contactpersoon voor het zorgcentrum na seksueel geweld. Wordt aan die voorwaarde voldaan? Zal de minister inspanningen doen om hierin te voorzien? Een andere aanbeveling was om in alle CAW's psychotherapeutische hulp bij traumaverwerking aan slachtoffers van seksueel geweld aan te bieden. Elk CAW zou minstens één dergelijke therapeut in dienst moeten hebben. Is dat voor handen in elk CAW? Hoe zal de minister omgaan met deze aanbeveling?

De CAW bieden hulp- en ondersteuning rond diverse vormen van slachtofferschap en maakt hierbij gebruik van een specifiek onthaalmodel om slachtoffers van misdrijven, traumatische gebeurtenissen, rampen en verkeersongevallen te begeleiden. Op die manier kan CAW garanderen dat alle hulpverleners slachtoffers van seksueel geweld kwalitatief kunnen ondersteunen en gericht kunnen doorverwijzen. De CAW zelf geven ook aan dat het niet wenselijk is om hun aanbod slachtofferhulp verder te versnipperen onder medewerkers.

Elk CAW heeft verschillende profielen van hulpverleners in dienst. Het belangrijkste voor elke hulpverlener is om een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt, zodanig dat hij/zij de ruimte en het vertrouwen kan ervaren om over traumatische ervaringen te spreken en er samen met de cliënt kan gezocht worden naar gepaste hulp. Bij alle hulpverleners van de CAW en dus ook binnen slachtofferhulp wordt er aandacht besteed aan methodieken om die hulpverleningsrelatie op te bouwen en te versterken.

De CAW organiseren voor slachtoffers en hun naasten een integraal psychosociaal onthaal- en begeleidingsaanbod op de eerste lijn. Wanneer gespecialiseerde begeleiding of behandeling nodig is, verwijzen zij door naar partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Er is dan ook momenteel niet binnen elk CAW een gespecialiseerde therapeut in dienst. Als eerstelijnsorganisatie is dat ook geen vereiste die we vooropstellen. Er wordt sterk

ingezet op een goede samenwerking met en doorverwijzing naar het gespecialiseerd aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg.

p.57 In het geïntegreerd breed onthaal werken OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk samen. Zijn er plannen om te komen tot een volledige integratie van het OCMW, het onthaal van het CAW en de dienst maatschappelijke dienstverlening?

Neen, in de regelgeving (nl. het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid uit 2018) is het geïntegreerd breed onthaal opgevat als een samenwerkingsverband tussen de 3 voornoemde actoren. Zij zullen de GBO-opdracht realiseren binnen hun reguliere werking in samenwerking met elkaar.

p. 59 GBO-1GCF2EA-WT Welzijnswerk : graag een uitsplitsing van het budget over de verschillende sectoren (CAW's, centra voor teleonthaal, ea).

WELZIJN EN SAMENLEVING INCLUSIEF LOKAAL SOCIAAL BELEID	145	145
ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK	139.690	139.690
WELZIJNSBELEID	130	130
RONDPUNT	317	317
KONINGIN FABIOLA HOME VZW	527	527
FARA VZW	360	360
MODERATOR VZW	14	14
PAYOKE VZW	236	236
VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATIE HERSENVERLAMMING VZW	137	137
	141.556	141.556

Sociale Akkoorden

p. 64 GBA-AGC2FB-WT Uitvoering sociale akkoorden : Kan de 18 miljoen extra uitgelegd worden ? Vloeit die uitsluitend voort uit de vele indexeringen ?

De uitgaven evolueren op basis van onderliggende parameters:

- Aanpassing van lonen aan de evolutie van de spilindex.
- De evolutie van het aantal rechthebbenden = aantal actieve personeelsleden vanaf 45 jaar.
- De evolutie van de vervangingsratio = aantal personeelsleden waarvoor effectief vervanging gevonden wordt.

Naast de vele indexeringen zijn er ook de jaarlijkse stijging van het aantal rechthebbenden en het aantal compenserende vervangers.

p.63 GBO-1GCF2FA-WT VIA : graag een uitsplitsing van het budget tussen de verschillende begunstigden (Verso, VIVI, Social Fonds non profit, enz.).

Naam subsidie	BO 2026
vzw Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso)	€ 724.139,37
vzw VIVO	€ 771.932,98
vzw Sociaal Fonds Non-Profit	€ 2.847.349,92
vzw Vlaamse Social-profitfondsen	€ 15.933.248,90
Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (FBZ BW)	€ 1.041.995,94
vzw Fonds voor Bestaanszekerheid in de Sociale Werkplaatsen (FVB-FSE)	€ 188.197,89
vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V)	€ 81.444.515,74
vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)	€ 3.938.142,03
Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren	€ 6.563.023,97
Het Sociaal fonds 318.02	€ 2.830.909,75
Het Sociaal fonds 319.01	€ 6.178.584,78
Het Sociaal fonds 327.01	€ 2.425.633,13
Het Sociaal fonds 329.01	€ 2.196.629,25
Het Sociaal fonds 331	€ 1.434.287,41
Totaal	€ 128.518.591,08

Preventie

-GBO-1GCF2JA-WT preventief beleid Er wordt 750.000 euro bespaard in het kader van de activering van opgebouwde reserves. Bij wie zijn die reserves opgebouwd ?

Zie het antwoord op vraag 1.

- Graag een uitsplitsing van deze middelen over de verschillende zaken aankoop van vaccins, enz.

De aankoop van vaccins gebeurt door het Departement Zorg. Hierbij worden geen reserves opgebouwd.

p. 69-73 Er wordt een toetsingskader ontwikkeld voor de implementatie van nieuwe vaccins. Wat betekent dat concreet? We hebben een toetsingskader, met name de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en daar zijn nog heel wat vaccins die door de Hoge Gezondheidsraad worden aanbevolen voor bepaalde groepen die vandaag niet behoren tot de gezondheidsdoelstelling vaccinatie voor volwassenen.

De aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad is een belangrijk maar niet het enige element in de afweging of een vaccin al dan niet best geïmplementeerd wordt. Een Vlaams toetsingskader is wenselijk, zodat een haalbare keuze van prioritair te implementeren vaccinaties op een goed onderbouwde en transparante manier kan gemaakt worden.

p.70 Wat betreft de verbreding van de focus van het nationaal HIV-plan naar een plan voor seksueel overdraagbare aandoeningen, dit is een goede zaak omdat we zien dat het aantal soa's toenemen. Wat betreft HIV is het essentieel dat we extra inspanningen doen om mensen die besmet zijn met HIV en dat niet weten op te sporen, want zij verspreiden de ziekte verder. Het gaat dan om een diverse groep: migranten uit Sub Sahara, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen. Welke inspanningen worden daar concreet geleverd? Welke belemmeringen zijn er om de vandaag besmette mensen die het niet weten te detecteren?

U haalt zelf al aan dat mensen vaak niet weten dat ze besmet zijn. Dit betekent ook dat ze zich niet met een klacht tot de (huis)arts wenden, wat in andere gevallen vaak de aanleiding is tot testen. Daarnaast betreft het veelal, maar zeker niet uitsluitend, kwetsbare groepen.

Sensibilisering en informatieverstrekking over veilige seksuele contacten en infectierisico's is belangrijk en dit gebeurt ook binnen het beleid. Laagdrempelige testing is een andere mogelijke maatregel. Een dergelijk programma moet robuust wetenschappelijk onderbouwd zijn en een duidelijke positieve impact hebben op de gezondheid. Capaciteit en kwaliteit moet gegarandeerd zijn. Dit is echter op dit ogenblik nog onvoldoende duidelijk en/of onderzocht.

p. 70 Het gebruik van antibiotica is in ons land bijna dubbel zo hoog als in Nederland en dat is een gevaar voor onze gezondheidszorg op lange termijn. U legt de focus op de Vlaamse residentiële settings en het gebruik van antibiotica daar. Hebt u de intentie om op vlak van preventie de Vlaamse burger te informeren over de noodzaak om het antibioticagebruik te beperken?

In 2026 is er vanuit Vlaanderen geen informatiecampagne voorzien naar de Vlaamse burgers over het antibioticagebruik. De focus in 2026 blijft op het verminderen van antimicrobiële resistentie in de residentiële zorgvoorzieningen.

p.72 Belangrijk is dat er aandacht is voor het vroegtijdig ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals het reguleren van emoties, het beheersen van impulsen, het omgaan met tegenslagen, enz. en dat men daarvoor een aanpak wil voor ontwikkelen om die vaardigheden al te versterken op school. Hoe ziet u dit concreet ?

Sociaal-emotionele vaardigheden moeten inderdaad vroeg ondersteund worden, en de school is daarvoor een cruciale setting. Dat ligt volledig in lijn met de nieuwe gezondheidsdoelstelling die we op 15 december zullen lanceren, waarin kinderen en jongeren, en mentaal welbevinden, belangrijke prioriteiten zijn.

Concreet starten we in 2026 met een initiatief om sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren te versterken via het onderwijs, met een uiteraard ook een link naar de thuiscontext. Er wordt voortgebouwd op bestaande en succesvolle methodieken zoals *Geluk in de klas* en *Expeditie Geluk*. De inhoud wordt verder verdiept, en vooral

beter afgestemd op verwante thema's, zodat leerkrachten via één herkenbare methodiek tegelijk kunnen inzetten op versterken mentaal welbevinden én de preventie van suïcide, van eet- en gewichtsproblemen, van middelengebruik en van grensoverschrijdend gedrag. Deze aanpak voorkomt versnippering, verlaagt de drempel voor gebruik in de klas en maakt het aanbod overzichtelijker en beter toepasbaar in uiteenlopende onderwijscontexten.

p.73 Er is bij de coaches bewegen op verwijzing ongerustheid over hun voortbestaan. Men wil het aanbod continueren, maar ook nagaan hoe de organisatie en de uitvoering ervan meer efficiënt en programmatisch kan gebeuren. Hoe ziet men dat dan ? Waar zal dat ingebed worden ? Wat zal de rol van de vandaag functionerende coaches dan zijn ?

We willen verschillende vormen van leefstijlaanbod op verwijzing bundelen in één meer gestroomlijnde organisatievorm en goed overwegen welke risicogroepen het meest in aanmerking komen voor dergelijke op maat ondersteuning. De rol van de vandaag functionerende coaches zal daarin worden ingepast.

p. 72 Als het gaat over een gezonde levensstijl zien we veel aandacht voor alcoholmisbruik, maar eigenlijk maar weinig aandacht voor preventie van drugsgebruik. Nochtans zien we een stijging van het gebruik van cocaïne. Welke acties gaat u daarrond voeren ?

Drugspreventie maakt een onderdeel uit van een oproep voor een beheersovereenkomst die eind 2025 zal gelanceerd worden. Binnen die beheersovereenkomst zullen acties opgenomen worden rond o.a. drugspreventie, op basis van de vier preventiestrategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding). Specifiek rond cocaïne loopt nog tot eind 2025 een selectieve preventiecampagne, gericht op mensen bij wie cocaïne in hun leefwereld aanwezig is. Het is vanuit wetenschappelijke evidentie afgeraden om universele preventiecampagnes te voeren rond drugs.

Eerste lijn

-p. 86 GBO-1GCF2KA-WT beleid eerstelijnsgezondheidszorg.

Bij welke organisaties zitten precies de opgebouwde reserves ?

Zie het antwoord op vraag 1.

p.80 Hoe zal de geïntegreerde zorg in concreto vorm krijgen in Vlaanderen nav het samenwerkingsakkoord met de federale overheid ? Er zal ingezet worden op perinatale zorg, kwetsbare ouderen en obesitas bij kinderen en jongeren. Wat met volwassenen en kinderen met zware aandoeningen ? Zij zijn het net die even goed nood hebben aan geïntegreerde zorg.

De zorgraden krijgen een belangrijke rol, maar de omschrijving ervan is zeer vaag. Kan die concreter gemaakt worden dan ondersteunen, lokale afspraken voor samenwerking bevorderen, ambassadeursrol voor Alivia.

Men werkt verder aan vergoedbare coördinatie en casemanagement in de thuissituatie en daarnaast ook in voorzieningen. Wie zal die rol opnemen in de thuissituatie ?

De concrete implementatie van de generieke concepten binnen GIZO gebeurt in eerste instantie op progressieve wijze via drie programma's die zich toespitsen op specifieke doelgroepen. Om deze generieke concepten en programma's uit te werken, zijn verschillende werkgroepen opgericht. Daar zal ook de rol en taak van elke actor bepaald worden.

De eerstelijnszones krijgen een rol van implementator, vanuit een generieke bril. Dat houdt in dat de zorgraden van de eerstelijnszones relevante actoren samenbrengen, samenwerkingsafspraken maken en deze ook blijven opvolgen en bijsturen waren nodig. Het is de bedoeling om te leren uit wat al lopende is (perinataal programma) om samen met de zorgraden hun rol verder uit te schrijven in 2026.

-p. 86 GBO 1GCF2KA-WT Beleid eerstelijnsgezondheidszorg.

Er is voorzien in 1 miljoen euro activering van opgebouwde reserves. Waar zitten die reserves precies ?

Zie antwoord op vraag 1

Vivel moet 1 miljoen euro besparen. Hoe ziet u die besparingen ? Worden er ook opdrachten van Vivel afgebouwd ?

De opdrachten van VIVEL worden aangepast door middel van een ministerieel besluit. Zo kan VIVEL focussen op de meest essentiële taken.

Vitalink bestaat al enige jaren. Het medicatieschema zogezegd ook, in realiteit moet iedereen met een briefje met zijn medicatie in zijn portefeuille rondlopen want het ziekenhuis heeft geen zicht op de aanpassingen in je medicatieschema aangebracht door de huisarts en omgekeerd. Beiden moeten ze in hun eigen computer de gegevens aanpassen. Dit is dus echt een totale mislukking.

p. 82 Men verwijst naar de 7 innovatieve projecten toegankelijke huisartsengeneeskunde die vorige legislatuur werden gelanceerd. Is daar al een eerste evaluatie over ? Zo ja, wat was die ? Zo niet, wanneer komt die er ?

De projectplannen van de 7 projecten lopen over twee jaar. De eerste projectperiode eindigt op 30 november 2025 en werd geëvalueerd. De finale oplevering van de projecten wordt verwacht einde 2026 begin 2027.

Gespecialiseerde zorg

-p.95 Er is een traject gestart inzake de integratie van CAR en CGG, de fase lopend vanaf 1 april 2026 tot 31 december 2027 moet het nieuwe financieringskader worden uitgetest. De definitieve uitrol start op 1 januari 2028. Wat ziet u als meerwaarde van de integratie op vlak van het bereik van meer cliënten, betere geografische spreiding, meer capaciteit inzake diagnostiek ?

De doelgroep waarop beide voorzieningen zich voornamelijk dienen te richten, is die van de mensen met een ernstige psychische zorgnood die vastlopen op één of meerdere domeinen. Het kernaanbod van deze gespecialiseerde voorzieningen bestaat uit multidisciplinaire, gespecialiseerde diagnostiek en behandeling op verwijzing en expertise-uitwisseling. De voorzieningen die een erkenning krijgen zijn verplicht een minimum aan capaciteit in hun regio hiervoor te voorzien (desgevallend in samenwerking met andere netwerkpartners). Dus ook voor gespecialiseerde diagnostiek.

De expertise-uitwisseling is er dan weer op gericht om mensen die niet/ nog niet in zorg zijn bij een CAR of CGG sneller en gericht te bereiken om eventueel meer ernstige psychische problemen te helpen voorkomen (bijvoorbeeld omdat men moet wachten op gespecialiseerde zorg) of veel sneller te kunnen inschatten, samen met de doorverwijzer, of gespecialiseerde zorg of behandeling noodzakelijk is.

-p.101 GBO-1GCF2LA-WT Beleid over ziekenhuizen en GGZ

146,731 miljoen euro voor CGG, VIKZ, onderzoeken SWVG, Perinatale mentale gezondheid, deradicalisering, CONNECT, Familieplatform, TDI-verwerking Sciensano, Tandem, Psyche, Online Hulp, Veilige Huizen, Vlaams Patiëntenplatform, Samenwerking CGG/CAR, UFC, Aanklampende Zorg, ...Kan het budget uitgesplitst worden per onderdeel ?

In de tabel is een overzicht terug te vinden van de voorziene projecten 2026.

Invulling BO 2026	Budget BO 2026
EVA PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL	€ 11.583.000,00
EVA PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM	€ 11.576.000,00
VIKZ	€ 690.143,22
Pilootproject CAR/CGG	€ 243.000,00
Project OBT	€ 159.000,00
IFIC OPZ	€ 855.680,00
Centra Menselijke Erfelijkheid	€ 2.696.000,00
CGG-enveloppe	€ 100.849.112,82
VIA6 IFIC-CGG (Saldo)	€ 2.533.452,63
CGG deradicalisering	€ 86.709,50

Familieplatform	€ 549.769,34
TDI-verwerking door Sciensano	€ 42.133,97
TANDEM (inclusief uitbreiding 2024)	€ 669.532,02
Psyche	€ 2.759.682,26
Onlinehulp	€ 1.000.629,38
Vlaams Patiëntenplatform	€ 258.781,98
VIA-5 samenwerking CAR-CGG	€ 400.000,00
UFC	€ 60.000,00
Intersectorale begeleidingsteams jongvolwassenen	€ 985.514,92
Perinet	€ 168.000,00
Herstelacademie	€ 760.500,00
Diagnostiek CAR	€ 964.000,00
Gents begeleidingspunt studenten	€ 193.200,00
Aanklampende zorg voor mensen met psychische problemen die sociaal huren	€ 1.345.588,37
CONNECT	€ 4.311.422,41
Aanbod personen met ernstige psychische zorgnoden	€ 1.205.989,22

Er wordt voorzien in 1,5 miljoen afbouw reserves. Waar worden precies reserves afgebouwd ? bij welke organisatie(s) ?

Zie het antwoord op vraag 1.

p.102 GBO-1GCF2LB-WT MAF

Vragen : Hoe komt het dat ondanks de stijgende noden in de gezondheidszorg de bijdrage van de Vlaamse overheid stabiel blijft op 4,104 miljoen euro.

In de interfederale teller voor de maximumfactuur (MAF) worden vanuit Vlaanderen nog steeds enkel de remgelden opgenomen die eerder al deel uitmaakten van de federale teller. Het gaat daarbij om de remgelden voor de geïsoleerde G- en Sp-ziekenhuizen (revalidatieziekenhuizen) en bepaalde revalidatieovereenkomsten. Er zijn tot op heden geen bijkomende remgelden uit andere voorzieningen, sectoren of doelgroepen binnen het Vlaamse gezondheidsbeleid toegevoegd.

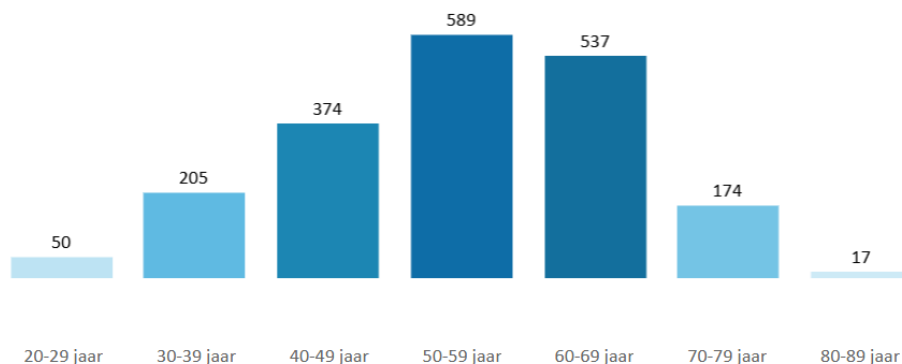
Voor Vlaanderen is overeengekomen dat jaarlijks een vast forfaitair bedrag van 3.795.379,37 euro wordt betaald voor dit systeem. Indien de werkelijke Vlaamse bijdrage in de interfederale teller dit forfaitaire bedrag zou overschrijden, dient Vlaanderen echter de werkelijke bijdrage te betalen. Om dit te kunnen opvangen, wordt in de begroting een marge voorzien van 4,104 miljoen euro. Tot op heden volstond het forfaitaire bedrag telkens om de Vlaamse inbreng in de teller te dekken, waardoor de uitgaven stabiel blijven.

p. 105 GMO-AGCF2LG-WT Werking en Toelagen – Sociale Bescherming – Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Beschut Wonen

Vraag : hoeveel patiënten verblijven nog in de PVT's ? Wat is hun gemiddelde leeftijd ? Wanneer schat de minister in dat de bedden PVT's volledig uitgedoofd zullen zijn ? Wat biedt zij aan aan het type patiënten dat vandaag verblijft in PVT's ?

De PVT in Vlaanderen beschikken over een definitieve opnamecapaciteit van 1877 plaatsen en een uitdovende opnamecapaciteit van 43 plaatsen. Dit maakt dat de totale erkende opnamecapaciteit PVT in Vlaanderen momenteel op 1920 plaatsen ligt.

Onderstaand de verdeling over de leeftijdscategorieën van alle zorggebruikers die momenteel in een PVT verblijven. Er is geen gemiddelde leeftijd weer te geven.



Er is geen inschatting mogelijk wanneer de uitdovende capaciteit volledig uitgedoofd zal zijn aangezien we niet weten binnen welke leeftijdscategorieën deze personen die een uitdovende plaats innemen zich bevinden.

Een PVT biedt residentiële herstelondersteunende zorg aan, aan volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige en psychiatrische problematiek. Deze herstelondersteunende zorg richt zich op het behouden van vaardigheden en het versterken van zelfzorgvermogen en zelfregie. Dat houdt onder andere in om te leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en de psychische kwetsbaarheid. De herstelondersteunende zorg ondersteunt en begeleidt de mensen bij het uitvoeren van hun activiteiten en neemt die over als deze personen dat zelf niet meer kunnen.

p. 98 Mbt de rol van zorginspectie van ziekenhuizen (het nieuwe organisatiebrede toezicht op de kwaliteitswerking in ziekenhuizen), wat is de verhouding met accreditaties door externe organisaties zoals Qualicor en JCI ?

Het organisatiebreed toezicht is geen vervanging van externe accreditatie: het richt zich uitsluitend op de maturiteit van de kwaliteitswerking, terwijl accreditatiesystemen een bredere scope hebben en ook andere aspecten beoordelen.

Vraag: idem als vraag VIPA p110 -Wat betreft ziekenhuizen wil minister Vandenbroucke van bepaalde kleine ziekenhuizen een soort van dagziekenhuis maken wat betekent dat er niet langer een beddenhuis zal zijn. Ondertussen liggen er investeringsdossiers op de tafel bij VIPA. Worden er nu projecten on hold gezet omwille van de intenties van minister Vandenbroucke ?

Er zijn geen goedgekeurde VIPA-dossiers die worden teruggeroepen of waarbij de uitvoering on hold wordt gezet. In overleg met de ziekenhuizen wordt wel ingezet, in het verlengde van de zorgstrategische planning, op een sterk toekomstperspectief en een duurzame investering van middelen.

Wat zijn vandaag de wachtlijsten bij de CGG, tussen enerzijds aanmelding en eerste gesprek en vervolgens tussen eerste gesprek en start van de therapie .

Er is geen overzicht van de wachtlijsten van de CGG beschikbaar.

Woonzorg

p.110 De formulieren die voorzieningen indienen bij het eLoket herzien worden herzien om te waarborgen dat de door prijzendienst goedgekeurde dagprijzen en supplementen correct worden toegepast. De datakwaliteit van de gegevens over de gebruikersfactuur die wordt bezorgd aan de zorgkassen moet verhoogd worden. Welke indicaties hebt u dat daar dingen fout lopen ? Hoeveel wil u daar besparen voor de gebruiker ?

Het uitgangspunt is daar het volgende: we willen de toepassing zowel voor gebruikers in voorzieningen als overheid verbeteren en de risico's op fouten in data minimaliseren. De formulieren kunnen zowel functioneel als datamatig verbeterd en gebruiksvriendelijker worden.

p. 111 GBO-AGCF2VB-WT – Thuis en ouderenzorgbeleid : graag een uitsplitsing van het budget per onderdeel;

-waaraan zullen de 12 miljoen euro precies voor lokale dienstencentra worden besteed ? Gaat het enkel over de financiering van hun extra opdrachten of ook aan uitbreiding van het aantal lokale dienstencentra of de creaties van antennes ?

Het betreft een budget van 7.033k euro. Een deel van het budget is voorzien voor de uitbreiding van het aantal lokale dienstencentra. Daarnaast werken we momenteel in het kader van de uitwerking van geïntegreerde zorg en ondersteuning, aan een verduurzaming van de kernelementen van zorgzame buurten, wat onder meer moet leiden tot een vernieuwd model van de huidige lokale dienstencentra. Voor de wijzigende opdrachten zullen bijkomende middelen voorzien worden.

-wat betekent het milderden van het groeipad ? Wat moeten we verstaan onder regelluwte en efficiënter beheer ?

Het groeipad dat wordt gemilderd, betreft het voorziene uitbreidingsbeleid voor ouderen- en gezinszorg binnen het begrotingsartikel. Er wordt €10 miljoen minder uitgetrokken voor het uitbreidingsbeleid in de verschillende sectoren. Het budget stijgt dus met vertraging. Tegelijkertijd nemen we maatregelen rond regelluwte (verminderen van administratieve lasten) en efficiënter beheer binnen de sectoren om toch extra ruimte te creëren.

p.113 GBO-1GCF2V-WT Gezinshulp : 1,012 miljard euro

Er is een daling met 4 miljoen euro door de opheffing van de bevrozing van het urencontingent en stopzetting van de erkenning van diensten die de minimale invulling van het urencontingent gedurende 2 opeenvolgend jaren niet halen. Kan dit worden toegelicht ? Wat betekent de opheffing van de bevrozing en hoe kan dat leiden tot een besparing ? En welke diensten zijn stopgezet ?

De stopzetting van de erkenning van diensten die de minimale invulling van het urencontingent gedurende 2 opeenvolgend jaren niet halen, zal nog niet van kracht zijn in 2026, maar pas nadat de dienst zowel in 2026 en 2027 niet voldoende uren heeft gepresteerd. Het betreft enkel de diensten voor gezinszorg die niet minimaal de uren van 10 VTE verzorgend personeel presteren. Dat is ook de minimale erkenningsnorm van een dienst voor gezinszorg in functie van kwaliteitsvolle en efficiënte werking. Deze diensten zullen ook de mogelijkheid krijgen om te fusioneren met een andere dienst voor gezinszorg of om hun erkenning naar een andere dienst voor gezinszorg over te dragen.

De gemotiveerde aanvragen van diensten voor gezinszorg tot behoud van het urencontingent gezinszorg of een vrijwillige verlaging van het urencontingent gezinszorg voor 2026 zullen dit jaar negatief beantwoord worden. Deze diensten zullen meegenomen worden in de rationaliseringsoefening van het urencontingent gezinszorg.

Er wordt voorzien in een vermindering van 21 miljoen euro door de verhoging van de efficiëntie van het urencontingent. Wat moeten we daaronder verstaan ?

De norm van de gelijkgestelde uren zal verlaagd worden. Daarnaast zal het urencontingent gezinszorg gerationaliseerd worden.

p.114 GBO-1GCF2VX-IS toelage aan VSB

Waarom denkt men door sterker in te zetten op financiële inspecties 8 miljoen euro te kunnen besparen? Betekent dit dat financiële inspecties in het verleden niet goed zijn gedaan ?

Een controle op de indicatiestellingen is niet hetzelfde als een financiële inspectie. Het eerste gebeurt door controle-artsen vanuit de zorgkassen, het laatste door het bevoegde team binnen Zorginspectie. De frequentie van controles op indicatiestellingen is momenteel zeer laag.

Zullen woonzorgcentra door de besparingscoëfficiënt hun dagprijs kunnen verhogen ?
Vreest u niet dat als dat niet kan, zij zullen besparen op zaken in het woonzorgcentrum ?
voeding ? personeel ?

Woonzorgcentra kunnen hun dagprijzen niet zomaar verhogen. Daar zijn procedures voor. Voorzieningen kunnen na twee boekjaren met een beperkt of negatief resultaat een aanvraag tot prijsverhoging indienen. Om aan de woonzorgcentra snel helderheid te kunnen bieden, ook over eventuele andere keuzes aan uitgavenkant, berekent de administratie op dit moment de concrete impact ervan per zorgvoorziening. Samen met de sector wordt gewerkt aan een interessant pakket aan maatregelen rond het wegwerken van overbodige of te gedetailleerde regelgeving, rond het beter kunnen inzetten van personeel en rond werkbaar werk om de impact te kunnen milderen.

p. 116 GMO-AGCFéVD-WT Werking en Toelagen – Sociale Bescherming – Residentiële Ouderenzorg : 2.765.610.000 VEK

+53,716 miljoen euro voor centra voor dagverzorging wegens hogere bezetting en aangroei van het aantal centra. Wat is die hogere bezettingsgraad en met hoeveel verwacht men dat die zal stijgen tov 2025 ? Hoeveel extra centra zullen er komen.

53,716 miljoen euro is het totaal vereiste budget voor de basistegemoetkoming voor zorg en de tegemoetkoming in de reiskosten voor de centra voor dagverzorging, niet de bijstelling. De bijstelling bedraagt 896 keuro omwille van hogere bezetting en aangroei.

Definitieve bezettingscijfers voor 2025 zijn pas beschikbaar begin 2026, maar we gaan uit van een bezettingsniveau van 82,81% in 2026.

Het budget voor de basistegemoetkoming voor zorg en de tegemoetkoming in de reiskosten voor de centra voor dagverzorging wordt niet geraamd in aantal centra maar in aantal plaatsen bijkomende erkenning binnen die centra. Deze extra plaatsen kunnen worden ingezet voor een betere financiering van de zware zorg binnen zowel bestaande als nieuwe centra. De 896 keuro extra voor 2026 omvat in totaal 104 extra plaatsen bijkomende erkenning.

+39.640 infrastructuurforfait ouderenzorg voor woonzorgcentra met 4,174 toename voor geplande ingebruiknames. Hoeveel bedden zullen in 2026 extra in gebruik worden genomen in de WZC ?

39,640 miljoen euro is het totaal vereiste budget voor de infrastructuurforfaits ouderenzorg, niet de bijstelling. De bijstelling bedraagt 4.174 keuro. Er is nog geen zicht op hoeveel bedden er effectief in gebruik genomen zullen worden aangezien ingebruikname uitgesteld kan worden of projecten niet door kunnen gaan.

De budgettaire raming voor 2026 houdt rekening met een extra ingebruikname van zowel vervangings- als uitbreidingscapaciteit van 2.122 woongelegenheden in de loop van 2026.

p.108 De lokale dienstencentra incorporeren waar mogelijk de pilootprojecten Zorgzame Buurten en ze implementeren het preventiebeleid. De uitbreiding van de werking van de lokale dienstencentra met mobiele antennepunten neemt hierdoor aan belang toe. Hoe ziet u de werking van de lokale dienstencentra in landelijke gemeenten ? Daar zijn al woonzorgcentra, dagverzorgingscentra soms, maar niet altijd dienstencentra.

Momenteel werken we in het kader van de uitwerking van geïntegreerde zorg en ondersteuning aan een verduurzaming van de kernelementen van zorgzame buurten, wat onder meer moet leiden tot een vernieuwd model van de huidige lokale dienstencentra. Voor de wijzigende opdrachten zullen bijkomende middelen voorzien worden.

p. 109 Men wil technologie stimuleren. We lezen dat al jaren, maar wat wil u concreet doen in 2026 aan innovatie in woonzorgcentra, gezinshulp, enz. en voor welk budget ? Krijgen voorzieningen daar carte blanche waarin ze investeren op vlak van innovatie ?

Technologie en innovatie vormen een belangrijk onderdeel van de modernisering van de ouderenzorg. Hun inzet wordt gestimuleerd wanneer ze een duidelijke meerwaarde bieden voor de verbetering van de zorgkwaliteit, het verlichten van de werkdruk en het verhogen van de tevredenheid en levenskwaliteit van bewoners. Maar technologie blijft een middel, geen doel op zich en dient de menselijkheid van de zorg te versterken, niet te vervangen. Woonzorgcentra zijn vrij om binnen hun bestaande middelen te investeren in technologische toepassingen die zij relevant achten. Binnen thuiszorg, en meer specifiek de diensten voor gezinszorg, zal hierop worden ingezet met het project collectieve gezinszorg en het verduurzamen van de methodiek van hybride gezinszorg.

Voor collectieve gezinszorg gedurende de looptijd (periode 1 december 2023 tot en met 31 december 2026) kan koepelorganisatie Zorggezind beroep doen op een subsidie van 450.000,00 euro.

Er werden in de voorbije jaren twee opeenvolgende gefinancierde projecten (van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2023 en van 1 september 2023 tot 31 december 2024) doorlopen rond hybride gezinszorg. Op basis van de ervaringen uit de projecten,

wordt verduurzaming onderzocht. Tegenover deze verduurzaming staan geen extra budgetten.

Opgroeien – Jeugdhulp

-p121 Streefdoel tegen 2027 is een bezetting van 90% voor elke erkende typemodule tegen eind 2027. De minister verklaarde eerder al dat er 500 openstaande plaatsen zijn. Wat is de bezettingsgraad dan vandaag ?

De gemiddelde bezetting van organisaties voor bijzondere jeugdzorg bedroeg in 2024 90,5% voor alle erkende modules samen. We merken grote verschillen tussen voorzieningen onderling en tussen modules (de verblijfsbezetting bedraagt gemiddeld 88,5%, met ook weer significante verschillen tussen voorzieningen, de bezetting van veilig verblijf 72,5%). We willen zowel de bezetting van de verschillende erkende typemodules als van de individuele organisaties verhogen.

-p. 121 Er is sprake van een referentieregio voor jeugdhulp : hoe ziet die regio eruit ? In welke mate komt die overeen met de eerstelijnszones ? We moeten stoppen met altijd maar meer regio's te creëren waarbinnen actoren moeten samenwerken.

We kiezen voor rationalisering van de werkingsgebieden door met drie niveaus te werken: lokale besturen, eerstelijnszones en regionale zorgzones, waar we opdrachten aan koppelen. Op die manier creëren we een vereenvoudiging van het landschap en de mogelijkheid om blinde vlekken weg te werken en vanuit zorgstrategisch perspectief spreiding en samenwerking te optimaliseren.

-p123 De pilootprojecten vroegdiagnostiek lopen af op 1 september 2026. Wanneer mogen we de definitieve verankering verwachten ? Er is sprake van uitbreiding van het diagnostisch aanbod. Met hoeveel capaciteit en waar zal die uitbreiding regionaal en in organisaties (, voorzieningen jeugdhulp, CAR, enz.) gebeuren ?

We voorzien de verankering van de pilootprojecten regelgevend vanaf 1 januari 2027. We voorzien een eerste investering van 2.000.000 euro waarmee we het aanbod van de centra voor ontwikkelingsstoornissen willen versterken.

-p. 124 Het OCJ wordt de enige gemandateerde voorziening. De opdracht van het OCJ wordt geherdefinieerd. Kan dat beter worden toegelicht ? Vertrouwenscentra Kindermishandeling krijgen een nieuwe positionering (p. 125). Dewelke ? We hebben al een paar casussen gehad waarin de rol van de vertrouwenscentra discutabel was? Zal daaraan geremedieerd worden ? In dat kader wordt ook de werking van de ondersteuningscentra, de sociale diensten en de intersectorale toegangspoort herbekeken om actoren beter te ondersteunen. Kan dit worden toegelicht ?

Het OCJ wordt de enige gemandateerde voorziening. We grijpen de evolutie naar één gemandateerde voorziening aan om een ruimere transitie van de sociale diensten, de OCJ en de toegangspoort door te voeren. Met deze transitie willen we een aantal ambities uit het regeerakkoord - vroegtijdig ingrijpen, vereenvoudiging van processen, ... - waarmaken.

Aan de hand van een participatief traject met de VK-sector en het Agentschap Opgroeien zal de nieuwe positionering van de vertrouwenscentra binnen het hulpverleningslandschap verder uitgeklaard worden en bekeken worden hoe de opdracht van de VK's optimaal uitgevoerd kan worden. We behouden de expertise van de vertrouwenscentra.

De evolutie naar één gemandateerde voorziening mag niet leiden tot extra breuken in de hulpverlening aan kinderen bij de stap van vrijwillige richting gedwongen jeugdhulpverlening. Toegankelijkheid staat centraal. Hierbij willen we het lineair doorverwijzingsmodel doorbreken en vertrekken van samenwerking en bijschakelen.

-p. 124 Het decreet van 30 juni 2023 voorziet in de gegevensdeling bij casusoverleg. Wat wil men nog extra doen ?

Na de impactanalyse in 2025 kwamen we tot 3 kernopdrachten die mogelijks een verschillend traject en andere inbedding zullen krijgen binnen Opgroeien:

- Gedeeld beroepsgeheim consequent toepassen;
- Versterken casusoverleg tussen hulpverleners, onderwijs, justitie, politie, ...;
- Gecentraliseerd systeem van gegevensdeling tussen voornoemde partners.

We implementeren het bestaande juridisch afgetoetst kader rond het gedeelde beroepsgeheim, dat de mogelijkheden én de grenzen ervan duidelijk afbakt.

-p.124 Hoe wil u complexe echtscheidingen aanpakken met onder meer casusoverleg en informatie-overleg en samenwerking tussen justitie en welzijnsactoren ? Hoe ziet u de rol van de scheidende ouders ? vrijwilligheid ? Verplichting ?

We zetten in op een meer geïntegreerde aanpak van complexe scheidingen door structurele informatiedeling en multidisciplinair casusoverleg te versterken. We brengen de rollen, mandaten en expertise van alle betrokken actoren in kaart en faciliteren samenwerking tussen justitiële en welzijnssectoren. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan veilige, doelgerichte en juridisch correcte informatie-uitwisseling.

Door bruggen te slaan tussen de sectoren streven we naar coherente, op elkaar afgestemde trajecten voor gezinnen. Vandaag verloopt ondersteuning nog te vaak parallel of versnipperd, wat leidt tot gemiste kansen op duurzame oplossingen.

-p. 125 Er zal een meldcode kindermishandeling worden uitgewerkt. Hoe verhoudt zich dat tot de bestaande “kindreflex” ?

Er zijn duidelijke linken tussen de kindreflex en de ontwikkeling van de meldcode kindermishandeling, toch zijn beiden niet hetzelfde.

De kindreflex is een methodiek en zorgt voor een concreet kader, handvatten en samenwerkingsrichtlijnen voor hoe we op een effectieve manier verantwoordelijkheid kunnen opnemen bij verontrusting en kindermishandeling.

Met de hulp- en meldcode kindermishandeling die wordt uitgewerkt, bieden we professionals handvatten in het omgaan met kindermishandeling en ondersteunen we hen in het omgaan met het beroepsgeheim en GDPR op cruciale momenten. Het doel is dat kinderen en jongeren die kindermishandeling meemaken beter worden beschermd en geholpen.

-p.126 Het opgroeien in een gezin is belangrijk. Men evalueert het concept gezinshuizen inhoudelijk, organisatorisch, regelgevend en financieel. Wat denkt men dat er fout is met de huidige werking ? Men lanceert een uitbreiding binnen de beschikbare kredieten. Wat zijn de beschikbare kredieten ? Hoeveel gezinshuizen kunnen dan gerealiseerd worden ? Hoe ziet men het statuut van de gezinsouder ? Hoe ziet men de residentiële hulpverlening in de gezinshuizen volgens de nieuwe programmatie ?

De evaluatie impliceert niet dat er iets fout is aan de werking, het betreft een nieuwe werkvorm die geëvalueerd wordt. De eerste signalen zijn in kaart gebracht. Volgende stappen zijn bijkomend onderzoek en een juridische analyse over de gezinshuizen. Op basis hiervan volgt een meer doorgedreven evaluatie in 2026.

Het zwaartepunt van de residentiële uitbreiding, ook van de gezinshuizen ligt later in de regeerperiode. We willen op basis van het capaciteitsbeheersysteem in de loop van 2026 zicht krijgen op de effectieve residentiële noden en de spreiding. Pas dan zullen we een fijnmaziger overzicht kunnen geven van de uitbreidingsprioriteiten en de budgettaire spreiding in 2026 en de volgende jaren.

-p.126 De ondersteuning van jongvolwassenen is essentieel maar kent al een lange geschiedenis. Waar loopt het vandaag nog fout ? Is er een rondetafel voor elke jongere die een voorziening verlaat waarbij contacten worden gelegd met de ambulante hulpverlening voor volwassenen (OCMW, CAW, GGZ, enz.) ? Wordt er vandaag voor gezorgd dat elke jongere een huisvesting heeft als hij de instelling verlaat ?

In 2018 legden we een belangrijke focus op de uitstroom uit jeugdhulp met het actieplan jongvolwassenen. In 2023 voerde zorginspectie een inspectieronde uit bij de voorzieningen. Daaruit bleek dat de voorzieningen de voorbije jaren belangrijke stappen zetten in een beleid voor jongvolwassenen. Op casusniveau wordt er ingezet op bruggen slaan met volwassenenhulpverlening en met verschillende levensdomeinen zoals wonen en werk.

Vandaag heeft nog niet elke jongere die een instelling verlaat huisvesting, vandaar de acties rond huisvesting bij uitstroom in het plan jeugdhulp.

-p. 127 Als een opvoeding in een gezinshuis of pleeggezin niet mogelijk is, dan is er het verblijf in een leefgroep die zo huiselijk mogen ingericht is. Men voorziet versterking van de leefgroepwerking. Wat betekent dat ? Men gaat voor één oproep tot uitbreiding over meerdere jaren in functie van de beschikbare middelen. Hoeveel middelen heeft men ? Hoeveel bijkomende plaatsen wil men creëren ? Gaat het over uitbreiding van bestaande voorzieningen of eerder over de creatie van nieuwe voorzieningen ? Men stimuleert jeugdhulpvoorzieningen voor die kinderen gezinsplek bij een partners-in parenting-gezin te vinden. Hoe gaat u voorzieningen daarin ondersteunen ? Dat gezin moet ook door de jeugdhulpvoorziening worden ondersteund. De jeugdhulp heeft een tekort aan personeel. Kan dit er nog bij ?

Een versterking van de leefgroepwerking behelst niet enkel een uitbreidingsbeleid, maar in eerste instantie het mogelijk maken dat de huidige capaciteit ten volle, én kwalitatief, ingezet kan worden. Om dit mogelijk te maken, dienen we in te spelen op randvoorwaarden.

Om te weten hoeveel middelen en bijkomende plaatsen er nodig zijn, dienen we in de loop van 2026 verder in te zetten op analyse van het huidige aanbod en de regionale spreiding hiervan. Op deze manier is in de verdere legislatuur een rationele programmatie mogelijk.

Met betrekking tot P&P is er in het plan jeugdhulp ruimte tot erkenning en subsidiëring voorzien om deze werkvorm mogelijk te maken.

p.128 Men zal de ondersteuningstoeslag bij ouders die beroep doen op een PAB of MFC verrekenen zodat het gezin geen nadelige gevolgen ondervindt. Kan dit worden toegelicht ? Gaat dit over een vermindering van de ondersteuningstoeslag ?

Vandaag is er een cumulverbod tussen het ontvangen van enige vorm van NRTH of PAB en het ontvangen van ondersteuningstoeslag. De ondersteuningstoeslag is evenwel bedoeld om ouders maximaal te ondersteunen om zorg op maat en thuis te organiseren. Ouders die slechts een beperkt beroep doen op NRTH worden daardoor benadeeld. We draaien de volgorde om en zorgen ervoor dat ouders de ondersteuningstoeslag blijven ontvangen. Het verschil zal verrekend worden bij het PAB of MFC. (voor ouders blijft de rekening netto dezelfde)

-p. 128 Op basis van de praktijkervaringen met betrekking tot de hulpprogramma's geblokkeerde ontwikkelingstrajecten installeren we een innovatieruimte met heldere rollen en mandaten waardoor we beter in staat zijn om vanuit gedefinieerde collectieve en individuele verantwoordelijkheden kwaliteitsvolle en effectieve antwoorden te bieden op jongeren wiens problematiek de reguliere jeugdhulpstructuren uitdagen. Kan dit worden toegelicht ?

De hulpprogramma's zijn een aantal jaar operationeel. We voorzien een gerichte evaluatie in 2026 waarop we antwoorden willen krijgen hoe de verschillende aanbodscomponenten – veilig verblijf, GES+, begeleidingsmodules, ...- in deze hulpprogramma's ingezet worden en hoe we er vanuit een geïntegreerde benadering voor kunnen zorgen dat we effectieve trajecten zonder breuken waar kunnen maken.

-p.128 Er komt een high care-high risk werking : hoeveel werkingen komen er ? In eerste instantie komen die werkingen in een gemeenschapsinstellingen, later in gesloten settings buiten de gemeenschapsinstellingen. In het verleden zijn er situaties voorgekomen waarbij de slachtoffers van tienerpooiers in de gemeenschapsinstellingen hun tienerpooiers zagen. Zal erover gewaakt worden dat slachtoffer en dader niet worden ondergebracht in dezelfde gemeenschapsinstelling of minstens zodanig afgescheiden dat ze elkaar niet tegen komen ?

De high care-high risk werking wordt, als tijdelijke noodoplossing geoperationaliseerd in de infrastructuur van de gemeenschapsinstellingen. Dit zal in aparte leefgroepen en afgescheiden infrastructuur zijn. We starten daarnaast met een traject om deze capaciteit op kwaliteitsvolle en duurzame manier uit te bouwen in de welzijnsvoorzieningen.

-p.130 De minister kondigde aan 2.200 extra plaatsen te creëren. Wat is de precieze verdeling ?

Het is vandaag niet mogelijk om een precieze verdeling te geven van deze plaatsen. Binnen jeugdhulp wordt er vertrokken vanuit een trajectlogica, waarbij er doorheen dit traject een aanbod op maat uitgewerkt wordt. Door beter in te zetten op een snellere instroom, het gebruik van het beschikbare aanbod beter te monitoren, organisaties die een lagere bezetting hebben sneller te activeren, het beschikbare aanbod te differentiëren en waar mogelijk te flexibiliseren zodat meerdere kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van een breder palet van aanbod, zal er al een eerste belangrijke stap gezet worden om extra begeleiding mogelijk te maken. Aanvullend zal er op diverse manier ingezet worden in bijkomend aanbod, waarbij we aandacht hebben voor de uitbreiding van gezinshuizen, residentiele gezinsbegeleidingen, versterking van het mobiele en het ondersteunende aanbod, enz.

-p.131 Wat betreft preventie wordt samengewerkt met andere actoren. Kan dit iets explicieter worden toegelicht ?

We ontwikkelen een versterkte structurele samenwerking tussen actoren uit onderwijs, welzijn en justitie. Daarnaast zal er onderzocht worden hoe we actoren binnen jeugdwerk, sport, vrije tijd actief kunnen betrekken op lokaal niveau wat betreft de preventieve acties aangaande jeugddelinquentie. Jeugddelinquentie leidt vaak tot uitsluiting van het 'normale' sociale leven van jongeren. Het doorbreken van deze spiraal heeft een duidelijk bewezen preventief effect.

-Nav de overdracht van de gemeenschapsinstellingen werd gesteld dat het Agentschap Opgroeien en het Agentschap Justitie en Handhaving een samenwerkingsprotocol zouden sluiten. Wat is de stand van zaken ? Welke zaken staan in dat samenwerkingsprotocol ?

Het klopt dat er een vernieuwd protocol wordt gemaakt voor de samenwerking welzijn-justitie betreffende het jeugddelinquentierecht. Samen met mijn collega minister van Justitie en Handhaving wordt een nieuw samenwerkingsprotocol uitgewerkt tegen eind 2025 met o.a. afspraken rond capaciteit, in-, door- en uitstroom in de jeugdrechtsketen, afstemming rond de samenwerking met welzijnspartners enz.

Geïntegreerd gezinsbeleid

-p. 145 GBO-1GEF2UX-IS Opgroeien regie bevat kredieten kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, adoptie, geïntegreerd gezinsbeleid. Graag een opsplitsing van het budget in de verschillende onderdelen.

De uitgaven voor kinderopvang worden begroot op 1.557,7 mio euro, voor PGJO op 36,2 mio euro en voor adoptie op 3,9 mio euro.

Op p141 lezen we dat voor 2026 heel wat extra plaatsen zullen worden gecreëerd : 2000 nieuwe plaatsen T2, 2000 nieuwe plaatsen T1, 600 plaatsen van T1 naar T2, 750 plaatsen van T0 naar T1, 1.600 plaatsen van T0 naar T2, 2.600 plaatsen van T1 naar T2 via oproep. Wat is het precieze beleid voor het uitbreidingsbeleid opgesplitst per trap ? hoeveel wordt voorzien voor elk type van uitbreiding of omzetting ?

Voor de nieuwe plaatsen T2 werd reeds voor 4500 plaatsen een meerjarenoproep gelanceerd. Aanvragen konden ingediend worden tot half september, de beslissingen over de toewijzing volgen medio december. Daarnaast volgt eind dit jaar nog een oproep voor 600 plaatsen T2 voor innovatief inkomensgerelateerd aanbod. Toewijzing is voorzien voor de zomer van 2026. De 2000 beschikbare plaatsen T2 voor 2026 zijn in deze 2 oproep geïntegreerd.

Voor nieuwe T1 met vrije prijs is vrije instap vandaag reeds mogelijk.

Voor T1 zullen we de regelgeving wijzigen, zodat ook voor bestaande plaatsen vrije instap, los van een uitbreidingsronde, mogelijk wordt. Op die manier kunnen ook bestaande plaatsen zonder subsidie (T1) omschakelen naar T1. Hiervoor is budget voorzien voor 1600 plaatsen T1 deze legislatuur, waarvan 750 in 2026.

Nog voor de zomer 2026 willen we dan een oproep lanceren voor de omschakeling van trap 1 naar trap 2 voor 2400 plaatsen deze legislatuur. In 2026 zullen inderdaad 600 plaatsen kunnen omschakelen.

Hoeveel middelen voorziet voor de vergoeding van het werknemersstatuut voor onthaalouders die vanaf het voorjaar 2026 instromen of van de onthaalouders sui generis die de overstap willen maken.

We voorzien deze legislatuur middelen om 900 VTE nieuwe onthaalouders onmiddellijk te laten opstarten in het werknemersstatuut. We rekenen hierbij aan 225 VTE startende onthaalouders per jaar.

Daarnaast is ook nog omschakeling mogelijk voor bestaande onthaalouders sui generis naar het werknemersstatuut. Tot op heden was dit enkel mogelijk na een oproep, maar we wijzigen daartoe de regelgeving zodat op ieder moment die omschakeling kan gevraagd worden. Deze omschakeling gebeurt binnen het budget dat daartoe reeds beschikbaar is. Er zijn op dit moment nog middelen beschikbaar voor 185 VTE.

-p.139 Mbt het multidisciplinaire pre- en postnataal zorgtraject voor kwetsbare vrouwen zien we in de begrotingsopmaak voor 2026 dat de federale overheid voorziet in 3 miljoen structurele onderbenutting en 3 miljoen euro onderbenutting in 2026 inschrijft waardoor het budget daalt van 12 naar 6 miljoen euro. Wat is de impact ervan op het Vlaamse niveau in de opstart van dat zorgtraject ?

Er is geen impact op opstart Vlaamse niveau zorgtraject voor kwetsbare zwangeren.

-p. 139 Mbt het plan “Ieder Kind Taalheld” dat samen in de Huizen van het Kind onder de vorm van een groepsaanbod wordt georganiseerd voor kinderen en ouders met een andere thuistaal : wat is het aandeel van de andere lokale actoren (BOA, scholen, bibliotheek, cultuur, jeugd, boekstart,...) in de financiering ? Nemen de Huizen van het Kind de regie hiervan op zich ?

De verdere uitwerking van het plan “Ieder Kind Taalheld” en de rol daarbinnen van de Huizen van het Kind is voorwerp van verdere uitklaring.

-p. 139 Men werkt aan een nieuw erkennings- en financieringskader om de OverKop-huizen bij te sturen waar nodig en te verduurzamen. Wat wil men bijsturen ?

De huidige financiering is grotendeels projectmatig. Naast het zorgen voor een regelgevend kader streven we naar een gebiedsdekkend aanbod met in elke ELZ minstens één Overkophuis. In functie van de nieuwe regelgeving zal er bijzondere aandacht gaan naar het formuleren van heldere opdrachten en doelstellingen zodat het voor de jongeren en professionelen duidelijker wordt wat er van een Overkopwerking kan verwacht worden.

-p. 140 Er wordt gezegd dat er een oproep is geweest rond innovatieve kinderopvang, maar op de website staat dat er binnenkort een oproep komt. Wanneer komt die oproep er ?

Deze oproep volgt eind 2025.

-p. 140 Eer is sprake van een kennis- en innovatiecentrum dat zou worden opgestart voor het opbouwen, centraliseren en beschikbaar stellen van expertise terzake. Hebben wij echt een nieuw centrum nodig daarvoor ? Waar zal dat gesitueerd zijn ? Hoeveel middelen krijgt dat centrum ?

We willen de regelgevende basis voor dit Kennis- en innovatiecentrum in het voorjaar van 2026 goedgekeurd hebben. De bestaande budgetten die hier nu al voor ingezet worden ten aanzien van verschillende ondersteuningspartners worden hiervoor geheroriënteerd. Door deze bestaande budgetten te bundelen bekomen we efficiëntiewinsten. Er wordt geen nieuw budget voorzien.

-er komen 400 plaatsen voor crisisopvang en daarin wordt ook een structurele regeling voor vervangcapaciteit voorzien voor gezinnen wier opvang plots sluit. Ik neem aan dat dit zwevende plaatsen zijn, plaatsen die kunnen ingezet worden op locaties waar er nood is ? Hoe gaat dit concreet georganiseerd worden ? En de vervangcapaciteit voor gezinnen is dat een permanent gegeven dat wordt ingezet waar nodig of komt die vervangcapaciteit uit de capaciteit die verloren gaat doordat het opvanginitiatief stopt waarna het opnieuw kan ingezet worden in reguliere opvangcapaciteit ?

We voorzien middelen voor 400 plaatsen voor noodopvang. Daartoe ontwikkelen we in 2026 een nieuw regelgevend kader. De modaliteiten moeten dus nog vastgelegd worden. Deze plaatsen zijn per definitie tijdelijk. Als bestaande middelen voor T2 vrijkomen ten gevolge van een stopzetting, dan worden die opnieuw ingezet in de regio waar de middelen vrijkwamen.

-p. 141 Men trekt lessen uit de evaluatie van de 5 proeftuinen voor kinderopvang in samenwerking met bedrijven. Welke lessen worden getrokken ?

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het opzetten van samenwerkingen tussen bedrijven en kinderopvangvoorzieningen complex is en veel tijd vergt. Daarnaast leert men dat het informeren van bedrijven een noodzakelijke maar tijdsintensieve stap is, die tot nu toe niet heeft geleid tot concrete engagementen. Er is nog geen enkel formeel akkoord gesloten over het realiseren van extra opvangplaatsen. De proeftuinen brengen de bestaande drempels systematisch in kaart, zodat de nodige lessen getrokken kunnen worden na afloop van de proeftuinen. De proeftuinen werden verlengd tot eind 2025. We verwachten de eindevaluatie in kwartaal 2 van 2026.

-p. 141 Men wil het beroep van onthaalouders aantrekkelijker maken. Vanaf het voorjaar 2026 stappen onthaalouders in in het werknemersstatuut. Hoeveel wordt hiervoor uitgetrokken voor 2026 ? Hoeveel middelen worden uitgetrokken voor de overstap van onthaalouders sui generis naar het werknemersstatuut ? Voor hoeveel onthaalouders

was er in 2025 budget voorzien om de overstap te maken naar het werknemersstatuut en hoeveel hebben dat effectief gedaan ?

We voorzien deze legislatuur middelen om 900 VTE nieuwe onthaalouders onmiddellijk te laten opstarten in het werknemersstatuut. We rekenen hierbij aan 225 VTE startende onthaalouders per jaar.

Daarnaast is ook nog omschakeling mogelijk voor bestaande onthaalouders sui generis naar het werknemersstatuut. Tot op heden was dit enkel mogelijk na een oproep, maar we wijzigen daartoe de regelgeving zodat op ieder moment die omschakeling kan gevraagd worden. Deze omschakeling gebeurt binnen het budget dat daartoe reeds beschikbaar is. Er zijn op dit moment nog middelen beschikbaar voor 185 VTE.

Op basis van de laatst beschikbare gegevens (kwartaal 2 van 2025) zijn er 751,56 voltijdsequivalenten (VTE) toegekend aan organisatoren gezinsopvang, ingevuld door 798 onthaalouders. Opgroeien kent op dit moment VTE toe op basis van een oproepsysteem. Op 20 februari 2025 besliste Opgroeien om subsidies voor 15 extra onthaalouders in het werknemersstatuut toe te kennen na de eerdere oproep waarbij er reeds subsidies voor 240 extra onthaalouders werden toegekend.

-p. 142 Wordt voor de omschakeling van samenwerkende onthaalouders naar groepsoopvang ene oproep gelanceerd en zo ja wanneer ?

Ja, de oproep zal voor de zomer 2026 worden gelanceerd. Eerst is het nodig dat het BVR terzake definitief wordt goedgekeurd (ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State).

-p.142 Eigenlijk hebt u de ambitie om maar vanaf 2027 te komen tot een administratieve vereenvoudiging op vlak van regelgeving terwijl dat vandaag de meest gehoorde klacht is, zeker voor onthaalouders en kleinschalige initiatieven. Komen er ondertussen ook nog administratieve lastenverlagingen ?

Samen met het Raadgevend Comité van Opgroeien gebeurt een oefening om te kijken hoe de administratieve lasten nog verder kunnen verlaagd worden. Sowieso is dit bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving steeds één van de aandachtspunten.

p.143 Er wordt in het kader van de vereenvoudiging van de zorgtoeslag een screening voor ouders en hulpverleners aangekondigd om in te schatten of ze in aanmerking komen voor de zorgtoeslag is volgens mij echt niet de weg om te gaan. Is dit niet weerom het verschuiven van een overheidstaak naar de ouders.

Ouders en hulpverleners geven zelf aan dat ze het moeilijk vinden om in te schatten of het kind recht heeft op zorgtoeslag. Bij ouderverenigingen en hulpverleners is er dan ook vraag naar zo'n instrument. Via deze screening kunnen ze op basis van een aantal vragen inschatten of het kind mogelijk recht heeft op een zorgtoeslag en zo nodeloos werk en

inzet vermijden. Het is niet de bedoeling om een overheidstaak naar de ouders door te schuiven, maar hen net wel ten volle te ondersteunen.

-Komt er nog een aangepast decreet interlandelijke adoptie of stopt u met interlandelijke adopties mogelijk te maken?

Het 'nieuwe' decreet over de organisatie en bemiddeling bij interlandelijke adoptie dat eind vorige legislatuur werd gestemd, moet sowieso gewijzigd worden om uitvoering te kunnen geven aan het gezamenlijk voortraject pleegzorg – adoptie. Geadopteerden, maar ook rapporten over wantoestanden in het verre en recente verleden, formuleren heel wat bezorgdheden. We zullen dit bijgevolg kritisch bekijken, inclusief een grondige evaluatie van het legistiek kader en bijhorende praktijk zoals voorzien in het Regeerakkoord.

-Hoeveel onthaalouders zijn inmiddels ingestapt in het werknemersstatuut en hoeveel waren er dat

De beschikbare cijfers vormen een momentopname op basis van aangeleverde kwartaalcijfers van organisatoren gezinsopvang. Op basis van de laatst beschikbare gegevens (kwartaal 2 van 2025) zijn er 751,56 voltijdsequivalenten (VTE) toegekend aan organisatoren gezinsopvang, ingevuld door 798 onthaalouders. Opgroeien kent op dit moment VTE toe op basis van een oproepsysteem. Op 20 februari 2025 besliste Opgroeien om subsidies voor 15 extra onthaalouders in het werknemersstatuut toe te kennen na de eerdere oproep waarbij er reeds subsidies voor 240 extra onthaalouders werden toegekend.

-Wat is vandaag de kostprijs voor de overheid van een opvangplaats in trap 1, trap 2 en trap 3 zowel voor een plaats bij een onthaalouder als voor een plaats bij een groepsopvang ?

De basissubsidie (trap 1) bedraagt:

- Voor groepsopvang: 4.902,65 euro per plaats per jaar
- Voor gezinsopvang met vrije prijs: 2.071,63 euro per plaats per jaar.

De subsidie voor inkomenstarief (trap 2) bestaat uit:

- De basissubsidie
- component prestaties: een bedrag per gepresteerde opvangprestatie
- component leeftijd: een bedrag op basis van de leeftijd van de medewerkers
- component VIA (oa subsidiëring werkdrukvermindering)

Deze subsidiebedragen worden verrekend met de bedragen die de organisator van de ouders ontvangt voor het inkomenstarief.

Er zijn verschillende bedragen naargelang het over groeps- of gezinsopvang gaat. We gaan uit van gemiddelde parameters in de sector:

- Totale gemiddelde kostprijs voor groepsopvang bedraagt dus in totaal 15.066 euro per plaats per jaar.
- Totale gemiddelde kostprijs voor gezinsopvang bedraagt dus in totaal 3.908 euro per plaats per jaar.
- De plussubsidie (trap 3) komt bovenop trap 1 en trap 2 en bedraagt, zowel voor gezins- als voor groepsopvang, 821,07 euro per plaats per jaar.

-Hoeveel opvangplaatsen bestaan vandaag bij trap 0 en trap 1

Een overzicht is te vinden op [Cijfers op maat | Opgroeien](#)

9.Wat zijn tot nog toe de resultaten van initiatieven van bedrijven op het vlak van kinderopvang ?

Tot op heden hebben de proeftuinen nog niet geleid tot de realisatie van extra kinderopvang-plaatsen. Hoewel er interesse is vanuit het bedrijfsleven, blijft het moeilijk om verder te geraken dan de informatiefase. Er is nog geen sprake van structurele samenwerking of formele afspraken tussen bedrijven en opvangvoorzieningen.

De voorlopige resultaten zijn dus vooral procesmatig: er is meer bewustwording gecreëerd en er wordt actief gezocht naar werkbare modellen. De concrete impact op het aanbod van kinderopvang blijft voorlopig uit. De opgedane inzichten kunnen bijdragen aan een bredere reflectie over de rol van bedrijven in het realiseren van kinderopvang.

10.Hoeveel samenwerkende onthaalouders zijn omgeschakeld naar reguliere groepsopvang met subsidie inkomentarief ?

Nog geen enkele, de oproep volgt in 2026.

Groeipakket

-De federale regering voorziet in de stopzetting van de werkloosheidsuitkering na maximum 2 jaar. Dit zal een impact hebben op het inkomen van gezinnen. Werd bij de budgettering hiermee rekening gehouden ?

Dit hoeft niet noodzakelijk een budgettaire impact te hebben op het Groeipakket. Het gaat om mensen die reeds langere tijd een precare inkomenspositie kennen. Maar er is geen algemeen overzicht in deze. Een precieze impact is niet ter beschikking.

-p. 151 Als we de inkomensgrenzen van de sociale toeslagen gaan uitfaseren, vergroten we dan de groep van mensen die genieten van een sociale toeslag? Dat wordt opgenomen in een conceptnota in 2026 met uitvoering vanaf september 2028 en is enkel van toepassing op nieuw instromers vanaf 1 januari 2026. Hoe moet dat geïnterpreteerd worden. Mensen die op 1 januari 2026 net iets meer verdienen zodat ze niet in aanmerking komen voor een sociale toeslag, zullen die de sociale toeslag als de inkomensgrenzen gefaseerd worden ? of geldt dat alleen voor mensen die al een sociale toeslag kregen ?

De concrete besluitvorming dient nog te worden uitgewerkt. Deze hervorming moet ervoor zorgen dat het toeslagbedrag gradueel daalt naargelang het gezinsinkomen toeneemt.

-p.152 De circulaire cheque wordt afgeschaft wegens weinig gebruikt. Tijdelijk kan de gezinsbijslag gestort worden aan het OCMW of het CAW. Wat is tijdelijk ?

De concrete besluitvorming dient nog te worden uitgewerkt.

Personen met een handicap

-Hoeveel personen kregen in 2025 een persoonsvolgend budget opgesplitst in automatische toekenningsgroepen, prioriteitengroep 1 en 2 ? Hoeveel minderjarigen kregen een PAB in 2025 ?

Op 30/06/2025 waren er 1340 PVB budgetten ter beschikking gesteld in de automatische toekenningsgroepen en 805 persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 1 .

Voor PAB's zijn de gegevens nog niet beschikbaar gezien het aantal PAB-priors voor de laatste maanden van 2025 nog niet gekend is.

-Vanaf 2025 geldt een open end financiering voor personen met een handicap in prioriteitengroep 1 en de automatische toekenningsgroepen. Daarvoor werd 52,4 miljoen euro voorzien. Moesten extra middelen worden voorzien om die open end financiering mogelijk te maken of volstond het voorziene budget ? Indien extra middelen moesten worden voorzien, hoeveel was dat dan ? Hoeveel ging naar personen met een handicap in prioriteitengroep 1 en hoeveel naar de automatische toekenningsgroepen ?

Het voorziene budget volstaat, samen met de middelen die vrijkomen door uitstroom (stopzettingen en overlijdens) in 2025 om de kost op te vangen van de automatische toekenningsgroepen en PG 1.

-Een aantal gezinnen ging naar de rechter tegen de beslissing tot toekenning van deelbudgetten. Sinds 2025 krijgt iedereen een volledig persoonsvolgend budget, maar

de rechtszaken zijn gebleven. Wat is de stand van zaken van de juridische geschillen mbt de retro-activiteit inzake de toekenning van de volledige budgetten aan personen uit prioriteitengroep 2 die een deeltijds budget kregen en in 2025 een volledig budget hebben toegekend gekregen ?

Nog hangende zaken:

- 1 eerste aanleg arbeidsrechtbank
- 2 zaken aanhangig bij Hof van Cassatie
- 2 zaken aanhangig arbeidshof

Afgewerkte dossiers

- 15 dossiers zijn afgesloten

-Is in het kader van de conceptnota de positie van de DOP's al uitgeklaard ?

De conceptnota stelt duidelijk dat 'de gebruikersverenigingen met infoloket voor individuele personen en de Diensten Ondersteuningsplan worden ondergebracht in het nieuw op te richten Aanspreekpunt handicap' en hierbinnen 'een vernieuwde rol en opdracht' opnemen. Dit wordt momenteel concreet uitgewerkt.

-p. 164 Er zal onderzocht worden hoe combinaties tussen verschillende sectoren flexibel kunnen gemaakt worden. Wat is de timing ? Hoe ziet u dat realiseerbaar mbt de financiering van de voorzieningen ? vanuit het persoonsvolgend budget ?

De conceptnota bepaalt een aantal acties die ondertussen vertaald zijn in een aantal projecten. Een van deze projecten is het hervormen van het financieringssysteem zodat middelen flexibel kunnen ingezet worden, ook als deze uit verschillende sectoren komen. Dit project bevindt zich in de opstartfase en dient gerealiseerd te zijn tegen 31 december 2027.

-p. 166 Verschillende instanties in Vlaanderen zijn bevoegd voor het erkennen van een handicap. Men wil die processen van erkenning op elkaar afstemmen met het oog op een optimale gegevensuitwisseling. Wat bedoelt men met afstemming van processen ?

We beogen minimaal te vermijden dat dezelfde gegevens dubbel/herhaald bevraagd worden. Dit is ook één van de zaken die verder uitgewerkt zal worden in een projectgroep in het kader van de uitrol van de conceptnota.

-p.166 In 2026 wordt gewerkt aan de invulling van de drie zorgniveaus, de criteria die bepalen in welk zorgniveau men terecht komt en de invoering van de zorgniveauscreener die het mogelijk maakt mensen in te delen in de drie zorgniveaus. Zal dan duidelijk zijn wat de verhoogde drempel is tussen RTH en niet-RTH ?

De conceptnota stelt dat de cesuur tussen RTH en niet-RTH aangepast moet zijn. Deze verhoging is pas zinvol wanneer ze gepaard gaat met een aangepaste invulling van de

rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning die in zorgniveau 1 zal worden geboden. Het is immers de bedoeling om in dit eerste zorgniveau een ruimere groep personen, ook met meer intensieve ondersteuningsnoden, te kunnen ondersteunen dan vandaag in de huidige RTH mogelijk is. Hoe hoog de verhoogde cesuur zal zijn, hangt dus niet enkel af van de invulling van de 3 zorgniveaus, de criteria voor zorgniveaubepaling en de ontwikkeling van een zorgniveauscreener, maar ook vooral van een evaluatie en aangepaste operationalisering van zorgniveau 1.

-In de conceptnota wordt gesproken over een verstrenging van de definitie handicapspecifiek. Is er al zicht op hoe die verstrenging eruit ziet ?

Het concept handicapspecifieke zorg en ondersteuning wordt momenteel verder uitgewerkt.

-p. 167 Men kondigt de hervorming van de toeleidingsprocedure aan. Die is inmiddels gestemd. Betekent deze aankondiging dat die toeleidingsprocedure alsnog moet aangepast worden.

Er werd tijdens de vorige legislatuur al een voorstel van hervorming van de toeleidingsprocedure uitgewerkt. Dit is voorzien van een flexibele inwerkingtreding, om de aanpassingen grondig te kunnen afstemmen op de brede hervormingen in de conceptnota van de nieuwe regering. In 2026 wordt al een eerste tussenstap uitgevoerd: het verplaatsen van de zorgzwaartebepaling naar het moment van terbeschikkingstelling.

-p. 167 Men past het huidige instrumentarium aan dat wordt gebruikt voor het bepalen van het PAB in functie van een geactualiseerde en ruimere zorgzwaartebepaling. Dat instrument zal worden gebruikt om de zorg en ondersteuning op maat te kunnen vaststellen ongeacht of men gebruikt maakt van een MFC of een PAB. Wat zal concreet het gevolg zijn voor jongeren die gebruik maken van een PAB ? Zal dit leiden tot een lager budget of een hoger budget ?

De methodiek zal gebruikt worden om het huidige instrument te vervangen en een accurater beeld te geven van de noden aan ondersteuning. De koppeling met het budget volgt in een volgende fase.

-p. 168 Men begint aan de ontwikkeling van een kader dat zal toelaten personen in P2 en P3 perspectief te bieden met verwijzing naar de vernieuwde, verruimde en vraaggestuurde RTH. Totnogtoe was de afspraak dat voor personen uit P3 men zorg zou realiseren via RTH. Nu verruimt men dit tot P2. Is dat correct ? Is men ervan overtuigd dat mensen die in P2 zitten kunnen volstaan met RTH ?

In de eerste plaats wordt een onderbouwde inhoudelijke invulling gegeven aan elk van de 3 zorgniveaus zoals beoogd in de conceptnota. Tegelijkertijd wordt bekeken en bepaald welke criteria een duidelijke indicatie kunnen geven welk van de 3 zorgniveaus

het best aansluit bij de ondersteuningsnoden van een individuele persoon met een (vermoeden van) handicap en dus in welk niveau betrokkene het best geholpen kan worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat die criteria zullen zijn

-p. 169-170 Men wil een nieuw regelluw en impactgericht kwaliteitskader. In welke mate zal men rekening houden met de noden van kleine private initiatieven en ouder-initiatieven die tijdens corona hebben aangetoond dat ze stand hebben gehouden ?

Het VAPH-kwaliteitskader is bedoeld om haalbaar te zijn voor alle organisaties. Vanuit de aanbevelingen en inzichten van het wetenschappelijk onderzoek, zal bij de implementatie ervan, om te komen tot het nieuwe kwaliteitskader, bekeken worden wat administratief haalbaar is voor alle initiatieven.

-p. 170 Kunnen voorbeelden worden gegeven van welke bestedingen met een PVB niet meer mogelijk zullen zijn ? Zal hierbij overleg worden gepleegd met vertegenwoordigers van personen met een handicap en bijstandsorganisaties ?

Het overleg met de vertegenwoordigers van de personen met een handicap en de bijstandsorganisaties ging medio november van start. Daarin zullen de huidige bestedingsregels tegen 31/12/2025 geëvalueerd en bijgestuurd worden. Voordat dit overleg heeft plaatsgevonden kunnen we nog geen voorbeelden geven.

-p.170 Mbt zorgniveau 1 : met hoeveel wordt de maximale grens van RTH-punten verhoogd ? Men herevalueert de ondersteuningsfuncties zodat ook personen in P2 en P3 ondersteuning kunnen krijgen via RTH. Dat was altijd al het geval. Wat voorziet u extra aan functies ?

Het project waarin de rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van het toekomstige zorgniveau 1 wordt uitgewerkt, loopt nog. In de eerste helft van 2026 zal hierover meer duidelijkheid gegeven kunnen worden.

-p. 184 GH0-AGGF2RB-WT Financiering van hulpmiddelen : 37, 957 miljoen euro.

-465.000 euro omwille van overdracht mobiliteitshulpmiddelen. Er gaat 930.000 euro van VAPH naar VSB omwille van de overdracht van aankoppelwielen voor manuele rolstoelen samen met 100.000 euro voor de rolstoeladviesrapporten die door het VSB zullen vergoed worden. Dit gebeurt in het kader van de realisatie van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. De overheveling gebeurt in twee fasen, 465.000 euro in 2026 en 465.000 euro in 2027. Waarom twee fasen?

Er werd gekozen om het budget in twee fasen over te dragen omdat het VAPH in 2026 de aanvragen voor de over te dragen hulpmiddelen die tem 31 december 2025 ingediend worden en in de loop van 2026 vervolledigd worden, moet behandelen en, in geval van een goedkeuring, moet uitbetalen.

-p. 162-166 Het VAPH gaat als expertisecentrum gaan samenwerken met andere sectoren. Er wordt melding gemaakt van overlegmomenten met de Huizen van het Kind, het OCMW. U onderzoekt of u het centraal aanspreekpunt kunt plaatsen op het niveau van de eerste lijn, via bestaande organisaties zoals Diensten Ondersteuningsplan, Huizen van het Kind en gebruikersverenigingen met infoloket ? Hoe ziet u dat concreet ? De Diensten Ondersteuningsplan zien zich functioneren in een rol als backoffice die optreedt als het Huis van het Kind, OCMW's, Sociale Huizen, CAW's eigenlijk niet het hele plaatje van de hulpverlening kunnen leggen. Zie u de DOP's in die rol ?

De conceptnota schetst duidelijk de ambitie om de ondersteuning voor personen met een handicap dicht bij de eerste lijn te organiseren. Daarbij wordt voorzien in de oprichting van Aanspreekpunten Handicap . Deze aanspreekpunten moeten voor burgers en professionals het herkenbare en toegankelijke loket worden voor informatie, advies en toeleiding rond handicap en ondersteuning. Tegelijk blijft het VAPH op Vlaams niveau een expertisecentrum handicap, dat kennis en expertise bundelt, ontwikkelt en verspreidt. Vanuit die rol zal het VAPH samenwerken met andere sectoren en beleidsdomeinen, onder meer via overleg met Huizen van het Kind, OCMW's, CAW's en andere eerstelijnsactoren.

Het is daarbij niet de bedoeling dat elk lokaal aanspreekpunt zelf algemene of duplicerende informatie rond handicap ontwikkelt. De bedoeling is net dat het VAPH, als Vlaams expertisecentrum, een gemeenschappelijk kennis- en referentiekader aanreikt — onder meer rond regelgeving, ondersteuningsmogelijkheden, hulpmiddelen en inclusieve praktijken. De Aanspreekpunten zullen die kennis vervolgens contextueel en op maat kunnen vertalen naar professionals en organisaties binnen hun eerstelijnszone. De huidige DOP's en de gebruikersverenigingen zullen binnen de Aanspreekpunten ingepast worden. De concrete invulling van die samenwerking en taakverdeling zal verder worden uitgewerkt in overleg met de betrokken organisaties en binnen de verdere operationalisering van het aanspreekpunt.

-p. 194 GH0-AGGF2RE-WT Financiering van ondersteunende en intermediaire organisaties (p. 194) : 28,122 miljoen euro. Graag uitsplitsing.

- Bijstandsorganisaties (4) € 3.580.000
- Tolk Bemiddelingsbureau (1) € 2.761.000
- Gebruikersverenigingen met informatieloket (5) € 355.000
- Zorgwijs.be (1) € 120.000
- Vertrouwenscentrum kindermishandeling (1) € 13.000
- Consulantenwerking (5) € 1.030.000
- Organisaties voor vrijetijdszorg (20) € 2.676.000
- Dubbeldiagnose verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis (5) € 959.000

- Autisme Chat (1) € 245.000
- begeleiden van jongeren of jongvolwassenen met risicogedrag (1) € 118.000
- ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen met een auditieve handicap (1) € 50.000
- Diensten ondersteuningsplan (7) € 8.553.000
- Gesco-projecten (2) € 166.000
- Onderhoudstoelagen Revalidatiecentra (53) € 2.337.000
- ex-DAC-projecten Revalidatie (18) € 1.898.000
- ex-DAC-projecten (7) € 2.535.000
- organiseren van de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen (1) € 27.000
- vertegenwoordiging van de verwijzende instanties in alle overlegorganen van het agentschap (1) € 210.000
- woon- en dagondersteuningsinitiatieven bij startende, kleinschalige initiatieven (1) € 157.000
- intersectorale begeleidingsteams voor jongvolwassenen in dreigende dak- en thuisloosheid (8) € 332.000

-1 miljoen minder door activatie van opgebouwde reserves. Waar wordt precies bespaard ? bij welke organisaties ?

Zie het antwoord op vraag 1.

-p.164 Er wordt een evaluatie gemaakt van de overlap tussen de verschillende vergoedingen die men kan ontvangen, zijnde zowel vanuit het Vlaamse als vanuit het federale niveau. Dat onderzoek kadert binnen de uitgaventoetsingen vastgelegd door Financiën en Begroting. Moeten we daaruit concluderen dat dit kan leiden tot het inkorten van subsidies, tegemoetkomingen ?

De doelstelling van de uitgaventoetsing is om te identificeren waar er overlap is om meer kostenefficiënt de beschikbare middelen in te zetten en mogelijke marges aan te geven als er sprake is van overlap is.

-p.165 Men gaat na hoe men de sterk groeiende groep personen met een handicap en een complexe problematiek het best ondersteunt

Vervolgens heeft men het over een reeks methodes om dit aan te pakken :

-een derde zorgniveau binnen de sector van VAPH waarbij wordt samengewerkt met partners uit de jeugdhulp, GGZ en justitie. Wanneer is de precieze timing ? Wordt vanuit die verschillende sectoren ook financieel bijgedragen ?

-de oprichting in 2025 samen met Opgroeien en de FOD Volksgezondheid van

intersectorale plaatsen voor complexe problematieken.

-ondersteuning van personen met een dubbeldiagnose in enkele psychiatrische ziekenhuizen.

-verkopingsunits VAPH en GGZ voor personen met een handicap en psychiatrische problematieken.

Het hulpverleningslandschap wordt voor ouders ingewikkeld. Hoe worden zij voorgelicht ? Er zijn meerdere sectoren betrokken (jeugdhulp, FOD Volksgezondheid, GGZ). Kan vanuit elke sector toegeleid worden naar deze hulpvormen ?

Het project waarin het derde zorgniveau wordt uitgewerkt, is nog volop bezig. Willen we deze problematiek effectief aanpakken, dan is het cruciaal dat er actief en intensief wordt samengewerkt met de andere partners om de zorg en ondersteuning voor deze personen te organiseren. Binnen het project Zorgniveau 3 wordt er momenteel gewerkt aan een eerste werknota over de doelgroep en organisatie van zorgniveau 3.

Om iedereen wegwijs te maken in het vernieuwde hulpverleningslandschap zal er informatie verspreid worden over de drie zorgniveaus via brochures, onze website, infosessies, en webinars.

-p. 168-170 Mbt de administratieve lasten, wat heeft men binnen het VAPH al gedaan zowel voor de organisaties als voor de personen met een handicap ? Op p. 170 lees ik nogal wat terughoudendheid ten aanzien van doelregelgeving. Waarom die terughoudendheid ?

Het VAPH brengt de administratieve lasten voor organisaties en voor personen met een handicap in kaart en bekijkt waar lasten kunnen worden verminderd of vereenvoudigd, in een continu proces.

Er is geen terughoudendheid ten aanzien van doelregelgeving. Zoals in de BBT omschreven, wordt het werken met doelstellingen naar voren geschoven vanuit het kwaliteitsdecreet. Per thema wordt dan bekeken hoe de doelstelling best kan worden bereikt. Doelregelgeving is een middel om dit regelluw te doen, maar is geen doel op zich. Soms is hybride regelgeving of middelregelgeving meer aangewezen, afhankelijk van het onderwerp en de te bereiken doelstelling.

-p.168-169 De paragraaf over de projecten geeft de indruk dat men geen actueel overzicht heeft van subsidies aan projecten en ondersteunende en intermediaire organisaties. Klopt dat ? In welke mate biedt het subsidieregister dan geen overzicht ? Is

er geen algemene evaluatiemethodiek van projecten ?

Het VAPH beschikt over een actueel overzicht van toegekende subsidies aan projecten en ondersteunende en intermediaire organisaties. Het VAPH werkte mee aan de ontwikkeling van een beleidsdomein-breed kader voor zowel subsidiekaders als beleidsevaluatie. De ambitie is een uniforme evaluatiemethodiek te implementeren, waarbij de 'Handleiding beleidsevaluatie van subsidies' van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin als leidraad zal dienen.

-p. 169 Men zal het BVR mbt bijstandsorganisaties aanpassen. Kan worden toegelicht welke precieze veranderingen men wil aanbrengen ? Wat zijn de verplichtingen van de bijstandsorganisaties ten aanzien van de overheid ? Welke sancties voor welke overtredingen wil men daar in schrijven ?

Het is momenteel nog te vroeg om hier gedetailleerd op te antwoorden. De conceptnota bevestigt de rol van de bijstandsorganisatie in het ondersteunen van budgethouders bij het inzetten van het persoonsvolgend budget met het oog op kwaliteit van leven, regie en inclusie. Als een budgethouder het budget niet inzet conform de regelgeving dan is het de rol van de bijstandsorganisatie om de budgethouder hierin bij te sturen. Wanneer de budgethouder zich niet laat bijsturen of bij eventuele fraude dient de bijstandsorganisatie dit te melden bij het VAPH.

-p.192 GHO-AGGF2RD-WT Financiering van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning : 2,596 miljoen euro

De middelen voor P1 en automatische toekenningsgroepen zijn gegarandeerd. Hoeveel budgetten kunnen daar gemiddeld worden mee toegekend. Worden de middelen die vrijkomen uit uitstroom ook gebruikt voor de financiering van P1 en automatische toekenningsgroepen ? Hoeveel middelen zouden vrijkomen uit die uitstroom en hoeveel PVB's kunnen daarmee gefinancierd worden ?

Op 30/06/2025 waren er 1.340 PVB budgetten ter beschikking gesteld in de automatische toekenningsgroepen en 805 persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 1. De uitstroom wordt momenteel geraamd voor 2026 op ongeveer 33 miljoen euro. Het exacte aantal bijkomende terbeschikkingstellingen zal pas eind 2025 bekend zijn.

Hoeveel extra PVB's kunnen worden toegekend door de extra inkomsten uit subrogatie (1,220 miljoen euro). Gaan deze middelen naar P2 ?

De extra eigen ontvangsten worden globaal voor de financiering van PVB's ingezet, niet

specifiek voor een bepaalde prioriteitengroep, dus zowel automatische toekenningen als prioriteitengroepen. Dit komt overeen met ongeveer 30 PVB's.

Door onderbenutting komt er een hoger VAK vrij ten belope van 9,225 miljoen euro. Voor welke doelgroep worden deze middelen ingezet en hoeveel PVB's kunnen daarmee in 2026 worden toegekend ?

De benodigde VEK middelen voor de automatische toekenningsgroep en PG1 ter waarde van 46,5 miljoen euro houden reeds rekening met onderbenutting. Het verhoogde VAK twv 9,225 miljoen euro is nodig om de effectief benodigde middelen VEK voor PG 1 en de automatische toekenningen correct en volledig te kunnen aanrekenen in VAK in Orafin (het financieel systeem van de Vlaamse overheid). De 46,5 miljoen euro VEK zal ten volle benut worden.

Het technisch VAK voor bijkomende terbeschikkingstellingen wordt aangepast omwille van herberekeningen. Dit geeft een aanpassing + 1,343 miljoen euro voor PAB en -8,774 miljoen euro voor PVB's. Moeten we concluderen dat voor minderjarigen er uitsluitend een investering in bijkomende PAB's is voor 1,343 miljoen euro ? Wat betekent de negatieve aanpassing van de VAK met 8,774 miljoen euro voor PVB's ? Gaan er dan minder PVB's kunnen worden toegekend dan voorzien ?

Het extra VAK tov. het VEK is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

- Vooreerst is er het extra VAK voor bijkomende terbeschikkingstellingen door de vastgestelde onderbenutting, waardoor er meer PAB en PVB ter beschikking gesteld worden dan er budget (in VEK) is.
- Ten tweede is er een extra 'technisch VAK voor de potentiële extra kost van de VIA-akkoorden uit het verleden, specifiek bij de rechtstreekse tewerkstelling van een persoonlijk assistent door de budgethouder. Hiertegenover staan geen bijkomende terbeschikkingstellingen.
- Tot slot is er een extra VAK voor de instroom die gefinancierd wordt met uitstroom, aangezien het budget van de uitstromers niet formeel wordt verlaagd in Orafin, noch in mijn.vaph, terwijl met het vrijgekomen budget toch al nieuwe terbeschikkingstellingen gebeuren. Er is dus een dubbele aanrekening in VAK nodig, terwijl het VEK slechts - voor de uitstromer en de instromer samen - eenmaal zal aangewend worden. Zowel bij PAB als bij PVB is het bedrag van het extra VAK verhoogd om rekening te houden met de toenemende uitstroom.

Het is belangrijk om de onderbenutting te monitoren. Als de onderbenutting door de budgethouders daalt, heeft dat tot gevolg dat er effectief minder bijkomende budgetten (PAB of PVB) kunnen worden ter beschikking gesteld, want anders zou de kost in VEK

hoger uitkomen dan het krediet. Als de onderbenutting stijgt, kunnen er meer extra budgetten worden toegekend. Dit wordt jaarlijks in kaart gebracht en hierop wordt het VAK aangepast om meer of minder extra budgetten te kunnen ter beschikking stellen.

De aanpassing van 1.343 keuro in VAK voor PAB heeft voor ongeveer de helft betrekking op het gebruik van de onderbenutting. Dat betekent dat er meer extra PAB kunnen toegekend worden. De onderbenutting bij PAB is tweeledig: Enerzijds worden budgetten verlaagd wanneer ze gecombineerd worden met dagondersteuning in een MFC. In de BA2025 werd al rekening gehouden met een lagere raming van deze combinatie obv voorlopige bestedingscijfers (8,57%). Het uiteindelijke cijfer obv de bestedingsanalyse 2024 (8,74%) is opgenomen in de BO2026. Anderzijds worden de budgetten niet volledig benut. De onderbenutting in BA2025 is gebaseerd op de bestedingsanalyse 2023 (11,00%). De onderbenutting in de BO2026 is gebaseerd op de bestedingsanalyse 2024 (11,15%). Het resulterende effect is een hogere onderbenutting die tot een aanpassing van 1.343 keuro VAK leidt.

De aanpassing van -8.774 keuro in VAK voor PVB is grotendeels ten gevolge van de verhoging van de aanwendingsgraad of een verlaging van de onderbenutting. Dat betekent dat er minder extra PVB kunnen toegekend worden om de verplichtingen na te komen met het beschikbare VEK. De onderbenutting op het constant beleid houdt rekening met de onderbenutting van de verschillende types PVB (procedures) uit de bestedingsanalyse 2024 en met het aandeel van deze procedures. Door de verandering van de samenstelling van de gebruikers is de onderbenutting op het constant beleid gedaald van gemiddeld 8,86% in 2023, dat de basis vormde voor de begroting 2025 naar gemiddeld 8,63% in 2024 dat de basis vormt voor de begroting 2026.

-Is de groep van personen met een handicap met complexe zorgen al afgelijnd ?

Neen, dat vormt een onderdeel van het verder uit te werken project en wordt ook intersectoraal bekeken.

-De minister kondigde een project aan waarbij men voor 300 mensen uit P3 die geen ondersteuning genieten de actuele zorgsituatie in kaart zou brengen. Wat is de stand van zaken hieromtrent ? Wat heeft men hieruit geleerd ? Is dat transponeerbaar naar de “hele” groep van mensen in P3 die geen enkele vorm van ondersteuning genieten ?

Dit specifieke project is omwille van de hervormingen stopgezet. We maken een gelijkaardige oefening in kader van de oplossingen die de conceptnota vraagt voor personen in PG2 en PG3.

-In de vorige beleidsnota sprak de minister de ambitie uit te werken aan

deinstitutionalisering. Wat kan de minister terzake aan resultaten voorleggen ?

Deinstitutionalisering betekent dat personen met een handicap, net als iedereen, volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en er ook volwaardig deel van uitmaken. Hoewel er een belangrijke rol is weggelegd voor de sector van personen met een handicap, vergt dit een inspanning die door alle beleidsdomeinen samen geleverd moet worden.

Om het traject naar deinstitutionalisering vorm te geven en de ambitie dat personen met een handicap tegen 2040 een kwaliteitsvol leven in een open en toegankelijke samenleving kunnen leiden, is het VAPH met een maatschappelijk debat gestart dat moet uitmonden in een perspectiefplan 2040. Het is de intentie om dit perspectiefplan eind 2026 door de Vlaamse Regering te laten valideren.

VSB

-p.204 GBO-1GHE2TX-IS VSB

Er is voorzien in een stijging van 6,495 miljoen euro voor de demografische groei en % uitstel in realisatie erkenningskalender. Wat wordt extra voorzien voor de demografische groei en wat wordt bespaard door % uitstel in realisatie van erkenningskalender ?

Voor de groei in de thuiszorg wordt er 5 mio EUR voorzien en 1,495 mio EUR aan bijkomende woongelegenheden bij de residentiële zorg. Zonder uitstel in de erkenningsskalender zou er 0,676 Mio EUR bijkomende groei zijn.

-p.204 Men evalueert het inkomensonderzoek met het oog op het wegwerken van onrechtvaardige verschillen in het huidig systeem. Kan dit worden toegelicht

De uitgaventoetsing van de zorgbudgetten leidde tot een aanbeveling dat een herdefiniëring van het inkomensbegrip binnen het zorgbudget ouderen kansen biedt om de automatische rechtentoekenning van het zorgbudget ouderen te versterken. Zo is het mogelijk om een inkomensonderzoek uit te werken waarbij de benodigde administratieve informatie digitaal raadpleegbaar is en geen tussenkomst van de gerechtigde vergt (bv. een inkomenstoets op basis van aanslagbiljet en kadastraal inkomen). Het agentschap gaat nu de inkomensbepalingen van andere entiteiten van het beleidsdomein samen met deze entiteiten evalueren op hun bruikbaarheid voor het zorgbudget.

-p.207 GMO-AGHE2TB-WT Zorgbudget ouderen met zorgnood

Bij het zorgbudget voor ouderen met zorgnood (THAB) wordt gesteld dat het aantal rechthebbenden de laatste jaren daalt. De federale regering voorziet in een hervorming

van de pensioenen die op toekomstige pensioenen een belangrijk impact zullen hebben. Hoe schat de minister de evolutie in van het aantal rechthebbenden op het zorgbudget voor ouderen met zorgnood voor het komend jaar en de jaren daarna ?

De impact van de hervorming van de pensioenen op het zorgbudget ouderen is moeilijk in te schatten. De pensioenen zullen voor bepaalde groepen in de toekomst iets lager zijn, maar het hangt dikwijls ook af van wanneer men al of niet vervroegd op pensioen gaat. De hervorming van de ambtenarenpensioenen zal door de geleidelijke invoering pas op lange termijn impact hebben op het zorgbudget ouderen. We hebben gezien dat in de voorbije jaren het aantal personen met een zorgbudget ouderen daalde, bijna zeker een gevolg van de stijging van de (minimum)pensioenen.

-p.208 GMO-AGHF2TC-WT – Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Bij het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden zien we een stijging van 6,638 miljoen euro wegens de demografische evolutie én actualisering van de berekening zorgbudget zwaar zorgbehoevenden. Wat betekent “actualisering van de berekening” ? Denkt men middelen te halen omdat de zorgzwaarte te hoog is ingeschaald ?

De raming zorgbudget zwaar zorgbehoevenden wordt aangepast aan de meest recente kennis van aantal lopende zorgbudgetten. Er wordt rekening gehouden met de bestaande aandelen van mensen met een zorgbudget in de verschillende leeftijdscategorieën van de bevolking, alsook de bijkomende erkende woongelegenheden bij de wooncentra. Er zijn geen verschillende inschalingen omwille van zorgzwaarte.

-p.209 GMO-AGHF2TD-WT – Zorgbudget Personen met een Handicap

De middelen van het zorgbudget personen met een handicap zijn uitdovend, maar er is eigenlijk maar een dik miljoen minder uitgaven en dat als gevolg van overhevelingen naar andere sectoren dan die van het VAPH. Zijn er überhaupt personen met een handicap die konden doorstromen naar de gehandicaptensector en zo ja, hoeveel ?

In 2024 zijn er 158 wiens zorgbudget beëindigd is wegen overstap naar niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

VIPA

-p.226 GBO-1GIF5SX-IS VIPA)

Er wordt voorzien in verlaging van het budget met 22,9 miljoen euro bij de klassieke infrastructuursubsidies voor 5 jaar met stopzetting systeem buffer. Kan dat worden toegelicht ?

De VAK-verlaging van 22,9 mio euro wordt deels gecompenseerd doordat er in het begrotingsjaar zelf geen bedragen extra in mindering meer moeten worden gebracht voor de toenames van de infrastructuurforfaits het volgende jaar en het jaar daarop. Dat in mindering brengen is het systeem van de buffer.

Een exact bedrag hierop plakken is moeilijk omdat dit wijzigt in functie van de ingeschatte startdatums voor de uitbetaling van de forfaiten voor de komende jaren. Op basis van de huidige ramingen voor de periode 2026-2028 zal hierdoor circa gemiddeld 17 mio euro per jaar niet meer in mindering worden gebracht.

-p. 219 Zorgnet-Icuro heeft ons er op gewezen dat het aandeel subsidies in de bouw van woonzorgcentra gezakt is tot 20% van de totale kost. Ook bij ziekenhuizen is het aandeel van de subsidies beperkt. Dat heeft allemaal te maken met de gestegen bouwkosten. Zorgorganisaties vragen een kritische evaluatie van de opgelegde bouwnormen die eveneens een oorzaak zijn van de gestegen zorgkosten. Er komt een evaluatie van het bestaande subsidiemechanisme van ziekenhuisinfrastructuur met oog op vereenvoudiging van bestaande financieringssysteem. Het infrastructuurforfait voor personen met een handicap wordt geëvalueerd. Wanneer mogen we de evaluatie van het infrastructuurforfait voor personen met een handicap verwachten ?

De administratie zal de resultaten van een herijkingsoefening van het infrastructuurforfait voor personen met een handicap tegen eind 2025 overmaken.

Wanneer mogen we de evaluatie van het subsidiemechanisme van ziekenhuisinfrastructuur verwachten ? Wanneer mogen we de aanpassingen van de regelgeving verwachten.

De aanpassingen ter vereenvoudiging van het subsidiemechanisme zijn conceptueel en inhoudelijk uitgewerkt. De juridische vertaling daarvan is momenteel bezig.

In de conceptnota kinderopvang stond dat men de ambitie had om de reglementering VIPA voor kinderopvang wou vereenvoudigen. Nu zie ik alleen initiatieven in die richting voor personen met een handicap en ziekenhuizen. Is men al gestart met de aanpassing van de VIPA-reglementering kinderopvang en zo niet, wanneer gaat men dan van start ?

De verschillende initiatieven lopen parallel. De aanpassing aan de reglementering voor de kinderopvang is inhoudelijk uitgewerkt en overlegd met de sector. Ook hier is de juridische vertaling lopende.

-Wat betreft ziekenhuizen wil minister Vandenbroucke van bepaalde kleine ziekenhuizen een soort van dagziekenhuis maken wat betekent dat er niet langer een beddenhuis zal zijn. Ondertussen liggen er investeringsdossiers op de tafel bij VIPA. Worden er nu projecten on hold gezet omwille van de intenties van minister Vandenbroucke ?

De hervorming van het ziekenhuislandschap, zoals besproken binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, is momenteel volop in ontwikkeling. De expertencommissie zal een definitief rapport voorleggen tegen het einde van dit. Dat rapport zal concrete aanbevelingen bevatten die de basis vormen voor verdere beleidsbeslissingen. Het is duidelijk dat het echte werk — de implementatie van de hervorming — dan pas zal beginnen.

Wat betreft VIPA-investeringsdossiers: er is momenteel een voorzichtige houding bij het indienen en beoordelen van bouw dossiers. We merken dat ziekenhuizen logischerwijze wachten op meer duidelijkheid over de toekomstige hervorming alvorens nieuwe infrastructuurprojecten op te starten. Anderzijds worden ingediende investeringen sowieso getoetst aan het zorgstrategisch kader.

-Er is een aankondiging geweest van de introductie van DBFM-infrastructuursubsidiesysteem naar het voorbeeld van Scholen van Vlaanderen. Wat is de stand van zaken ? Weet men al voor welke sectoren men met dit systeem wil werken?

Heel wat evaluaties en vereenvoudigingen worden bij VIPA momenteel uitgewerkt. Daar gaat nu de eerste aandacht naartoe. DBFM wordt een volgende werf. In eerste instantie moeten de sectoren nog afgebakend worden. Ongetwijfeld zal het daarbij belangrijk zijn om in acht te nemen dat schaalvoordelen maximaal moeten kunnen spelen, om op die manier een temperend effect te hebben in termen van contractkosten (die in een context van DBFM van toepassing zijn).

Technische vragen BBT WVGA - PVDA

Algemeen

Bij de begrotingsaanpassing 2025 WVGA in juni 2025 werd een budget van 17.453.781.000 euro ingeschreven als VAK BA 2025. Daarvan waren er 191.219.000 apparaatsuitgaven. Als we die aftrekken komen we tot een bedrag van 17.262.562.000 euro.

Bij de begroting 2026 staat echter een bedrag van 17.216.700.000 euro ingeschreven als VAK BA 2025 (excl. apparaatsuitgaven) binnen beleidsdomein WVGA. Komt dat omdat in juni het domein armoede niet werd meegeteld? En bedraagt dat budget voor armoede in 2025 dan precies het verschil, zijnde 45.862.000 euro?

De begrotingsaanpassing Gelijke Kansen was VAK BA 2025 15,18 miljoen euro in juni en dan zien we ook terug in deze begroting 2026.

Wat is de totale groei van budget binnen resp. domein WVGA en Armoede ?

In de tabellen zoals opgenomen in de BBT BO 2026 van WVGA en Armoedebestrijding in de rubriek V 'Beleidsvelden: overzicht totalen per programma' (p. 18) ontbreken inderdaad de kredieten van het ISE Armoedebeleid.

De correcte cijfers voor het ISE Armoedebeleid, voor het programma GC – Welzijn en voor het totaal van het beleidsdomein WVGA exclusief apparaatskredieten zijn hieronder weergegeven.

De totale groei van budget voor het beleidsdomein WVGA inclusief het ISE Armoedebeleid bedraagt 164.815 keuro VAK. De totale groei van budget voor het ISE Armoedebeleid bedraagt 13.598 keuro VAK.

ISE ARMOEDEBELEID

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2025	0	0	0	45.899	46.547
Bijstelling BO 2026	0	0	0	13.598	14.507
BO 2026	0	0	0	59.497	61.054

PROGRAMMA GC - ZORG - GECORRIGEERD (= inclusief ISE Armoedebeleid)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2025	0	0	0	2.275.235	2.280.353
Bijstelling BO 2026	0	0	0	3.540.897	3.540.369
BO 2026	0	0	0	5.816.132	5.820.722

TOTAAL - WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, excl. apparaatsuitgaven en programma B - GECORRIGEERD (= inclusief ISE Armoedebeleid)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BA 2025	0	0	0	17.262.562	16.945.976
Bijstelling BO 2026	0	0	0	164.815	154.620
BO 2026	0	0	0	17.427.377	17.100.596

Jeugdhulp

Kostendrijver

We lezen dat er 3 en 11 miljoen euro extra gaat naar ‘kostendrijvers weddedrift private voorzieningen’ en ‘kostendrijver pleegzorg’ (p.133). Waar gaat dit over? Graag verduidelijking waar deze budgetten precies voor worden ingezet en wat ‘kostendrijvers’ precies inhoudt in deze bedoorlooptijgroting?

Het erkennings- en subsidiëringsbesluit voor de jeugdhulpvoorzieningen voorziet dat de subsidie aangepast wordt aan de gemiddelde anciënniteit van de medewerkers van een voorziening. De weddedrift private voorzieningen heeft betrekking op de toename van de personeelskost voor de private voorzieningen door de stijgende anciënniteit. Dit budget wordt integraal ingezet om deze anciënniteitstoename te financieren.

Met de kostendrijver pleegzorg wordt de toename in het aantal pleegzorgsituaties gefinancierd. Dit budget wordt ingezet voor de personeels- en werkingssubsidie voor de diensten voor pleegzorg en de onkostenvergoeding voor de pleeggezinnen.

Uitbreidingsbeleid

Er wordt 7 van de 10 miljoen euro aan uitbreidingsbeleid uitgesteld naar 2027 (p.133).

1. Welk budget is er effectief uitgegeven aan extra investering in 2025 van de geplande 10 miljoen euro?

We hebben het budget in hoofdzaak aangewend om de tijdelijke projectsubsidies n.a.v. het crisis- en investeringsplan te continueren. Daarnaast hebben we gerichte ingrepen gedaan om de samenwerking tussen welzijn en onderwijs, in het bijzonder de internaten, te optimaliseren.

2. Waarom maakt de minister de keuze om dit uitbreidingsbeleid uit te stellen?

We maken expliciet de keuze om niet te besparen op kinderen en jongeren. Om de budgetafspraken binnen de Vlaamse Regering na te komen, is er wel voor gekozen om te temporiseren met het uitbreidingsbeleid. Dit betekent niet dat we volgend jaar geen uitbreidingsinitiatief zullen nemen: we willen de Overkop-huizen structureel maken en uitbreiden, investeren in vroegdiagnostiek en in hulpaanbod voor het ongeboren kind.

3. Op welk onderdeel van het beleid zal dit een impact hebben?

De impact zal minimaal zijn, omdat we het zwaartepunt van de investeringen later in de regeerperiode geprogrammeerd hadden.

4. Welk uitbreidingsbeleid zal hiermee uitgesteld worden?

Het was de intentie om in 2026 te investeren in Overkop, vroegdiagnostiek en aanbod voor het ongeboren kind. De investering voor Overkop voeren we uit zoals gepland, voor de overige uitbreidingswerven doen we een opstap in 2026 met verdere groei in 2027.

5. Wat zal er gebeuren met de 1,202 miljoen euro die wel geïnvesteerd zal worden?

Deze wordt ingezet voor de structurele financiering van de consultants die bijkomend mochten geworven worden n.a.v. BO2024 (33 na de 90 VTE waren bij BO2024 nog niet structureel gefinancierd).

6. Welk uitbreidingsbeleid zal er wel gerealiseerd worden en wat betekent dat concreet in aantal extra plaatsen in de jeugdhulp? Wat zal het verwachte effect zijn op de wachtlijsten?

Zichtbare effecten zullen er pas zijn als we onze volledige hervormings- en uitbreidingsagenda ten volle gerealiseerd hebben.

Activering van opgebouwde reserves Er zal 1,5 miljoen bespaard worden door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen + door de activering van opgebouwde reserves (p.134). Hoe komt men tot het bedrag van 1,5 miljoen euro aangezien het kader nog uitgewerkt moet worden?

Zie antwoord op vraag 1.

Op welke organisaties in de jeugdhulp of welke specifieke beleidsdomeinen zal deze besparing effect hebben?

Zie antwoord op vraag 1.

Kinderopvang Compensatie VIPA Er wordt 60 miljoen euro teruggezet als eenmalige compensatie van VIPA uit de begroting van 2025 voor de realisatie van infrastructuur in de kinderopvang via de lokale besturen (p.146). Als ik het goed begrijp is dit voorzien maar niet besteed budget uit 2025, dat nu wel ingezet zal worden? Wat zijn de redenen dat dit budget in 2025 niet uitgegeven werd? Welke garanties zijn er dat dit budget in 2026 wel uitgegeven zal worden?

Dit budget werd niet uitgegeven omdat de plaatsen pas zullen toegekend worden eind 2025. Daarom is er met éénmalige middelen een overdracht geweest naar VIPA, zodat zij lokale besturen kunnen subsidiëren om infrastructuur voor nieuwe plaatsen mogelijk te

maken. Zie ook: [Subsidie aan gemeenten voor financiële ondersteuning aan organisatoren van kinderopvang voor infrastructuur | Vlaanderen.be](#)

Vanaf 2026 komt dit budget terug naar Opgroeien, zodat dit ook kan gebruikt worden voor de realisatie van de nieuwe plaatsen trap 2 waarvoor de subsidiebeloftes midden december 2025 toegekend worden.

Resterend uitbreidingsbeleid BO2024

Er zou ook nog 10 miljoen euro aan resterend uitbreidingsbeleid van BO2024 opgevraagd worden met betrekking tot de verlaging van de kindratio (p.147). Begrijp ik het goed dat dit opnieuw budget is dat voorzien was maar niet uitgegeven werd in 2024 en nu wel ingezet zal worden?

Het gaat hier over het nog niet op kruissnelheid zijn van de maatregel m.b.t. de verlaging van de ratio in 2024 en 2025. Vanaf 2024 werden de vastleggingskredieten voor deze maatregel reeds volledig toegekend. De vereffeningskredieten volgden pas later volledig. Vanaf 2026 worden ook de vereffeningskredieten voor deze maatregel op kruissnelheid voorzien.

1. Wat zijn de redenen dat dit budget in 2024 niet uitgegeven werd?

Omdat nog niet voor alle kinderopvangplaatsen de verlaagde ratio behaald werd.

2. Welke garanties zijn er dat dit budget in 2026 wel uitgegeven zal worden?

Op basis van de cijfers 2024 weten we dat al voor veel plaatsen deze ratio behaald werd. In 2025 en 2026 zal zich dit doortrekken. Pas vanaf 2027 zijn voorzieningen verplicht om deze ratio te behalen. Nu wordt het saldo van 40 % pas (gedeeltelijk) uitgekeerd als de verlaagde ratio behaald wordt.

Premie onthaalouders

De onthaalouders hebben nog steeds geen nieuws gekregen in verband met de beloofde renovatie- en installatiepremie. Wordt hiervoor budget voorzien voor 2026 of valt dat nog binnen de begroting van 2025? Hoe groot zal dat budget zijn?

De start- en renovatiepremie voor onthaalouders werd nog niet ingevoerd omdat ook de fiscale implicaties voldoende moesten worden in kaart gebracht. Intussen heb ik formeel de vraag gesteld aan federaal minister van Financiën Jan Jambon om een bijkomende fiscale vrijstelling mogelijk te maken voor opstartkosten en renovaties die onthaalouders maken.

Minister Jambon staat hier positief tegenover, maar vraagt eerst een ontwerp van regelgeving om in te kunnen schatten wat de mogelijkheden op het vlak van fiscale

vrijstelling zijn. Mijn administratie werkt hier momenteel aan. Zodra dit ontwerp klaar is en er federale goedkeuring komt, kan de Vlaamse Regering het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering (BVR) goedkeuren. Op die manier willen we alsnog tegemoetkomen aan de investeringen die onthaalouders moeten doen.

Ouderenzorg

Activering van opgebouwde reserves

Er zal 750.000 euro bespaard worden in het thuis- en ouderenzorgbeleid door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen door de activering van opgebouwde reserves (p.113).

1. Hoe komt men tot het bedrag van 750.000 euro aangezien het kader nog uitgewerkt moet worden?

Zie het antwoord op vraag 1.

2. Op welke organisaties binnen de thuis- en ouderenzorg of op welke specifieke beleidsdomeinen zal deze besparing effect hebben?

Zie het antwoord op vraag 1.

Uitbreidingsbeleid

Het is me niet duidelijk of binnen de ouderenzorg en gezinszorg er eveneens uitbreidingsbeleid uitgesteld wordt. Klopt het dat er 2 miljoen euro geïnvesteerd wordt en 10 miljoen euro uitbreidingsbeleid uitgesteld wordt? Wat zullen de effecten daarvan zijn?

We blijven nog steeds investeren maar de 140 mio euro die voorzien werd, wordt 130 mio euro op het einde van de rit. Door in te zetten op regelluwte en efficiënter beheer moeten we niet zuiver besparen, maar creëren we extra ruimte voor diensten of voorzieningen zonder uit te breiden.

Totale besparing gezins- en thuiszorg

Klopt het dat er binnen de gezinszorg en de thuiszorg een totale besparing komt van samen 33.797 miljoen euro?

Ja, dat klopt.

Totale besparing residentiële ouderenzorg

Binnen de residentiële ouderenzorg valt er een totale besparing van 45,3 miljoen euro, door actualisering, extra strenge financiële inspecties en de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt op de BTZ (p.115).

Graag een verduidelijking wat deze besparingen precies inhouden. Graag verduidelijking van ‘actualisering’, van ‘extra financiële inspecties’ en ‘toepassing van de aanpassingscoëfficiënt op de BTZ’.

Basistegemoetkoming ouderenzorg

De ingeschreven uitgavenverlaging van 29,3 mio euro betreft een aanpassing via de basistegemoetkoming Zorg. Momenteel berekent de administratie de impact per zorgvoorziening op basis van de meest recente parameters.

Samen met de sector wordt bekeken hoe hiernaast een interessant pakket aan maatregelen kan komen te staan rond het wegwerken van overbodige of gedetailleerde regellast en meer flexibel inzetten van personeel.

Handhaving en het aanscherpen van de Kappa-controles

Om de begrotingsdoelstellingen te halen werd met deze maatregel bewust gekozen voor een bijstelling - niet voor een besparing - van €8 mio op het totale budget (€2,7 miljard) ouderenzorg. Al langer weerklinkt, ook vanuit de sector, de vraag om toe te zien op een correctere naleving van de inschaling van de zorgzwaarte. Maar het gaat over open-end financiering: als er meer geld nodig is, dan zal dat er komen.

Zorgzwaarte

Dit is een bijstelling, die ingeschreven staat voor een bedrag ten belope van € 8 mio. Om de begrotingsdoelstellingen te halen werd met deze maatregel bewust gekozen voor een bijstelling die de woonzorgcentra niet zullen voelen. Het is een begrotingstechnische ingreep die, op basis van de cijfers uit het verleden, als erg haalbaar wordt ingeschat. Het budget voor de actualisatie werd oorspronkelijk immers te hoog ingeschat en wordt daarom voorlopig bijgesteld naar beneden. Maar ook hier gaat het over open-end financiering: als er meer geld nodig is, dan zal dat er komen.

1. Hoe zullen deze besparingen precies uitgevoerd worden en wat zullen de gevolgen zijn?

Zie bovenstaand antwoord.

Urencontingent

Graag uitleg over ‘opheffen bevrozing behoud urencontingent en stopzetting erkenning voor diensten die de minimale invulling van het urencontingent niet halen gedurende 2 jaar op rij’ en over de ‘verhoging efficiëntie urencontingent’ (p.114).

1. Graag begripsverduidelijking, wat houden deze besparingen van in totaal 25 miljoen euro precies in?

De norm van de gelijkgestelde uren zal verlaagd worden.

Daarnaast zal het urencontingent gezinszorg lineair gerationaliseerd worden.

2. Hoeveel diensten dreigen stopgezet te worden, en gaat dat over hele organisaties of delen van organisaties? Hoeveel erkenningen dreigen er gestopt te moeten worden?

Het betreft enkel de diensten voor gezinszorg die niet minimaal de uren van 10 VTE verzorgend personeel presteren. Dat is ook de minimale erkenningsnorm van een dienst voor gezinszorg in functie van kwaliteitsvolle en efficiënte werking. Deze diensten zullen ook de mogelijkheid krijgen om te fusioneren met een andere dienst voor gezinszorg of om hun erkenning naar een andere dienst voor gezinszorg over te dragen.

De intrekking van de erkenning zal nog niet in 2026 gebeuren, maar pas nadat de dienst zowel in 2026 en 2027 niet voldoende uren heeft gepresteerd. Pas dan zullen we ook effectieve aantallen kennen.

Personen met een handicap

Er lijkt geen budget vrijgemaakt te worden om de geplande hervormingen uit te werken. Het hele budget lijkt te gaan naar de persoonsvolgende budgetten zelf. Klopt dit? En zo ja, is er een raming van de kosten nodig om de hervormingen uit te werken?

Dat klopt. Wat betreft de ramingen van de kosten voor de hervormingen: De hervormingsprojecten lopen nog en de budgettaire impact zal pas zichtbaar zijn wanneer het moment van de inwerkingtreding van de conceptnota nadert (1 januari 2028). De projecten worden nauw opgevolgd vanuit het team Cijferbeleid, Boekhouding en Budget van het VAPH dat instaat voor de budgetopvolging en stapsgewijs wordt de puzzel volledig gelegd.

Uitbreidingsbeleid

Er wordt 10 miljoen euro aan uitbreidingsbeleid uitgesteld naar 2027 (p.175).

1. Welk budget is er effectief uitgegeven aan extra investering in 2025 van de geplande 102 miljoen euro?

In 2025 is 52,4 miljoen euro voorzien voor terbeschikkingstellingen PG 1 en de automatische toekenningsgroepen binnen PVB. De overige 50 miljoen is ingezet voor het

optrekken van deelbudgetten PG 2 (24 miljoen) en voor nRTH minderjarigen (PAB en MFC).

2. Waarom maakt de minister de keuze om dit uitbreidingsbeleid uit te stellen?

Het uitstel van het uitbreidingsbeleid is onderdeel van de algemene beslissing ter beheersing van de begrotingsdoelstellingen.

3. Op welk onderdeel van het beleid zal dit een impact hebben?

Het uitbreidingsbeleid wordt opgedeeld in een gedeelte voor automatische toekenningen en prioriteitengroep 1 enerzijds, en middelen in kader van de hervormingen anderzijds. Het zijn de middelen in kader van de hervormingen die opgeschoven worden naar 2027.

4. Welk uitbreidingsbeleid zal hiermee uitgesteld worden?

Het uitbreidingsbeleid buiten de automatische toekenningen en prioriteitengroep 1

5. Wat zal er gebeuren met de 47 miljoen euro die wel geïnvesteerd zal worden?

Deze middelen zullen ingezet worden voor terbeschikkingstellingen PVB in prioriteitengroep 1 en in de automatische toekenningsgroepen.

6. Welk uitbreidingsbeleid zal er wel gerealiseerd worden en wat betekent dat concreet voor de persoonsvolgende budgetten? Wat zal het verwachte effect zijn op de wachtlijst voor persoonsvolgende budgetten?

Er is 46,5 miljoen euro gereserveerd voor terbeschikkingstellingen PVB in PG 1 en voor de automatische toekenningsgroepen. Het engagement om binnen de 18 maand na de start van de aanvraag een budget ter beschikking te stellen aan mensen in PG 1 blijft gehandhaafd.

Er wordt 10 miljoen euro gebudgetteerd voor 'Uitbreidingsbeleid Hervormen personen met een handicap', 'Voorziene opstap regeerakkoord 2024-2029'. Waarom wordt er eerst 10 miljoen euro geschrapt om er dan 5 vakken later weer 10 miljoen euro bij te doen?

Hiermee geven we in alle duidelijkheid weer welk groeipad er initieel voorzien was, maar vertraagd wordt tot 2027.

Vertraging groeipad

Er wordt ook 10 miljoen euro bespaard via de vertraging van het groeipad naar 2027 (p.175).

1. Betekent dat dat er minder persoonsvolgende budgetten zullen worden uitgekeerd? Zullen alle mensen binnen de groep AT/PG1 geholpen kunnen worden en binnen welke wachtttermijn?

De ingreep van €10 miljoen als gevolg van de vertraging van het groeipad naar 2027 zal geen impact hebben op de toekenning van PVB's aan de meest prioritaire groepen.

Het engagement ten aanzien van de automatische toekenningsgroepen (AT) en prioriteitengroep 1 (PG1) blijft gehandhaafd. Volgens de huidige ramingen zullen de persoonsvolgende budgetten voor mensen in de AT-groepen onmiddellijk en in PG1 binnen de 18 maanden na de start van de aanvraag ter beschikking worden gesteld. In 2026 is reeds €46,5 miljoen voorzien voor de automatische toekenningsgroepen en PG1. Dit voorziene budget, samen met de middelen die vrijkomen door de uitstroom van budgethouders (overlijden en stopzettingen), is volgens de huidige inschattingen voldoende om alle PVB's binnen de vastgestelde termijn van 18 maanden aan de AT-groepen en PG1 toe te kennen.

De vertraging van het groeipad heeft dus geen negatieve gevolgen voor de toekenning van budgetten aan mensen in de hoogste prioriteitengroepen.

2. Is dat bepaald beleid dat niet uitgewerkt wordt?

Neen.

3. In de uitleg staat er dat 'uitbreidingsbeleid voor PVB's van andere doelgroepen dan ATK en PG1 wordt uitgesteld'. Hoeveel mensen van PG2 en PG3 zullen geholpen worden met een persoonsvolgend budget in 2026?

De voorziene middelen UB 2026 zullen in 2026 niet ingezet worden voor terbeschikkingstellingen PG 2 en PG 3. Deze zijn immers gereserveerd voor terbeschikkingstellingen in PG 1 en de automatische toekenningsgroepen.

Activering van opgebouwde reserves

Er zal 1 miljoen euro bespaard worden door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen door de activering van opgebouwde reserves (p.175).

1. Hoe komt men tot het bedrag van 1 miljoen euro aangezien het kader nog uitgewerkt moet worden?
2. Op welke organisaties binnen de sector of op welke specifieke beleidsdomeinen zal deze besparing effect hebben?

Zie het antwoord op vraag 1.

Schoolmaaltijden

Graag hadden we duidelijkheid over hoeveel budget er in 2026 effectief naar gezonde voeding op school zal gaan. Er was binnen het domein Welzijn 46,7 miljoen euro uitbreidingsbeleid gepland, daarvan wordt 33,5 miljoen uitgesteld (p.48). Tijdens de toelichting van de begroting in commissie Onderwijs spreekt de minister van een investering van 70 miljoen euro.

1. Wat is het totale budget voor de cofinanciering van gezonde voeding op school in 2026 binnen de verschillende beleidsdomeinen? Wordt er binnen twee beleidsdomeinen allebei budget voor voorzien, waarin ligt het onderscheid?

Het voorziene budget voor 2026 is 36.500.000 euro. De 70.000.000 euro waar de minister van onderwijs naar verwijst, is hetzelfde budget, maar dan vanaf 2027. Het gaat dus niet om extra budget vanuit de begroting onderwijs.

Activering reserves

In verschillende sectoren zal er bespaard worden door het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen door de activering van opgebouwde reserves:

- Beleidsontwikkeling en ondersteuning (Vlaamse Ouderenraad, Sociaal.net)
 - 1,5 miljoen euro (op een totaalbudget van 19 miljoen euro) (p.35)
- Welzijnswerk (CAW's, teleonthaal)
 - 1,5 miljoen euro (op een totaalbudget van 141 miljoen euro) (p.60)
- Preventieve gezondheidszorg
 - 750.000 euro (op een totaalbudget van 96 miljoen euro) (p.77)
- Beleid eerstelijnszorg (Vivel...)
 - 1 miljoen euro (op een totaalbudget van 35 miljoen euro) (p.86)
- Beleid voor ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg
 - 1,5 miljoen euro (op een totaalbudget van 46 miljoen euro) (p.101)

Hoe komt men tot deze bedragen aangezien het kader nog uitgewerkt moet worden?

Zie het antwoord op vraag 1.

Sociale akkoorden

Er is een uitbreidingsbeleid van 18 miljoen euro gepland voor 'eindeloopbaan' (p.65). Kan verduidelijkt worden wat hier precies onder begrepen wordt? Gaat dat over de eindejaarspremie voor zorgpersoneel?

Dit gaat niet over de eindejaarspremies maar over de eindeloopbaanmaatregelen. Eindeloopbaanmaatregelen zijn onderdeel van een sociaal akkoord zodat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven in de sector (de zogenaamde rimpeldagen). De overheid komt tussen in de loonkost van de vervangers die aangeworven worden om de personeelsleden met vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP) te compenseren, of in de kostprijs van de premie.

De uitgaven in het kader van eindeloopbaanmaatregelen evolueren op basis van onderliggende parameters:

- Aanpassing van lonen aan de evolutie van de spilindex.
- De evolutie van het aantal rechthebbenden = aantal actieve personeelsleden vanaf 45 jaar.
- De evolutie van de vervangingsratio = aantal personeelsleden waarvoor effectief vervanging gevonden wordt.

Naast de vele indexeringen zijn er ook de jaarlijkse stijging van het aantal rechthebbenden en het aantal compenserende vervangers.

Technische vragen BBT WVGA – Vlaams Belang

Overkoepelende strategische doelstellingen

- Elke keer staat erin dat barrières en overlap tussen zorgverleners en beleidsniveaus weggewerkt worden en dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Hoe gaat de minister er deze keer effectief in slagen om de huidige barrières weg te werken? Denkt zij dat dit mogelijk is zonder nog verder te regionaliseren?

We hebben intensief overleg met de federale overheid en worden betrokken bij de hervormingen die zij voorzien. Er zijn verschillende instrumenten voorhanden om een nauwe samenwerking met federaal niveau te hebben (overleg met de federale minister en het federale kabinet, IAP, IMC, IKW's, overleg op administratief niveau). Er wordt gewerkt aan verschillende samenwerkingsakkoorden met de federale overheid.

- Er wordt verwezen naar het actieplan zij-instroom, welke resultaten worden van dit onderzoek verwacht?

De evaluatie van het actieplan moet nog worden opgestart. Bij de opstart zal in onderling overleg met alle betrokken partners concreet worden afgesproken op welk manier geëvalueerd zal worden en wat de timing is.

- Hoe wordt er verder ingezet op digitale competenties zodat iedereen mee kan met de technologische innovatie?

Momenteel worden sectoren van het beleidsdomein WVGA ondersteund via het expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen. In hun aanbod wordt ingezet op de versterking van digitale competenties en het screenen van kwaliteitsvolle technologie. Daarnaast loopt ook het project Bandbreedte waarin aandacht is voor de digitale competenties van jongeren en medewerkers in de jeugdhulp.

In het kwaliteitskader digitale zorg en ondersteuning is er eveneens aandacht voor digitale competenties en inclusie. We bekijken hoe we dit kader kunnen vertalen in ondersteunende regelgeving. Het is bovendien belangrijk om op te merken dat inzetten op digitale competentieversterking een gedeelde inspanning vereist vanuit verschillende beleidsvelden (cfr. Het actieplan mediawijsheid, het horizontaal gelijkheidsbeleidsplan met aandacht voor digitale inclusie, de opmaak van het actieplan digitale vaardigheden dat door ADV wordt gecoördineerd, ...).

Beleidsveld Zorg:

Beleidsondersteuning

- Hoe wordt de coördinatie tussen de entiteiten (Departement Zorg, VAPH, Opgroeien, VUTG) verzekerd om overlappingsen te vermijden?

De coördinatie tussen de entiteiten wordt verzekerd door structureel overleg en samenwerking bij de uitwerking van plannen, ook in het kader van geïntegreerde zorg en ondersteuning. We betrekken steeds alle administraties.

- De beleidsnota erkent zelf dat er nood is aan meer *geïntegreerde zorg* en *minder versnippering* tussen beleidsniveaus (Vlaams, federaal, lokaal). Hoe ziet de minister deze concrete implementatie van deze samenwerking? Welke kwantitatieve doelstellingen of meetpunten worden vastgelegd?

In lijn met het protocolakkoord dat werd afgesloten tijdens de vorige legislatuur werken we samen met de federale overheid verder aan de uitwerking van geïntegreerde zorg en ondersteuning. Momenteel lopen de onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord dat een juridische basis moet bieden voor zowel de generieke bouwstenen voor geïntegreerde zorg en ondersteuning als de basis voor de uitrol van geïntegreerde zorgprogramma's, onder meer op vlak financiering en gegevensdeling.

- Welke concrete resultaten worden verwacht van het project “administratieve vereenvoudiging” binnen het beleidsdomein WVG (p. 22)?

Regelrecht, het regeringsbrede project voor administratieve vereenvoudiging, bewandelt 2 sporen: de blik naar binnen, en de blik naar buiten. In het eerste spoor is de administratie al bezig met een hele reeks van vereenvoudigingsinitiatieven die de regeldruk en de administratieve lasten verlichten en vereenvoudigen. We schrappen in onbruik geraakte regelgeving, we gaan van papier naar digitaal, we koppelen databanken aan elkaar om bv. De facturatie binnen de Vlaamse Sociale Bescherming te vergemakkelijken, we nemen rapportageverplichtingen onder de loep en vereenvoudigen die.

In de blik naar buiten reiken we de hand naar onze stakeholders. Ook zij hebben een hele reeks voorstellen aan ons overgemaakt. Dit zijn voorstellen die zowel betrekking hebben op Europese, federale en Vlaamse regels en administratieve verplichtingen. We bestuderen nu deze voorstellen. De Europese en federale regels worden tevens meegenomen naar de centrale werkgroep van het project Regelrecht. En we verwachten ook van de voorzieningen zelf dat zij eveneens de blik naar binnen richten om de eigen regels en administratie die zij zelf opleggen aan personeel en zorggebruikers kritisch te bekijken. Alle actoren, overheid en de zorgsector zelf, nemen zo initiatieven om de administratie te verlichten.

- P. 23: Hoe worden de inspanningen inzake “Zorgzame buurten” structureel verankerd in het beleid en budgettair ondersteund?

Zie eerdere antwoorden

- P. 23: Hoe zullen de lokale dienstencentra versterkt worden?

Enerzijds via uitbreiding en anderzijds via een doorontwikkeling in het kader van zorgzame buurten.

- Hoeveel middelen worden toegewezen aan het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2026–2030 en hoe wordt de uitvoering opgevolgd?

Er wordt geen extra budget voorzien voor het Vlaamse Ouderenbeleidsplan 2026-2030. De opvolging van het ouderenbeleidsplan gebeurt via monitoring.

- Welke budgettaire impact heeft de Green Deal Duurzame Zorg (p. 24) op het totale zorgbudget?

De Green Deal Duurzame Zorg heeft geen budgettaire impact binnen de BBT van 2026.

- Op welke wijze wordt de uitvoering van het Eenzaamheidsplan 2026–2029 opgevolgd en gebudgetteerd, aangezien geen afzonderlijke beleidskredieten voorzien zijn (p. 24)?

Er wordt geen extra budget voorzien voor het eenzaamheidsplan 2026 – 2029. De opvolging van het eenzaamheidsplan gebeurt via een monitoring.

- Hoe wordt de samenwerking met Brussel concreet ingevuld en gefinancierd binnen dit ISE (p. 24–25)?

Voor welzijn, volksgezondheid en gezin zijn zowel de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie als de lokale besturen (gemeenten en OCMW's) in Brussel bevoegd.

In het kader van de besprekingen met betrekking tot het interfederaal plan geïntegreerde zorg zijn wij vragende partij om expliciet een afstemming te voorzien waarin alle overheden die in Brussel bevoegd zijn voor welzijn en gezondheid worden betrokken van bij de start van initiatieven inzake geïntegreerde zorg. Voor samenwerking en overleg voorzien we geen aparte financiering.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft de prioritaire partner voor het gemeenschapsbeleid van de Vlaamse Regering.

- P. 25: In welke mate zijn er bijkomende middelen voorzien voor onderzoek en praktijkondersteuning via het Steunpunt WVG en SAM?

Het huidige Steunpunt WVG is erkend tot 30/06/2026. Er zal een nieuwe open oproep gelanceerd worden voor een vijfde steunpuntgeneratie (Steunpunt WVG) dat zal lopen

van 1 oktober 2026 tot en met 30/09/2031. Voor het volgende steunpunt wordt er opnieuw – naar analogie van het huidige Steunpunt – gewerkt met een structurele werkingssubsidie per werkjaar van 606.000 euro. Daarnaast kan elke entiteit ook via bijkomende eigen middelen onderzoek bestellen.

Voor het Steunpunt SAM is de basiswerkingssubsidie voorzien, er zijn geen bijkomende middelen voorzien.

- P. 27: VASGAZ wordt afgeschaft. Kunnen de doelstellingen gerealiseerd worden zonder het oprichten van een aparte structuur?

In het regeerakkoord staat vermeld dat we VASGAZ gaan afschaffen in deze regeerperiode. We zoeken naar oplossingen om de werking van het huidige Vitalink comité niet in het gedrang te brengen, daarnaast erkennen we het belang om op een gecentraliseerde manier onze stakeholders te kunnen consulteren.

- P. 28: Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsakkoord voor de uitwisseling van BelRAI gegevens tussen het federale BelRAI-platform en het Vlaams IT-platform BelRAI. Hoe gebeurt de uitwisseling van de gegevens dan momenteel?

Momenteel worden er geen gegevens uitgewisseld tussen het federale en het Vlaamse BelRAI-platform.

- P. 29: Er wordt geïnvesteerd in een geïntegreerd datamanagementsysteem. Welke stappen worden er concreet genomen en hoe zal deze opgevolgd worden?

Om tegen maart 2029 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de eerste fase van de European Health Data Space (EHDS), wordt een gefaseerde aanpak gevolgd. In het vierde kwartaal van 2025 start een pre-analyse voor een datamanagement programma met focus op de EHDS. In 2026 volgen diepgaande analyses van het datalandschap en de technische bouwblokken, de uitwerking van een governance- en juridisch kader, en de uitvoering van technische proof-of-concepts. Eind 2027 moeten de eerste meta-data-transfers mogelijk zijn binnen een testomgeving, en tegen eind 2028 moeten de bouwblokken operationeel zijn.

- P. 30 inzake de uitbouw van een digitale data-infrastructuur voor surveillance, testing en contact-tracing: gaat het om een nieuwe data-infrastructuur? Hoe zal dit exact vorm krijgen?

InfectioNet, Vaccinet en de reeds lopende surveillanceovereenkomst met Sciensano vormen de basis waarop verdere integratie en interoperabiliteit zullen worden gerealiseerd om opschaling binnen crisiswerking mogelijk te maken.

- P. 31 over de oproepbare reserve-eenheid: met welke externe partner wordt hiervoor samengewerkt? Hoeveel budget wordt er hiervoor voorzien? Hoe groot zal deze reserve-eenheid zijn?

Voor de organisatie en operationele aansturing van de Reserve-eenheid Paraatheid werd gekozen voor een samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen, dat over de vereiste expertise, vrijwilligerswerking en operationele slagkracht beschikt om deze opdracht te vervullen. De REP zal in het eerste jaar bestaan uit 100 (para)medische profielen, waaronder artsen en verpleegkundigen die op vrijwillige basis beschikbaar zijn om bij noodsituaties tijdelijk ingezet te worden binnen de Vlaamse zorgcontext in afwachting van crisisorganisatie binnen de reguliere zorg.

Voor de realisatie van dit initiatief is een totaalbudget van 250.000 euro voorzien voor de samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis-Vlaanderen.i

- P. 31: hoe zal de evaluatie van subsidies binnen het beleidsdomein verfijnd en geoptimaliseerd worden?

In 2026 wordt verder gewerkt aan een evaluatiekader dat de interne processen voor subsidie-evaluatie binnen de administratie optimaliseert en stroomlijnt. Het doel is om het evaluatieproces efficiënter te maken. Dit gebeurt door het verder ontwikkelen en verbeteren van uniforme handleiding, sjablonen en databank voor het verzamelen van evaluaties. Er worden praktische hulpmiddelen voorzien beleidsdomein breed om beleidsevaluatie te optimaliseren.

De evaluatiekalender blijft een belangrijk instrument: hierin worden alle geplande evaluatiemomenten opgenomen. Op die manier wordt de opvolging van evaluaties gestructureerd en transparant, met jaarlijkse updates over de stand van zaken.

- P. 34: hoeveel middelen gaan er concreet naar de opvolging en de participatie aan het internationale en Europese beleid? Graag ook enige toelichting.

Internationaal Beleid geeft jaarlijks 23.000€ uit voor lidmaatschappen aan vier Europese / Internationale netwerken: European Regional and Local Health Network – EURGHA; het Regions For Health Network RHN van WHO Europe; de European Health Telematics Association - EHTEL; de International Commission on Couple and Family Relations – ICCFR.

- Er wordt veel nadruk gelegd op administratieve vereenvoudiging, maar ook daar worden er geen specifieke budgetten voor ingezet. Waarom werden deze budgetten nog niet ingezet? Dit zijn hervormingen maar ze worden niet gefinancierd?

Een groot deel vereenvoudigingen vraagt geen budget, denk aan het verduidelijken van regelgeving, schrappen van overbodige of in onbruik geraakte regelgeving, het afstemmen van rapportagecycli op elkaar, het verminderen van registraties enz.

Buiten ICT-matige investeringen en uitgaven (bv. eCalcura, VSB, platform zorgberoepen, meldingsplichtige infectieziekten enz.) en een deel personeelskosten binnen de administratie, zullen geen aparte budgetten worden ingezet.

Armoedebestrijding

- Er komt een nieuwe opleiding ervaringsdeskundige. Hierbij zou er gezorgd worden voor voldoende financiering. Wat wordt er net verstaan onder voldoende financiering? Hoeveel budget is er voorzien en hoe werd dit bepaald?

180.000 euro op jaarbasis per opleidingslocatie. Er zal gestart worden met 1 opleidingslocatie vanaf januari 2027. Dit op basis van een inschatting door de organisatie die voorheen de opleiding coördineerde (deLink vzw).

- Hoeveel van dit budget inzake armoedebestrijding betreft structurele middelen tegenover projectmatige of tijdelijke kredieten?

Begrotingsartikel	Structurele inzet	Projectmatige of tijdelijke inzet
GB0-1GCF2CA-WT	18.058	1.400
GB0-1GCF2CB-WT	354	37.302

ro

lijk: 37.302k euro

- Hoeveel middelen worden voorzien voor wetenschappelijk en ervaringsonderzoek over armoede, en welke instellingen voeren dit uit?

Op begrotingsartikel GB0-F2CB-WT is een budget voorzien van 156.000 euro. Dit bedrag is op dit ogenblik nog niet toegekend.

- Welke budgetten werden in het vorige jaar niet volledig aangewend, en wat waren de oorzaken (vertraging, projectstopzetting, personeelstekort)?

Voor 2024 kunnen we verwijzen naar de BBT BU2024.

- Hoeveel middelen worden er concreet voorzien in de strijd tegen kinderarmoede?

We benoemen 2 concrete projecten, maar andere beleidsmaatregelen zoals de investeringen in de extra inkomensgerelateerde kinderopvang, de investeringen in toeleiding naar werk etc bestrijden kinderopvang:

We zetten 1 miljoen euro Vlaamse middelen in voor de uitvoering van de actie in het VAPA: 5.2.9 “We verankeren de praktijk ‘Geïntegreerd groepsaanbod gezinsondersteuning met bruggen naar kinderopvang, werk, opleiding en inburgering’ voor maatschappelijk kwetsbare moeders met jonge kinderen.”

620.000 euro wordt ingezet voor de projecten preventieve gezinsondersteuning.

- P. 46 & P. 55: hoeveel middelen zullen er worden uitgetrokken om de housing-first projecten structureel te verankeren?

We verduurzamen de Housing First projecten door uitbreiding van de erkenning van de CAW met 11 VTE. Dit stemt overeen met een totaalbudget van 977.567,67 euro.

ISE Welzijnswerk

- p. 52: er wordt geen rekening gehouden met het aantal gemiste oproepen bij 1712. Waarom worden er hieromtrent geen streefwaarden geformuleerd?

Door diverse factoren (bijvoorbeeld door bekendmakingsacties, campagnes, berichtgevingen, televisieprogramma's,...) schommelt het dagelijkse aantal oproepen bij de hulplijn. Om die reden wordt er geen specifieke streefwaarde bepaald voor het aantal gemiste oproepen. De hulplijn 1712 registreert hoeveel oproepen er effectief beantwoord worden, over (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling. Toch onderneemt hulplijn 1712 zaken om gemiste oproepen te ondervangen, zo krijgt de contactnemer bij een bezette lijn aan de telefoon een antwoordapparaat te horen, waarbij de contactnemer zijn/haar telefoonnummer kan achterlaten, de hulplijn 1712 belt zo snel mogelijk terug. Bij bepaalde piekmomenten kan er een extra chatlijn ingevoerd worden.

- P. 54: er kunnen momenteel geen gegevens aangeleverd worden mbt het ingebouwd vrijwilligerswerk binnen WVG. Gaat de minister initiatieven nemen om toch gegevens hieromtrent te verzamelen?

Het ingebouwd vrijwilligerswerk maakt integraal deel uit van het vrijwilligersbeleid in de voorzieningen van de verschillende WVG-sectoren. Dit is zeer uitgebreid en te complex om dit voor de verschillende sectoren eenduidig in kaart te brengen maar wordt wel binnen de sectoren zelf opgevolgd.

- P. 55: er zou gezorgd worden voor een betere afstelling tussen het aanbod van de hulplijnen en er worden maatregelen genomen om de betrouw- en bereikbaarheid te verbeteren. Naar welke bereikbaarheid wordt er gestreefd? Wat bedoelt de minister met betrouwbaarheid? Wordt hierbij verwezen naar de kwaliteit van de gesprekken?

Betrouwbaarheid en bereikbaarheid hangen nauw samen: als we aangeven dat een hulplijn bereikbaar is op bepaalde uren, moet die beschikbaarheid ook effectief gegarandeerd zijn. We leggen dus de nadruk op de betrouwbaarheid van het aanbod, zodat burgers erop kunnen rekenen dat de hulplijn bereikbaar is binnen de aangekondigde uren. We focussen op het versterken van de kwaliteit en voorspelbaarheid van de dienstverlening.

- P. 56: welk budget wordt er voorzien voor een bijkomend zorgaanbod in de nieuwe gevangenissen en detentiehuizen? Hoeveel wordt er specifiek voorzien voor de detentiehuizen?

Het aanbod is bepaald in het decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het bijkomende aanbod omwille van uitbreiding

detentiecapaciteit zal verder worden uitgewerkt afhankelijk van de specifieke noden. Vlaanderen beschikt niet over de nodige financieringsmechanismen bij dergelijke capaciteitsuitbreiding. Het evenwicht tussen dit aanbod en de noodzakelijke hulp- en ondersteuning aan niet-gedeteneerden en niet-justitiabelen dient hierin bewaakt te worden.

- Hoeveel van het budget binnen dit ISE is specifiek toegewezen aan forensische zorg, en hoe wordt de samenwerking met Justitie en GGZ gefinancierd?

De financiering verloopt via de algemene enveloppe-financiering van CAW.

- Disengagement-consulenten: 3,5 VTE + 1 VTE projectmatig
- HSD-teams (buiten de gevangenis); 10,5 VTE
- Hulplijn SiN! = 2,5 VTE

Daarnaast zijn er nog projecten voorzien in 2026 rond de forensische doelgroep/context.

- project rond naasten van SiN!=40.085, euro
- verlenging detentiecapaciteit Dendermonde-Hulp = 171.341,30 euro
- verderzetting project hulpverlening aan plegers/daders zedenfeiten in de gevangenis = 202.600, 00 euro
- uitbreiding detentiecapaciteit = 177.914,12 euro
- ondersteuning UFC ikv samenwerkingsakkoord = 75.000 euro
project contextueel herstel - Dit project loopt 15/12/2021 - 31/12/2026. UFC ontvangt hiervoor 234.113,70€ voor de ganse periode.

Voor de samenwerking met Justitie of GGZ zijn er geen specifieke middelen voorzien. Als partner in een netwerk worden de CAW verondersteld met iedereen samen te werken.

- Zal er vanuit welzijn een budget voorzien worden voor het nieuwe actieplan inzake seksueel geweld? Zo ja, hoeveel? Zo nee, kan de minister dan garanderen dat de acties budgetneutraal uitgevoerd kunnen worden?

Vanuit welzijn worden er voor verschillende acties middelen voorzien:

- Actie met betrekking tot een projectsubsidie voor GAMS vzw: 92.307,69 euro. Deze organisatie zet zich in voor de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking en eengerelateerd geweld.
- Actie met betrekking tot projectsubsidies voor Stop it Now!. Enerzijds financiert Welzijn het naastenproject (40.085,59 euro) en de ontwikkeling van de chatbot (20.900 euro). De mogelijkheden van de verdere werking van de chatbot is Departement Zorg via een projectaanvraag aan het bekijken.
- Actie met betrekking tot psycho-educatie van slachtofferschap (143.570 euro aan CAW Antwerpen).
- Actie met betrekking tot de organisatie van lotgenotengroepen aan verschillende lotgenotenverenigingen met in totaal 120.000 euro.

- P. 61: GBO-1GCF2EE-WT: er wordt gesproken over een terugvordering van middelen die niet volledig aangewend zijn voor de casemanagers zorg. Kan de minister dit verder toelichten?

Voor de werk- en zorgtrajecten gebeurt toeleiding naar activeringstrajecten door VDAB. Op basis van die toeleiding en van het verloop van een activeringstraject, worden de samenwerkingsverbanden zorg vergoed voor de inzet van casemanagers zorg. (Afgeronde traject wordt vergoed aan 100% van de voorziene subsidie, een vervroegd stopgezet traject wordt vergoed aan 60% van de voorziene subsidie.). De stijging verloopt trager dan initieel verwacht maar het aantal AMA-trajecten blijft wel in stijgende lijn gaan.

- Zijn er middelen voorzien om welzijnsactoren te ondersteunen bij de toenemende complexiteit van hulpvragen (meervoudige problematiek, migratie, vergrijzing)?

Na vijf jaar projectmatige ondersteuning van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor de inzet van sociaal tolken wordt het toegekende subsidiebedrag (145.000 euro) recurrent toegevoegd aan de subsidie-enveloppe van de CAW via een verhoging van het forfaitair subsidiebedrag per erkende VTE. Het BVR Algemeen Welzijnswerk werd hiertoe gewijzigd. De aangepaste regelgeving gaat in werking vanaf 1 januari 2026.

- P. 59: kan de minister meer toelichting geven over de verschuiving van GBO-1GCF2ED-WT, de compensatie voor de reguliere inbedding van de projecten Housing First?

We verduurzamen de Housing First projecten vanaf 1 januari 2026 door uitbreiding van de erkenning van de CAW met 11 VTE. De middelen worden hiertoe overgeheveld van GBO-1GCF2ED-WT.

ISE sociale akkoorden

- Op welke wijze wordt de beleidsdoelstelling “werken in de zorg aantrekkelijker maken” geconcretiseerd in meetbare indicatoren of beleidsresultaten?

We werken dit samen met de administratie uit. Dit hangt ook samen met de eindevaluatie van VIA6 en actieplan (zij-)instroom dat wordt opgestart.

ISE preventie

- Door de vertraging in volledigheid van de IMA-databank beschikt men pas 2 jaar na het desbetreffende jaar van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek over het correcte cijfer. Worden er initiatieven genomen om dit te vervroegen?

De Bevolkingsonderzoeken naar kanker worden continu gemonitord en resultaten voor de belangrijkste indicatoren worden jaarlijks weergegeven in de jaarfiches over het

screeningsjaar x-1. Deze resultaten zijn gebaseerd op de meest recente en beschikbare data. Er wordt daarbij consequent aangegeven welke indicatoren nog niet volledig zijn. Alle indicatoren samen geven wel degelijk een goed inzicht in de jaarlijkse evolutie van het bereik van de screeningsprogramma's.

De bedoeling is om de vertraging structureel te verkleinen door verbeterde data-uitwisseling, meer geautomatiseerde koppelingen en snellere validatieprocessen. De gesprekken hierover lopen reeds met de betrokken databeheerders. De strikte vereisten op vlak van GDPR, en de noodzaak om registratie en koppeling van data decretaal te verankeren zorgt ook voor uitdagingen op vlak van voldoende en tijdige gegevens.

- . 68: welk budget wordt er concreet voorzien voor onderzoek rond suïcidaliteit?

Het VAS III wordt uitgevoerd via de beheersovereenkomst met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ, 933.250 euro) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP, 1.324.200 euro). Daarnaast is er de suïcidepreventiewerking van de CGG (16 VTE via enveloppe financiering van de CGG).

De gezondheidsdoelstelling Suïcidepreventie omvat ook acties gericht op versterken van mentaal welbevinden (geestelijke gezondheidsbevordering). Dit wordt recurrent mee ondersteund via de beheersovereenkomst Geestelijke Gezondheidsbevordering

- P. 69 “we versterken de mogelijkheden voor de opvolging van meldingsplichtige infectieziekten door verder te investeren in de tijdige analyse, interpretatie en terugkoppeling van meldingsdata en door het ontwikkelen van dashboards om evoluties beter te kunnen opvolgen. Welke knelpunten zijn er momenteel reeds gekend?

Er werd een eerste operationele versie ontwikkeld van een dashboard waarmee de teams de meldingen per werkregio kunnen opvolgen. Dit instrument zal verder worden verfijnd om de teams nog beter te ondersteunen in de opvolging van meldingsplichtige infectieziekten.

De voornaamste aandachtspunten zijn:

1. De automatisering van meldingen zal een positieve impact hebben op de rapporteringsgraad en de tijdigheid van meldingen van infectieziekten, evenals een kwaliteitsverbetering en standaardisatie van meldingsdata.
2. Met de nieuwe registratietool ‘Infectionet’ wordt verder gewerkt aan de aansluiting op het datawarehouse zodat variabelen progressief beter kunnen worden gevisualiseerd.
3. De early warning module, die automatische waarschuwingen aan artsen van de teams Infectieziektebestrijding zal mogelijk maken, zal bijdragen tot een snellere detectie van ongebruikelijke epidemiologische signalen over de provincies heen en zo de reactietijd verkorten.

- P 69 We zetten bijkomend in op het communiceren naar burgers en vaccinatoren via intermediarissen waarbij we gebruik maken van een herkenbaar merk en imago en ontwikkelen een strategisch communicatieplan met inbegrip van een ‘sociale

media'-plan. -> wie zijn die intermediairen? kosten voor ontwikkeling van herkenbaar merk en imago, met wie? kosten strategisch communicatieplan, met wie en tegen wanneer komt dat plan er? en hebben ze nu dan geen plan want de zorg zit wel veel reclame te maken voor vaccinatie op sociale media

Het Departement Zorg zet in op een dubbele communicatiestrategie: enerzijds wordt rechtstreeks gecommuniceerd naar burgers en vaccinatoren, anderzijds gebeurt dit via een netwerk van intermediairen.

Deze intermediairen zijn cruciaal om de informatie breed en betrouwbaar te verspreiden. Het gaat om een diverse groep van organisaties en actoren, waaronder Gezondheidsmakers, Opgroeien en CLB, mutualiteiten, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), arbeidsgeneeskundige diensten en verschillende beroepsgroepen zoals Domus Medica, het Vlaams Apothekersnetwerk, The Belgian Academy of Paediatrics (BAOP), de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), het Netwerk Verpleegkunde en de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV). Ook eerstelijnszones en het Departement Onderwijs en Vorming spelen een rol. Daarnaast fungeren vaccinatoren zelf als belangrijke intermediairen richting burgers.

Om de communicatie structureel te verbeteren, werkt het Departement aan een strategisch meerjarenplan. Het doel is om een betrouwbaar en herkenbaar beeld te creëren dat het vertrouwen van burgers versterkt.

- P. 70: welke middelen worden er momenteel voorzien voor tuberculosebestrijding? Graag ook toelichting waaraan deze middelen concreet zullen worden besteed.

Concreet wordt tuberculosebestrijding uitgevoerd via de beheersovereenkomst met 'Respiratoire Gezondheid' - de voormalige Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) met looptijd van 2025-2029 en vormgegeven door jaarlijkse subsidies. In 2025 bedroeg het subsidiebedrag 1.546.531euro. De beheersovereenkomst draagt bij aan het uitvoeren van het tuberculosebeleid naar de algemene bevolking of risicogroepen d.m.v.:

- Aanbod van informatie, documentatie, advies en wetenschappelijke ondersteuning van het tuberculosebeleid
 - De ontwikkeling en disseminatie van methodieken (naar intermediairs of einddoelgroep)
 - De ondersteuning en uitvoering van methodieken (rechtstreeks naar de einddoelgroep) via laagdrempelige dienstverlening:
 - o Doelgroepgerichte screening (oa via de MRU,...)
 - o Opvolging TB behandeling (therapiebegeleiding en -supervisie)
- p70 staat: "De noodzaak en financiering van een COVID-19-vaccinatiecampagne in 2026 dienen nog verder onderzocht en afgestemd te worden."
Is het dus mogelijk dat er volgend jaar geen campagne wordt georganiseerd?

Zolang de covidvaccins niet beschikbaar zijn op de publieke markt en de vaccins enkel in multidose vials beschikbaar zijn, kunnen deze enkel aangeboden worden in een campagne.

Op basis van welke parameters zou dat worden beslist?

Op basis van het tijdig beschikbaar zijn van covid-vaccins, die aangepast zijn aan de dan circulerende stam, op de private markt in België en waarbij deze vaccins aangeboden worden in mono-verpakkingen. Het advies van de Hoge gezondheidsraad evenals de epidemiologie zullen hierbij ook een leidraad zijn voor het maken van een beslissing op dat moment.

Op basis van welke parameters werd beslist dat dat dit jaar wel nodig was?

Op basis van bovenvermelde parameters.

Wanneer wordt dat beslist?

In de loop van het voorjaar wordt nagekeken wat er nodig is voor het najaar.

Hoe zit het nu tijdens de huidige campagne met de vaccinatiegraad?

Voor 14,8% van de totale bevolking werd tijdens de herfstcampagne al een vaccin tegen covid geregistreerd. Voor de 65-79 jarigen is de registratiegraad voorlopig 45,1% en voor de 80-plussers is dit 58,7%.

Hoeveel van de in Vlaanderen beschikbare vaccins werden door de vaccinatoren besteld en hoeveel werden er reeds geregistreerd?

Voorlopig werden er 1.451.000 besteld en werden er al 1.013.284 vaccins geregistreerd.

Heeft men dit jaar een zicht op wie de vaccins opneemt, i.e. los van de leeftijd, heeft men nu zicht op het feit of ook veel mensen buiten de risicogroepen zich laten vaccineren?

Nee, dit kan conform de decretale basis enkel bepaald worden op leeftijd tijdens deze herfstcampagne.

Hoeveel van de beschikbare vaccins van vorig jaar zijn nog over?

Nog ongeveer 350.000 JN.1 covidvaccins zijn beschikbaar.

Is ondertussen reeds beslist deze te vernietigen?

Nee, voorlopig zijn de vaccins van de vorige campagne nog niet vervallen en worden deze nog bewaard.

- P. 72: welke middelen worden voorzien in de aanpak om sociaal-emotionele vaardigheden te versterken in de school, thuis of via andere contexten?

Hiervoor is een budget toegekend van 249.000 euro voor de periode van 15/12/2025 tot en met 31/12/2026.

- P. 73: welke middelen worden voorzien voor het aanbod van bewegen en voeding op verwijzing?

Voor de uitvoering van het aanbod Bewegen op Verwijzing wordt via een facultatieve subsidie (952.000 euro) continuering voorzien in 2026.

- P. 73: zullen de zelfafnametesten in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gefinancierd worden door de overheid? Zo ja, met hoeveel middelen?

Momenteel is nog geen beslissing genomen over zelfafname in kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zoals meermaals aangegeven wachten we de resultaten van 2 studies over deze strategie af. We verwachten de resultaten in de loop van 2026.

- P. 77: er worden middelen voorzien voor vaccinatie van Oekraïense ontheemden. Worden er ook budgetten voorzien voor vaccinaties van andere vluchtelingen? Zo ja, hoeveel? Hoe is dit budget geëvolueerd sinds dit jaar?

De gratis vaccins worden ter beschikking gesteld van alle vaccinatoren in Vlaanderen en ook aan de medische diensten van de opvangcentra in Vlaanderen. Hiermee kunnen ze alle vluchtelingen en ontheemden vaccineren die toegewezen worden aan Vlaanderen. Hiervoor is geen extra budget voorzien.

Daarnaast beschikt Vlaanderen sinds 2015 over een Vlaams mobiel vaccinatieteam. Dit is een team die groepen vaccineert die minder gemakkelijk toegang hebben tot de reguliere zorg in Vlaanderen. Zij vaccineren ook vluchtelingen en ontheemden als die zich aanbieden op de vaccinatiemomenten die door dat team voorzien worden, maar vaccineren niet exclusief vluchtelingen. Voor dit team wordt jaarlijks een budget van 400.000 euro voorzien. Dit budget is niet toegenomen in 2025 en ook voor 2026 wordt niet voorzien dat dit budget moet toenemen.

- Is er een duidelijke link tussen de middelen per gezondheidsdoelstelling en de meetbare gezondheidswinsten bij de bevolking?

Elke gezondheidsdoelstelling gaat gepaard met een strategisch en budgettair plan. Bij de afloop en/of tussentijds (bij een lange doorlooptijd) wordt een gezondheidsdoelstelling geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt op basis van beschikbare data nagegaan in welke mate de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn. Deze evaluaties zijn publiek beschikbaar.

Voor zichtbare impact in termen van gezondheidswinst, is het dus noodzakelijk evoluties op te volgen op een langere termijn en rekening te houden met veel verschillende factoren.

- Hoeveel middelen zijn voorzien voor de drie Vlaamse bevolkingsonderzoeken (borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker), en hoe evolueert dat t.o.v. 2025?

In 2025 werd een budget toegekend van 8.728.700 € in het kader van de beheersovereenkomst met CvKO. Daarnaast werd ook een jaarlijkse subsidie toegekend aan het Belgisch Kankerregister (BCR, 244.300 euro in 2025) in het kader van het interfederaal protocolakkoord voor financiering van BCR.

Jaarlijks, wordt een subsidie toegekend aan Brussel als bijdrage voor het organiseren van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker (50.000 euro in 2025) en het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (40.550 euro in 2025) in kader van desbetreffende protocolakkoorden.

In 2026 zal het Centrum voor Kankeropsporing eenmalig via een facultatieve subsidie worden gefinancierd, in afwachting van een nieuwe beheersovereenkomst vanaf 2027. Ook voor het BCR en de bijdrage aan Brussel wordt in 2026 en volgende jaren budget bestemd. De budgetten 2025 worden daarbij aangehouden.

Er wordt, met budget 2025 ook een vooronderzoek gepland, voor participatieverhogende communicatiestrategie specifiek voor doelgroep mannen. Hiervoor wordt 200.000 euro voorzien vanuit het uitbreidingsbudget preventief gezondheidsbeleid.

- Hoeveel budget wordt besteed aan tabaksontmoediging, alcoholbeleid en drugspreventie, en zijn er verschuivingen t.o.v. 2025?

Er wordt op verschillende manier geïnvesteerd in preventie van middelengebruik. In 2026 voorzien we, zoals de voorbije jaren:

- Verlenging van de beheersovereenkomst met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs (VAD) met 1 jaar: 4.070.503 euro
- Facultatieve subsidie voor 1 jaar voor Free Clinic (voorkomen van gezondheidsschade bij injecterende druggebruikers): 1.085.120 euro
- Verlenging van de beheersovereenkomst met het consortium Tabak met 1 jaar: 2.494.800 euro
- In de overeenkomsten met de CGG zit ook de opdrachten op vlak van CGG-preventiewerking Middelengebruik vervat (28,02 VTE aan 77.100 euro = 2.160.342 euro).
- Facultatieve subsidie Reitox i.k.v. interfederaal protocolakkoord: 57.838 euro
- Facultatieve subsidie Algemene Cel Drugs i.k.v. interfederaal protocolakkoord: 65.100 euro

In 2026 versterken we dit beleid eenmalig, in afwachting van nieuwe beheersovereenkomsten 2026 met:

- Een facultatieve subsidie Safe 'n sound: 200.000 euro voor 1 jaar
- Een facultatieve subsidie ter ondersteuning van CGG-preventiewerking middelengebruik in scholen: 240.000 euro
- Herhaling en versterking van een brede mediacampagne gericht op het verschuiven van de sociale norm rond alcohol: 240.000 euro

- Versterking van een brede campagne om stoppen met roken aan te moedigen: 100.000 euro
- Versterken van RIP roken (campagne om roken te denormaliseren bij jongeren) voor vaperen: 200.000 euro

ISE eerstelijns

- Welke middelen gaan naar de digitale samenwerking tussen eerstelijnsactoren en lokale besturen (p. 82)?

Vanuit ISE eerstelijns gaan geen rechtstreekse middelen naar de digitale samenwerking tussen eerstelijnsactoren en lokale besturen.

- P. 80: “ we werken aan een Vlaams actieplan om te komen tot een geïntegreerde aanpak voor kinderen en jongeren met obesitas” Wanneer wordt dit plan verwacht? En welke budgetten gaan hiermee gepaard?

Het luik preventie van obesitas (bij alle leeftijdscategorieën) wordt opgenomen binnen de nieuwe gezondheidsdoelstelling ‘Gezonde leefstijl’ die gelanceerd wordt op 15/12. Een Vlaams Actieplan obesitas bij kinderen en jongeren bouwt hier maximaal op verder.

- P. 81: de palliatieve sector wordt hervormd. Kan de minister meer toelichting geven over de concrete actie hierrond?

Tijdens de vorige legislatuur werd er met de sector palliatieve zorg een visietraject gelopen. Deze vernieuwde visie resulteerde in een actie- en transitieplan om te hervormen. Binnen deze hervorming is het de bedoeling om de opdrachten, financiering en werking van de palliatieve zorg volledig te richten op geïntegreerde zorg waarbij de persoon en diens omgeving centraal staan, met aandacht voor subsidiariteit, versterking van de eerste lijn, kwaliteit en kostenefficiëntie.

De drie bestaande erkenningsvormen (multidisciplinaire begeleidingsequippe, palliatieve netwerken en palliatieve samenwerkingsverbanden) zullen geïntegreerd worden in de nieuwe erkenningsvorm Netwerken Palliatieve Zorg. Deze beweging vraagt het nodige maatwerk waar de volgende jaren tijd voor is voorzien. In 2026 starten we met het schrijven van nieuwe regelgeving en zullen we ook het nieuwe erkennings- en financieringsmodel voor de sector ontwikkelen.

- P. 84: GBO-9GCFKA-OW: terugbetalingen in het kader van Impulseo. Er is een groot verschil tussen 2023 en 2024: hoe komt dit en heeft deze trend zich verder gezet in 2025?

Het bedrag uit 2024 is lager omdat er in dat jaar geen vestigingspremies zijn teruggevorderd. Dit in het kader van het niet langer voldoen aan de opgestelde voorwaarden om deze premie van 20.000 euro te ontvangen.

Om vestigingen in prioritaire zones te stimuleren konden huisartsen tot medio 2020 aanspraak maken op deze premie. Wanneer een huisarts binnen de 5 jaar zijn/haar activiteit echter stopt, of opnieuw vertrekt uit deze zone, dient er een evenredig met deze periode (uitgedrukt in jaren) bedrag terugbetaald te worden. Op basis van de huidige cijfers uit 2025 zet deze trend zich verder.

- P. 87: Huisartsen of huisartsengroeperingen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat. Over welk bedrag gaat het dan?

Het maximale bedrag per huisarts bedraagt 3.400 euro.

ISE gespecialiseerde zorg

- P. 96: er wordt gesproken van een traject waarin een concreet projectkader voor de aanspreekpunten wordt uitgewerkt. Kan u dit traject toelichten?

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en gezin (SWVG) voerde een onderzoek uit ivm het bevorderen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg via (intersectorale) samenwerking in de geestelijke gezondheidsnetwerken voor volwassenen en ouderen. Op basis van deze onderzoeksbevindingen wordt het verder traject samen met de administratie voorbereid.

- P. 96: hoe evalueert de minister de huidige online-hulpverlening? Welke knelpunten zijn er?

Het aanbod online hulpverlening via OnlinePsyHulp is evidence based voor de meest voorkomende psychische problemen. Een grote sterkte is dat het aanbod aanvullend is bij andere vormen van hulpverlening (eerste lijn, gespecialiseerd, hulplijnen, ...). Aandachtspunten zijn:

- Blijvende bekendmaking in het hulpverleningslandschap is wenselijk, in afstemming met het reguliere aanbod en netwerken.
- Technische voorwaarden, noden en mogelijkheden veranderen zeer snel, permanent en zeer dynamisch hierop inspelen is en blijft nodig.
- Krijgen de CGG subsidies om online hulp uit te breiden? Zo ja, hoeveel? Zo nee, hoe wordt er in deze sector dan wel ingezet op online hulpverlening?

De CGG ontvangen geen bijkomende middelen voor de uitbreiding van online hulpverleningsaanbod. In de overeenkomsten met de CGG 2024- 2026 werd een bepaling opgenomen waarbij het online en blended hulpverleningsaanbod expliciet benoemd wordt als een verwachting.

- P. 97: welke ervaring is er momenteel reeds met bemoeizorg?

Sinds 1 maart 2018 zijn er 6 projecten werkzaam die zich specifiek richten naar de doelgroep voor bemoeizorg; nl zorgmijdende personen die sociaal huren. Het betreft 6 projecten die verbonden zijn aan IBW.

- P. 97: hoeveel disengagement-trajecten werden het afgelopen jaar opgestart? Welk budget wordt hiervoor voorzien?

Begin 2024 waren er nog 10 lopende trajecten binnen de disengagement-trajecten van de CGG en werden er 4 nieuwe trajecten opgestart. Er werden dat jaar 5 lopende trajecten afgerond. Eind 2024 waren er dus nog 9 zorggebruikers in behandeling.

In 2024 werd er een budget van 84.000 euro voorzien voor de inzet van 1 VTE.

- Hoeveel extra capaciteit zal er voorzien worden voor geïnterneerden binnen beschut wonen? Hoe werd de noodzaak aan deze extra capaciteit bepaald?

Er wordt een bijkomende begeleidingscapaciteit voorzien van 20 plaatsen IBW. Op basis van een bevraging bij de voorzieningen die instaan voor de begeleiding van personen met een interneringsstatuut, werd deze noodzaak bepaald.

- Wie zit er in de Vlaamse stuurgroep voor de hervorming van het revalidatielandschap?

In de Vlaamse stuurgroep voor de hervorming van het revalidatielandschap zetelen twee revalidatieartsen, een vertegenwoordiger van de beroepsvereniging kinesithérapie), een vertegenwoordiger van de ziekenfondsen een vertegenwoordiger van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, een vertegenwoordiger van de revalidatieziekenhuizen , twee vertegenwoordigers van de administratie en een vertegenwoordiger van het kabinet van minister Gennez.

- P. 99: kan de minister meer info geven over de pilootfase in het kader van het systeemtoezicht?

Het Departement Zorg ontwikkelt een nieuw organisatiebreed toezicht voor algemene en revalidatieziekenhuizen. Dit toezicht bestaat uit drie onderdelen. In de eerste fase voeren directieteam een zelfevaluatie uit over de maturiteit van hun kwaliteitswerking met een beoordeling door de administratie. Deze vormt de basis voor de tweede fase: een risicogestuurd toezicht ter plaatse.

Om het digitale instrument voor deze zelfevaluatie te verfijnen, start in het voorjaar van 2026 een pilootfase. Op 22 oktober 2025 werd hiervoor een oproep gelanceerd naar de Vlaamse ziekenhuizen. Zij kunnen zich kandidaat stellen tot 17 november 2025. Ongeveer tien ziekenhuizen zullen deelnemen. Het doel van deze piloot is om het instrument inhoudelijk en technisch te testen, de gebruiksvriendelijkheid te beoordelen en de werklast voor ziekenhuizen in kaart te brengen. Tijdens de pilootfase worden feedbackmomenten georganiseerd om verbeterpunten te identificeren.

- P. 99: wat is net de rol van Vlaanderen binnen de interfederale werkgroep kwaliteit? Wie zetelt hierin? Hoe vaak wordt er overleg gepleegd?

De interfederale werkgroep kwaliteit werd door de IMC van 9 juli 2025 opgericht en is samengesteld uit vertegenwoordigers uit FOD VVVL, Departement Zorg (Leidinggevende ELGEZ & Zorginspectie), AVIQ, VIVALIS, Ministerie van de Duistalige gemeenschap, RIZIV, PAQS en VIKZ. De werkgroep heeft als doelstelling voorstellen tot een gedeeld beleidskader te ontwikkelen voor kwaliteitsmonitoring en –verbetering in ziekenhuizen.

- P. 100: hoeveel middelen gaan er specifiek naar de CGG in het kader van deradicalisering?

Er wordt een budget van 85.344 euro (niet geïndexeerd) voorzien voor de inzet van 1 VTE.

ISE Woonzorg

- P.108: “we versterken de werking van de lokale dienstencentra. We implementeren de kennis uit de pilootprojecten rond Zorgzame Buurten.” Zijn deze pilootprojecten al gestart? Zo ja, wanneer zijn de resultaten beschikbaar? Welke budgetten werden voorzien voor het versterken van de LDC’s?

128 projecten zorgzame buurten werkten in Vlaanderen en Brussel van maart 2022 tot februari 2025. Begin 2024 leverde het SWVG een onderzoek op waaruit de impact van zorgzame buurten blijkt (en dat na slechts 1,5 jaar looptijd). Het SWVG rapport is beschikbaar op de site van het SWVG.

Er wordt in 2026 7.033 keuro voorzien voor de versterking van de preventieve en coördinerende rol van de lokale dienstencentra.

- P. 108: “we werken aan een zorgprognose-instrument”. Kan de minister hierover meer toelichting geven en wanneer wordt dit instrument verwacht?

Het project verloopt in 2 grote fasen. In een eerste fase wordt in 2026 een technische startversie voor het zorgprognosemodel ontwikkeld. Vervolgens zal in een tweede fase, tegen 2029, het eigenlijke zorgprognosemodel ontwikkeld worden. Het zorgprognose model bevindt zich momenteel in conceptuele fase waarin een wetenschappelijk onderzoek door LUCAS (KU Leuven) wordt uitgevoerd naar welke data relevant zijn voor de inschatting van de evolutie van de zorgnood.

- P. 110: in het najaar van 2025 is een pilootproject opgestart in het kader van ALIVIA. Tot hoelang loopt dit project?

Het pilootproject “Alivia in de woonzorgcentra” is gestart op 17 oktober 2025 en loopt tot en met 30 juni 2026.

- P. 109: De minister wil de bestaande flexibiliseringsmaatregelen in woonzorgcentra herbekijken en werkt een nieuwe regeling uit.

- Wat was het resultaat van de huidige flexibiliseringsmaatregelen?
- Welke richting gaat de nieuwe regeling uit? Welke verbeteringen worden er aangebracht

Het gaat hier zowel over tijdelijke als structurele maatregelen (logistiek medewerker in de zorg, zij-instroomzorgkundigen, BelRAI-coördinator, uitbreiding lijst personeel voor reactivering).

We zien een verdere toename van het aantal voorzieningen dat gebruikmaakt van deze flexibiliseringsmaatregelen. De tijdelijke maatregelen flexibiliteit personeelsinzet zijn verlengd tot en met 30 juni 2026. De administratie werkt momenteel aan een voorstel waarbij de signalen vanuit de sector worden meegenomen.

- Werken verder aan nieuw financieringsmodel voor de gezinszorg waarbij ze evolueren naar een uniform, eenvoudiger en transparanter model
 - Hoe gaat dat financieringsmodel er uit zien?
 - Wat is de timing?

We zijn reeds gestart met een intensief traject samen met de diensten gezinszorg om te komen tot een gemeenschappelijke businessvisie als basis voor dit nieuwe model. De volgende stap is dat er een conceptnota met businessvisie en een principe document zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. Hierin zal toegelicht worden welke de verschillende werven zullen zijn om tot een nieuw financieringsmodel gezinszorg te komen. Dit moet implementeerbaar zijn in 2028.

- Verdere uitrol van de sectorspecifieke transparante boekhouding met de verplichting voor de woonzorgcentra om te rapporteren over het vorig boekjaar, ook in kader om betaalbaarheid van de zorg op te volgen;
 - Zijn alle woonzorgcentra daarin mee om op tijd en correct te rapporteren?

Vanuit het departement werden de woonzorgcentra actief in het project betrokken en begeleid voor de aankomende verplichte rapportering. Voor boekjaar 2024 werden alle voorzieningen aangemoedigd om deel te nemen aan de vrijwillige zachte uitrol. Een belangrijk deel van de woonzorgsector is vandaag al voorbereid en heeft ervaring opgebouwd, voor de resterende voorzieningen is ook nog een begeleidingstraject voorzien in 2026 zodat ook zij tijdig en correct kunnen rapporteren.

- P. 113-114: Bijstelling van -21.000k verhoging efficiëntie urencontingent
 - Wat is juist die verhoging efficiëntie urencontingent? Graag enige toelichting.

De norm van de gelijkgestelde uren zal verlaagd worden . Daarnaast zal het urencontingent gezinszorg lineair gerationaliseerd worden.

ISE Jeugdhulp

- P. 121: er wordt tegen 2027 gestreefd naar een bezetting van 90%, waarom dan pas? Hoe heeft men dit percentage bepaald?

- Hoe zal er specifiek ingezet worden om de zwaktes van deze indicator zo klein mogelijk te houden?

We willen met het capaciteitsbeheersysteem vanaf 2026 een correct en geobjectiveerd beeld krijgen van het gebruik van de residentiële capaciteit, zowel de bezetting, de onbeschikbaarheid en redenen hiervoor en de beschikbare plaatsen. Dit zal ons helpen om de toeleidingsprocessen te versnellen en sterker te sturen, om korter op de bal te spelen wanneer capaciteit onvoldoende gebruikt wordt. Daarnaast willen we via de uitgaventoetsing voor de jeugdhulp in 2026 scenario's uitwerken om capaciteit en middelen die niet gebruikt sneller te activeren.

- P. 123: welk budget wordt er voorzien voor het versterken van het welzijnsaanbod?

We voorzien in de jeugdhulp, incl. de Huizen van het kind en de Overkop-huizen, een investering van 120 miljoen euro. Deze middelen zullen grofmazig als volgt verdeeld wordt: preventief aanbod: 20%; laagintensief aanbod: 20% reguliere jeugdhulp: 50%; complexe jeugdhulp: 10%.

- P. 123: Huizen van het Kind:
 - welke initiatieven worden er momenteel genomen in het kader van specifieke aandacht voor kinderen en ouders van wie de thuistaal niet Nederlands is? Welke middelen worden hiervoor voorzien? Hoe werd dit budget bepaald?

De verdere operationalisering van het plan “Ieder Kind Taalheld” en de rol daarbinnen van de Huizen van het Kind is momenteel voorwerp van verdere uitwerking

- Is er zicht op het bereik van de huizen van het kind? Hoeveel mensen wilt men bereiken? Hoe wordt de dekkingsgraad (aantal inwoners per Huis van het Kind) gemonitord, en bestaan er blinde vlekken in landelijke of grootstedelijke gebieden?

De Huizen van het Kind worden gepositioneerd als proportioneel universeel aanbod, wat wil zeggen dat elk gezin in of via de Huizen van het Kind ondersteuning moet kunnen krijgen. Elke gemeente in Vlaanderen (behalve Herstappe) is vandaag gedekt door de werking van een Huis van het Kind, weliswaar rekening houdende met diversiteit in het aanbod. Er is vandaag geen exact zicht op het bereik van de verschillende onderdelen van de Huizen van het Kind, maar we kunnen wel stellen dat gezien het feit dat de consultatiebureaus er inherent deel van uitmaken dat het potentieel bereik in de periode 0 tot 3 jaar quasi universeel is.

- Waar is er een fysieke locatie en waar niet?

Er is geen accuraat beeld op de spreiding van de fysieke locaties.

- Hoeveel VTE's zijn er momenteel binnen HvhK? (Per provincie en per HvhK? Hoe wordt juist de online HV voorzien?

De Huizen van het Kind zijn op dit moment een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, het is dus niet mogelijk om een juist beeld te geven van de personele inzet door die vele verschillende organisaties.

- Hoeveel middelen worden toegewezen aan Huizen van het Kind in 2026, en hoe wordt hun basisfinanciering berekend?

Voor 2026 is er voor de Huizen van het Kind (excl. Brussel) 2.845keer voorzien. De basisfinanciering wordt berekend op het aantal minderjarigen binnen het werkingsgebied vermeerderd met een kansarmoede-index.

- P. 123: OverKop-huizen:
 - Is er een uitgebreide evaluatie gebeurd van de Overkophuizen? Is er zicht op de huidige knelpunten? Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? Hoe wordt er ingezet op het bereiken van de doelgroep?

De werking van de Overkophuizen wordt continu opgevolgd door het agentschap Opgroeien ondermeer in samenhang met de Stuurgroep Overkop op basis van de huidige projectmatige regelgeving. Er wordt een nieuwe, structurele regelgeving opgemaakt die ingang zal vinden op 1 januari 2027. In het proces van opmaak van nieuwe regelgeving is de component van beleidsevaluatie onontbeerlijk en krijgt een meer uitgebreide evaluatie dus ook een formele plek. Knelpunten die alvast een antwoord zullen moeten krijgen in de nieuwe regelgeving zijn meer duidelijkheid over opdrachten en doelstellingen, monitoring van het bereik/impact, betere verbinding met jeugdwerkactoren, een meer afgestemd kwaliteitsbeleid en meer duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en mandaten van de verschillende betrokken actoren.

- P. 124: verontrusting en één gemandateerde voorziening:
 - Hoe zal de caseload van OCJ op deze manier exact onder controle gehouden worden? Wordt er extra personeel voorzien? Zo ja, hoeveel?

OCJ zal fungeren als de enige gemandateerde voorziening. Er zal een inschatting worden gemaakt van de verwachte toename in caseload en van de benodigde personele middelen om deze kwalitatief te kunnen verwerken. In de komende maanden wordt de impact hiervan gericht in kaart gebracht. Daarbij zal de caseload van de consulent voortdurend gemonitord worden.

- P. 125: hoeveel wordt er geïnvesteerd in de hulplijnen? Hoe is dit geëvolueerd ten op zichte van vorig jaar?

Voor de hulplijn nupraatikerover wordt er geen uitbreiding van middelen voorzien voor het jaar 2026. Nupraatikerover ontving de afgelopen jaren bijkomende financiering ter versterking van de hulplijnen: afgelopen jaren werd dit voorzien adhv middelen via relanceplan en vervolgens via crisis- en investeringsplan. Om de huidige werking te continueren in 2026 zal er wel een bedrag voorzien worden van 197K (jaarbasis). Dit in afwachting van een aantal lopende processen om de hulplijnen te rationaliseren.

- P. 126: Er komt een jaarlijks contingent aan woonsttoewijzingen; is er zicht op hoeveel er nodig is? Hoe gaat dit gerealiseerd worden gezien de huidige crisis op de woningmarkt?

Op basis van BINC-cijfers weten we dat er tussen 250 en 300 +18-jongeren en jongvolwassenen op jaarbasis de residentiële jeugdhulp verlaten. Door een gegarandeerde woonst, creëren we stabiliteit en nemen we een spanning weg bij de jongvolwassene waardoor er ruimte komt om te werken aan de verschillende levensdomeinen waarin hij/ zij een weg moet zoeken binnen deze transitieperiode. Opgroeien realiseert dit in nauwe afstemming met Wonen in Vlaanderen en in partnerschap met de sociale woonmaatschappijen.

- Welke projecten zijn er momenteel rond dak- en thuisloosheid bij volwassenen? Kunnen deze niet beter verankerd worden?

Er zijn sinds 2024 8 intersectorale intensieve begeleidingsteams die kwaliteitsvolle, outreachende en integrale begeleiding voor jongvolwassenen in (dreigende) dak- en thuisloosheid voorzien, gefinancierd door Opgroeien, VAPH en Departement Zorg. We maken een grondige evaluatie en bekijken de opportuniteiten voor versterking en verdere verankering van deze teams.

Daarnaast stelt Opgroeien sinds 2024 ook middelen ter beschikking voor innovatieve en outside of the box werkingen en projecten die inzetten op het creëren van veilige ontmoetings- en/of overnachtingsplekken voor jongvolwassenen in precare (woon)situaties. Al deze projecten zitten ingebed in stevige partnerschappen of samenwerkingsverbanden op (sub)regionaal niveau.

- P. 126: hoeveel middelen worden specifiek voorzien voor de Gezinshuizen? In de conceptnota wordt verwezen naar een financieel kader, waarom wordt hier in de begroting niets over gezegd?

Het zwaartepunt van de residentiële uitbreiding, ook van de gezinshuizen ligt later in de regeerperiode. We willen op basis van het capaciteitsbeheersysteem, in de loop van 2026 zicht krijgen op de effectieve residentiële noden en de spreiding. Pas dan zullen we een fijnmaziger overzicht kunnen geven van de uitbreidingsprioriteiten en de budgettaire koppeling hieraan.

- P. 127: welk budget wordt er voorzien voor het ontwikkelen en implementeren van een Crisisapp? Graag ook enige toelichting.

Er werd 53.000 euro besteed voor het ontwikkelen en opstarten van de app. Dit bedrag wordt bekostigd door de diensten voor pleegzorg. De werkingskosten (jaarlijkse onderhoudskosten van de app) worden geschat op ongeveer 2500 euro per jaar.

- P. 127: versterking residentiële jeugdhulp: hoe zal dit gerealiseerd worden gezien de huidige personeelstekorten

Een versterking van het residentieel aanbod behelst niet enkel een uitbreidingsbeleid, maar in eerste instantie het mogelijk maken dat de huidige capaciteit ten volle, en kwalitatief, ingezet kan worden. Het versterken van het residentiele hulpverlening staat bovendien in functie van een trajectmatige benadering van jeugdhulp, waardoor er mogelijk een grotere groep van kinderen en jongeren kortdurend en tijdelijk gebruik kunnen maken van residentieel aanbod wanneer nodig. De doorvertaling van deze diverse aspecten naar concrete versterkings- en uitbreidingsinitiatieven zal in de loop van 2026 verder vorm krijgen.

- hoe zal de financiering concreet aangepast worden?

We actualiseren de huidige manier van erkennen en zetten in op demoduleren. Daarnaast willen we via de uitgaventoetsing voor de jeugdhulp in 2026 scenario's uitwerken om capaciteit en middelen die niet gebruikt sneller te activeren.

- Is er momenteel voldoende zicht op regionale verschillen? Wat verstaat de minister net onder een 'regionale evenwichten'?

We merken dat er op dit moment nog steeds grote verschillen zijn in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van jeugdhulpaanbod in de verschillende regio's. In een eerste fase, 2026, zal Opgroeien een analyse maken van de huidige programmatie en de regionale inbedding. We koppelen toekomstig uitbreidingsbeleid en regionale afstemming aan deze zorgstrategische oefening, en komen tot een heldere inbedding van zowel het laagdrempelige als het aanvullende jeugdhulpaanbod.

- P. 128: welke middelen worden voorzien voor het aanbod rond traumasensitief werken bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen?

Solentra krijgt van Opgroeien een jaarlijkse subsidie van (afgerond) 226.000 euro om traumasensitief aanbod bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan te bieden.

- P. 128: de financiering rond Veilig Verblijf wordt geëvalueerd. Hoe gebeurt de huidige financiering en waar zitten de knelpunten?

De huidige financiering van veilig verblijf is een enveloppefinanciering op basis van aantal erkende plaatsen. De organisatie krijgt een vast bedrag per erkende verblijfsmodule veilig verblijf en per contextbegeleidingsmodule hoog intensief. Per leefgroep van 6 plaatsen, krijgen ze ook 1 module ondersteunende begeleiding om leerrecht en dagbesteding te organiseren. Deze subsidie is bedoeld om alle werkingskosten, personeel, infrastructuur en begeleiding te dekken.

Knelpunten:

- Er is een verschil in subsidiering met GES+ die (ook) met jongeren werken met grote uitdagingen.
- Jongeren in Veilig Verblijf zitten vaak op het kruispunt van jeugdhulp, GGZ en justitie, maar de financiering blijft per sector apart.

- P. 130: wordt er budget voorzien voor de ontwikkeling van een capaciteitsbeheersingssysteem?

Er wordt budget voorzien voor de ontwikkeling van een capaciteitsbeheersysteem binnen de structurele ICT budgetten van het agentschap Opgroeien, waarbij er aanpassingen zullen gebeuren in de nodige systemen (databank jeugdhulp bij de start, BINC en INSISTO op termijn) en om de nodige rapportage te kunnen doen (datawarehouse E-youth)

- P. 130: welk budget wordt er voorzien voor crisisjeugdhulp? Hoe is dit budget geëvolueerd?

Er wordt volgend jaar opnieuw extra budget in crisisjeugdhulp geïnvesteerd. Het crisis- en investeringsplan uit 2023 bevatte een aantal projecten met eenmalige middelen die aflopen in 2025. Er wordt geïnvesteerd in de C.A.W. voor zowel crisisbegeleiding (1.510 k) als voor de crisismeldpunten hun werking (500 k), er wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsverbanden 1G1P met flexibele vervolghulp na crisis (1000 k) en in de netwerken GGKJ voor de duo's crisisbegeleidingen jeugdhulp GGZ (1000k).

- Welk budget wordt er voorzien voor wetenschappelijk onderzoek? Graag concrete toelichting.

Binnen Opgroeien is er een gezamenlijke budgetlijn en aanpak voor het uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek over alle deelopdrachten heen. Daarin wordt een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen gemonitord over de verschillende opdrachten van het agentschap. Een eerste significant element daarin is de samenwerking met het Steunpunt WVG. Het huidige Steunpunt loopt af in juni 2026; een nieuw Steunpunt is in voorbereiding en zou opstarten in oktober. Tot op heden beschikt Opgroeien jaarlijks over een budget van €200.000 binnen het Steunpunt. Naast de samenwerking met het Steunpunt is er binnen Opgroeien een budget van €280.000 beschikbaar.

- P. 131: hoe zal het aanbod delictgerichte contextbegeleiding permanent gemonitord worden?

Het aanbod delictgerichte contextbegeleiding wordt permanent gemonitord via BINC (het uniforme registratiesysteem voor private voorzieningen in de jeugdhulp). Voorts worden jaarlijks een aantal gegevens – inzake uitstroom GI/GOT/delco na KV/autonome reguliere delco - opgevraagd aan de voorzieningen zelf. Tot slot kijkt Agentschap Opgroeien ook naar de informatie die hierover wordt opgenomen in de inhoudelijke kwaliteitsverslagen die de voorzieningen jaarlijks bezorgen aan Agentschap Opgroeien.

- P. 133: GBO-1GEF2MX-IS: er wordt verwezen naar terugdraai afroaming indexkost loonkrediet consulenten BA25: kan de minister dit extra toelichten?

De structurele financiering van de consulenten werd bij BA2025 deels gefinancierd vanuit uitbreidingsbeleid jeugdhulp, daartoe werd budget overgeheveld naar begrotingsartikel GD0-1GZF2ZZ-LO. Van het voorziene budget werd er echter 119 duizend euro afgeroomd voor toekomstige indexeringen in deze legislatuur. Dit budget zou dan naar algemene

middelen terugvloeien ter financiering van toekomstige indexeringen. Daar dit budget echter nodig was op loonartikel zelf, wordt dit nu toch teruggezet. Deze 119 duizend euro wordt van hieruit dan overgeheveld naar begrotingsartikel GD0-1GZF2ZZ-LO waar de lonen van de consultants gebudgetteerd zijn

- P. 134: -1500: activering van de opgebouwde reserves. Kan de minister dit toelichten? Om welke opgebouwde reserves gaat het hier?

Zie het antwoord op vraag 1.

- P. 135: de terugvorderingen van onterecht uitbetaalde subsidies worden, ingeschat op 2600 keuro. Over welke onterecht uitbetaalde subsidies gaat het in het merendeel van de gevallen?

Dit heeft te maken met herzieningen van uitbetaalde voorschotten op basis van de effectieve verantwoordingen voor subsidies voor het verblijf van jongeren die zelfstandig wonen, zakgeld en bijzondere kosten.

- Hoeveel werd voorzien voor 1G1P in 2025, hoeveel projectmiddelen? Hoeveel nu voorzien voor de structurele inbedding?

In 2025 werd 26.626.660 euro voorzien voor 1G1P. In 2026 zullen de 1G1P samenwerkingsverbanden verder versterkt worden met de extra middelen uit het Crisis- en Investeringsplan die ingekanteld worden binnen de 1G1P werking.

ISE geïntegreerd gezinsbeleid

- Worden er middelen vrijgemaakt voor vernieuwing of digitalisering van gezinsondersteunende dienstverlening (online opvoedingsadvies, apps, digitale loketten)?

Bij de doorontwikkeling van de Huizen van het Kind zal er aandacht gaan naar een mix van aanbod om een diversiteit aan ouders te kunnen bereiken. Dit kan als resultaat hebben dat er ingezet wordt op meer blended dienstverlening waar digitalisering een rol in speelt.

- P. 139: “we versterken een kwaliteitsvol groepsaanbod Huizen van het Kind, met de focus op kinderen en jongeren waarbij de thuistaal niet Nederlands is”
 - Hoeveel personen bereikt dit groepsaanbod reeds?
 - Welk budget wordt er voorzien voor deze versterking?
 - Om welke thuistalen gaat het dan wel?

De verdere operationalisering van het plan “Ieder Kind Taalheld” met inbegrip van de rol van de Huizen van het Kind daarbinnen en het groepsaanbod dat in dat kader aangeboden kan worden is voorwerp van verdere uitwerking.

- P. 144: “We voeren een adoptiebeleid dat de rechten en belangen van alle betrokkenen respecteert”: Werd de projectsubsidie voor het Kleine Mirakel vernieuwd, zo ja hoeveel bedraagt deze subsidie? Hoeveel budget is er voorzien

voor de “nazorg”? Er werd 300.000 euro voorzien voor het Afstammingscentrum is dit voldoende om de bestaande wachtlijsten weg te werken?

- P. 144: welk budget wordt er voorzien voor het Afstammingscentrum? Hoe is dit budget geëvolueerd ten aanzien van het vorige jaar?

Het budget voor de nazorg / de projectsubsidie voor Het Kleine Mirakel bedroeg in 2025 575.000 euro. Op dit moment is er nog geen nieuwe regelgeving. Daarom verlengen we de huidige situatie met één jaar zodat de continuïteit maximaal gegarandeerd wordt.

Vanaf 2026 wordt er bijkomend 300.000 euro toegekend aan het Afstammingscentrum opdat nieuwe aanvragen tijdig behandeld kunnen worden en de bestaande wachtlijst weggewerkt kan worden. Naast een verhoging van de middelen, is het evenzeer noodzakelijk in te zetten op een meer efficiënte werking – daarbij staat het begrenzen van de gemiddelde begeleidingsduur (doorlooptijd) van de dossiers centraal.

- “In de loop van 2026 stellen we, na screening door een onafhankelijke instantie, voor alle betrokken herkomstlanden een betrouwbare en kwaliteitsvolle partner aan die de opdracht krijgt om over te gaan tot onderzoek van de dossiers ter plaatse.” Wie is de onafhankelijke instantie? En wie wordt er bedoeld met een betrouwbare en kwaliteitsvolle partner? Welke budgetten worden hiervoor voorzien?

De screening van lokale partners die (in de verschillende, betrokken herkomstlanden) kunnen instaan voor het onderzoek van individuele adoptiedossiers waar vermoedens van wanpraktijken werden gesignaleerd, werd door het VCA uitbesteed aan International Social Services. Zij ontwikkelden een instrument waarmee onder meer gepeild wordt naar de stabiliteit van de organisatie, onafhankelijkheid ten aanzien van het adoptieproces en een aantal technische/methodische vaardigheden die nodig zijn voor een kwalitatief hoogstaand onderzoek. Hiervoor is een budget voorzien van maximaal 50.000 euro.

- P. 144: er wordt gewerkt aan een screening waarmee ouders en hulpverleners beter kunnen inschatten of een kind mogelijks in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. Kan de minister dit verder toelichten?

Het is inderdaad de bedoeling dat een ouder of hulpverlener op basis van een aantal eenvoudige vragen een eerste inschatting maakt of het kind mogelijk recht heeft op een zorgtoeslag. Ouders en hulpverleners worden op die manier ondersteund om de criteria om recht te hebben op zorgtoeslag toe te passen op hun situatie en de ondersteuningsnoden van hun kind. De screener is anoniem en volledig vrijblijvend, louter bedoeld als ondersteuning.

- Bij de prestatie-informatie worden er vooral kwantitatieve indicatoren gemeten. Hoe zal de minister ervoor zorgen dat het kwalitatieve aspect ook de nodige aandacht krijgt?

Deze vraag kunnen we niet plaatsen.

ISE Groeipakket

- Waarom is er gekozen voor de sociale toeslag als indicator?

Het Groeipakket ondersteunt de gezinnen bij de opvoeding van kinderen. De automatische rechtentoekenning garandeert dat ieder kind in Vlaanderen een universele ondersteuning krijgt toegekend met het basisbedrag. De sociale toeslag zorgt ervoor dat de meest kwetsbare gezinnen hier bovenop extra materiële en financiële ondersteuning ontvangen. De sociale toeslag zorgt er dus voor dat de ondersteuning wordt gefocust op die gezinnen die de ondersteuning het hardst nodig hebben, en is dus van belang voor een efficiënte en effectieve inzet van de overheidsmiddelen en –instrumenten. Een evolutie in het aandeel toegekende sociale toeslagen kan aanwijzingen bieden over veranderingen in de sociaaleconomische situatie van de Vlaamse gezinnen met kinderen, evenals over de mate waarin het Groeipakket erin slaagt om de meest kwetsbare gezinnen te bereiken.

- P. 151: welke investeringen worden er concreet gedaan in de Centrale Groeipakketapplicatie?

Jaarlijks zijn er investeringen om o.a. de veiligheid van de applicatie te garanderen, de performantie op peil te houden, de indexering van de toelagen te bewerkstelligen. Daarnaast kunnen er investeringen nodig zijn om aanpassingen aan de toepassing te realiseren in het kader van maatregelen die de Vlaamse Regering neemt in het Groeipakket.

- P. 152: hoe vaak werd er nog gebruik gemaakt van de circulaire cheque?

Er zijn cijfers ter beschikking binnen de publieke uitbetalingsactor voor het jaar 2022. Er werden 43.000 circulaire cheques aangemaakt.

- P. 156: hoe verlopen de terugvorderingen van het Groeipakket? Welke stappen zijn er momenteel reeds gezet?

De terugvorderingen verlopen overeenkomstig de decretaal bepaalde regels. Er wordt steeds overgegaan tot terugvorderingen, behoudens bij vergissing door een uitbetaler (waar de burger zich geen rekenschap van kon geven). Terugvorderingen verlopen waar mogelijk door inhoudingen op toekomstige betalingen: in de regel aan 10%, bij fraude steeds aan 100%, en bij grove nalatigheid vanwege de burger kan het gaan om een aangepast percentage tussen die beide limieten. Waar inhoudingen niet mogelijk zijn, dient de burger zelf over te gaan tot terugbetaling. Dit kan via een afbetalingsplan; wordt er niet terugbetaald dan kan Vlabel ook ingeschakeld worden om de terugbetaling uit te voeren.

- Hoeveel middelen zijn voorzien voor uitbetaling en administratie via het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)?

Het agentschap beschikt over een uitgavenbudget bij BO26 van 42.565duizend euro ter financiering van de personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en investeringen.

- Worden de uitvoeringskosten per dossier transparant gerapporteerd, en is er een vergelijking met vorige jaren?

Het VUTG rapporteert jaarlijks aan haar Raad van Bestuur over de uitvoeringskosten per dossier.

- Hoeveel middelen zijn voorzien voor zorgtoeslagen (handicap, specifieke ondersteuningsnoden), en hoe evolueren die t.o.v. 2025?

In de begroting is er 144,5 miljoen euro voorzien aan zorgtoeslagen voor 2026. Dit is het bedrag inclusief index. Ten opzichte van 2025 is dit een toename met 3,4 miljoen euro (onder meer door de indexering van de toeslagbedragen).

- Hoeveel klachten over het Groeipakket werden in 2025 geregistreerd en hoe worden ze opgevolgd?

In 2025 werden er 3 beleidsklachten geregistreerd over het Groeipakket. De melder krijgt duiding over een bepaalde beleidskeuze, zodat de melding binnen een juist perspectief wordt geplaatst. Indien de melder niet tevreden is met de duiding, kan die een verzoekschrift indienen bij het parlement, dit wordt ook zo meegedeeld.

ISE Personen met een handicap

- P. 160: er wordt gesteld dat men voor hulpmiddelen en aanpassingen geen wachttijd willen. Waarom werd er nooit gestreefd naar geen wachttijd voor een zorgbudget?

Bij de invoering van het PVF-systeem werden richttijden voor de wachttijden per prioriteitengroep meegegeven, alsook een evolutie naar een systeem zonder wachttijden. De evolutie van de instroom in het systeem was echter van die aard dat, zelfs met een jaarlijks uitbreidingsbeleid, de ondersteuningskloof groter werd en de lengte van de wachtlijst toenam.

- P. 162: hoeveel middelen worden voorzien voor het CuHeSa-project?

De raming voor 2026 bedraagt € 230.589,95. Het VAPH is de mogelijkheden aan het verkennen tot structurele samenwerking met andere partners en beleidsdomeinen in het kader van het expertisecentrum handicap. Op dit moment zijn er nog geen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, maar we voorzien dit voor de toekomst.

- P. 163: de mogelijkheid wordt voorzien dat erkende/vergunde en gesubsidieerde organisaties een deel van hun middelen kunnen inzetten om niet VAP organisaties te ondersteunen bij het nemen van initiatieven en acties die de eigen hulp- en dienstverlening beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk maken voor personen met een vermoeden van handicap. Waarom wordt hiervoor gekozen en wordt er zelf geen extra budget hiervoor voorzien? Hoeveel middelen denkt de minister dat organisaties hiervoor kunnen vrijmaken?

We zien het ontsluiten, delen en gericht inzetten van de eigen ervaring en expertise van professionals binnen de VAPH-sector ifv het meer open en toegankelijk maken van de samenleving en de hulp- en dienstverlening in deze samenleving als één van de kernopdrachten van organisaties die door het VAPH erkend en gefinancierd worden. De middelen die organisaties krijgen van het VAPH dienen dan ook om ook deze opdracht mee waar te maken. Het delen van expertise met het oog op het toegankelijk maken van reguliere hulp- en dienstverlening heeft ongetwijfeld een belangrijke impact voor personen met (een vermoeden van) handicap, ook al gaat het maar om een beperkte inzet van middelen.

- P; 165: hoeveel intersectorale plaatsen voor complexe problematieken zijn er reeds opgericht? Hoe komt het dat er nog geen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen?

Er zijn er 5 lopende, Oost-Vlaanderen heeft pas recent een aanvraag ingediend.

- P. 166: er wordt gestreefd naar een afgestemde aanpak over het erkennen van handicap met als doel het vlot verlenen van afgeleide rechten. Binnen welke termijn zullen de processen voor de erkenning van een handicap op elkaar worden afgestemd?

Dit kunnen we voorlopig nog niet aangeven.

- P. 165: er komen twee verknopingsunits, hoeveel middelen ontvangen deze en hoe werden deze bepaald?

De verknopingsunits zijn ondertussen opgestart. Deze vorm van intensieve ondersteuning is geregeld door het Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van units voor personen met een handicap met een bijkomende ernstige psychische problematiek van 19/07/2024. Er wordt een maximale subsidiëring van ca. 600.000 euro voorzien per verknopingsunit op jaarbasis.

P. 168: welke subsidies zijn momenteel toegekend aan projecten? Is hier geen overzicht van?

Volgende subsidies worden voor 2026 geraamd:

- | | |
|--|-------------|
| • Bijstandsorganisaties (4) | € 3.580.000 |
| • Tolk Bemiddelingsbureau (1) | € 2.761.000 |
| • Gebruikersverenigingen met informatieloket (5) | € 355.000 |

- Zorgwijs.be (1) € 120.000
- Vertrouwenscentrum kindermishandeling (1) € 13.000
- Consulantenwerking (5) € 1.030.000
- Organisaties voor vrijetijdszorg (20) € 2.676.000
- Dubbeldiagnose verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis (5) € 959.000
- Autisme Chat (1) € 245.000
- begeleiden van jongeren of jongvolwassenen met risicogedrag (1) € 118.000
- ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen met een auditieve handicap (1) € 50.000
- Diensten ondersteuningsplan (7) € 8.553.000
- Gesco-projecten (2) € 166.000
- Onderhoudstoelagen Revalidatiecentra (53) € 2.337.000
- ex-DAC-projecten Revalidatie (18) € 1.898.000
- ex-DAC-projecten (7) € 2.535.000
- organiseren van de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen (1) € 27.000
- vertegenwoordiging van de verwijzende instanties in alle overlegorganen van het agentschap (1) € 210.000
- woon- en dagondersteuningsinitiatieven bij startende, kleinschalige initiatieven (1) € 157.000
- intersectorale begeleidingsteams voor jongvolwassenen in dreigende dak- en thuisloosheid (8) € 332.000
- Op p. 170 wordt vermeld dat het uitbreidingsbeleid voor nieuwe doelgroepen uitgesteld wordt naar 2027. Wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor gezinnen die in 2026 op ondersteuning rekenen?

De beschikbare budgetten voor uitbreidingsbeleid zullen in 2026 worden ingezet voor de automatische toekenningen en prioriteitengroep 1.

- P. 171: de ondersteuningsmogelijkheden voor RTH worden verder uitgebreid. In welke mate wordt er tegemoet gekomen aan bezorgdheden uit het werkveld hieromtrent?

In het project Zorgniveau 1 wordt momenteel bekeken en besproken welke zorg en ondersteuning binnen zorgniveau 1 nodig is om een gepast antwoord te kunnen bieden op de noden van de personen die voortaan in dit zorgniveau geholpen zullen moeten worden. Deze oefening gebeurt in nauw overleg met experts uit het werkveld: ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van gebruikers, zorgaanbieders, verwijzers ... en dit voor zowel minder- als meerderjarigen met een (vermoeden van) handicap. De bezorgdheden van het werkveld kunnen dus rechtstreeks mee ingebracht worden in de discussie en de betrokkenen kunnen gericht mee helpen zoeken naar een passend antwoord.

- P. 171: is er zicht op hoeveel extra personeelsleden de sector nodig heeft?

Het VAPH heeft hier geen concrete cijfers van.

- P. 172: hoeveel middelen worden er voorzien voor het uitbreiden van het e-loket mijnvaph.be?

Het VAPH financiert haar digitale dienstverlening vanuit de recurrente werkmiddelen. Jaarlijks is dit een bedrag van 2 tot 2,5 miljoen euro.

- P. 176: er wordt gesproken over het activeren van de historisch aangelegde reserves. Om hoeveel reserves gaat het? Hoe werden deze reserves opgebouwd?

Zie het antwoord op vraag 1.

- P. 194: Hoeveel subsidies krijgt het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven? Hoe zijn deze geëvolueerd sinds 2025?

Het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) ontvangt van het VAPH enkel een subsidie voor het bemiddelen tussen Dove gebarentaligen en tolken gebarentaal voor opdrachten in de Leefsituaties (L-uren). Voor het werkingsjaar 2025 werd 2.706.786 euro begroot.

- P. 197: hoeveel middelen worden er voorzien voor de uitgifte van de European Disability Card?

Er is momenteel geen zicht op de kost van het afleveren van de EDC voor 2026. In 2025 werd een factuur ontvangen van 93.740 euro voor de aanmaak van de kaarten in 2024.

- P. 199: welke middelen worden er specifiek voorzien voor wetenschappelijk onderzoek en hoe worden deze aangewend?

Voor 2025 was 500.000 euro voorzien voor wetenschappelijk onderzoek. Het gros van deze middelen werd aangewend om wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren via het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zo werden onder meer een internationaal vergelijkend onderzoek naar de intersectorale aanpak van personen met een handicap en complexe ondersteuningsnoden, een onderzoek naar de draagwijdte van de Standstill-verplichting, een onderzoek om basisvoorzieningen te versterken om meer inclusie voor personen met een handicap te verkrijgen, een naar een geïntegreerd beleid rond afzondering en fixatie en een duurzaam en multidisciplinair psychofarmacabeleid in de zorg opgestart.

- Het technisch VAK voor PVB wordt –8,774 miljoen euro verlaagd op basis van gebruiksparementen.
Hoe werd deze berekening uitgevoerd, en welke realisatiecijfers liggen eraan ten grondslag? (p. 171)

Het extra VAK tov. het VEK is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

- Vooreerst is er het extra VAK voor bijkomende terbeschikkingstellingen door de vastgestelde onderbenutting, waardoor er meer PVB ter beschikking gesteld worden dan er budget (in VEK) is.
- Ten tweede is er een extra technisch VAK voor de potentiële extra kost van de VIA-akkoorden uit het verleden, specifiek bij de rechtstreekse tewerkstelling van een persoonlijk assistent door de budgethouder. Hiertegenover staan geen bijkomende terbeschikkingstellingen. De BA2025 houdt rekening met een aandeel PVB dat ten minste gedeeltelijk in cash wordt besteed van 38,64%. In de BO2026 is dit aandeel verhoogd naar 39,67%.
- Tot slot is er een extra VAK voor de instroom die gefinancierd wordt met uitstroom, aangezien het budget van de uitstromers niet formeel wordt verlaagd in Orafin, noch in mijn.vaph, terwijl met het vrijgekomen budget toch al nieuwe terbeschikkingstellingen gebeuren. Er is dus een dubbele aanrekening in VAK nodig, terwijl het VEK slechts - voor de uitstromer en de instromer samen - eenmaal zal aangewend worden. In BO2026 is bedrag van het extra VAK verhoogd om rekening te houden met de toenemende uitstroom.

Het is belangrijk om de onderbenutting te monitoren. Als de onderbenutting door de budgethouders daalt, heeft dat tot gevolg dat er effectief minder bijkomende budgetten (PAB of PVB) kunnen worden ter beschikking gesteld, want anders zou de kost in VEK hoger uitkomen dan het krediet. Als de onderbenutting stijgt, kunnen er meer extra budgetten worden toegekend. Dit wordt jaarlijks in kaart gebracht en hierop wordt het VAK aangepast om meer of minder extra budgetten te kunnen ter beschikking stellen.

De aanpassing van -8.774 keuro in VAK voor PVB is grotendeels ten gevolge van de verhoging van de aanwendingsgraad of een verlaging van de onderbenutting. Dat betekent dat er minder extra PVB kunnen toegekend worden om de verplichtingen na te komen met het beschikbare VEK. De onderbenutting op het constant beleid houdt rekening met de onderbenutting van de verschillende types PVB (procedures) uit de bestedingsanalyse 2024 en met het aandeel van deze procedures. Door de verandering van de samenstelling van de gebruikers is de onderbenutting op het constant beleid gedaald van gemiddeld 8,86% in 2023, dat de basis vormde voor de begroting 2025 naar gemiddeld 8,63% in 2024 dat de basis vormt voor de begroting 2026.

- Hoeveel wordt voorzien voor innovatie in handicapspecifieke ondersteuning (technologie, assistieve tools, e-care)?

We gaan ervan uit dat deze vraag zich toespitst op hulpmiddelen gezien de aangehaalde voorbeelden. Hier is geen specifiek budget voor voorzien, maar het team dat kennis bundelt en verspreidt rond deze materie houden constant vinger aan de pols rond nieuwe ontwikkelingen.

- Hoeveel cliënten schakelen jaarlijks over van voucher naar cash, en wat betekent dit qua administratieve monitoring en frauderisico's?

De vraag hoeveel cliënten jaarlijks overschakelen van enkel voucher naar enkel cash is gebaseerd op een verkeerde premisse. Het VAPH-beleid is juist gericht op flexibiliteit en keuzevrijheid voor de budgethouder.

De actuele cijfers over het aantal personen dat zuiver het ene of het andere systeem gebruikt, en hoeveel de systemen combineren, zijn jaarlijks terug te vinden in het VAPH-jaarverslag. Wij volgen deze evolutie nauwgezet op om de behoeften van de cliënten te blijven begrijpen. Het VAPH ziet geen verhoogde frauderisico's bij de besteding in cash of de combinatie van systemen, dankzij een geïntegreerd en waterdicht monitoringssysteem.

ISE zorgbudgetten

- p. 207: -1000 keuro voor het efficiënter inzetten van overheidsmiddelen: toegepast op werkingssubsidies van de zorgkassen. Kan de minister dit verder toelichten?

Er wordt in 2026 1 miljoen euro in mindering gebracht op de werkingssubsidies van de zorgkassen. Deze vermindering wordt evenredig verdeeld over de werkingssubsidie van de zorgkassen per pijler.

- Hoe groot is het aandeel van de administratiekosten van de zorgkassen in verhouding tot het totale zorgbudget (p. 204)?

De werkingssubsidie voor het Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden bedraagt voor 2026 11.099 Keuro ten opzichte van een totaalbudget aan tegemoetkomingen ZZZ van 460.083 Keuro, oftewel 2,4%.

- Hoe wordt het zorgprognosemodel geactualiseerd met data van zorgkassen, VAPH en het KCE? Welke scenario's (optimistisch, realistisch, pessimistisch) worden in het model gebruikt, en wat is hun budgettaire impact (p. 213)?

Het zorgprognoseproject bevindt zich momenteel in een conceptuele fase waarin een wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar welke data relevant zijn voor de inschatting van de evolutie van de zorgnood.

Daarnaast wordt door de administratie in kaart gebracht welke data vandaag reeds ontsloten kunnen en welke juridische stappen daarvoor moeten ondernomen worden. Het insluiten van data van zorgkassen, VAPH en het KCE wordt onder die scope dus ook onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten en de oefening door de administratie zal een raming worden gemaakt voor de bouwkost van het Zorgprognosemodel.

ISE Zorginfrastructuur

- p. 219: hoe zal het bestaande subsidiëeringsmechanisme van de ziekenhuisinfrastructuur geëvalueerd worden? Binnen welke termijn?

De aanpassingen ter vereenvoudiging van het subsidiemechanisme zijn conceptueel en inhoudelijk uitgewerkt. De juridische vertaling daarvan is momenteel bezig.

- P. 220: IPO is overgeheveld naar welzijn en zal dus ook aanspraak kunnen maken op infrastructuursubsidies. Hoe werd hiermee rekening gehouden in de begroting?

De budgettaire impact doet zich gespreid voor gezien niet alle IPO's tegelijkertijd een investering willen opstarten. De theoretische impact is 7,7 mio euro per jaar indien alle IPO's elke 20 jaar een aanvraag tot betoelaging zouden indienen. Rekening houdend met een gangbare afschrijvingstermijn van een investering (33 jaar) is dat een overschatting.

- P. 220: Rollend Welzijnsfonds: hoe zal er bepaald worden wie in aanmerking komt om hierop beroep te doen?

De modaliteiten worden nog verder concreet uitgewerkt.

- P. 223: hoeveel wordt er concreet uitgegeven aan klimaatsubsidies?

In de huidige fase van de klimaatsubsidies is er enkel nog sprake van betaalafwikkeling van historische subsidies en eventuele kostprijsverhogingen. Voor wat de betaalafwikkeling van het historisch reeds toegezegde bedrag betreft, stond er begin 2025 nog een te betalen saldo van 62,47 mio euro open. Gezien dit betrekking heeft op lange termijn-infrastructuurprojecten, zal dit over een periode van 2026-2032 worden betaald.

Specifiek wat 2026 betreft is hiervoor 7,47 mio euro voorzien op de VIPA-begroting voor de betaling van die eerdere subsidietoezeggingen. Daarnaast kan voor de betaalafwikkeling ook nog gerekend worden op nog niet opgevraagde betaalmiddelen bij het Vlaams Klimaatfonds (VKF). Over diezelfde periode (2026-2032) is dat globaal 28,28 mio euro. Daarnaast kan er voor de vastlegging van de kostprijsverhogingen voor de eerder toegezegde projecten globaal nog circa 5,29 mio euro worden opgevraagd bij het VKF.

- Wat is de gemiddelde doorlooptijd van goedkeuring tot realisatie van VIPA-projecten per sector (p. 230)?

Indien met goedkeuring, de goedkeuring van de minister wordt bedoeld, dan is er voor 312 dossiers met zogenaamde klassieke VIPA-financiering met ingebruikname in de periode 2016-2026, gemiddeld 2,6 jaar verstreken tussen de belofte en ingebruikname.

Bij het VAPH-forfait voor meerderjarigen stellen we ook een doorlooptijd vast van circa 3 jaar.

Bij de ziekenhuizen is de doorlooptijd logischerwijze langer gezien de investeringsgrootte. De gemiddelde doorlooptijd van de verleende strategische forfaits

die in gebruik genomen zijn vanaf goedkeuring tot realisatie bedraagt 3,3 jaar. Het overgrote deel van de projecten (34/45) zijn echter nog niet in gebruik genomen waardoor de gemiddelde doorlooptijd voor deze sector niet representatief is en tevens sterk onderschat is.